Governo Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia

UNIR

Resolução nº 545/CONSEA, de 23 de outubro de 2018.

Reformulação do projeto pedagógico do curso de Medicina

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.000906/2018-40 – Volumes I a III;
- Parecer 2286/CGR, do relator conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano;
- Deliberação na 170ª sessão da Câmara de Graduação, em 04-10-2018;
- Deliberação na 96ª sessão Plenária, em 17-10-2018.

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar reformulação do curso de Medicina constante às folhas 474 a 483 do mencionado processo, nos termos descritos a seguir e no anexo:

- **Nome do curso:** Medicina
- **Ato de Criação para Autorização e Reconhecimento ou Ato autorizativo anterior para renovação de Reconhecimento:** Criado através da Resolução 24/CONSUN/1997, autorizado através do Parecer 1631/2001/CNE, publicado no DOU de 18/01/2002, reconhecido pela Portaria SESU nº 141, de 30/01/2009.
- **Número de vagas pretendidas ou autorizadas:** 40 vagas anuais
- **Conceito Preliminar de Curso – CPC**: 4
- **Turnos de funcionamento do curso:** integral
- **Carga horária total do curso:** 8.680 horas-aula (7233 horas/relógio) mais 750 horas de atividades complementares, totalizando 7.983 horas/relógio;
- **Tempos mínimo e máximo para integralização:** Tempo mínimo: 6 anos (12 semestres) e tempo máximo: 9 anos (18 semestres);
- **Grau conferido ao egresso:** Médico;
- **Tipo de Ingresso:** Processo seletivo da Universidade, definido anualmente pelo Conselho Superior competente;
- **Endereço de funcionamento do curso:** UNIR – BR 364 – Km 9,5 - Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho - Rondônia

Art. 2º Revogam-se disposições contrárias.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

Governo Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Retificação nº 01 da Resolução nº 545/CONSEA, de 12 de novembro de 2018.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.000906/2018-40 – Volumes I a III;
- Parecer 2286/CGR, do relator conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano;
- Deliberação na 170ª sessão da Câmara de Graduação, em 04-10-2018;
- Deliberação na 96ª sessão Plenária, em 17-10-2018.

R E S O L V E:

Art. 1º Retificar a redação da Resolução 545/CONSEA, de 23 de outubro de 2018, nos seguintes termos:

Onde se lê:

Art. 1º Aprovar reformulação do curso de Medicina constante às folhas 474 a 483 do mencionado processo, nos termos descritos a seguir e no anexo: [...]

Leia-se:

Art. 1º Aprovar reformulação do curso de Medicina constante às folhas **262 a 471** do mencionado processo, nos termos descritos a seguir e no anexo: [...]

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

Projeto Pedagógico do Curso

MEDICINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

2017

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

Departamento de Medicina

Porto Velho, dezembro de 2017

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Fundação Universidade Federal de Rondônia

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DA MEDICINA

Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar
Prof. Ms André Luis Peterman
Profa. Ms. Andressa Tumelero
Prof. Dr. Dhelio Batista Pereira
Profa. Dra. Gisele Martins Gonçalves
Profa. Prof. Dr. José Odair Ferrari
Ms. Kátia Regina Schesquini Roriz
Profa. Dra. Maillene Rodrigues Lisboa
Prof. Ms. Renato Roriz da Silva
Prof. Dr. Rodolfo Korte

Coordenação da elaboração do projeto

Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar

Porto Velho RO
2017

Lista de Ilustrações

Lista de Quadros

Quadro 1: Cursos de graduação conforme Núcleo e Departamento, UNIR, 2017. 6
Quadro 2: Cursos de Graduação por Campi, UNIR, 2017. 7
Quadro 3: Cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, UNIR, 2017. 8
Quadro 4: Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 8
Quadro 5: Carga horária do curso 49
Quadro 6: Atividades Complementares 52
Quadro 7: Atividades de Extensão 52
Quadro 8: Detalhamento do corpo docente (dados funcionais) do curso de Medicina .. 191
Quadro 9: Corpo docente, lattes, disciplinas e estágios 194
Quadro 10: Servidores Técnicos do Departamento de Medicina 200
Quadro 11 Matriz de correspondência curricular 284

Lista de Figuras

Figura 1: ESTADO DE RONDÔNIA, 2017. 10
Figura 2: Principais causas de mortalidade, Rondônia, 2013 15
Figura 3: Distribuição dos médicos por município, Rondônia, 2016. 19
Figura 4: Representação esquemática da estrutura curricular 24
Figura 5: Representação esquemática da estrutura curricular 29
Figura 6: Representação gráfica do percurso curricular do curso de medicina da UNIR. 180
Figura 7 - Síntese do percurso curricular 181

Lista de Tabelas

Tabela 1: Estabelecimentos de saúde, conforme natureza, Rondônia, outubro de 2015.. 17
Tabela 2: Leitos distribuídos segundo natureza, Rondônia, outubro de 2015. 18
Tabela 3: Médicos conforme Região de saúde, Rondônia, março de 2016 19
Tabela 4: Municípios conforme o número de médicos, Rondônia, 2016 20
Tabela 5: Distribuição do corpo docente por área e titulação. 190

Lista de Organogramas

Organograma 1 - Organização modular do currículo do curso de Medicina (2002) 25
Organograma 2 - Organização modular do currículo do curso de Medicina (2017) 26

Sumário

APRESENTAÇÃO **1**

1. CONTEXTUALIZAÇÃO **3**

1.1. Contextualização da Universidade Federal de Rondônia 3

1.1.1 Princípios e valores da UNIR 4

1.1.2 Cursos de Graduação e Pós-Graduação 5

1.1.3 Estrutura do Núcleo de Saúde e do Departamento de Medicina 9

1.2. Contextualização da realidade econômica e social de Rondônia 10

1.2.1 Características gerais do Estado de Rondônia 10

1.2.2 Características demográficas e epidemiológicas de Rondônia 12

1.2.3 Organização dos serviços de saúde em Rondônia 17

1.2.4 Distribuição dos médicos em Rondônia 18

1.2.5 O curso de Medicina da UNIR 20

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA **21**

2.1. Objetivos do Curso 21

2.1.1 Objetivo Geral 22

2.1.2 Objetivos Específicos 22

2.2 Concepção do Curso 23

2.2.1 Premissas da concepção curricular 23

2.2.2 Conteúdos optativos 31

2.2.3 Atividades Complementares e de Extensão 31

2.3. **Justificativa** 32

2.4. Legislação 34

2.5. Perfil do Egresso 36

2.6 Perfil do Curso 42

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso 42

2.6.2 Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS 50

2.7 Estrutura Curricular 51

2.7.1 Componentes curriculares obrigatórios 51

2.7.2 Disciplinas optativas 51

2.7.3 Relação das Disciplinas Optativas 51

2.7.4. Atividades Complementares e de Extensão 52

2.7.5 Matriz Curricular 54

2.7.6 Libras 58

2.7.7 Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Educação Inclusiva de Portadores de Autismo e Dislexia 58

2.7.8 Ementário das Disciplinas Obrigatórias 60

2.7.10 Alterações da Matriz Curricular 171

2.7.11 Requisitos para integralização do currículo 171

2.7.12 Avaliação do Curso de Medicina 172

2.7.13 Regulamento do Internato 173

2.8 Representação gráfica do perfil de formação 180

2.9 Acompanhamento e atualização do Projeto Pedagógico 182

2.9.1 Reuniões da Rede Docente Assistencial 182

2.9.2 Seminários de Formação dos Professores e Seminários de Avaliação do Currículo . 182

2.9.3 Acompanhamento dos Egressos 183

2.9.4 Avaliação da aprendizagem 184

2.10 Avaliação institucional interna do Curso de Medicina 186

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 186

3.1. Conselho do Departamento de Medicina 187

3.1.1. Coordenações de área 188

3.1.2. Comissão do Internato do Curso de Graduação em Medicina 188

3.1.3 Núcleo Docente Estruturante 189

3.2 Recursos Humanos 190

3.2.1 Corpo Docente 190

3.2.2. CORPO DISCENTE 198

3.2.3. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 199

4. INFRAESTRUTURA 201

4.1. Descrição da estrutura administrativa do Curso 201

4.2. Descrição do suporte administrativo: DIRCA e Núcleo de Saúde 204

4.3. Equipamentos e laboratórios 206

4.3.1 Biotério 207

4.3.2 Laboratório de Anatomia Humana 207

4.3.3 Laboratório de Técnicas Cirúrgicas 210

4.3.4 Laboratório de Anatomopatologia 210

4.3.5 Laboratório de Fisiologia Humana 212

4.3.6 Laboratório de Farmacologia 213
4.3.7 Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia 214
4.3.8 Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 215
4.3.9 Laboratório de habilidades 216
4.4 Protocolos de experimentos 219
4.5 Comitê de ética em pesquisa 219
4.6. Biblioteca 221
4.7. Infraestrutura básica utilizada no ensino. 222
4.8. Acessibilidade 224
5. BIBLIOGRAFIA. 224
ANEXOS 226
Anexo 1 – Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina 227
Anexo 2 – Carga horária mínima: 232
Anexo 3 – Reconhecimento do Curso de Medicina 234
Anexo 4 – Matriz curricular 2002 e suas adaptações: 236
Anexo 5 – Coordenações de Área do Curso de Medicina 240
Anexo 6 – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina 240
Anexo 7 – Coordenação do Internato da Medicina 241
Anexo 8 – Regimento do Internato 243
Anexo 9 – Relatório do Processo de Acreditação do Curso de Medicina da UNIR (SAEME) 250
Anexo 10 – Guia de avaliação interna de curso. 268
Anexo 11 – Ata de reunião do NDE 279
Anexo 12 – Ata de Reunião do DEPMED 280
APÊNDICES 281
Apêndice 1 - Plano de Adaptação Curricular ao Novo Currículo do Curso de Graduação em Medicina da UNIR 282
Apêndice 2 – Detalhamento da Infraestrutura 289
Apêndice 3 - Listagem dos equipamentos dos Laboratórios 315
Apêndice 4 – Questionário do plano de acompanhamento de egressos 377
Apêndice 5 – Requerimento de atividades complementares e de extensão 382
Apêndice 6 – Instrumento de avaliação – internato 383
Apêndice 7 – Ementas, objetivos e bibliografia das disciplinas optativas 384

APRESENTAÇÃO

O plano estratégico de Recursos Humanos para as Américas 2007-2015 estabelece que o processo de expansão do ensino médico no Brasil deve contemplar a formação do profissional adaptado a um modelo universal e equitativo para oferecer atenção de qualidade de acordo com as necessidades da população. Segundo o *Global Health Workforce Alliance* (GHWA), o ensino médico deve ser reorientado para formação de um profissional com enfoque na atenção primária, direcionado para resolver as principais questões de saúde pública do país.

O modelo assistencial deve buscar a excelência para proporcionar uma assistência mais humanizada e integral do indivíduo, além de contribuir para maior divulgação do conhecimento sobre a doença e medidas educacionais para prevenção de agravos à saúde. Os fundamentos básicos da medicina, centrados na escuta do paciente e no contato manual, através do exame físico, ainda têm o seu lugar, em que pese os avanços tecnológicos na área médica. Em que pese a importância do cuidado curativo, a medicina caminha a passos largos na esfera preventiva. Tal visão passa a ser determinante para a sobrevivência do sistema de saúde como um todo. O médico atual precisa de competência para tratar do indivíduo, sem perder o foco no coletivo, e vice- versa.

Neste contexto, a formação do profissional médico da Universidade Federal de Rondônia deve estar atrelada às necessidades de saúde da população, à mudança do processo de trabalho em saúde, às transformações nos aspectos demográficos e epidemiológicos, bem como ao acelerado ritmo de evolução do conhecimento, tendo como perspectiva o equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância social.

De acordo com o documento do MEC “Proposta de Expansão de Vagas do ensino médico nas Instituições Federais de Ensino Superior” elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 86, de 22 de março de 2012, os novos cursos de Medicina devem adotar o modelo de atendimento de saúde orientado para a comunidade (Campos et al. 2012). Esta proposta destaca a necessidade da prática de um ensino centrado no estudante, este visto como sujeito ativo do processo, enfocando o aprendizado vinculado aos cenários reais de prática e baseado em problemas da realidade (Mattos, 1997). Esta nova orientação deixa de seguir o modelo clássico

proposto por *Flexner* que, baseado no hospitalocentrismo, fragmentou o curso de medicina em diversas especialidades, segmentou o paciente em sistemas isolados, aprofundando a distância dentro do binômio médico-paciente, numa falta de integração dos conhecimentos na abordagem da saúde.

As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2014 do Curso de Graduação em Medicina determinam que o graduado deve ter formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção do processo saúde-doença, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana, objetivando-se como promotor da saúde integral do ser humano. É ressaltada a necessidade de articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas do egresso, para o futuro exercício profissional do médico graduado, o currículo do curso deve contemplar as seguintes áreas de formação: I - Atenção à Saúde; II - Gestão em Saúde; III - Educação na Saúde (Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior – CNE/CES2014).

As mudanças no sistema de saúde, paralelamente à implantação das DCN refletiram sobre as tendências na formação médica, com valorização do profissional generalista e da medicina comunitária, determinando novas demandas para o ensino médico. A visão integral do usuário implica em percebê-lo como sujeito histórico, social e político, portanto, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se insere. Desse modo, torna-se fundamental a atenção às questões ambientais, às doenças relacionadas ao trabalho e a temas atuais como: as diversas formas de violência e a utilização de drogas.

As linhas gerais do Projeto Pedagógico para o curso de graduação de Medicina da UNIR possibilita abordagem de caráter multi e interdisciplinar, pautada no compromisso com as necessidades de saúde da comunidade, visando à formação de um profissional médico com competências e habilidades para a assistência em todos os níveis de complexidade da assistência ao paciente, na prevenção e promoção da saúde. Além disso, tem em sua matriz curricular a prioridade de treinamento e capacitação do aluno na Atenção Primária a Saúde e na Urgência e Emergência.

O curso de Medicina no formato proposto busca a formação de profissional generalista e humanista, integrando-os à equipe multidisciplinar de cuidados à saúde, com ênfase nas peculiaridades e necessidades específicas das regiões onde a UNIR está inserida. Essa orientação se integra às DCN do curso de graduação em Medicina e às proposições do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde no tocante ao conteúdo teórico, aos cenários de práticas e à orientação pedagógica; guardada a necessária consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular própria da UNIR.

Para elaboração desse Projeto Pedagógico foram utilizados como fontes, referências e partes dos seguintes documentos: Projeto Pedagógico dos cursos de Medicina da UFSC, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, UFSJ - Campus Centro Oeste e São João Del Rey, UFPA, CESUPA. Além disso, foram utilizados documentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Contextualização da Universidade Federal de Rondônia

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única universidade pública de Rondônia. Foi criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho, após a criação do estado pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981.

Hoje, a UNIR possui oito *campi*, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

A sede administrativa da UNIR fica em Porto Velho, e está dividida em duas Unidades, a Unidade Administrativa sito à Av. Presidente Dutra, 2965, bairro Centro, onde estão a Reitoria, Secretaria dos Conselhos Superiores (SECONS), as Pró-Reitorias de Administração (PRAD), de Planejamento (PROPLAN), de Assessoria Jurídica e Procuradoria (PROJUR), Assessoria de Comunicação (ASCOM), a Editora da UNIR (EDUFRO), entre outras unidades administrativas subordinadas, e a Unidade Campus José Ribeiro Filho sito a BR 364, Km 9,5, onde estão as Pró-Reitorias de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

(PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq), os Núcleos de Saúde (NUSAU), de Ciências Humanas (NCH), de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), de Ciência Exatas e da Terra (NCET), e de Tecnologia (NT), os Departamentos Acadêmicos a eles vinculados, bem como Laboratórios, Biblioteca Central, e unidades administrativas do campus.

Os princípios organizacionais são balizamentos para o processo decisório e para o comportamento da organização no cumprimento de sua missão. Já os valores são preceitos essenciais e permanentes de uma organização. Como um pequeno conjunto de princípios de orientação perenes, não requer nenhuma justificativa externa: têm valor e importância intrínsecos e são importantes para aqueles que fazem parte da organização.

1.1.1 Princípios e valores da UNIR

PRINCÍPIOS	**VALORES**
Desenvolvimento Humano	Respeito e valorização do ser humano
	Foco nas pessoas e na qualidade de vida
	Condições adequadas de higiene e segurança do trabalho
	Desenvolvimento dos talentos humanos
	Solidariedade
Eficiência, Eficácia e Efetividade	Delegação coordenada
	Geração de valor
	Simplificação e gestão integrada de processos
	Aperfeiçoamento contínuo
	Atitude proativa
	Meritocracia
	Planejamento sistêmico
Sustentabilidade Institucional	Foco nos propósitos e objetivos
	Foco nos resultados e na qualidade
	Defesa dos princípios e valores
	Formação de lideranças para governança

Cooperação e Integração	Valorização do trabalho em equipe
	Gestão participativa
	Liderança integradora
	Alinhamento e convergência de ações
Integração Ensino, Pesquisa e Extensão	Interdisciplinaridade
	Aplicabilidade dos estudos da UNIR
	Educação superior inclusiva
	Promoção do desenvolvimento regional
Transformação Social	Foco na missão e visão institucional
	Permanente atuação nas políticas estratégicas do Estado
	Defesa dos direitos humanos
	Defesa da diversidade étnica, cultural e da biodiversidade
	Proatividade frente aos anseios da sociedade
	Inovação, monitoramento e avaliação permanentes
	Responsabilidade Social
Transparência e Moralidade	Visibilidade da produção da UNIR
	Coerência nas atitudes e práticas
	Zelo pela imagem e patrimônio da UNIR
	Compartilhamento de informações e conhecimento
	Garantia do interesse coletivo

MISSÃO

Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da sociedade.

VISÃO

Ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018.

1.1.2 Cursos de Graduação e Pós-Graduação

No campus sede da instituição, Campus José Ribeiro Filho, as atividades acadêmicas estão distribuídas entre os Núcleos e seus departamentos. São oferecidos 40

cursos de graduação, sendo 36 presenciais. Na tabela a seguir encontra-se o detalhamento dos cursos de graduação oferecidos em Porto Velho, conforme os seus Núcleos e Departamentos Acadêmicos:

Quadro 1: Cursos de graduação conforme Núcleo e Departamento, UNIR, 2017.

Núcleo	Cursos	Departamentos
NUCSA 7	Administração Administração Pública - EAD	Administração
	Biblioteconomia	Biblioteconomia
	Ciências Contábeis	Ciências Contábeis
	Ciências Econômicas	Ciências Econômicas
	Direito Segurança Pública (Convênio com o Governo do Estado de Rondônia)	Ciências Jurídicas
NCH 17	Arqueologia	Arqueologia
	Teatro Artes Visuais Música	Artes
	História - Licenciatura História – Bacharelado	História
	Letras Inglês Letras Espanhol	Línguas Estrangeiras
	Pedagogia Pedagogia EAD	Ciências da Educação
	Filosofia – Licenciatura Filosofia - Bacharelado *	Filosofia
	Ciências Sociais – Licenciatura Ciências Sociais – Bacharelado*	Ciências Sociais
	Letras - Português Letras - Libras Letras - EAD	Letras Vernáculas
NCET 8	Física	Física
	Geografia - licenciatura Geografia - bacharelado	Geografia
	Ciências Biológicas - licenciatura Ciências Biológicas - bacharelado Ciências Naturais e Biologia – EAD*	Biologia
	Matemática	Matemática
	Química	Química
NT 4	Ciências da Computação Computação	Ciências da Computação
	Engenharia Civil	Engenharia Civil
	Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica

NUSAU 4	Educação Física	Educação Física
	Enfermagem	Enfermagem
	Psicologia	Psicologia
	Medicina	Medicina
Total Porto Velho		40, sendo 36 presenciais

* Em extinção

Além do campus-sede, a UNIR também apresenta cursos de graduação nos campi dos municípios do interior, sistematizados no quadro a seguir:

Quadro 2: Cursos de Graduação por Campi, UNIR, 2017.

Campi	Cursos	Departamentos
Cacoal 4	Direito	Direito
	Administração	Administração
	Ciências Contábeis	Ciências Contábeis
	Eng. de Produção	Eng. de Produção
Vilhena 5	Jornalismo	Comunicação Social/Jornalismo
	Ciências Contábeis	Ciências Contábeis
	Letras - Português	Estudos Linguísticos e Literários
	Administração	Administração
	Pedagogia	Ciências da Educação
Ji-Paraná 7	Engenharia Ambiental	Engenharia Ambiental
	Física – Licenciatura Física – bacharelado	Física
	Matemática Estatística	Matemática e Estatística
	Educação Básica Intercultural	Educação Intercultural
	Pedagogia	Ciências Humanas e Sociais
Rolim de Moura 6	Agronomia	Agronomia
	Engenharia Florestal	Engenharia Florestal
	História	História
	Pedagogia Educação no Campo	Educação
	Medicina Veterinária	Medicina Veterinária
Ariquemes 2	Engenharia de Alimentos	Engenharia de Alimentos
	Pedagogia	Ciências da Educação
Guajará-Mirim 4	Administração	Ciências da Administração
	Gestão Ambiental	Ciências Sociais e Ambientais
	Letras Português	Ciências da Linguagem
	Pedagogia	Ciências da Educação
Presidente Médici 2	Engenharia de Pesca	Engenharia de Pesca
	Zootecnia	Zootecnia**

Portanto, a UNIR oferece atualmente 70 cursos de graduação, dos quais 66 são presenciais.

Quanto aos cursos de Pós-graduação, a tabela a seguir apresenta os dados atuais da instituição:

Quadro 3: Cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, UNIR, 2017.

DOUTORADOS		
PROGRAMAS	**CAMPUS**	**NÚCLEO**
Biologia Experimental	Porto Velho	NUSAU
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente	Porto Velho	NCET
Geografia	Porto Velho	NCET
Biodiversidade e Biotecnologia - Rede Bionorte	Porto Velho	NCET
MESTRADOS ACADÊMICOS		
PROGRAMAS	**CAMPUS**	**NÚCLEO**
Administração	Porto Velho	NUCSA
Biologia Experimental	Porto Velho	NUSAU
Ciências Ambientais	Rolim de Moura	-
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente	Porto Velho	NCET
Educação	Porto Velho	NCH
Estudos Literários	Porto Velho	NCH
Geografia	Porto Velho	NCET
História e Estudos Culturais	Porto Velho	NCH
Letras	Porto Velho	NCH
Psicologia	Porto Velho	NUSAU
MESTRADOS PROFISSIONAIS		
Administração Pública em Rede Nacional	Porto Velho	NUCSA
Direitos Humanos - Em implantação	Porto Velho	NUCSA
Educação Escolar	Porto Velho	NCH
Ensino de Física – Em rede	Porto Velho e Ji-Paraná	NCET
Ensino em Ciências da Saúde	Porto Velho	NUSAU
Matemática em Rede Nacional	Porto Velho	NCET
Saúde da Família	Porto Velho	NUSAU

Quadro 4: Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

PRESENCIAIS			
PROGRAMAS	**CAMPUS**	**NÚCLEO**	**Resolução nº**
Educação de Jovens e Adultos no campo com ênfase em economia solidária	Ariquemes	-	385/CONSEA/2015
Gênero e Diversidade na Escola	Rolim de Moura	-	394/CONSEA/2015
Residência em Enfermagem Obstétrica	Porto Velho	NUSAU	332/CONSEA/2014
Residência em Medicina da Família e Comunidade	Porto Velho	NUSAU	412/CONSEA/2015
Segurança Pública e Direitos Humanos	Porto Velho	NCH	385/CONSEA/2015
À DISTÂNCIA			
Gestão em Saúde			253/CONSEA/2010
Gestão Escolar			331/CONSEA/2014
Gestão Municipal			246/CONSEA/2010
Gestão Pública			245/CONSEA/2010

Para atender aos cursos de graduação e pós-graduação, além das atividades de pesquisa, centralizadas nos Centros e Grupos de Pesquisa, e de extensão, a UNIR atualmente possui 848 docentes, 457 técnicos administrativos e cerca de nove mil alunos.

1.1.3 Estrutura do Núcleo de Saúde e do Departamento de Medicina

O Núcleo de Saúde e composto por Departamentos que são responsáveis pela oferta dos cursos de graduação e pós-graduação da área. Os cursos de graduação são Enfermagem, Psicologia, Medicina e Educação Física. Mestrado e doutorado em Biologia Experimental, mestrado em Psicologia e o mestrado profissional em Ensino em Ciências da Saúde são os programas estrito senso. Em vias de implantação o Mestrado Profissional em Rede em Saúde da Família, em articulação com outras universidades e coordenado pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). Oferece também a Residência em Medicina de Família e Comunidade e as especializações em Gestão em Saúde, ... Atualmente são xxx alunos matriculados nos cursos de graduação e xxx nas pós-graduações. No Departamento de Medicina, que atualmente oferece 40 vagas anuais, contando com 240 alunos matriculados são 62 professores e 5 técnicos (4 de laboratório e um assistente administrativo).

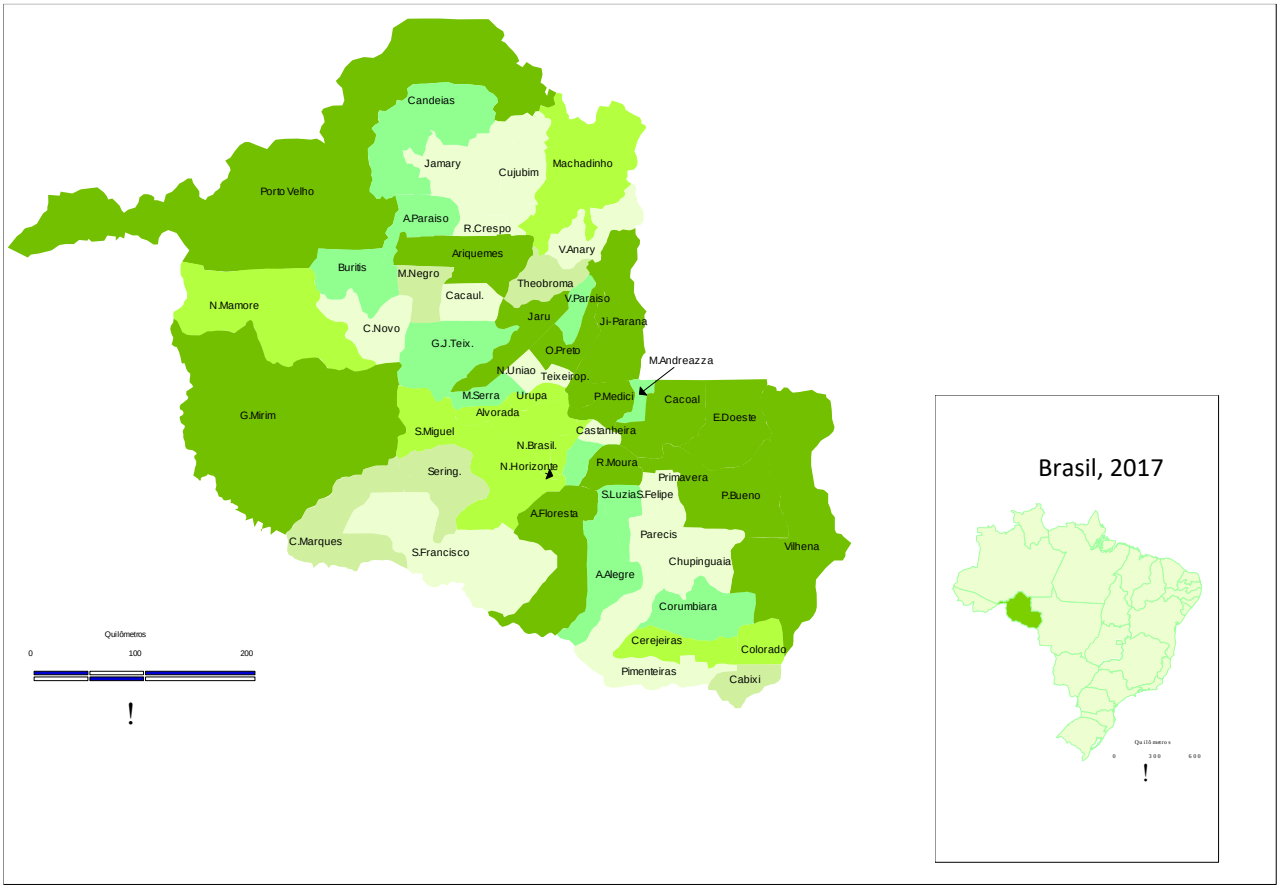
O NUSAU dispõe de espaço específico para as salas de aula e laboratórios para os cursos de Psicologia, Enfermagem, Educação Física e Medicina. O curso de Medicina funciona nos Blocos 3-A, 3-B e 3-C. No Bloco 3-A estão seis salas de aula, uma sala de professor, uma sala do Centro Acadêmico de Medicina, 6 laboratórios e 12 salas de professor e técnicos. O Bloco 3-B comporta o laboratório de Anatomia que, além dos espaços de prática, possui um anfiteatro e 3 salas, sendo uma ocupada pelo Centro de Estudos em Transplantes e duas voltadas para atividades administrativas. Ali também está localizado o laboratório de habilidades clínicas, que conta com 6 salas, abrigando cerca de 30 simuladores e peças didáticas. O Bloco 3-C, já construído, abrigará o biotério, aguardando a aquisição dos equipamentos para sua operacionalização.

1.2. Contextualização da realidade econômica e social de Rondônia

1.2.1 Características gerais do Estado de Rondônia

Ocupando 243.044 Km^2 da parte sudoeste da Amazônia Brasileira, a área do Estado de Rondônia (Figura 1) corresponde a 2,8% da área do país. Foi criado como Território Federal, nos anos 40, sob o nome de Guaporé, a partir de terras dos Estados do Amazonas e Mato Grosso.

Figura 1: ESTADO DE RONDÔNIA, 2017.



A construção da estrada ligando Porto Velho a Cuiabá, a transferência da fronteira agrícola do centro-sul para Rondônia e a implantação pelo governo federal, através do INCRA, de projetos de colonização para pequenos produtores como forma de resolução de conflitos de terra que ocorriam no centro-sul do país, foram instrumentos decisivos na consolidação da ocupação da área que em 1980 atingia uma população residente de 491.025 habitantes, com uma densidade demográfica de 2,02 habitantes por Km^2, e uma

taxa geométrica de crescimento em torno de 16% ao ano nos primeiros anos da década de 70 (IBGE, 1984).

O fluxo migratório gerou intensa ocupação espontânea e desordenada, provocando a intervenção federal através do INCRA, que elegeu inicialmente uma faixa de seis quilômetros às margens da BR 364, no trecho compreendido entre Ariquemes e Pimenta Bueno, como prioritária para a reforma agrária. Esta atitude, associada com a expansão das atividades mineradoras, com a mecanização da exploração da cassiterita e a abertura de garimpos de ouro, concorreu para intensificar ainda mais a corrente migratória.

O ápice da migração em Rondônia foi atingido em 1986, reduzindo, posteriormente, ano a ano. Em 1988, constatou-se queda de 50% em relação ao ano anterior. No entanto, houve migração por entradas não vigiadas ou cadastradas, como também há evasão para novas áreas atrativas (SEPLAN, 1990).

A importância da colonização agrária para o desenvolvimento demográfico também se reflete na relação entre população rural e urbana. As cidades, em Rondônia, tornaram-se pontos de atração populacional, com uma relação de 54% de população urbana frente a 46% de população rural, no período de 1960-1970. Esta tendência mudou para uma relação de 53,5% de população rural para 46,5% de população urbana até 1980, indo contra a tendência observada na região Norte e no Brasil como um todo. E mudou novamente na década seguinte, quando os dados do censo de 1991 demonstraram que do total de 1.130.296 habitantes, 58,8% estava na zona urbana e 41,2% na zona rural (IBGE, 1992). Desde o final dos anos 70, quando 70% dos migrantes provinham de regiões rurais, a situação mudou de tal modo que a percentagem de migrantes rurais se reduziu até 30% em 1983, significando que as regiões urbanas predominavam como sítios de procedência.

Até o final dos anos 70, os poucos rondonienses que tinham acesso a cursos superiores levavam dias a bordo de embarcações pelos rios da Amazônia para chegar a outros centros do país. Com a abertura e asfaltamento da BR 364 e com a implantação de linhas aéreas ligando Porto Velho ao restante do país, os jovens passaram a ter mais facilidades para se dirigir a outros estados sem os percalços das rotas fluviais.

No início dos anos 80, com a proclamação do eldorado, deu-se início ao fluxo migratório de pessoas que vieram atrás de esperanças e de um futuro melhor e mais tranquilo para os filhos e familiares. Entre tantos brasileiros que vieram habitar as fronteiras de Rondônia, motivados por estímulos diversos, para aqui vieram também médicos e outros profissionais da área da saúde.

O final dos anos 80 se caracterizou como já citado anteriormente, por uma inversão no fluxo migratório que levou para os estados de origem milhares de famílias que não conseguiram se fixar no estado. Nesta mesma época, muitos profissionais especializados retornaram ou decidiram tentar vida nova em outros estados do país.

Os processos econômicos e sociais tiveram impulsos distintos nos últimos anos, com crescimento da agropecuária e com a implantação de obras de infraestrutura, em especial na área de produção de energia elétrica.

1.2.2 Características demográficas e epidemiológicas de Rondônia

Conforme as estimativas do IBGE a população estimada do Estado de Rondônia, em 1 de julho de 2016, será de 1.787.495 habitantes, concentrando 28% na capital, Porto Velho. São 52 municípios, dos quais sete tem mais de 50 mil habitantes e têm, juntos, 58% da população total. O Índice de Desenvolvimento Humano calculado para a década de 2000 era de 0,690, o que o coloca entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano. Rondônia ocupa a 15ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,824 (Distrito Federal) e o menor é 0,631 (Alagoas). Os municípios de Porto Velho (0,736) e Vilhena (0,731) apresentaram os melhores índices e o município de Vale do Anari apresentou o pior índice (0,584). Apenas sete dos 52 municípios tinha IDH acima de 0,700. A densidade demográfica é de 5,8 hab/$Km^{2,}$ com taxa de urbanização de 64,1%. A razão de dependência era de 60,7% e a esperança de vida ao nascer de 73,71 anos (IBGE, 2016).

É possível construir quatro distintos agrupamentos geográficos a partir das características ambientais, sócio-políticos e geo-populacionais. Um primeiro, a capital, com cerca de 500 mil habitantes. O município, por si, tem dimensões equivalentes a da Bélgica e vários micro-ambientes: a zona urbana, a zona rural, com seus assentamentos de pequenos produtores e grandes fazendas, a zona ribeirinha ao longo dos Rios Madeira

e Machado, e os aglomerados populacionais localizados ao longo das estradas. As populações ribeirinhas de outros municípios, juntamente com as de Porto Velho, conformam um agrupamento que terá configurações próprias, tanto devido ao acesso como às características socioculturais de sua população. Outro agrupamento são os municípios localizados ao longo da BR 364, que liga a região ao Centro-Sul do país e ao Estado do Acre e, dali, à América Andina, numa configuração do tipo espinha de peixe. Estes municípios têm aglomerados urbanos expressivos, com extensas áreas rurais, nas quais a população encontra-se dispersa. Vivem em Rondônia aproximadamente 13 mil índios, a maioria nas 23 terras indígenas que ocupam cerca de 20% do território. Estes povos, distribuídos em mais de 50 etnias, conferem à região características multiculturais e polilinguísticas (Neves, 2012).

Rondônia é um estado cujo perfil epidemiológico se caracteriza pela complexidade e pela sobreposição de perfis. Convivemos com taxas elevadas de doenças transmissíveis, entre as quais a malária ocupa o primeiro lugar. Mas não é possível minimizar a importância de problemas como a tuberculose, a hanseníase, as diarreias infecciosas, a leishmaniose, a paracoccidioidomicose, entre outras. A cada dia assumindo papel mais relevante na morbidade e mortalidade, surgem os mais diversos tipos de câncer, sendo hoje a terceira causa de morte. Entre suas características, pode-se destacar o câncer de pulmão, câncer de mama, de colo uterino, de próstata, entre outros, não menos relevantes.

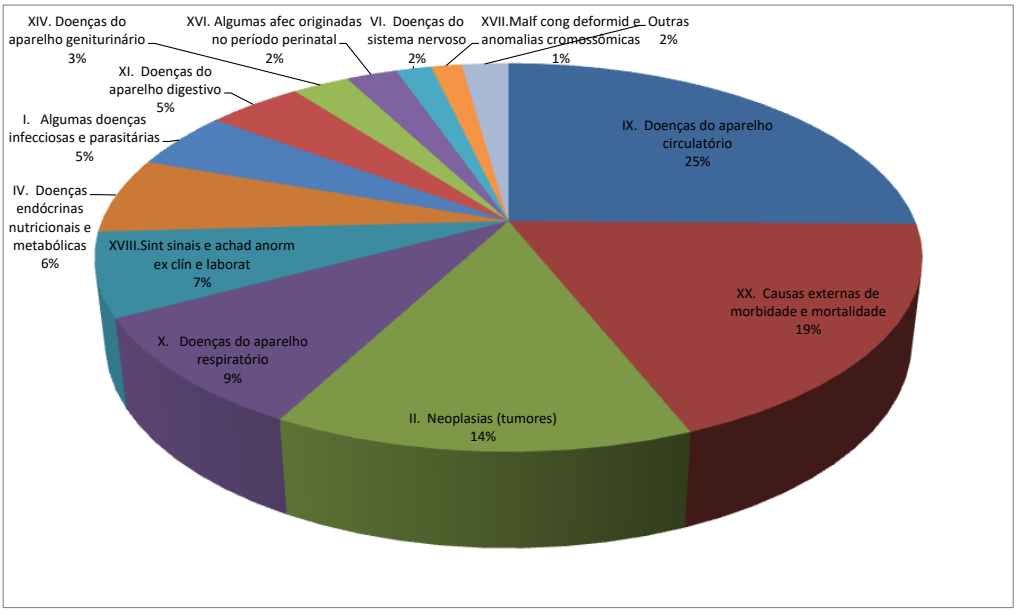
As doenças do aparelho respiratório, destacando-se as pneumonias, atingem toda a população, em especial nos seus extremos de vulnerabilidade: entre as crianças e entre os idosos. Estes problemas devem ser destacados para os períodos de seca amazônica, quando, aliada à poeira, somam-se as queimadas, que, por vezes, impedem inclusive o pouso e decolagem de aviões. Além das doenças respiratórias, também ocorrem e se expressam na mortalidade, as diarreias decorrentes tanto de problemas ambientais como daqueles inerentes aos cuidados com as crianças. Embora com taxas aparentemente baixas de mortalidade, a malária continua sendo responsável por grande parte da carga de doenças do estado, em especial nos locais caracterizados como fronteira agrícola, na periferia das cidades, em especial de Porto Velho e Candeias do Jamari, nos garimpos, nos assentamentos e nas áreas indígenas. A tuberculose permanece como um grave

problema da saúde da população, contribuindo para os óbitos por doenças transmissíveis. Este conjunto de doenças (as infecciosas e as respiratórias) é responsável por 13,9% dos óbitos do Estado.

As principais causas de mortalidade são as circulatórias (25%), seguidas pelas causas externas (19%) e neoplasias (14%) (figura 2).

Os indicadores de serviço do Estado demonstram a baixa capacidade operacional, sendo que as coberturas dos programas ditos prioritários, como o da Saúde da Família e toda a sua estratégia, atingem 60% da população. As unidades hospitalares dos diversos municípios, desde os menores, com seus leitos de observação, os que compõem os módulos assistenciais, os sede de regionais e os estaduais estão permanentemente com seus leitos ocupados, com dificuldades para acomodar a demanda. Tanto para o nível de complexidade a que se destinam como para as necessidades de referência. Dada a baixa resolutividade do sistema como um todo, o fluxo de ambulâncias entre os municípios do interior e Porto Velho só tem crescido nos últimos tempos. Este fluxo tem como destino na capital o João Paulo II, Pronto Socorro Estadual com demanda muitas vezes superior à sua capacidade. Isto gera situações caóticas de atendimento, aumentando em muito o sofrimento daqueles que para lá são conduzidos. No Pronto Socorro os usuários aguardam leitos para as unidades de referência estadual: o Hospital de Base e o CEMETRON. A depender do problema, esta espera pode se prolongar por semanas, quando não por meses. Outra unidade, também de referência estadual, é o Hospital e Pronto Socorro Infantil Cosme e Damião.

Figura 2: Principais causas de mortalidade, Rondônia, 2013



Fonte: DATASUS, 2016.

É interessante observar que, ao se utilizar os parâmetros gerais para avaliar a cobertura, aparentemente os leitos são suficientes para o Estado. Isto, os números frios das estatísticas, é capaz de convencer quem não convive com a realidade crua de nosso cotidiano. E com o sofrimento e exclusão de nossa população. Em momentos cruciais da vida das pessoas, quando identificam problemas tão graves como a presença de um câncer, por exemplo, são deslocados para longe de seu ambiente e de sua família, pois não há serviços adequados e suficientes no Estado, sendo deslocados para as referências nacionais, através do TFD. Este tem sido um dos serviços muito utilizados: a transferência para outros centros, dada a incapacidade local de se organizar para atender à demanda.

É neste contexto que Rondônia deve ter as condições de saúde de sua população analisada.

A população de Rondônia está distribuída equitativamente entre os sexos, com predominância de jovens. A fatia da população compreendida após os 60 anos vem aumentando gradativamente, ano a ano. Isto é, apesar do grande potencial imigratório, sua população está envelhecendo. E, assim como em outros lugares, com sobreposição de perfis epidemiológicos que só aumentam as dificuldades de enfrentamento dos problemas pelo setor público, por um lado, e o sofrimento da população, por outro.

Estas características demográficas trazem desafios novos para o setor: as doenças crônicas não transmissíveis. Aumentaram os casos de hipertensão e de diabetes, concomitantemente com o aumento de doenças cardíacas e cérebro-vasculares. Surgem as doenças ditas enigmáticas, Parkinson e Alzheimer. Aumenta a prevalência de doenças renais, em especial as crônicas. E aumenta também, em todas as faixas de idade, a prevalência de câncer. Este quadro se torna mais grave, quando se observa que, mesmo com o envelhecimento da população, não se está livre das doenças infecciosas, dos acidentes, da violência e da gravidez na adolescência.

Exemplo marcante que se destaca é que dos 287 casos de tuberculose notificados em 2007 apenas 54,70% (157) tiveram cura e 9,76% (28) abandonaram o tratamento. Isto é, há falhas na vigilância. E, evidentemente, a organização de serviços é um fator primordial para a melhoria deste indicador. Neste tipo de problema, o impacto da atenção básica pode ser imediato. Assim como no controle adequado e prevenção das doenças diarreicas, na prevenção de óbitos por doença respiratória, no controle adequado dos portadores de diabetes e hipertensão, na implementação de programas de planejamento familiar e pré-natal adequados e no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. E em muitas outras situações.

Na observação da composição do obituário do município de Porto Velho, determinados problemas são acentuados, ao se comparar com o perfil estadual. Do total de óbitos, 46% são devidos a causas externas. E destas, 47% ocorrem por agressão e cerca de 30% por acidentes de transporte. Isto cria uma demanda por atendimentos de urgência e emergência que o município ainda não é capaz de absorver, mesmo com a implantação das Unidades de Pronto Atendimento. Isto é agravado pela demanda por terapia intensiva sem resposta adequada, pois os leitos existentes no estado são sabidamente insuficientes, forçando os profissionais neste setor a escolher, de forma cruel, quem receberá tais cuidados.

Não é possível desconsiderar os graves problemas de saúde prevalentes e a baixa capacidade de enfrentamento que os gestores municipais e estaduais têm demonstrado ao longo do tempo. Os gestores estaduais, no afã da manutenção dos poderes centralizados, alimentaram e alimentam o descompromisso dos gestores municipais com a saúde dos munícipes. Isto é, a saúde, em especial no que se refere à atenção de média e

alta complexidade, é responsabilidade do Estado, com seus hospitais, policlínicas, laboratórios e pronto-socorros, centralizados em Porto Velho, ou, no máximo, descentralizada em municípios pólos-regionais. E aos municípios cabe a baixa complexidade, com seus postos de saúde mal estruturados e mal equipados, com suas equipes de saúde da família arranjadas para atender às tais características "amazônicas". Isto é, num faz de conta sem fim, que não resolve os problemas da população e aumenta cada vez mais a insatisfação dos que trabalham ali.

Os óbitos por doenças do aparelho circulatório (40%), por neoplasias (21%), pelas doenças respiratórias (18%), pelas causas perinatais (17%), endócrinas, nutricionais e metabólicas (9%) e do aparelho digestivo (6%) são complementadas, em pleno século XXI, pelas doenças infecciosas (9%).

Se forem implementadas as ações ditas básicas, através da adequação das equipes de saúde da família, muitos problemas poderão ser evitados. Contudo, a necessidade por unidades de referência, com disponibilidade de métodos diagnósticos distintos dos básicos, ambulatórios especializados e disponibilidade para internação não desaparecerá. Pelo contrário: a melhoria da atenção básica forçosamente criará demanda ainda maior para os serviços especializados, tanto ambulatoriais como de internação.

1.2.3 Organização dos serviços de saúde em Rondônia

Nas tabelas a seguir constam o número de estabelecimentos de saúde e a quantidade de leitos, conforme a sua natureza (público ou privado).

Tabela 1: Estabelecimentos de saúde, conforme natureza, Rondônia, outubro de 2015.

Tipo de Estabelecimento	Públicos	Privados	Total
ACADEMIA DA SAÚDE	6		6
CENTRAL DE REGUALAÇÃO	5		5
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS	2		2
CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-CASF	5		5
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA	2	1	3
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	21	0	21
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE	234	6	240
CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	3	0	3
CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO	42	333	375
CONSULTORIO	7	957	964
COOPERATIVA		5	5
FARMACIA	29	98	127
HOSPITAL ESPECIALIZADO	2	6	8

HOSPITAL GERAL	33	42	75
HOSPITAL DIA		2	2
LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN	2	0	2
LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	5	0	5
POLICLINICA	6	18	24
POSTO DE SAUDE	98	2	100
PRONTO ANTEDIMENTO	4	0	4
PRONTO SOCORRO GERAL	1	0	1
SECRETARIA DE SAUDE	57	0	57
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)		3	3
UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA	16	0	16
UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA	14	251	265
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	76	0	76
UNIDADE MISTA	24	0	24
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCI	20	0	20
UNIDADE MOVEL FLUVIAL	1	0	1
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	1	5	6
TELESAÚDE	1	0	1
TOTAL	717	1729	2446

Fonte: Ministério Da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES

Tabela 2: Leitos distribuídos segundo natureza, Rondônia, outubro de 2015.

Tipo de estabelecimento	Públicos	Privados	Total
Clinica especializada/ ambulatorio especializado	-	36	36
Hospital especializado	219	85	304
Hospital geral	2164	1172	3336
Hospital dia	0	31	31
Pronto socorro geral	82	0	82
Unidade mista	491	0	491
Total	2956	1324	4280

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

1.2.4 Distribuição dos médicos em Rondônia

Há, no estado, 2515 médicos com registro profissional ativo, o que corresponde a 1,4 médicos por mil habitantes, ocupando a 10ª posição entre os estados brasileiros (CFM, 2016). Ressalte-se que, ao iniciar o curso em 2002, a relação era de 1 : 2.043 habitantes, sendo Rondônia o estado com a menor densidade de médicos por habitante de toda a região Norte e do país.

Destes, nas diversas especialidades, estão cadastrados no CNES 2.176 profissionais, distribuídos nas sete regiões de saúde(Tabela 3) (DATASUS, 2016).

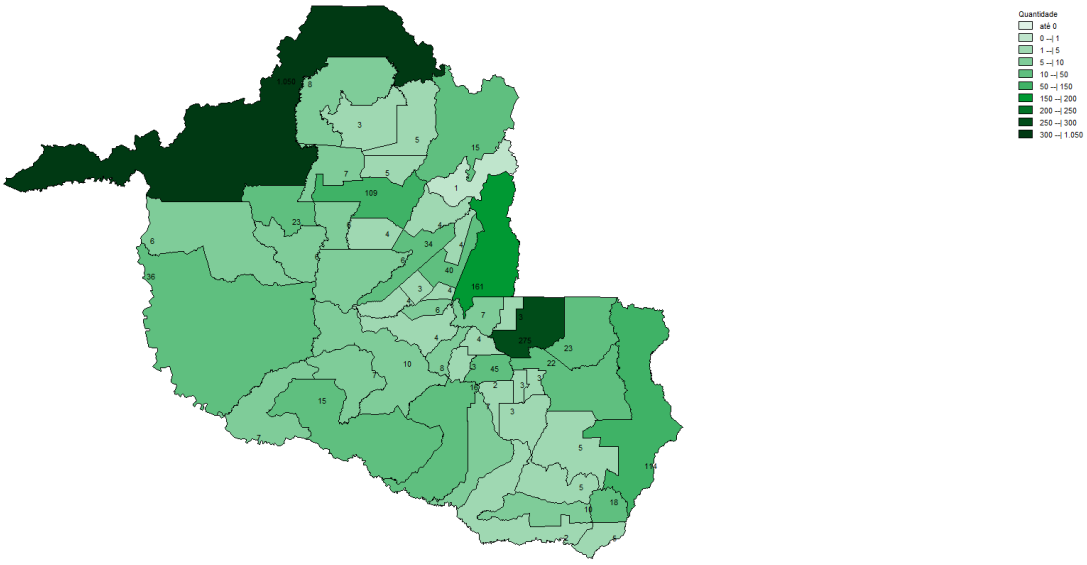
Tabela 3: Médicos conforme Região de saúde, Rondônia, março de 2016

Região de Saúde (CIR)	Quantidade
11001 Vale do Jamari	180
11002 Café	329
11003 Central	288
11004 Madeira-Mamoré	1103
11005 Zona da Mata	88
11006 Cone Sul	159
11007 Vale do Guaporé	29
Total	2176

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

A distribuição conforme municípios indica que havia, em março de 2016, uma distribuição desigual dos médicos entre os municípios. Não havia nenhum município sem médico. Apenas um (Vale do Anari) possuía somente um profissional. Observe-se, na figura 3, a distribuição dos médicos nos municípios do Estado.

Figura 3: Distribuição dos médicos por município, Rondônia, 2016.



Na tabela 4 constata-se que a maior parte dos municípios possui entre 1 e 10 médicos (34 municípios). Apenas quatro municípios têm mais de 100 profissionais

(Ariquemes, Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal) e a maior parte (quase a metade) está em Porto Velho, a capital.

Tabela 4: Municípios conforme o número de médicos, Rondônia, 2016

Número de Médicos	Número de municípios	%
00|-- 005	17	32,7
05|-- 010	17	32,7
10|-- 020	6	11,5
20|-- 050	7	13,5
50|-- 100	0	0,0
100|--300	4	7,7
1050	1	1,9
	52	100,0

Os programas de provimento de profissionais médicos para o país, o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) e o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) tiveram a adesão, em Rondônia de praticamente todos os municípios. Em agosto de 2016, havia 286 médicos do PMMB em 49 dos 52 municípios. Destes, 63 tinham registro no Conselho Regional de Medicina, 210 eram intercambistas cooperados (Cubanos) e outros 13 eram intercambistas individuais (médicos estrangeiros sem registro no Conselho Regional de Medicina). Outros 11 médicos participam do PROVAB, em 10 municípios do Estado.

1.2.5 O curso de Medicina da UNIR

O curso de graduação em Medicina da UNIR teve a sua implantação aprovada pelo CONSUN em 31 de julho de 1997, através da Resolução nº 24/CONSUN/1997. Após articulações com várias instituições, em especial com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, o projeto foi encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho Nacional de Educação. Em ambos foi aprovado, após visita técnica da Comissão de Especialistas em Medicina e do Conselheiro do Conselho Nacional de Educação, o Dr. Efrem Maranhão. A Resolução do CNE autorizou a implantação do curso com 80 vagas anuais, embora o projeto apresentado previsse 40

vagas. O Parecer foi aprovado pelo CNE e homologado pelo Ministro da Educação, publicado no DOU de 18/01/2002.

Após a realização do vestibular, a aula inaugural foi realizada no dia 16 de setembro de 2002 a aula inaugural, coincidindo com a seção solene do CONSEA para concessão do título de Professor Emérito da UNIR ao Professor Dr. Luís Hildebrando Pereira da Silva. A primeira turma colou grau no dia 9 de dezembro de 2008. Até o momento, formamos 9 turmas, com 360 profissionais no total. Destes, a grande maioria seguiu sua formação profissional, cursando residências e especializações nas diversas áreas da medicina e em diferentes instituições do país. Boa parte permanece na região, atuando nas várias especialidades médicas, com foco especial no Sistema Único de Saúde.

Desde a sua implantação, alguns ajustes na matriz curricular foram realizadas, mas nada que alterasse de forma substancial o projeto inicial, que teve como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Medicina de 2001. Estas alterações consistiram de mudanças de períodos de ofertas de disciplinas, criação de novas disciplinas optativas e outros ajustes. O curso foi reconhecido pela Portaria 141/SESU, de 30/01/2009 e tem sido avaliado através do ENADE, tendo obtido nota 4 em 2010 e 2013.

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. Objetivos do Curso

Os principais objetivos da alteração do PPC da Medicina são:

a) Atender às DCN emitidas em 2014, conforme legislação específica;

b) Integração entre o ciclo básico e o profissionalizante;

c) Inserção precoce do estudante na comunidade e no sistema público de saúde;

d) Processo de ensino aprendizado focado nos problemas e afecções mais comuns identificadas nos níveis de atenção primária e secundária do Sistema Único de Saúde e tendo como eixo integrador do processo de ensino-aprendizado a medicina de família e comunidade.

2.1.1 Objetivo Geral

O curso de Medicina da UNIR objetiva contribuir com a melhoria dos indicadores de saúde da Amazônia Ocidental, em especial diante da formação de médicos com o perfil profissional definido nas DCN, além de atender às especificidades e demandas regionais, visando impactar positivamente nas atividades de saúde desenvolvidas, dadas as atividades integradoras de formação, desencadeadas pela inserção da comunidade acadêmica na rede assistencial do SUS. Explicitamente, objetiva-se formar o médico com base generalista do conhecimento científico, humanista, crítica e reflexiva, habilitado e treinado para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde com ações voltadas para a promoção, prevenção, recuperação e habilitação da saúde nos âmbito individual e coletivos pautado na responsabilidade social e comprometido com a qualidade de vida e dignidade do cidadão.

2.1.2 Objetivos Específicos

O curso tem como objetivos específicos a formação de médicos capazes de:

- Exercer a Medicina com postura ética e humanística em relação ao paciente, à família e à comunidade, observando os aspectos sociais, culturais, psicológicos e econômicos relevantes do contexto, baseados nos princípios bioéticos.
- Exercer a Medicina com uso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos validados cientificamente, estando apto a participar efetivamente das transformações sociais da região.
- Ter domínio dos conhecimentos de fisiopatologia, procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à prevenção, tratamento e reabilitação das doenças de maior prevalência epidemiológica regional e aspectos da saúde ao longo dos ciclos biológicos.
- Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza biopsicossocial subjacentes à prática médica.
- Utilizar recursos semiológicos e terapêuticos contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção.
- Dominar as técnicas da leitura crítica, indispensáveis frente à sobrecarga de informações e da transitoriedade de conhecimentos.

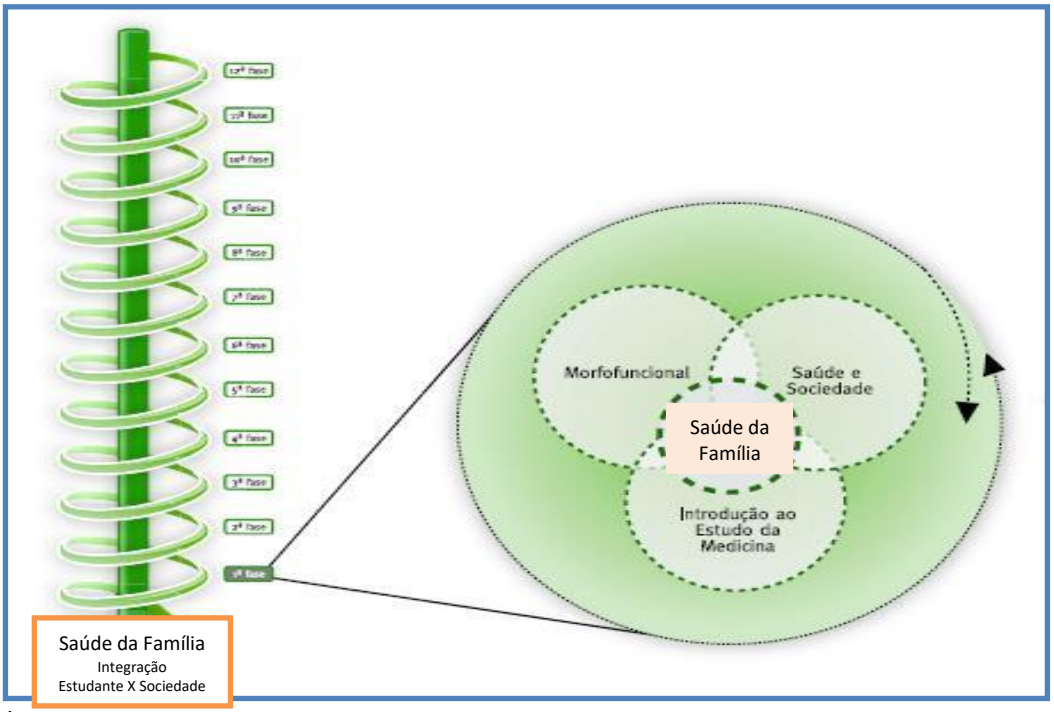
- Utilizar procedimentos semiológicos e terapêuticos com base em critérios de indicação e contra-indicação, limitações, riscos, confiabilidade e sua validação científica.
- Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde, em obediência aos princípios técnicos e éticos da equidade e universalidade da atenção à saúde, valorizando o sistema de referência e contra-referência, através do fortalecimento da atenção primária à saúde
- Saber atuar em equipe multiprofissional, assumindo, quando necessário, o papel de responsável técnico, relacionando-se com os demais membros em bases éticas.
- Ter uma visão social do papel do médico e disposição para engajar-se em atividades de política e de planejamento em saúde.
- Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas adequadas de comunicação.
- Conhecer as principais características do mercado de trabalho no qual deverá se inserir, procurando atuar dentro dos padrões locais, buscando o seu aperfeiçoamento, considerando a política de saúde vigente.
- Utilizar e administrar recursos financeiros e materiais, observando a efetividade, visando à equidade e a melhoria do sistema de saúde, com base em conhecimentos validados cientificamente.

2.2 Concepção do Curso

2.2.1 Premissas da concepção curricular

O currículo, desde o projeto apresentado em 2002, está organizado em módulos que abordam áreas específicas do conhecimento, chamadas “disciplinas” dos módulos (Organograma 1). Em linhas gerais, esta organização modular está mantida, demandando algumas alterações apresentadas esquematicamente no Organograma 2. A concepção do novo currículo, com as consequentes adaptações às DCN de 2014, está representada esquematicamente na Figura 4. Uma espiral, demonstrando um fluxo contínuo ascendente e descendente e a integração entre os módulos de organização nas fases e entre os módulos é a representação esquemática do currículo, que tem como eixo integrador a Saúde da Família, havendo em todas as fases o módulo de atividades de Saúde da Família e possibilidades de atividades complementares (Figura 4).

Figura 4: Representação esquemática da estrutura curricular*



*Destaque para os conteúdos programáticos da 1ª fase.

Organograma 1 - Organização modular do currículo do curso de Medicina (2002)

ANO	SAÚDE E SOCIEDADE	BASES MORFOLÓGICAS, CELULAR E MOLECULAR	INTRODUÇÃO À PRÁTICA MÉDICA
1	Antropologia Médica Bioética Sociologia Metodologia Científica Estatísticas de Saúde Língua Portuguesa Filosofia	Anatomia Histologia/Embriologia Citologia e Biologia Molecular Genética Bioquímica	Introdução à atenção básica Psicologia médica
2	Saúde Coletiva I Epidemiologia I	Fisiologia/Biofísica Microbiologia Patologia Geral Imunologia Parasitologia e Entomologia médica Farmacologia	Semiologia Introdução às doenças infecto-parasitárias Procedimentos básicos de enfermagem
	MEDICINA, SAÚDE E SOCIEDADE	FORMAÇÃO CLÍNICA	
3	Saúde Coletiva II Epidemiologia II Ética Médica e Exercício Profissional Medicina Legal Saúde do Trabalhador	Clínica Médica Clínica Cirúrgica Saúde da Mulher Saúde da Criança Métodos diagnósticos e imagenologia Patologia Sistêmica Genética Humana	
4	Medicina Preventiva Comunicação Científica Gestão dos Serviços de Saúde Informática Médica	Clínica Médica Clínica Cirúrgica Saúde da Mulher Saúde da Criança Psiquiatria Doenças Infecto-Parasitárias	
5	Internato		
6	Internato		

Organograma 2 - Organização modular do currículo do curso de Medicina (2017)

	Módulos		
Ano	SAÚDE E SOCIEDADE	MORFOFUNCIONAL	PRÁTICA MÉDICA
1	Humanidades em Medicina Introdução à pesquisa científica Bioestatística	Anatomia Embriologia Biologia celular aplicada à medicina Biofísica de sistemas Fundamentos de Bioquímica Histofisiologia dos Sistemas Imunologia Médica Microbiologia Médica Microbiologia Médica	Introdução ao SUS Introdução à Saúde Mental Introdução ao Suporte Básico de Vida Atenção Primária à Saúde
		MÓDULO INTEGRATIVO TUTORIA PRÁTICA	
	LIBRAS INGLÊS LÍNGUA PORTUGUESA	FISOLOGIA DO EXERCÍCIO TÓPICOS ESPECIAIS EM IMUNOLOGIA HOMEOSTASIA DOS FLUIDOS CORPÓREOS TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOFÍSICA	DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PARASITOLOGIA IMUNOLOGIA CLINICA AVANÇADA
2	Epidemiologia Bioética	Histofisiologia dos sistemas Bioquímica clínica Patologia Geral Imunologia Parasitologia médica Farmacologia Genética Humana	Semiologia Introdução às doenças infecto-parasitárias Semiotécnica
		MÓDULO INTEGRATIVO TUTORIA PRÁTICA	
	HISTÓRIA DA MEDICINA	Tópicos especiais em bioquímica. Tópicos especiais em biologia celular. Tópicos especiais em genética	FERRAMENTAS MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

	Módulos		
Ano	SAÚDE E SOCIEDADE	MORFOFUNCIONAL	PRÁTICA MÉDICA
3	Ética Médica e Exercício Profissional Medicina Legal Vigilância em Saúde Ações Programáticas	Farmacologia Patologia Sistêmica	Imagem Saúde do Adulto Saúde da Mulher Clínica Cirúrgica Saúde da Criança
	MÓDULO INTEGRATIVO TUTORIA PRÁTICA		
	Ciências Humanas Ciências Sociais Aplicadas Ciências da Saúde	TOPICOS EM FIS.CARDIO-VASCULAR	Semiotécnica Neurológica Métodos de diagnóstico em pneumologia e cardiologia: eletrocardiograma e provas de função respiratória
4	Gestão dos Serviços de Saúde Informática Médica Introdutório à Saúde da Família		Psiquiatria Urgência e emergência Doenças Infecto-Parasitárias Saúde do Adulto Clínica Cirúrgica Saúde da Mulher Saúde da Criança
	MÓDULO INTEGRATIVO TUTORIA PRÁTICA		
	Interconsulta psicológica Fundamentos da saúde do trabalhador Direitos humanos e medicina Responsabilidade jurídica pelo ato médico	Farmacologia Clínica	Osteometabolismo Emergências endocrinológicas. Introdução à medicina genômica. Cuidados Paliativos Acupuntura Cuidados paliativos
5	Internato	Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Medicina de Urgência e Emergência	
6	Internato	Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Optativo	

Os módulos, que abordam conhecimentos cognitivos, atitudinais e procedimentais, se constituem nos fundamentos para a graduação do profissional médico que está voltado para as necessidades de saúde da população e do Sistema Único de Saúde e visa à integralidade da assistência à saúde. As atividades complementares e de extensão permitem ainda que o acadêmico também se dedique às áreas específicas do conhecimento, de acordo com suas preferências e aptidões.

O currículo compreende, nesta reformulação, a três módulos por semestre:

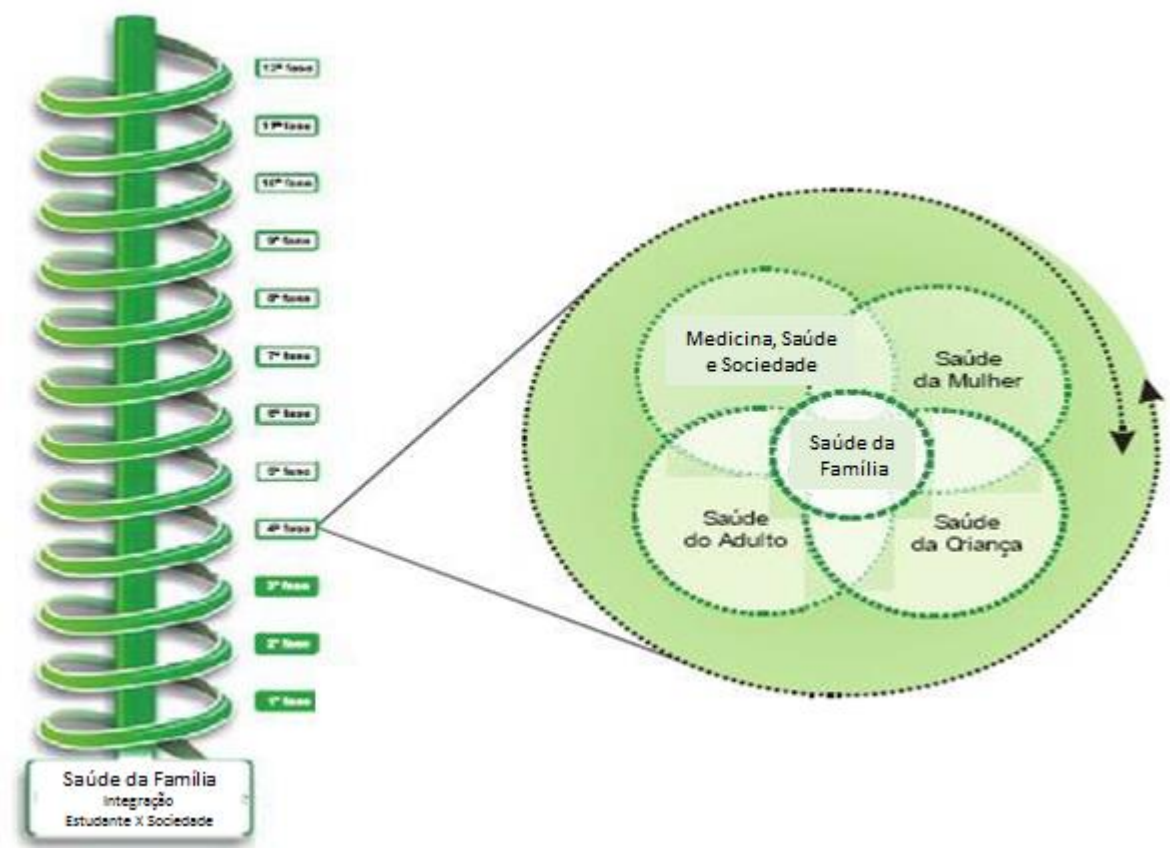
- Saúde e Sociedade
- Morfofuncional
- Prática Médica

Estes módulos têm o objetivo de iniciar a apreensão de conhecimentos relativos aos aspectos morfofuncionais do ser humano saudável e suas inter-relações com a família, comunidade e ambiente de trabalho. Nesse momento o acadêmico é inserido no ambiente universitário e nas unidades de saúde do SUS, com as quais a UNIR possui termos de cooperação, através de convênios ou de outros instrumentos jurídicos previstos na legislação. Esta inserção é importante para que o estudante possa conhecer, relacionar-se e interagir com as pessoas, com os aparelhos comunitários e com os diferentes cenários de práticas, que têm papel importante e ativo na construção do conhecimento.

Após a fundamentação teórica dos aspectos morfofuncionais, bioquímicos, patologia geral, introdução do estudo do processo saúde-doença e epidemiologia, inicia-se então o estudo do processo de adoecer do ser humano, com os mesmos módulos. Pretende-se que sejam observados aspectos integrativos e complementares das áreas do conhecimento. A construção do currículo segue uma espiral ascendente de complexidade dos níveis de atenção, procurando estabelecer uma imagem espelho entre os conhecimentos apreendidos e sua correlação com as necessidades sociais de saúde encontrados na população nos diferentes níveis de atenção. Cada módulo procura apresentar eixos integrativos do raciocínio médico, relacionado com as necessidades de saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo setor de

saúde, potencializando a abordagem construtivista sociologicamente orientada de aprendizagem, utilizando-se de uma abordagem relacional do conteúdo (Figura 5).

Figura 5: Representação esquemática da estrutura curricular*



*Destaque para os conteúdos programáticos da 4ª fase.

Em todas as fases será desenvolvido módulo integrativo entre os conteúdos daquele nível com os demais módulos. As atividades serão coordenadas por um docente a cada semestre e envolverão a participação dos demais docentes. Seminários, discussões de casos clínicos, leitura crítica da literatura, painel de leitura, workshops, entre outras estratégias, serão utilizados para atingir os objetivos propostos.

No momento do ingresso dos estudantes no curso, a cada um será designado um tutor. Este tutor acompanhará o desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante, atuando como orientador, inclusive na escolha das atividades eletivas e complementares. Cada tutor será responsável por até cinco estudantes, do início ao final do curso. Estes tutores receberão orientação psicopedagógica, em processo a ser desenvolvido integrando os demais cursos de graduação da área de saúde.

A orientação pedagógica proposta está baseada na centralização do processo de ensino-aprendizagem no estudante e nas necessidades de saúde da população. Para tanto os recursos didático-pedagógicos a serem utilizados terão como base os métodos de aprendizagem ativa e construtiva. Estes incluirão aulas práticas e teóricas, seminários multidisciplinares de integração, aprendizagem baseada em problemas, raciocínio baseado em casos e orientação construtivista sociologicamente orientada do processo de aprendizagem. Utilizar-se-á do sistema de avaliação da aprendizagem como oportunidade de avaliar e aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, a avaliação deverá permear todas as etapas do processo, ocorrendo antes (diagnóstica), durante (formativa) e no fim (somativa) de momentos determinados de ensino-aprendizagem.

Ao final do quarto ano (8ª fase), pautado em uma formação ética e humanista, o acadêmico deve ter a compreensão dos aspectos bio-psico-sociais do ser humano saudável e da integralidade do processo saúde e doença, estando apto para o Internato Médico.

O Internato Médico, com duração de 2 anos, caracteriza-se como um treinamento supervisionado em serviço, com aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Medicina de Urgência e Emergência e Medicina de Família e Comunidade, devendo incluir atividades no primeiro, segundo e terceiro nível de atenção em cada área.

Ao final do curso, baseado na proposta didático-pedagógica e fundamentado nas DCN em Medicina, o egresso deverá ter completado uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.

Busca-se uma adequação da formação profissional que se pretende oferecer às necessidades de saúde da população brasileira, integrada à Estratégia de Saúde da Família (ESF) e na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS).

A articulação entre a UNIR e o Sistema Único de Saúde já é uma realidade no curso de Medicina, com a inserção precoce do estudante na comunidade desde as primeiras

fases. A busca por expansão das atividades docentes assistenciais nas Unidades de Saúde do SUS e a construção de unidades próprias da UNIR, integradas ao SUS é o objetivo atual do Departamento de Medicina e do Núcleo de Saúde.

2.2.2 Conteúdos optativos

A cada fase serão oferecidas disciplinas optativas, das quais o estudante deverá cursar, até a oitava fase, 200 horas-aula. Estas horas deverão ser distribuídos entre os módulos dos dois primeiros anos (80) e entre os módulos do terceiro e quarto ano do curso (120). Serão considerados equivalentes aos créditos optativos disciplinas cursadas em outros cursos da UNIR ou em outras instituições, desde que autorizadas previamente pelo tutor e homologadas pelo NDE do curso de Medicina. Quando cursadas desta forma, as atividades serão aproveitadas em quatro blocos de conteúdos: ciências humanas, ciências exatas e da terra, ciências sociais aplicadas e ciências da saúde.

2.2.3 Atividades Complementares e de Extensão

Cada estudante deverá, com a anuência do tutor, completar 750 horas em atividades complementares e de extensão. Estas atividades deverão ser desenvolvidas ao longo de todo o curso e constarão da grade de aproveitamento constante do item 2.7.4. Envolvem atividades de monitoria, pesquisa, representação estudantil e extensão.

Os estudantes de medicina da UNIR deverão, para receber o diploma de graduação, ter desenvolvido todas as atividades obrigatórias, as atividades optativas e completar as horas previstas para atividades complementares e de extensão.

2.3. **Justificativa**

O curso de Medicina da UNIR foi criado com as seguintes justificativas, ainda atuais:

"A linha de atuação da UNIR, que procura refletir os anseios da comunidade, tem a área da saúde como objeto de preocupação constante, não só pelas carências regionais em termos de formação de mão-de-obra para o setor, como pela necessidade de formar quadros voltados para estudos e pesquisas no campo das doenças infecto-contagiosas e carenciais da região amazônica. Destaque-se a premente necessidade de técnicos, pesquisadores, cientistas, formados na Amazônia, com os olhos e as mãos postas nos problemas sociais e médico-sanitários da Amazônia".

"As Instituições de Ensino Superior (IES), em nosso país, passam por um momento de profunda reflexão, impondo-se discussões sobre autonomia universitária, financiamento, avaliação e articulação com outros setores da sociedade. O papel do Estado na Educação e na Saúde, bem como a função social e relevância da universidade são questões centrais destas discussões e exigem definições".

"No que se refere à formação dos profissionais da área da saúde, particularmente, há que se considerar questões específicas da área – processo acelerado de mudanças do Sistema de Saúde e respectivo financiamento, transformações no perfil epidemiológico e na composição sócio-demográfica da população e os avanços técnico-científicos que exigem da universidade novas práticas de ensino, visando a formação de um profissional capaz de buscar informação, atento às mudanças, motivado para o aprimoramento contínuo e que compreenda seu papel na sociedade".

"A saúde não é um conceito abstrato, nem um fenômeno puramente biológico. Para uma avaliação da saúde de um determinado local, há que se levar em consideração o contexto da sociedade em questão, bem como o estágio de desenvolvimento em que esta se encontra. É a resultante das formas de organização social dos meios de produção que podem ter como consequência grandes desigualdades relacionadas aos níveis de vida."

“Em seu conceito mais amplo, saúde é o produto das condições objetivas de existência, é resultante das condições de alimentação, educação, emprego, moradia, meio ambiente, trabalho, lazer, liberdade, transporte, acesso e posse da terra, bem como acesso aos serviços de saúde. Ao se falar em direito à saúde, significa dizer que o Estado tem por obrigação proporcionar condições dignas de vida, como também garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os níveis e a toda a população.

Portanto, o direito à saúde não resulta apenas de um processo setorial de formulação de políticas de saúde, mas sim de um processo integrado de todas as políticas sociais do Estado, como também do balizamento, elaboração e implementação das políticas econômicas.

Quanto à realidade brasileira, temos uma sociedade extremamente estratificada e hierarquizada, caracterizando-se pela alta concentração de renda e da propriedade fundiária, observando-se a coexistência de formas rudimentares de organização do trabalho produtivo com as mais avançadas tecnologias da economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem as condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno desenvolvimento de um nível satisfatório de saúde e de uma organização de saúde que se defronta com inúmeros problemas intrinsecamente ligados às condições de vida dos diferentes grupos sociais, refletindo as desigualdades regionais, espaciais e sociais da distribuição de renda e dos recursos públicos, traduzidas através dos indicadores de saúde.

Da mesma forma como a conceituação do que venha a ser saúde é muito complexa, pelos vários fatores intervenientes, também é complexa a definição da situação de saúde em um determinado local. Para tanto, utilizando-se de indicadores de saúde, que na verdade medem o risco do indivíduo adoecer e morrer, pode-se inferir as condições de saúde do local.”

Isto é, as justificativas apresentadas para a criação do curso ainda hoje são atuais. É necessário formar profissionais tendo como fundamento esta visão do processo saúde-doença. E com os pés e mãos calcados no Sistema Único de Saúde (SUS) e na realidade amazônica. Na perspectiva de reduzir os vazios sanitários e prover profissionais comprometidos com a nossa realidade.

A mudança do Projeto Pedagógico do Curso se justifica pela edição das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina em 2014 e diante da Lei 12.871, de 23 de outubro de 2013, conhecida como Lei do Mais Médicos. Diante dos novos dispositivos legais e como o projeto pedagógico do curso em vigor desde 2002 já contemplava as principais diretrizes apontadas nas DCN de 2014, as mudanças na estrutura curricular ocorrerão de forma harmônica com o desenvolvimento atual do curso, sem que grandes rupturas ou mudanças no andamento atual do curso ocorram. Também se justifica a alteração do número de turmas a ser ofertado, no momento em que o MEC cumprir com os acordos estabelecidos no escopo da necessidade de ampliação da formação médica no país. Isto é, quando destinar o número de professores, de técnicos de laboratório e administrativos acordados, quando concluir os repasses e a UNIR construir os espaços adequados para receber novos alunos e quando o hospital universitário estiver em construção, será possível oferecer mais uma turma, com mais 40 alunos, intercalando as entradas, passando a contar com dois ingressos anuais de 40 alunos. Neste caso, passará a oferecer para a sociedade 80 vagas anuais, com entradas no primeiro e segundo semestres.

Não é demasiado lembrar que o curso de Medicina é desenvolvido desde o seu início atendendo aos princípios fundamentais do SUS e buscando a inserção precoce dos alunos, no processo de integração ensino-serviço, nas diversas estruturas do SUS. As atividades práticas de atenção à saúde e interação com a comunidade são desenvolvidas integralmente nas unidades públicas de saúde do Estado de Rondônia, em especial no município de Porto Velho. Desde a rede básica, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, como na atenção terciária, expressa nas unidades de saúde de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.

2.4. Legislação

O PPC do curso de Medicina está baseado na Lei de Diretrizes de Bases da Educação, nos seus fundamentos gerais, nas DCN da Medicina, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministro da Educação em 2014.

Com base na autonomia didático-pedagógica conferida à Universidade pela Constituição Federal de 1988 e nas orientações emanadas pelo Ministério da Educação, o Curso é regido por bases legais, das quais são destacadas:

i) LDB a Lei nº 9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, encerrando com o currículo mínimo, e determinou as competências do que caberia ao Conselho Nacional de Educação na definição das regras para orientação dos cursos na educação superior.

ii) Resolução Nº 04 de 07 de novembro de 2001 que estabeleceu os novos fundamentos para a formação médica, baseado em competências, habilidades e atitudes; a formação generalista, a integração com o sistema de saúde e a flexibilização na formação.

iii) Decreto 5.773/2006 que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação no sistema federal de ensino.

iv) Portaria 40 de 2007/Revisada em 23/12/2010 que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições.

v) Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

vi) Lei 12.871/2014, que instituiu o Programa “Mais Médicos”.

vii) Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014 que dispõem que a formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença, destacando que a formação abrangerá a atenção em saúde, gestão em saúde e a educação em saúde e, portanto, devendo ser ancorado em metodologias ativas

que permitam a vivência da autonomia, da interdisciplinaridade, da problematização, do enfrentamento de situações reais e simuladas em cenários diversos.

viii) O Regimento do Internato, acordos e normas que regem as práticas no âmbito do Curso.

ix) Resolução 24/CONSUN/1997, que criou o curso de Medicina na UNIR.

Diante deste arcabouço legal, o curso de Medicina foi implantado na UNIR através da Resolução CONSUN nº 24/CONSUN/1997, de 31 de julho de 1997. A Resolução do CNE autorizou a implantação do curso com 80 vagas anuais, embora o projeto apresentado previsse 40 vagas. O Parecer foi aprovado pelo CNE e homologado pelo Ministro da Educação, publicado no DOU de 18/01/2002. O curso foi reconhecido pela Portaria 141/SESU, de 30/01/2009 e tem sido avaliado através do ENADE, tendo obtido nota 4 em 2010, 2013 e 2016.

A carga horária mínima estabelecida pela Resolução CNE nº 2, de 18 de junho de 2007 e pelo parágrafo único do artigo segundo das DCN é 7200 horas, com prazo mínimo de integralização em 6 anos. Considerando que na UNIR os períodos de aula têm duração de 50 minutos, esta carga horária mínima corresponde a 8640 horas/aula da UNIR. A legislação estabelece também que no mínimo 35% da carga horária total do curso deve ser desenvolvida através de estágio curricular obrigatório, denominado internato médico. E, desta carga horária, no mínimo 30% deve ser desenvolvida na Atenção Básica e na Urgência e Emergência, sendo que a maior parte deve ser realizada na Estratégia da Saúde da Família (art. 24 das DCN).

As atividades estão distribuídas entre disciplinas obrigatórias e optativas, compreendendo atividades teóricas e práticas, atividades complementares e de extensão, atividades tutoriais e integrativas. Todas serão desenvolvidas podendo utilizar também as ferramentas de educação à distância disponíveis na UNIR.

2.5. Perfil do Egresso

Em consonância com as DCN da Medicina, “o graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e

compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença." (CNE, 2014 –p. 1 artigo 3º do Capítulo I - Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, Resolução 3/2014 CNE/CES).

Como previsto no Capítulo II da citada Resolução, serão buscadas atingir, com a formação do egresso em Medicina da UNIR, as competências em **Atenção, Gestão e Educação em Saúde**. Competência,conforme definida na mesma Resolução, é "a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS)".

A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes **competências e habilidades gerais**:

Na **Atenção à Saúde**, estruturada nas subáreas atenção às necessidades individuais de saúde e atenção às necessidades de saúde coletiva, o processo de formação do graduando deverá sempre considerar as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social, no sentido de concretizar:

I. Acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as desigualdades com equidade e atendendo as necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida, observado o que determina o Sistema Único de Saúde(SUS);
II. Integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde;

III. Qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico, que conduz o seu fazer, nas melhores evidências científicas, na escuta ativa e singular de cada pessoa, família, grupos e comunidades e nas políticas públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes.

IV. Segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde, com base em reconhecimento clínico-epidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais.

V. Preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;

VI. Ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e da Bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico;

VII. Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado;

VIII. Promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde, articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;

IX. Cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-se as necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade, a compreensão destes sobre o adoecer, a identificação de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e usuários no cuidado; e

X. Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com

deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas especificidades.

Na **Gestão em Saúde**: a Graduação em Medicina visa à formação do médico capaz de compreender os princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde, e participar de ações de gerenciamento e administração para promover o bem-estar da comunidade, por meio das seguintes dimensões:

I. Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos;

II. Valorização da vida, com a abordagem dos problemas de saúde recorrentes na atenção básica, na urgência e na emergência, na promoção da saúde e na prevenção de riscos e danos, visando à melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de mortalidade, por um profissional médico generalista, propositivo e resolutivo;

III. Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa das pessoas, famílias, grupos e comunidades, das políticas públicas sociais e de saúde, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias, procedimentos, instalações, equipamentos, insumos e medicamentos, de modo a produzir melhorias no acesso e na qualidade integral à saúde da população e no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação que retroalimentam as decisões;

IV. Comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), para interação à distância e acesso a bases remotas de dados;

V. Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicar-se e desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação e diálogo, tendo em vista o bem-estar da comunidade,

VI. Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes,

estimulando e ampliando a aproximação entre instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção integral e promoção da saúde;

VII. Construção participativa do sistema de saúde, de modo a compreender o papel dos cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias do controle social na elaboração da política de saúde brasileira; e

VIII. Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para promover a integração de ações e serviços de saúde, provendo atenção contínua, integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando o sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na saúde.

Na **Educação em Saúde**: o graduando deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social, ao tempo em que se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional, objetivando:

I. Aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem, identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a curiosidade e formulando questões para a busca de respostas cientificamente consolidadas, construindo sentidos para a identidade profissional e avaliando criticamente as informações obtidas,preservando a privacidade das fontes;

II. Aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada, a partir da mediação dos professores e profissionais do Sistema Único de Saúde, desde o primeiro ano do curso;

III. Aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas do conhecimento, para a orientação da identificação e discussão dos problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e da qualidade da atenção à saúde;

IV. Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade, identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem profissional e organizacional e como suporte pedagógico;

V. Comprometer-se com seu processo de formação, envolvendo-se em ensino,

pesquisa e extensão e observando o dinamismo das mudanças sociais e científicas que afetam o cuidado e a formação dos profissionais de saúde, a partir dos processos de auto-avaliarão e de avaliação externa dos agentes e da instituição, promovendo o conhecimento sobre as escolas médicas e sobre seus egressos;

VI. Propiciar a estudantes, professores e profissionais da saúde a ampliação das oportunidades de aprendizagem, pesquisa e trabalho, por meio da participação em programas de Mobilidade Acadêmica e Formação de Redes Estudantis, viabilizando a identificação de novos desafios da área, estabelecendo compromissos de corresponsabilidade com o cuidado com a vida das pessoas, famílias, grupos e comunidades, especialmente nas situações de emergência em saúde pública, nos âmbitos nacional e internacional; e

VII. Dominar língua estrangeira, de preferência língua franca, para manter-se atualizado com os avanços da Medicina conquistados no país e fora dele, bem como para interagir com outras equipes de profissionais da saúde em outras partes do mundo e divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.

Como característica especial desejada para o médico formado pela UNIR, o mesmo deverá, além das características gerais que o habilitam a exercer a medicina no país, também desenvolver capacidades especiais para atuação quanto aos processos determinantes e junto aos portadores de doenças endêmicas prevalentes da região.

2.6 Perfil do Curso

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso

a) Nome do curso: Medicina

b) Endereço de funcionamento do curso: UNIR – BR 364 – Km 9,5 - Campus José Ribeiro Filho, Blocos 3-A, 3-B e 3-C.

c) Ato de Criação para Autorização e Reconhecimento ou Ato autorizativo anterior para renovação de Reconhecimento:

Criado através da Resolução 24/CONSUN/1997, autorizado através do Parecer 1631/2001/CNE, publicado no DOU de 18/01/2002, reconhecido pela Portaria SESU nº 141, de 30/01/2009.

d) Número de vagas pretendidas ou autorizadas:

Foram autorizadas pelo CNE 80 vagas, mas vêm sendo oferecidas 40 vagas anuais. Pretende-se, diante do cumprimento dos acordos estabelecidos com o MEC de destinação de vagas docentes, técnicos e administrativos, além de infraestrutura de salas de aula e laboratórios e início da construção do Hospital Universitário, que sejam oferecidas a partir de 2020 duas entradas, uma no primeiro e outra no segundo semestre, com 40 alunos cada.

e) Conceito Preliminar de Curso – CPC: 4

f) Turnos de funcionamento do curso: turno de funcionamento integral

g) Carga horária total do curso: 9280 horas-aula (7733 horas) mais 200 horas de atividades complementares, totalizando 7933 horas corrigidas.

h) Tempos mínimo e máximo para integralização:

Tempo mínimo: 6 anos (12 semestres) e tempo máximo: 9 anos (18 semestres)

i) Histórico do curso:

O curso de Medicina foi criado na UNIR através da Resolução 024/CONSUN/1997, após tramitação e aprovação do projeto elaborado por um grupo de docentes do antigo Departamento de Ciências Biomédicas, do Núcleo de Saúde. Este projeto seguiu para apreciação no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Educação, tendo sido reconhecida a necessidade social do mesmo pelo primeiro e aprovada a sua implantação, com 80 vagas anuais, a partir do segundo semestre de 2002. O curso teve início no dia 16 de setembro de 2002, com a aula inaugural sendo proferida

pelo Professor Luiz Hildebrando Pereira da Silva, que recebeu em seção solene do CONSEA o título de Professor Emérito da UNIR, no mesmo dia.

O Projeto de implantação do curso foi aprovado nas diversas instâncias, sendo que a matriz curricular praticada foi aprovada pelo CONSEA em 20/12/2002, através da Resolução 071/CONSEA. Com o início do curso foram desencadeadas ações pela Administração Superior da UNIR, sempre articuladas em conjunto com o NUSAU e com o Departamento de Ciências Biomédicas (posteriormente substituído pelo Departamento Acadêmico de Medicina), junto ao MEC, ao Ministério da Saúde, ao Governo do Estado e Rondônia e à Prefeitura de Porto Velho e algumas outras do interior, com o objetivo de dotar o curso dos recursos necessários para o seu desenvolvimento. Foram construídos e equipados laboratórios didáticos e salas de aula, adquirido material de consumo e bibliográfico, contratados docentes e técnicos de laboratório. Iniciativas foram desenvolvidas junto ao Governo Federal, para implementar ações através de projetos específicos junto ao PRÓ-SAÚDE e ao PET-Saúde, as quais permitiram captar recursos para aquisição de equipamentos e capacitação docente, além de apoiar o desenvolvimento de projetos de integração ensino-serviço junto ao SUS em Porto Velho. Foram obtidas bolsas para preceptores, para tutores e para estudantes que participavam dos projetos PET ao longo de vários anos. Também foram desenvolvidas ações articuladas com outros cursos de medicina de IFES que não possuem hospital próprio a bem de viabilizar recursos para assegurar a inserção dos estudantes nos campos de estágio junto à rede assistencial do SUS em Porto Velho. Estas ações redundaram em programas como o Pró-Internato, que mantiveram o pagamento de bolsas para preceptores do SUS pelo Ministério da Saúde até o início de 2016. Neste momento, este programa foi substituído pelo Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde – PRODEPS. O PRODEPS manterá o pagamento de bolsas de preceptoria na proporção de um preceptor para cada quatro alunos do internato. Além destas, a UNIR mantém o pagamento de mais 20 bolsas de preceptores, totalizando 40 bolsas. Isto é, temos assegurado um preceptor para cada dois alunos no internato, com bolsa, além dos preceptores voluntários.

Através de edital específico do NUSAU, o Departamento de Medicina divulgou e propôs o credenciamento de preceptores, além dos anteriormente credenciados. Houve a manifestação de interesse de estabelecer cooperação voluntária com a UNIR, mesmo na

ausência de pagamento de bolsa de vários profissionais. Este é um forte indício de inserção do curso e das atividades de formação de forma orgânica no SUS.

j) Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão

Fazem parte do Departamento de Medicina os centros de pesquisa: Centro de Estudos em Saúde do Índio de Rondônia, Genética Humana, Centro de Estudos em Transplantes, Centro de Biomoléculas Aplicadas à Medicina. Também há docentes do Departamento de Medicina vinculados ao Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Coletiva e ao Centro Interdepartamental de Biologia Experimental e Biotecnologia. A partir destes grupos/centros são desenvolvidos projetos de pesquisa e de extensão. Estes podem ser projetos mais amplos ou dirigidos para a formação de jovens pesquisadores, através do Programa de Iniciação Científica. Foram aprovados no Conselho de Departamento, para esta última edição do PIBIC, os seguintes projetos: aprendizado baseado em problemas na Patologia; incidência de infecções no serviço de transplante renal do Estado de Rondônia; perfil epidemiológico dos exames colpocitológicos com diagnóstico de neoplasia intra epitelial cervical e carcinoma realizados no HBAP; análise das motivações de recusa familiar em relação à doação de órgãos e tecidos nos Estados de Rondônia e Acre, Avaliação externa das equipes de saúde da família (PMAQ), As iniquidades e os determinantes sociais da saúde e da doença dos indígenas Wari' – Rondônia.

Isto é, há o desenvolvimento de pesquisa nas diversas áreas da saúde, em muitos projetos incluindo estudantes também de outros cursos de graduação. Além da pesquisa, são realizadas inúmeras atividades de extensão, sendo algumas de caráter permanente, como o Programa de Doação de Órgãos, e outros mais pontuais. Muitos projetos são de iniciativa dos estudantes, como é o caso das ligas acadêmicas, mas todos têm o acompanhamento de pelo menos um professor orientador.

Compreendendo a extensão universitária como um campo político, como um espaço relacional e plural, onde se estruturam visões, ideias, ideologias, saberes, projetos e políticas. As práticas acadêmicas tornam-se indissociáveis da realidade social, rompendo com as estruturas de pensamento predominantes passando a definir-se não apenas como terceira função, concorrente com o ensino e a pesquisa, mas, como um paradigma, um modo de ser e fazer universitários, um espaço estratégico para a

ampliação da qualidade acadêmica e do papel social da universidade, como um bem público. Desta forma, a extensão universitária está incorporada como um modo de ser e fazer, ou seja, um modo de fazer o ensino, a pesquisa e a produção cultural, numa relação dialógica, entre o saber universal e a realidade cotidiana local, fazendo com que a universidade e os demais setores da sociedade impliquem-se e fomentem-se mutuamente.

Quanto à política de ensino, são realizados estímulos para a participação docente, discente e de profissionais do serviço (preceptores) nas atividades de ensino no que concerne ao fortalecimento e disseminação da flexibilidade curricular nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; criação de espaços diversificados de formação. Tem-se na graduação e na pós-graduação práticas em laboratórios, comunidades urbanas e rurais, escolas, cooperativas, organizações não-governamentais, unidades básicas e hospitalares de saúde e centros de atenção psicossocial; desenvolvimento de práticas pedagógicas com a utilização de recursos das novas tecnologias de apoio ao ensino e à aprendizagem, com o uso de computadores, laboratório de informática, projetor multimídia, rodas de conversa, estudos de caso e simulações em laboratórios, ambientes virtuais de ensino; estímulo à mobilidade estudantil, mediante o aproveitamento da carga horária e do conhecimento adquirido com a circulação de estudantes entre cursos, programas e instituições de educação superior nacionais e estrangeiras. Além dos editais de Monitoria. Na pós-graduação são oferecidos cursos de especialização, visando desenvolver a profissão, principalmente em âmbito local.

Quanto à política de pesquisa, os docentes submetem seus projetos de pesquisa a agências de fomento e/ou ao PIBIC institucional, com o envolvimento de alunos do curso na iniciação científica.

Quanto à política de extensão: As diretrizes da UNIR visam à expansão e qualificação das ações de extensão, o fortalecimento e ampliação de interfaces com os movimentos sociais, segmentos produtivos e institucionais, a ampliação e diversificação da produção artístico-cultural, o aprimoramento de gestão e da avaliação dos projetos e a adoção de mecanismos para maior visibilidade das ações institucionais. Seguindo tais diretrizes, o Curso de Graduação em Medicina tem concorrido aos editais de extensão,

em âmbito nacional: PRO-SAÚDE/PET-SAÚDE e no Programa de Extensão Nacional (PROEXT), além das participações do Curso em ações de extensão na comunidade, dentre outras.

k) Titulação conferida aos egressos: Médico

l) Modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso:

Ingresso através do processo seletivo da Universidade, definido anualmente pelo Conselho Superior competente. Pretende-se, diante do cumprimento dos acordos estabelecidos com o MEC de destinação de vagas docentes, técnicos e administrativos, além de infraestrutura de salas de aula e laboratórios e início da construção do Hospital Universitário, que sejam oferecidas a partir de 2020 duas entradas, sendo uma no primeiro e outra no segundo semestre, com 40 alunos cada. Atualmente, o curso tem apenas uma entrada, no primeiro semestre do ano.

A UNIR oferece 40 vagas anuais para ingresso por processo seletivo regular, que usa a nota do ENEM como critério de seleção, respeitadas as cotas. As salas de aula e laboratórios foram construídas e equipadas para atender ao Projeto Pedagógico do curso. Os convênios estabelecidos com o Governo Estadual e com a Prefeitura Municipal de Porto Velho asseguram o acesso dos estudantes e dos professores às unidades necessárias para o desenvolvimento das atividades práticas desde o primeiro período. As UBS de Porto Velho foram territorializados e as áreas divididas entre as diversas instituições que oferecem cursos na área de saúde. Para os cursos da UNIR foram atribuídas (em acordo com a instituição) as unidades localizadas na zona leste da cidade, que abriga as Unidades Pedacinho de Chão, Ernandes Índio, Mariana, Socialista, Cuniã e Agenor de Carvalho, com 18 Equipes de Saúde da Família. Estas unidades recebem exclusivamente os alunos da UNIR para as atividades práticas, tanto nas disciplinas como no internato. No internato temos simultaneamente dois grupos de oito alunos, sendo um no I1 e outro no I2. As atividades do I1 são realizadas na UBS Pedacinho de chão e do I2 nas UBS Ernandes Indio, Mariana, Socialista, Agenor de Carvalho e Cuniã, com 2 e 16 equipes de ESF respectivamente e 8 preceptores cadastrados.

As atividades ambulatoriais das demais áreas são desenvolvidas no ambulatório universitário Rafael Vaz e Silva, que possui 7 consultórios. Neles são desenvolvidas as atividades ambulatoriais da clínica médica, da pediatria e da ginecologia e obstetrícia. Os alunos frequentam o Centro de Referência da Mulher, complementando as atividades ambulatoriais em ginecologia e obstetrícia. Também é utilizado o ambulatório de especialidades do estado, Policlínica Oswaldo Cruz, para complementar as atividades ambulatoriais da cirurgia, oftalmologia e algumas especialidades clínicas como endocrinologia.

Na maternidade municipal Mãe Esperança, que possui 70 leitos, os alunos desenvolvem as atividades práticas de obstetrícia e pediatria, incluídas atenção ao trabalho de parto da gestante e do recém-nascido, planejamento familiar e incentivo ao aleitamento materno, tanto nas disciplinas como no internato.

Nas unidades hospitalares do estado, são desenvolvidas todas as outras atividades. A rede hospitalar está assim organizada: Hospital de Base; 590 leitos, Hospital Pronto Socorro João Paulo II: 56 leitos, Hospital Infantil Cosme e Damião: 139 leitos e CEMETRON: 99 leitos, além dos 70 leitos da maternidade municipal, totalizando 954 leitos.

Na clínica médica os alunos realizam atividades no CEMETRON (Centro de Medicina Tropical), com dois leitos por aluno, avaliando pacientes com doenças tropicais e doenças infectocontagiosas; no Hospital de Base Ary Pinheiro, com dois a seis leitos por alunos dependendo do setor, atendendo clínica médica e especialidades como cardiologia, gastroenterologia, nefrologia e hematologia; no Pronto Socorro João Paulo II os alunos estagiam na sala de emergência, com quatro leitos para cada aluno, atendendo a demanda. Os alunos da clínica médica complementam o aprendizado em urgência emergência com plantões nas UPA do município.

Na clínica cirúrgica, os alunos estagiam no Hospital de Base, com dois leitos por alunos, acompanhando os pacientes desde a avaliação pré-operatória, procedimento cirúrgico e acompanhamento pós-operatório; no Pronto Socorro João Paulo II atendendo a demanda com patologias cirúrgicas; no Hospital de Câncer de Barretos atendem as cirurgias da especialidade (dois a quatro leitos por aluno).

Na Saúde da Criança os alunos frequentam o Hospital Infantil Cosme e Damião com um a quatro leitos por aluno dependendo do setor. Atuam também no ambulatório da Policlínica Rafael Vaz e Silva.

Na Saúde da Mulher são desenvolvidas atividades ambulatoriais de Ginecologia na Policlínica Rafael Vaz e Silva e no setor de ginecologia do Hospital de Base. O treinamento em obstetrícia é feito na Maternidade Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde.

m) Regime de oferta e de matrícula: Regime semestral, com matrícula por disciplinas, acompanhando o calendário acadêmico da UNIR.

n) Calendário acadêmico (número de semanas de aula, eventos como semanas acadêmicas)

As atividades acadêmicas são desenvolvidas em 20 semanas por semestre, incluídos os períodos destinados para seminários de divulgação científica e semana acadêmica.

o) Distribuição da carga horária em componentes curriculares obrigatórios, componentes curriculares optativos e complementares de graduação:

O currículo do curso está organizado em conteúdos obrigatórios, optativos e complementares e e extensão. A carga horária total do curso é de 8680 horas/aula da UNIR, o que corresponde a 7233 horas acrescidas de 750 horas complementares, totalizando 7983 horas, pouco acima das 7200 horas, que é a carga horária mínima estabelecida na legislação.

Das 8680 horas/aula, 8480 são desenvolvidas em componentes curriculares obrigatórios, 200 em disciplinas optativas, além das 750 horas em atividades complementares e de extensão (Quadro 5).

Quadro 5: Carga horária do curso

Carga horária mínima estabelecida pela legislação	Horas relógio (60 minutos)	Horas-aula (50 minutos)
	7200	8640
Componente Curricular		
Componentes obrigatórios	7066	8480
Componentes optativos	167	200
Sub-total	7233	8680
Complementares e de extensão	750	
Total	7983	

A carga horária total do internato é de 3600 horas/aula, respeitando a determinação de no mínimo 35% da carga horária total do curso, sendo que 800 horas são desenvolvidas na atenção básica (dois estágios específicos, de 300 horas cada um e 200 horas de atividades da Saúde da Criança e da Saúde da Mulher, que são desenvolvidas na Atenção Básica) e 540 horas estágio na urgência e emergência (um módulo específico de 300 horas e 240 horas dos módulos de clínica médica e cirurgia), também conforme o que estabelecem as DCN: no mínimo 30% da carga horária total do internato deve ser desenvolvida na Atenção Básica e na Urgência e Emergência, sendo que a maior parte deve ser realizada na Estratégia da Saúde da Família (art. 24 das DCN). Como os estágios nestas áreas totalizam 1340 horas, correspondem a 37% da carga horária total do internato.

p) Descrição das formas de ingresso:

Ingresso através de processo seletivo anual (vestibular). Vagas eventualmente decorrentes de desistências ou transferências serão preenchidas através de processo seletivo específico (Vestibulinho), conforme normas de ingresso da instituição. Estas normas são utilizadas, também, para regular possíveis transferências *ex-officio*. Será aceito que até dois anos do curso sejam cursados em instituição do Sistema Federal de Ensino, conforme convênio de mobilidade acadêmica da ANDIFES. Excetua-se, para esta norma, o internato, que tem regramento próprio das próprias DCN. A UNIR autoriza que um dos módulos do segundo ano do internato (com 300 horas) seja cumprido em outra instituição com a qual haja termo de cooperação específico para este fim. Nos termos da legislação, solicitações que ultrapassem este tempo deverão ser aprovadas pelo CONSEA.

Neste caso, a instituição pode autorizar, mediante justificativa apresentada, até o limite de 30% das vagas do segundo ano do internato.

2.6.2 Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS

O curso de Medicina é desenvolvido integralmente na rede SUS. As unidades municipais (UBS, UPA, CAPS e Maternidade) e estaduais (Hospital de Base, Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital Pronto Socorro João Paulo II e Hospital Infantil Cosme e Damião) são os nossos campos de estágio e aulas práticas. Temos convênio entre as instituições, no qual estão estabelecidas as regras da cooperação. A integração é plena, sendo que várias atividades em conjunto são desenvolvidas. A avaliação externa do PMAQ e do PNAS são coordenadas no Estado por docentes do Departamento de Medicina. Somos a instituição supervisora dos programas de provimento do Ministério da Saúde (Mais Médicos e PROVAB) no âmbito do Estado e dos dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas, nos quais estão envolvidos mais de 300 médicos, 40 supervisores e 4 tutores acadêmicos (estes todos do Departamento de Medicina). Participamos dos programas PET e do Pró-Saúde, através do qual obtivemos recursos para ampliação e equipamento de unidades básicas do município de Porto Velho para adequação às funções de ensino. Participamos ativamente da CIES e temos representação nos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde. Além dos 39 docentes médicos que acompanham as atividades assistenciais, temos cadastrados 40 preceptores conforme a Resolução 328/CONSEA/ 2014. Além disto, participamos também do Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde – PRODEPS. Neste Programa, o MEC disponibiliza bolsas de preceptoria na proporção de um preceptor para cada quatro alunos do internato. Além destas, a UNIR mantém o pagamento de mais 20 bolsas de preceptores, totalizando 40 bolsas. Isto é, temos assegurado um preceptor para cada dois alunos no internato, com bolsa, além dos preceptores voluntários. Os preceptores cumprem os planos de trabalho junto aos internos, sendo as suas atividades acompanhadas e supervisionadas por docentes definidos no ato do credenciamento dos mesmos.

2.7 Estrutura Curricular

2.7.1 Componentes curriculares obrigatórios

O currículo está estruturado na forma de módulos, constituídos por disciplinas obrigatórias (as que todos os estudantes devem cursar e obter aprovação), os dois anos de internato, além de obrigatoriamente cursar disciplinas optativas, escolhidas entre aquelas oferecidas pela instituição e por cumprir o mínimo de 750 horas em atividades complementares e de extensão.

2.7.2 Disciplinas optativas

A seguir estão apresentadas as disciplinas optativas, entre as quais os estudantes deverão escolher, juntamente com o tutor, aquelas que complementarão sua formação. Deverá cumprir um total de 200 horas/aula de disciplinas optativas. As ementas, objetivos e bibliografia estão no apêndice

2.7.3 Relação das Disciplinas Optativas

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA	PERÍODO DE OFERTA
LÍNGUA PORTUGUESA	60	2
LIBRAS	60	1
HOMEOSTASIA DOS FLUIDOS CORPÓREOS	40	1
INGLÊS INSTRUMENTAL	60	1
CIÊNCIAS HUMANAS	60	
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	60	
CIÊNCIAS DA SAÚDE	60	
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA	60	
FERRAMENTAS MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL	40	2
TOPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA	40	2
TÓPICOS ESPECIAS EM BIOLOGIA CELULAR	40	2
TÓPICOS ESPECIAIS EM GENÉTICA	40	2
HISTÓRIA DA MEDICINA	40	3
TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOFÍSICA	40	3
FISOLOGIA DO EXERCÍCIO	40	3
TÓPICOS ESPECIAIS EM IMUNLOGIA	40	3
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PARASITOLOGIA	40	4
IMUNOLOGIA CLINICA AVANÇADA	40	4
TOPICOS EM FIS.CARDIO-VASCULAR	40	5
SEMIOTÉCNICA NEUROLÓGICA	40	5
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EM PNEUMOLOGIA E CARDIOLOGIA: ELETROCARDIOGRAMA E PROVAS DE FUNÇÃO RESPIRATÓRIA	40	6
DIREITOS HUMANOS E MEDICINA	80	6
ACUPUNTURA	60	7
FARMACOLOGIA CLÍNICA	60	7

INTERCONSULTA PSICOLÓGICA	60	7
INTRODUÇÃO À MEDICINA GENÔMICA	40	7
INTERPRETAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS EM MEDICINA INTERNA	20	7
EMERGÊNCIAS ENDOCRINOLÓGICAS	20	8
OSTEOMETABOLISMO	20	8
CUIDADOS PALIATIVOS	40	8
FUNDAMENTOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	60	8
RESPONSABILIDADE JURÍDICA PELO ATO MÉDICO	60	8

Além destas disciplinas elencadas, poderão ser criadas outras tantas quantas necessárias e que a instituição tenha capacidade de oferecer, na medida da identificação das potencialidades e necessidades de formação.

2.7.4. Atividades Complementares e de Extensão

Cada estudante deverá, com a anuência do tutor, completar 750 horas em atividades complementares e de extensão. Estas atividades deverão ser desenvolvidas ao longo dos quatro primeiros anos do curso, sendo pré-requisito para matrícula no nono semestre (internato) e constarão da seguinte grade de aproveitamento (Quadros 5 e 6):

Quadro 6: Atividades Complementares

Atividade	**Horas correspondentes**
Monitoria	100 horas por semestre certificado
Programa de Iniciação Científica	200 horas por ano certificado
Participação em entidades do movimento estudantil/representação discente	
• Presidente do DCE ou CAMUFRO	50 horas por ano certificado
• Membro de diretoria de entidade representativa dos estudantes (DENEM, DCE, CA, Atlética, outra)	20 horas por ano certificado
• Representação discente em órgãos colegiados da UNIR	20 horas por ano certificado
Estudos complementares em outros cursos de medicina, no Brasil ou no exterior	10 horas por crédito certificado
Cursos em área afim	10 horas por curso de pelo menos 40 horas

Quadro 7: Atividades de Extensão

Programas de Extensão	

• Programa de Extensão de longa duração	200 horas por ano certificado pela PROCEA
• Programa de Extensão com mais de 40 horas e menos de um ano de duração	100 horas por atividade certificada pela PROCEA
• Atividade de extensão com menos de 40 horas de duração	10 horas por atividade certificada pelo Departamento
• Programa de Educação pelo Trabalho (PET)	200 horas por ano certificado
• Ligas Acadêmicas	
• Ligas acadêmicas certificadas na UNIR	50 horas por ano, desde que com atividades mensais comprovadas
• Coordenação de liga acadêmica certificada na UNIR	100 horas por ano, desde que com atividades mensais comprovadas
• Ligas acadêmicas de outra instituição	30 horas por ano, desde que com atividades mensais comprovadas
Congressos/Seminários/Simpósios	

• Participação
  ○ Evento nacional
  ○ Regional/Estadual/Local
	
	40 horas por evento
	20 hora por evento

• Apresentação de Trabalho
  ○ Oral
  ○ Poster
	
	40 horas
	20 horas

Publicação • Artigo em revista indexada • Artigo em revista não indexada • Resumo expandido em anais	 100 horas 50 horas 50 horas
Outras atividades não previstas poderão serão avaliadas e atribuídas horas pelo NDE, com recomendação do tutor	

O acompanhamento destas atividades deverá ser feito pelos tutores. Ao final do quarto período, deverá ser entregue ao departamento relatório parcial do cumprimento destas atividades, devidamente comprovadas, para registro e acompanhamento. A validação das atividades será feita pelo tutor do estudante, após o interessado ter apresentado o requerimento (Apêndice 6), devidamente comprovado. O registro da carga horária validada será feita até o final do oitavo período, junto à DIRCA. É requisito para ingresso no internato que o estudante tenha cumprido todos os créditos obrigatórios, incluindo as disciplinas optativas e a carga horária de 750 horas em atividades complementares e de extensão.

2.7.5 Matriz Curricular

A seguir, encontra-se o detalhamento da distribuição das disciplinas obrigatórias, conforme as diversas fases e disciplinas do curso, incluída distribuição de carga horária teórica e prática, além dos pré-requisitos de cada disciplina.

	1º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
1	ANATOMIA I	90	70	160	8	
2	BIOLOGIA CELULAR APLICADA A MEDICINA	60	20	80	4	
3	INTRODUÇÃO AO SUS	30	50	80	4	
4	BIOESTATÍSTICA	40	20	60	3	
5	INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA	40	20	60	3	
6	INTRODUÇÃO AO SUPORTE BÁSICO DE VIDA	20	40	60	3	
7	EMBRIOLOGIA	40		40	2	
8	BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL	40	20	60	3	
9	INTRODUÇÃO A SAÚDE MENTAL	40		40	2	
10	MÓDULO INTEGRATIVO I		40	40	2	
11	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	400	300	700	35	

	2º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
12	ANATOMIA II	80	60	140	7	1
13	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA I	60	40	100	5	2, 1
14	ATENÇÂO PRIMÁRIA A SAÚDE	40	20	60	3	4
15	IMUNOLOGIA MÉDICA	60		60	3	2, 8
16	MICROBIOLOGIA MÉDICA	40	20	60	3	2
17	HUMANIDADES EM MEDICINA	80		80	4	
18	BIOFÍSICA DE SISTEMAS	40		40	2	
19	MÓDULO INTEGRATIVO II		40	40	2	
20	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	400	200	600	30	

	3º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
21	SEMIOTÉCNICA	20	40	60	3	12, 13
22	BIOQUÍMICA CLÍNICA	20	20	40	2	8
23	SEMIOLOGIA I	80	40	120	6	12, 13
24	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA II	80	40	120	6	12, 13
25	PARASITOLOGIA MÉDICA	60	20	80	4	15, 16

26	BIOÉTICA	40		40	2	17
27	MÓDULO INTEGRATIVO III		40	40	2	
28	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	300	220	520	26	

	4º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
29	EPIDEMIOLOGIA	80	20	100	5	3, 4
30	FARMACOLOGIA I	60	20	80	4	22, 24
31	PATOLOGIA GERAL	80	20	100	5	21, 23, 24
32	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA III	40	20	60	3	24
33	SEMILOGIA II	80	40	120	6	23
34	GENÉTICA HUMANA	60		60	3	2, 22
35	INT. DOENÇAS PARASITARIAS	70	30	100	5	23, 25
36	MÓDULO INTEGRATIVO IV		40	40	2	
37	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	470	210	680	34	

	5º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
38	FARMACOLOGIA II	40	20	60	3	30
39	PATOLOGIA SISTEMICA	100	20	120	6	31
40	ETICA MED E EXERC PROFIS	60		60	3	26
41	SAÚDE DO ADULTO I	60	20	80	4	30, 31, 33
42	BASES DA CLIN CIRURGICA	60	40	100	5	30, 31, 33
43	SAUDE DA CRIANÇA I	40	20	60	3	30, 31, 33
44	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30	10	40	2	29
45	IMAGEM	50	30	80	4	31, 33
46	MÓDULO INTEGRATIVO V		40	40	2	
47	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	440	220	660	33	

	6º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
48	AÇOES PROGRAMATICAS	40	20	60	3	44
49	MEDICINA LEGAL	40	20	60	3	33, 39
50	SAUDE DO ADULTO II	60	20	80	4	33, 39, 40
51	SAUDE DA MULHER I	80	40	120	6	33, 40
52	SAUDE DA CRIANÇA II	60	40	100	5	43
53	CLINICA CIRURGICA I	60	40	100	5	42
54	MÓDULO INTEGRATIVO VI		40	40	2	
55	TUTORIA		20	20	1	

	TOTAL DO SEMESTRE	340	240	580	29	

	7º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
56	DIP	80	20	100	5	33, 35, 38
57	SAÚDE DO ADULTO III	60	20	80	4	33, 38, 39
58	CLINICA CIRÚRGICA II	80	40	120	6	53
59	SAÚDE DA MULHER II	60	40	100	5	51
63	SAÚDE DA CRIANÇA III	60	40	100	5	52
61	GESTÃO DOS SERV DE SAUDE	60	20	80	4	48
62	MÓDULO INTEGRATIVO VII		40	40	2	
63	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL DO SEMESTRE	400	240	640	32	

	8º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
60	INTRODUTÓRIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20	20	40	2	61
64	PSIQUIATRIA	40	20	60	3	9, 33
65	SAUDE DO ADULTO IV	60	20	80	4	33, 38, 39
66	CLINICA CIRÚRGICA III	80	20	100	5	58
67	SAUDE DO ADULTO V	40	20	60	3	33, 38, 39
68	EMERGÊNCIAS CLÍNICAS	40	20	60	3	33, 38, 39
69	INFORMÁTICA MÉDICA	20	20	40	2	40
71	MÓDULO INTEGRATIVO VIII		40	40	2	
72	TUTORIA		20	20	1	
	TOTAL SEMESTRE	300	200	500	25	

73	Atividades Complementares e de Extensão (ACE)			750		

	9º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	CR	PRÉ-REQUISITO
	INTERNATO	180	720	900	45	TODAS AS ANTERIORES
74	PEDIATRIA I	30	270	300		
75	MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I	30	270	300		
76	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA I	30	270	300		
77	CLINICA MEDICA I	30	270	300		
78	CLINICA CIRURGICA I	30	270	300		
79	MEDICINA DE EMERGÊNCIA	30	270	300		

	TOTAL SEMESTRE	180	720	900	45	

	10º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOT	CR	PRÉ-REQUISITO
	INTERNATO	180	720	900	45	TODAS AS ANTERIORES
74	PEDIATRIA I	30	270	300		
75	MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I	30	270	300		
76	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA I	30	270	300		
77	CLINICA MEDICA I	30	270	300		
78	CLINICA CIRURGICA I	30	270	300		
79	MEDICINA DE EMERGÊNCIA	30	270	300		
	TOTAL SEMESTRE	180	720	900	45	

	11º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOT	CR	PRÉ-REQUISITO
	INTERNATO	180	720	900	45	TODAS AS ANTERIORES
80	PEDIATRIA II	30	270	300		74
81	MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II	30	270	300		75
82	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA II	30	270	300		76
83	CLINICA MEDICA II	30	270	300		77
84	CLINICA CIRURGICA II	30	270	300		78
85	OPCIONAL	30	270	300		74 A 78
	TOTAL SEMESTRE	180	720	900	45	

	12º PERIODO	TEÓRICA	PRÁTICA	TOT	CR	PRÉ-REQUISITO
	INTERNATO	180	720	900	45	TODAS AS ANTERIORES
80	PEDIATRIA II	30	270	300		74
81	MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II	30	270	300		75
82	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA II	30	270	300		76
83	CLINICA MEDICA II	30	270	300		77
84	CLINICA CIRURGICA II	30	270	300		78
85	OPCIONAL	30	270	300		74 A 78
	TOTAL SEMESTRE	180	720	900	45	

2.7.6 Libras

Esta disciplina, como se trata de bacharelado, é oferecida como optativa, no primeiro período do curso, com 60 horas semestrais.

2.7.7 Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Educação Inclusiva de Portadores de Autismo e Dislexia

A Educação em Direitos Humanos tem por finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, e fundamenta-se nos seguintes princípios da dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e globalidade; e sustentabilidade socioambiental, analisando a realidade criticamente, visando o enfrentamento das injustiças e desigualdades. Os conteúdos curriculares também devem possuir temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento.

Estes temas são abordados transversalmente no currículo. Sua importância perpassa o processo de formação médica, estando inserido nos diversos módulos e disciplinas do curso, em especial nas disciplinas das áreas da Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Clínica Médica e Saúde Coletiva, além da abordagem especial dada pelas disciplinas de Bioética e Ética Médica. Especificamente, temas relacionados à Educação Ambiental constam das ementas das disciplinas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde. Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena compõem os conteúdos abordados nas disciplinas de Humanidades em Medicina. Além desta abordagem, será oferecida, no sexto ou sétimo períodos do curso, como optativa, a disciplina de Direitos Humanos e Medicina, com 80 horas. Temas específicos relacionados à saúde indígena, saúde da população negra, entre outros, são abordados nas disciplinas das áreas de Saúde do Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Educação e Medicina Social, assim como educação Inclusiva da pessoa com transtornos de autismo e dislexia.

A UNIR destina 5% (cinco por cento) das vagas da ampla concorrência aos candidatos com deficiência, em conformidade com a descrição constante no Decreto nº 3.298/99, que estabelece a Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência e Decreto nº 7.612/2011 que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite.

Para concorrer à vaga de pessoa com deficiência o candidato deverá identificar essa opção no ato da inscrição para o vestibular na instituição e, no ato da matrícula,

entregar o laudo médico, emitido nos últimos doze meses, atestando o tipo, grau ou o nível da deficiência, identificando o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

A Instituição também promove o edital de bolsa monitoria especial com objetivo identificar, selecionar e conceder bolsa aos discentes de graduação dos Campi da Universidade Federal de Rondônia - UNIR conforme a necessidade solicitada e enviada a Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis PROCEA, por meio da Coordenadoria de Atenção à Pessoa com Necessidades Especiais/CAPNES, devidamente matriculados na UNIR os quais assumirão atividades de acompanhamento e auxilio didático pedagógico preferencialmente no contra turno ao que estudam, junto aos discentes com deficiência, respeitando-se as peculiaridades e necessidades de cada área de deficiência: físico-motora (D.F.), auditiva (D.A), visual (D.V) e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) com vistas a melhorar o desempenho acadêmico e prevenir a evasão e a repetência escolar.

2.7.8 Ementário das Disciplinas Obrigatórias

1º PERIODO

ANATOMIA I (160 horas/aula – 8 créditos)

EMENTA:

Estudo teórico-prático das bases da anatomia dos diversos sistemas e regiões do corpo humano, a fim de fornecer subsídios suficientes para a compreensão dos processos patológicos que acometem o homem, bem como a fundamentação anatômica necessária para a compreensão das decisões diagnósticas e terapêuticas mais comuns na prática clínica.

OBJETIVO:

Apresentar uma síntese dos temas que compõem o conteúdo programático, com ênfase nos aspectos mais importantes para a prática do médico e com a centralidade das aplicações clínicas do conhecimento anatômico como eixo que estrutura a formação do conhecimento nessa área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1 DRAKE, A.; WAYNE V. & ADAM W. M. . Gray's Anatomy for Students / Richard L. - 2nd ed - Churchill Livingstone Elsevier, 2010

2 MOORE, K. L., AGUR, A. M. R., DALLEY, A. F. Essential Clinical Anatomy/, Fourth Edition, 2013, Guanabara Koogan Edit

3 SOBOTTA - Atlas of Human Anatomy / R. Putz and R. Pabst, 14th Ed, Elsevier, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1 MOORE, KEITH L. Anatomia orientada para a clínica. 7a edição. Ed Guanabara Koogan, 2014

2 NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

3 GOLDBERG, Stephen. Descomplicando... anatomia clínica: ed. Artes Médicas, 1993.

4 SPENCE, Alexander P., 1929-. Anatomia humana básica: . 2 ed. Manole, 1991.

5 ABRAHAMS, Peter H.. Atlas colorido de anatomia humana: . 7 ed. Elsevier, 2014.

BIOLOGIA CELULAR APLICADA A MEDICINA (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Aspectos estruturais e funcionais das moléculas. Membrana celular e suas especializações. Morfologia e função dos compartimentos intracelulares. Produção celular de energia. Tráfego intracelular e endereçamento de moléculas. Métodos para a evidenciação de estruturas e moléculas celulares específicas. Práticas educativas usando microscópio de luz, lâminas histológicas e microfotografias. Diagnóstico de células e tecidos em secções histológicas e microfotografias. Integração dos conhecimentos de biologia celular e suas possíveis correlações clínicas.

OBJETIVO:

Possibilitar ao estudante de Medicina, a compreensão da forma e função da célula, em condições de normalidade e desenvolver habilidades de manuseio adequado de microscópio de luz, diagnóstico de células e tecidos em secções histológicas e microfotografias de amostras de tecidos de saudáveis, relacionar estrutura e função de células e tecidos especializados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BRUCE ALBERTS; DENNIS BRAY; KAREN HOPKIN; ALEXANDER JOHNSON; JULIAN LEWIS; MARTIN RAFF; KEITH ROBERTS; PETER WALTER. **Fundamentos da Biologia Celular.** 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2017.
2. Bruce Alberts; Alexander Johnson; Julian Lewis; David Morgan; Martin Raff; Ketih Roberts; Peter Walter; John Wilson; Tim Hunt. **Biologia molecular da célula**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
3. DE ROBERTIS, E.M.; HIB, J. Biologia Celular e Molecular.16. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. JAMES D. WATSON; TANIA A. BAKER; STEPHEN P. BELL; ALEXANDER GANN; MICHAEL LEVINE; RICHARD LOSICK. **Biologia molecular do gene.** 7ª EDIÇÃO. Porto Alegre: Artmed, 2015.
2. KIERSZENBAUM, Abraham L. **Histologia e Biologia Celular - Uma Introdução a**

Patologia. 4ª EDIÇÃO. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

3. ALBERTS, Bruce. Biologia Molecular da Celula: . 5 ed. Artmed, 2010.
4. JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa; CARNEIRO, Sylvio Mário Puga. Biologia celular e molecular: . 8 ed. Guanabara Koogan, 2011.
5. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. **Imunologia celular e molecular**: . 6 ed. Elsevier, c2008.

INTRODUÇÃO AO SUS (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Essa disciplina tem por finalidade proporcionar ao aluno uma visão política e administrativa da rede de serviços de saúde e preparar o aluno para seu primeiro contato com o usuário e a equipe de saúde.

OBJETIVO:

Conhecer o Sistema Único de Saúde – SUS, os marcos históricos, legais e princípios que o orientam até a atualidade e sua organização como um todo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PINHEIRO, Roseni; MATTOS, R. A de. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: UERJ. IMS: Abrasco, 2003, 228 p.
2. POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Organização Pan-Americana de Saúde, Universidade Federal Fluminense, Fundação Euclides Cunha. Roteiro e Direção: Renato Tapajós. Vídeo sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil. Tapiri Cinematográfica Ltda., Kinostudio Cinema Digital, 2006. Duração 60 minutos.
3. GONDIM, Roberta. Unidade I – Fundamentos do Sistema Único de saúde. IN: Qualificação de gestores do SUS. / organizado por Roberta Gondim, Victor Grabois e Walter Mendes – 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: EAD/Ensp, 2011. 480 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. VIANA, Lucila Amaral. Processo Saúde – Doença. Especialização em saúde da Família. UNA-SUS/UNIFESP. Disponível em: http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_6.pdf Acesso em: 10/07/2014.

2. BATISTELLA, Carlos. Cap. 1 Saúde, Doença e Cuidado: complexidade teórica e necessidade histórica. IN:
3. O território e o processo saúde-doença. Angélica Ferreira (Org.). Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.
4. FARIA, Horácio Pereira de et al. Seção I - Modelo assistencial em saúde. IN: Modelo assistencial e atenção básica à saúde 2. ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed, 2010. Disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/92 Acesso em: 06/04/2014
5. PAIM, J. S. 20 Anos de Construção do Sistema Único De Saúde. Tempus - Actas de Saúde Coletiva, v.2 n.1, p.63-86, jul./dez. 2008.

Periódicos:

Cadernos de Saúde Pública, Revista de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva

Legislação:

BRASIL. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/9/1990, Página 18055. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-norma-pl.html. Acesso em: 28 jan. 2013.

BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm Acesso em: 28 jan. 2013.

BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

BIOESTATÍSTICA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Apresentar uma visão geral de aplicação das técnicas estatísticas em estudos dos fenômenos relativos ás ciências da vida. Ênfase é dada ao conjunto de métodos e técnicas quantitativas que auxiliam a organizar, descrever, analisar e interpretar os fenômenos

coletivos.

OBJETIVOS: Familiarizar os alunos com um determinado tipo de vocabulário e linguagem próprios da Estatística, muito necessários para a compreensão da leitura de artigos científicos. Proporcionar a aprendizagem de variados conceitos, teorias e métodos estatísticos, sensibilizando-os para a sua futura utilidade a quando da realização dos seus próprios estudos experimentais. Introduzir os alunos na utilização de programa de tratamento de dados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Soares, J. F.; Siqueira, A. L.. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2002.
2. Vieira, S. Introdução à Bioestatística. 5 ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2016
3. Glantz, S. A. Princípios de Bioestatística. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Callegari-Jacques, Sídia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003.
2. Pagano, Marcelo; Gauvreau, Kimberlee.Traduzido por Luiz Sérgio de Castro Paiva. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learnig, 2004.
3. Paiva. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learnig, 2004.
4. Zar, Jerrold H. Biostatistical analysis. 3. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
5. Barbeta, Pedro Alberto. Estatística aplicada à ciências sociais. 4. ed. Forianópolis: Ed. Da UFSC, 2001.

INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

O método científico, a pesquisa científica e a organização dos trabalhos científicos.

OBJETIVOS:

Ensinar as bases do conhecimento e do método científico para a produção da pesquisa científica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 5. ed. São Paulo, Atlas, 2001.
2. CRUZ, Carla & RIBEIRO, Uirá. Metodologia científica – teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2003.
3. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes universitários. 12. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
2. KAUARK, Fabiana. Metodologia da Pesquisa: guia prático / Fabiana Kauark, Fernanda Castro Manhães e Carlos Henrique Medeiros. – Itabuna : Via Litterarum, 2010. 88p.
3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991.
4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual operacional para comitês de ética em pesquisa. Série CNS – Cadernos técnicos. Série A. Normas e manuais técnicos. n. 133. Brasília/DF, 2002.
5. PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento científico – do planejamento aos textos, da escola à academia. 3. ed. São Paulo: Respel, 2007.

INTRODUÇÃO AO SUPORTE BÁSICO DE VIDA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Primeiros cuidados a pacientes em situações de urgência e emergência - Introdução às técnicas de suporte básico de vida e técnicas de habilidades de comunicação no atendimento de paciente gravemente enfermo. Treinamento do ensino à distância e Laboratório de Habilidades do curso de Medicina da UNIR.

OBJETIVOS:

Introduzir aspectos de identificação e intervenção junto a pacientes graves, incluindo o desenvolvimento de habilidades de comunicação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GONZALVES, M.M.; TIMERMAN S.; GIANOTTO-OLIVEIRA R.; POLASTRI T.F.; CANESIN M.F.; LAGE S.G.; et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2013; 101(2Supl.3):1-221.
2. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. PHTLS: atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 8. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, c2017.
3. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MARTINS, Herlon Saraiva, Pronto Socorro – Medicina de Emergência. Ed:2012, São Paulo.
2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Básico de Vida – Manual do Aluno. São Paulo: 2015
3. KLEINMAN, M.E., et al. 2017 American Heart Association Focused Update on Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 2018
4. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. International first aid and resuscitation guidelines 2016. Genebra, 2016.
5. GUIMARÃES, H. P. et al. Tratado de Medicina de Urgência e Emergência – Pronto Socorro e UTI. Atheneu. São Paulo, 2010..

Periódicos:

- New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org

- JAMA: https://jamanetwork.com/journals/jama

- Critical Care Medicine: https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx

- **Circulation**: http://circ.ahajournals.org/

EMBRIOLOGIA (40 horas-aula - 2 créditos)

EMENTA:

Compreender os aspectos fundamentais do desenvolvimento do embrião e de seus anexos embrionários: da formação dos gametas à morfologia externa do embrião e aspectos da organogênese dos principais sistemas que compõem o organismo humano. A disciplina aborda os processos relacionados a ontogenia humana, a partir de uma única célula, descrevendo os principais eventos da anatomia do desenvolvimento desde o período preconcepção até a nona semana do desenvolvimento com um enfoque voltado as ciências médicas. O conteúdo abordará aspectos básicos da Embriologia. Conceitos gerais do processo ontogenético pré-natal; Gametogênese, fertilização, clivagem e blastulação; Implantação e formação da placenta; Gastrulação e Neurulação; Dobramentos do embrião e Anomalias congênitas.

OBJETIVOS:

A disciplina de Embriologia tem como OBJETIVO geral o de oportunizar aos discentes uma visão holística, dinâmica e contextualizada da atual situação do desenvolvimento científico e tecnológico referente aos conhecimentos da anatomia do desenvolvimento do organismo humano com ênfase as ciências médicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PEREIRA L.A.V.; JUSTINO, M.L.; MORAES, S.G. **Embriologia Humana integrada**: animações e casos clínicos. Campinas, SP: Cedet; 2014. Disponível em: http://www.embriologiahumana.com.br
2. MOORE K L., PERSAUD T.V.N. **Embriologia Clínica**. 10ª Edição. Elsevier, 2016. 560p
3. NETTER, Frank H. COCHARD, Larry R. Atlas de Embriologia Humana - 1ª EDIÇÃO. Elsevier, 2014. 288p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MOORE, K. **EMBRIOLOGIA BÁSICA**. 8ª EDIÇÃO. ELSEVIER, 2013. 376P.
2. GARCIA, S. M. L.; FERNÁNDEZ, C. G. **Embriologia**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 668p.
3. CARLSON, Bruce M.. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Guanabara Koogan, 2016
4. JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; ZAGO, Douglas. **Fundamentos de embriologia humana**: . ed. Guanabara Koogan, 2012
5. SADLER, T. W.. **Langman embriologia médica**: . 9 ed. Guanabara Koogan, 2005

BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Tópicos relevantes da estrutura e da função de moléculas biológicas em metabolismo geral. Identificação e relacionamento da estrutura das moléculas com sua função biológica. Determinação dos princípios gerais de regulação de vias metabólicas e as principais interações entre as distintas vias. Introduzir discussões acerca de tópicos complementares referentes a assuntos que estejam relacionados com o conteúdo programático proposto.

OBJETIVOS:

Contribuir para a formação do aluno do curso de Medicina, mostrando a importância das macromoléculas no comportamento bioquímico das células e de seus elementos, órgãos e tecidos, com o intuito de facilitar a compreensão dos principais eventos bioquímicos realizados *in vivo e in vitro,* embasados no conhecimento das diversas substâncias componentes das biomoléculas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CAMPBELL, M. K.; FARREL, S.O. – Bioquímica, 2007
2. LAGUNA et al.: Bioquímica de Laguna, 6a ed., 2012

3. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. – Bioquímica Básica, 3a ed., 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MURRAY, R. K. e outros: “Harper – Bioquímica”, 29a ed., 2013
2. NELSON, D. L.; COX, M. M.: Lehninger – Princípios de Bioquímica, 6a ed., 2014
3. VOET, D.; VOET, J. G. – Bioquímica, 4a ed., 2013
4. MORAN, L. A. et al. Bioquímica, 5a ed.,2013
5. CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.. **Bioquímica ilustrada**. 2 ed. Artmed, 2002.

INTRODUÇÃO A SAÚDE MENTAL (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

A história da loucura. A saúde mental nos níveis de prevenção e áreas de atuação. Características, atribuições e serviços de assistência. Proteção ao paciente e a equipe. Políticas de assistência ao doente mental e de reintegração à família e à sociedade.

OBJETIVO:

Compreender o processo de saúde doença mental; discutir a transdisciplinaridade e suas implicações à saúde mental; apresentar as diversas formas de reabilitação psicossocial; discutir os instrumentos e dispositivos de cuidado em saúde mental; refletir sobre o sofrimento psíquico como fenômeno inerente à condição humana.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007.
2. BALLARIN, M.L.G.S., CARVALHO, F.B., FERIGATO, S.L. Os diferentes sentidos do cuidado: considerações sobre a atenção em saúde mental. *O Mundo da Saúde*, São Paulo: 2010; 34(4):444- 450. observasmjc.uff.br/psm/uploads/SntidosdocuidadoemSaudEMENTAl.pdf.
3. BORBA, L.O., PAES, M. R., GUIMARÃES, A. et al. A família e o portador de transtorno mental: dinâmica e sua relação familiar, *RevEscEnferm*USP 2011;

45(2):442-9. www.ee.usp.br/reeusp/

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria nº 3.088*, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAMPOS, Rosana. *Psicanálise e saúde coletiva*. 2ª edição. São Paulo: Hucitec, 2014.
2. CZERESNIA, Dina. *Os sentidos da saúde e da doença*. Rio de Janeiro: Editora da Fiocruz, 2013.
3. FOUCAULT, M. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 2008.
4. LOBOSQUE, Ana M.; SILVA, Celso. (Org.). *Saúde Mental* – Marcos Conceituais e Campos de Prática. Belo Horizonte: CRP 04, 2013.
5. MACHADO, A. L.;COLVERO, L. de A.;RODOLPHO, J. (org.). *Saúde Mental: Cuidados e Subjetividade*. São Paulo:Saraiva, 2016**.**

MÓDULO INTEGRATIVO I (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

2º PERIODO

ANATOMIA II (140 horas-aula – 7 créditos)

EMENTA:

Estudo teórico-prático das bases da anatomia dos diversos sistemas e regiões do corpo

humano, a fim de fornecer subsídios suficientes para a compreensão dos processos patológicos que acometem o homem, bem como a fundamentação anatômica necessária para a compreensão das decisões diagnósticas e terapêuticas mais comuns na prática clínica.

OBJETIVOS:

Apresentar uma síntese dos temas que compõem o conteúdo programático, com ênfase nos aspectos mais importantes para a prática do médico e com a centralidade das aplicações clínicas do conhecimento anatômico como eixo que estrutura a formação do conhecimento nessa área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DRAKE, A.; WAYNE V. & ADAM W. M. . Gray's Anatomy for Students / Richard L. - 2nd ed - Churchill Livingstone Elsevier, 2010
2. MOORE, K. L., AGUR, A. M. R., DALLEY, A. F. Essential Clinical Anatomy/, Fourth Edition, 2013, Guanabara Koogan Edit
3. SOBOTTA - Atlas of Human Anatomy / R. Putz and R. Pabst, 14th Ed, Elsevier, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1 MOORE, KEITH L. Anatomia orientada para a clínica. 7a edição. Ed Guanabara Koogan, 2014
2 NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
3 GOLDBERG, Stephen. Descomplicando... anatomia clínica: . ed. Artes Médicas, 1993.
4 SPENCE, Alexander P., 1929-. Anatomia humana básica: . 2 ed. Manole, 1991.
5 ABRAHAMS, Peter H.. Atlas colorido de anatomia humana: . 7 ed. Elsevier, 2014.

HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA I (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Estudo da Histologia e Fisiologia Humana do Sistema Endócrino e Nervoso, dando ao aluno do curso de Medicina a visão de funcionamento e comunicação do organismo como um todo. Serão abordados conceitos de homeostase, controle e as integrações das principais funções, correlacionando a fisiologia com a patologia.

OBJETIVOS:

Contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de aplicar as informações teóricas de modo a observar os mecanismos envolvidos nos processos fisiológicos neural e endócrino, e relacioná-los com os fatores interligados, permitindo concluir quais as causas e consequências dos mecanismos que mantém a normalidade das funções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVERTHORN, D. U. *Fisiologia Humana - uma abordagem integrada*, 5a ed., Ed. Artmed, RS. ISBN 9788536322841, 2010) .

HALL, J. E. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica*, 12a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN: 978-85-352-3735-1, 2011.

FOX, S. I. - Human Physiology 12th ed., Mac Graw Hill (2011).

JUNQUEIRA E CARNEIRO Tratado de Histologia - - Editora Guanabara Koogan - décima segunda edição, 2013.

DI FIORE-PIEZZI. Novo Atlas de Histologia Normal de Di Fiore. Editora Guanabara Koogan, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COSTANZO, L. S. *Fisiologia*, 4a ed., Ed., Elsevier, Rio de Janeiro. ISBN-10:85-352-3894-8, 2011.

BERNE, R. M., LEVY, M. N., KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. *Fisiologia*, 6a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN-10: 9788535230574. 2009.

Stevens, Alan & Romrell, L.J.; Histologia Humana – Editora Manole. 7ª edição São Paulo 2001

Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Esta disciplina tem por finalidade a compreensão sobre a rede básica de serviços de saúde, desenvolvendo ações junto aos programas implantados através de acompanhamentos e visitas domiciliares, e realização de investigações sobre a problemática de saúde da área de abrangência da unidade de referência.

OBJETIVOS:

Conhecer o campo teórico da Atenção Primária no Brasil, os marcos legais e diretrizes que a amparam até a atualidade e sua organização como um todo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. PORTARIA MS/GM Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html. Acesso em: 28 jan. 2013.

COSTA, Elisa Maria A. da C; CARBONE, Maria Herminda (Orgs.). Saúde da Família: uma abordagem multidisciplinar. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2009.

VASCONCELOS, E. M.; CRUZ, P. J. S. C. Educação popular na formação universitária:

reflexões com base em uma experiência / Eymard Mourão Vasconcelos, Pedro José Santos Carneiro Cruz, organizadores.- São Paulo: Hucitec; João Pessoa: Editora Universitária da UFPB; 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_popular_formacao_universitaria.pdf Acesso em: 25/01/2015

MELLO, D. F. de et al. Genograma e Ecomapa: possibilidades de utilização na estratégia de saúde da família. Revista Brasileira Crescimento e Desenvolvimento Humano. 2005;15(1):79-89. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/jhgd/article/download/19751/21816 Acesso em 23/07/2014.

STARFIELD, B. Atenção Primária – Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO/MS, 2002. Disponível online no Ministério da Saúde.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALFRADIQUE, M.E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP – Brasil). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25 (6):1337-1349, jun, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n6/16.pdf Acesso em: 03/02/2016

FARIA, H. P. et al. Modelo assistencial e atenção básica à saúde. 2. ed. --Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed, 2010.

FONSECA, Angélica Ferreira (Org.) O território e o processo saúde-doença. / Organizado por Angélica Ferreira Fonseca e Ana Maria D'Andrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

MARTINS, Carla M.; STAUFFER, Anakeila de B. (Orgs.). Educação e Saúde. Rio de Janeiro, EPSJV/Fiocruz, 2007.

MENDES, E.V. Atenção Primária à Saúde no SUS. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2002.

MOROSINI, Márcia Valéria C. G.; CORBO, Anamaria D'andrea (Orgs.). Modelos de Atenção

e a Saúde da Família. Rio de Janeiro, EPSJV/Fiocruz, 2007.

IMUNOLOGIA MÉDICA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Abordar os mecanismos imunológicos básicos e princípios de Imunopatologia, com a finalidade de fornecer aos alunos subsídios necessários para as cadeiras clínicas afins ou aplicações em outras. Abrange os aspectos mais modernos do ensino de Imunologia para o curso básico, enfocando seus mecanismos do ponto de vista molecular e celular. Conceitos gerais de imunologia. Descrição e análise do Sistema Imune. Noções básicas do funcionamento do Sistema Imune. Conhecimento e prática dos principais testes sorológicos. Doenças infecciosas e Sistema Imune. Auto-imunidade.

OBJETIVOS:

Descrever as generalidades do Sistema Imune e familiarizar o aluno com a terminologia da imunologia; conhecer os principais tipos celulares e moleculares que compõem o sistema imune e seus modos de ação; proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos dos mecanismos pelos quais este sistema consegue fazer respostas quantitativa e qualitativamente diferentes; compreender os mecanismos de controle – de modulação negativa e de término - das respostas imunes; descrever as consequências fisiopatológicas das respostas elaboradas por este sistema; conhecer as principais técnicas utilizadas no estudo da reatividade imunológica

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABBAS, Abul K. Imunologia básica – Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. Elsevier, Rio de Janeiro, 2015. 8ª edição.

KINDT, T.J.; GOLDSBY, R. A.; & OSBORNE, B.A. Imunologia de Kuby. Artmed, Porto Alegre, 2008. 6ª Edição

JANEWAY, CHARLES A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 7ª edição.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROITT, IVAN M. Imunologia. Guanabara Koogan. São Paulo: Atheneu, 2013. 12ª edição.

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Revinter. Rio de Janeiro, 2009. 2ª edição.

GELLER, M; SCHEINBERG, M. Diagnóstico e tratamento das doenças imunológicas. Elsevier, Rio de Janeiro, 2005.

PAUL, WILLIAM E. Fundamental Immunology./ Philadelphia: Lippincott-Raven, 2008. 6. ed.

BALESTIERI, Filomena Maria Perrella. Imunologia: . ed. Manoele, 2006

MICROBIOLOGIA MÉDICA (60 horas-aula 3 créditos)

EMENTA:

Estudo e prática sobre biologia e fisiologia das bactérias, vírus e fungos presentes no ambiente, de forma comensal e/ou patológica no hospedeiro humano. Análise dos mecanismos de patogenicidade, vias de transmissão, métodos de diagnóstico, métodos de controle e prevenção, além das doenças relacionadas as características étnicas, raciais e ambientais de determinadas populações, envolvendo bactérias, vírus e fungos.

OBJETIVOS

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a biologia, fisiologia e mecanismos de patogenicidade de bactérias, vírus e fungos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke e Christine L. Case. Microbiologia. Artmed Porto Alegre. 2012

Murray, P.R.; Rosenthal, K.S.; Kobayashi, G.E.; Pfaller, M.A. Microbiologia Médica, 6 a edição, 2010. Ed. Elsevier.

Trabulsi, LR; Alterthum F. Microbiologia. 5ª edição, 2008. Ed. Atheneu..

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MICROBIOLOGIA PRÁTICA. Roteiro e Manual Maria Mali S. R. Soares e Mariangela Cagnoni Ribeiro. Editora Atheneu. 2002.

ATLAS DE DIAGNÓSTICO EM MICROBIOLOGIA. De la Maza, Pezzlo e Baron. Editora Artmed. 2001.

MICROBIOLOGIA: Mecanismos das doenças infecciosas. 3º edição. Schaechter, Engleberg, Eisensteins e Medoff. Guanabara – Koogan. 2002. Rio de Janeiro.

MICROBIOLOGIA: Fundamentos e perspectivas. 4º edição. Black. Editora Guanabra-koogan. Rio de Janeiro. 2002.

MICROBIOLOGIA Conceitos e Aplicações. Pelczar, Chan e Krieg. Volumes 2, 2º Edição. MAKRON Books 2009.

HUMANIDADES EM MEDICINA (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Introdução do campo das Ciências Sociais e sua relação com a prática profissional na saúde, apresentando conceitos de organização da sociedade com seus desafios e fenômenos sociais contemporâneos e, posteriormente, relacionando estas questões à saúde no contexto da realidade brasileira.

OBJETIVOS:

Introduzir o aluno aos conceitos de organização social e seus desafios contemporâneos, bem como seu campo de aplicação à saúde coletiva; enfatizar a dimensão social da organização da sociedade, das diversas culturas e credos e como estes influenciam a noção de saúde/ doença da sociedade; estudar os preconceitos de diversas formas e suas manifestações como doença social e como estes geram estigmas de diversas doenças que interferem o relacionamento social e o cuidado aos doentes; abordar o corpo e seu

simbolismo social como introdução aos conceitos de cuidados ampliados na saúde; analisar o trabalho e a prática em saúde bem como suas influências na organização social.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Donnangelo MC, Pereira L. Saúde e Sociedade. São Paulo: Hucitec; 2011.

Helman, Cecil G. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed; 2009.

Laraia RB. Cultura- um conceito antropológico. São Paulo: Zahar Editores. 6ª. Ed; 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUARESCHI, P. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 63. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS/JORNAL MUNDO JOVEM, 2011.

CARVALHO, M. A família contemporânea em debate. São Paulo: Cortez, 2000. DELORS, J. et al. Educação um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC: UNESCO, 1998.

HELLER, A. A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999.

PASTORE, E.; TEDESCO, C. J. Ciências sociais: temas contemporâneos. Passo Fundo: Méritos Editora, 2005.

DOMINGUES, J. M. Sociologia e modernidade: para entender a sociedade contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

BIOFÍSICA DE SISTEMAS (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Biofísica dos sistemas. Biofísica Celular e Molecular (energia, fenômenos ondulatórios, fluidos em sistemas biológicos, fenômenos elétricos nas células). Métodos Biofísicos de Investigação. Biofísica das radiações e Introdução à Radiobiologia.

OBJETIVO:

O objetivo desta disciplina é introduzir o aluno no campo da Biofísica dos Processos

Moleculares e Supramoleculares, fundamento da fisiologia das células vivas e das inter-relações funcionais inerentes aos tecidos que compõem os organismos superiores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Koeppen, B.M. & Stanton, B.A. Berne & Levy – Fisiologia, 6ª Ed. São Paulo: Elservier, 2009. ISBN: 8535230572
2. DURÁN, J.E.R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. 2ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. *ISBN*. 9788576059288
3. MOURAO Jr, C.A. & ABRAMOV, D.M.G. Biofísica Essencial. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012. ISBN: 8527719711.

BIBLIOGRAIFA COMPLEMENTAR

1. HENEINE, I.F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2016.
2. NELSON, DAVID L. Princípios D]de Bioquímica De Lehninger 6a Ed, Porto Alegre, ARTMED, 2014. ISBN: 8582710720.
3. RIVA, Eduardo A. C.. Biofísica: . 2 ed. Sarvier, 2015.
4. LEÃO, MOACIR DE ALMEIDA CARNEIRO. PRINCÍPIOS DE BIOFÍSICA. 2 ed. Guanabara Koogan, 1982.
5. AIRES, MARGARIDA DE MELLO. Fisiologia: . 4 ed. Guanabara Koogan, 2015.

MÓDULO INTEGRATIVO II (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

3º PERIODO

SEMIOTÉCNICA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Trata das técnicas básicas de enfermagem, com desenvolvimento de habilidades práticas realizadas na assistência às pessoas e execução de procedimentos não-invasivos e invasivos utilizados no exame físico e na terapêutica, respeitadas as normas de biossegurança e Segurança do Paciente. Semiotécnica de enfermagem.

OBJETIVOS:

Apreender técnicas básicas de enfermagem, observando princípios científicos para promoção, prevenção e recuperação da saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TAYLOR, Carol . Fundamentos de enfermagem: a arte e a ciência do cuidado de enfermagem. 5 ed. Artmed, 2007.

SMELTZER, Suzanne C. & BARE, Brenda G. Brunner&Suddarth – tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9. ed. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

OHNISHI, Mitsuko et al. Feridas: cuidados e condutas. Londrina: Ed. UEL, 2001.

COMPLEMENTAR:

1 – GUIMARÃES, Marcio Cesar. Feridas e curativos: uma forma simples e prática de tratar. ed. Rubio, 2011.

2 – SILVA, Maria D'Apparecida Andrade; RODRIGUES, Aparecida Laureci; CESARETTI, Isabel Umbelina Ribeiro. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: EPU, 1997.

3 - Administração de medicamentos na enfermagem 2000/2001. EPUB, 2000. 376 p.

4 - NETTINA, Sandra M.. Prática de enfermagem: . 8 ed. Guanabara Koogan, 2007.

5 - MARTINS, Marcia de. Assistência de enfermagem em infectologia: . ed. Atheneu, 2006.

SUGERIDA:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Protocolo para prática dehigiene das mãos em serviços de saúde. Brasília: Anvisa/Fiocruz, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Biossegurança em saúde: prioridades e estratégias de ação. Brasília:Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana de Saúde, 2010.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.

HU/UFSC. Guia básico de precauções, isolamento e medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina/Hospital Universitário Prof. Dr. Polidono Ernani de São Thiago/CCIH/SCIH, 2012-2013. Disponível em: http://www.hu.ufsc.br/CCIH/manual_isolamento_2012-13.pdf. Acesso em: 20 jan. 2013.

BIOQUÍMICA CLÍNICA (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Origem, destino e função dos componentes do sangue com valor diagnóstico; aspectos diferenciais dos transtornos do metabolismo de glicídeos, lipídeos, compostos nitrogenados, vitaminas e minerais nas diferentes espécies domésticas e suas implicações clínicas e diagnósticas; alterações do equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico; provas empregadas no diagnóstico de disfunções hepáticas, pancreáticas e renais; principais transtornos endócrinos; biologia molecular e DNA recombinante aplicados à medicina; hemograma; diferenças e alterações hematológicas nas espécies animais; técnicas hematológicas complEMENTAres, hemoterapia. Exame de urina e líquidos cavitários: análises físicas, químicas e citológicas.

OBJETIVOS:

Adquirir conhecimentos teóricos e práticos para realização de coleta, processamento e conservação de amostras biológicas, bem como para realização e interpretação dos

exames bioquímicos dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança, caracterizando patologias que apresentam alterações metabólicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Burtis, C.A.; Ashwood, E.R.; Bruns, D.E. Tietz Fundamentos de Química Clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª ed. Barueri, SP: Manole, 2008.

Erichsen, E.S.; Viana, L.G.; Faria, R.M.D.; Santos, S.M.E. Medicina Laboratorial para o Clínico. 1ª ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Pratt, C.; Cornely, K. Bioquímica Essencial. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Nelson, D.L.; Cox, M.M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 4 ª ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

MURRAY, R. K. e outros: “Harper – Bioquímica”, 29a ed., 2013

NELSON, D. L.; COX, M. M.: Lehninger – Princípios de Bioquímica, 6a ed., 2014

VOET, D.; VOET, J. G. – Bioquímica, 4a ed., 2013

MORAN, L. A. et al. Bioquímica, 5a ed.,2013

SEMIOLOGIA I (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos da metodologia do exame clínico, incluindo: a relação médico-paciente, anamnese, ectoscopia e exame físico geral .

OBJETIVO:

Proporcionar ao aluno da graduação a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes na relação com o paciente tendo como base a abordagem a Anamnese e o Exame Físico com vistas à capacitação para o raciocínio clínico contextualizado no processo do adoecer considerando os aspectos físicos, psicológicos, familiares e sociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Porto, C.C. – Semiologia Médica, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

Lopez, M. ; Laurentis, MJ. – Semiologia Médica: As Bases do diagnóstico clínico, Revinter, São Paulo.

Swartz, C.L – Manual do Exame Psíquico: uma Introdução prática a psicopatologia, Editora Revinter, Rio de Janeiro.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Junior, J.R. – Semiotécnica da observação Clínica, Editora Sarvier, São Paulo.

Lopes, A. C. – Semiologia Cardiovascular baseada em evidências, Editora Atheneu.

Mattos, W. – Semiologia do Adulto – Diagnóstico Clínico Baseado em Evidências, Editora Medbook

Porto, C. C. – Exame Clínico, Editora Guanabara

Bickley, L. S. - Bates - Propedêutica Médica – Essencial, Editora Guanabara

HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA II (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Estudo da Histologia e Fisiologia Humana do Sistema Muscular, Cardiovascular, Respiratório e Renal, dando ao aluno do curso de Medicina a visão morfofuncional de cada um desses sistemas assim bem como a integração dos mesmos objetivando uma visão mais ampla da fisiologia humana e do organismo como um todo.

OBJETIVO:

Contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de aplicar as informações teóricas de modo a observar os mecanismos envolvidos nos processos fisiológicos muscular, cardiovascular, respiratório e urinário, e relacioná-los com os fatores interligados, permitindo concluir quais as causas e conseqüências dos mecanismos que mantém a normalidade das funções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Guyton, A.C. & Hall, J.E. – Tratado de Fisiologia Médica – 11a edição– Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2006.

Silverthonr , U. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 2a edição – Editora Manole, São Paulo, 2003.

Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Aires, M.M. – Fisiologia – 2a edição – Rio de Janeiro – Editora Guanabara Koogan, 1999.

Berne, R.M., Levy, M.N., Koeppin, B.M. & Stanlon, B.A. – Fisiologia – 5o edição – Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004.

West, J.B. – Fisiologia Respiratória – 6a edição – Willians and Wedkins, 2002.

Kandel, Eric R.; Schwartz, James H.; Jessell, Thomas M. Principles of Neural Science – Ed. Appletton & Lange, 1991.

McArdle, William D.; Katch, Frank I.; Katch, Victor L. Fisiologia do Exercício 5. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e

ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

Lent, R. – Cem Bilhões de Neurônios. – 1o edição, - Atheneu, São Paulo, 2001.

Martin, J.H. – Neuroanatomia Texto e Atlas. 1a edição, Artes Médicas, Porto Alegre, 1998.

Douglas, C.R. – Tratado de Fisiologia Aplicada á Ciências da Saúde 6a edição – Rio de Janeiro – Editora Guanabara koogan, 2006.

PARASITOLOGIA MÉDICA (80 horas-aula – 4 créditos)

Estudo teórico-prático das parasitoses promovidas por protozoários e helmintos no hospedeiro humano, bem como mecanismos de patogenicidade, vias de transmissão, métodos de diagnóstico, métodos de controle e prevenção, além das doenças relacionadas as características étnicas, raciais e ambientais de determinadas populações, envolvendo diversos parasitas.

OBJETIVO:

Descrever as principais relações entre parasito-hospedeiro. Avaliar as ações espoliativas e comensais do parasito-hospedeiro. Estudo morfológico e funcional de cada parasitose. Formas de diagnóstico clínico e laboratorial. Bases clínicas e terapêuticas das principais parasitoses de interesse médico e sua incidência regional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1 - NEVES, D. P.; MELO, A. L.; GENARO, O.; LINARDI, P. M. Parasitologia humana. 12º ed., São Paulo: Atheneu, 2012.

2 – NEVES, D. P. Parasitologia Dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2009.

3 - CIMERMAN, B.; CIMERMANN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Queiroz de Leão, R.N. Ed. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Belém, CEJUP, 1997

Tortora, G.J.; Funke, B.R.; Case, C.l. Microbiologia. Artmed, 2012

PESSOA, Samuel Barnsley; MARTINS, Amilcar Vianna. Parasitologia médica: . 11 ed. Guanabara, 1988.

REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 4º ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Townsend, Colin R. - Begon, Michael - Harper, John L. Fundamentos em Ecologia - Townsend - 3ª edição. Artmed, 2010

BIOÉTICA (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Estudo das inter-relações existentes entre a Ética, a Moral e o Direito. Filosofia da Tecnologia, Caracterização da Bioética como uma Ética inserida na Prática. Comparação entre os diferentes modelos explicativos utilizados na Bioética. Reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos nas questões relativas a privacidade e confidencialidade, problemas de início e final de vida, alocação de recursos escassos, respeito à pessoa e tomada de decisão e pesquisa.

OBJETIVO:

Apresentar conceitos e teorias em Bioética, que permitam refletir sobre conflitos e dilemas morais na área da saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CEMIN, A. B. Bioética Intercultural Crítica e Antropologia das Civilizações: O “conflito das interpretações” e os Direitos Humanos. Montevideo\Uruguai. ABA\RAM (Reunião de Antropologia do Mercosul), 2015.

COSTA, Ségio; DINIZ, Debora. Bioética: ensaios. Brasília: Letras Livres, 2001. 206 p.

DINIZ, D.; GUILHEM, D. O que é Bioética¿ São Paulo: Brasiliense, 2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERRER, J. J.; ÁLVAREZ, J. C. Para fundamentar a Bioética: teorias e paradigmas teóricos na Bioética contemporânea. São Paulo: Loyola, 2005.

FONSECA, A. C. da C. (Obra de autoria coletiva). Cinema, Ética e Saúde. Porto Alegre: Editora Bestiário, 2012.

RUSS, Jackeline. *Pensamento ético contemporâneo*. São Paulo: Paulus: 2003, p. 88-95.

SINGER, Peter (ed.). *Compendio de Ética.* Madrid, Alianza, 2004. (Tradução de *A Companion to Ethics.* Malden; Oxford; Victória: Blackwell, 1993). Capítulos: 1 a 3; 10 a 22; 39 e 40.

PORTO, D.. GARRAFA, V; MARTINS, G.Z; BARBOSA, S. do N. Bioética, poderes e injustiças, 10 anos depois. Brasília: CFM\Catedra UNESCO de Bioética, 2012.DINIZ, D; SUGAI, A; GUILHEM, D; SQUINES, F. Ética em Pesquisa, temas globais. Brasília: Letras Livres, 2008.

Números temáticos da Revista de Bioética do Conselho Federal de Medicina, Brasil

MÓDULO INTEGRATIVO III (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

4º PERIODO

EPIDEMIOLOGIA (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Introdução das bases conceituais da Epidemiologia como método de investigação indispensável ao estudo da origem, evolução e controle dos problemas de saúde. Principais sistemas de informação em saúde. Indicadores de saúde. Delineamentos de estudos epidemiológicos. Preparo para tomada de decisão em relação a tratamentos apoiados pelas melhores evidências, com base na avaliação metodológica dos artigos científicos sobre diagnóstico e terapêutica.

OBJETIVOS:

Apreender os métodos da epidemiologia para o estudo da origem, evolução e controle dos problemas de saúde da população.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA FILHO, N.& BARRETO, M. L. *Epidemiologia & Saúde*. - Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011

GORDIS , L. *Epidemiologia*.– 4 ed. Revinter, 2010

PEREIRA,M. G.*EPIDEMIOLOGIA: TEORIA E PRÁTICA*. *Guanabara Koogan,* Rio de Janeiro, *1995.*

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MEDRONHO, R. et al.*Epidemiologia*. 2 ed., Atheneu,São Paulo, 2009

MONTEIRO, C. A. (org).*Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas doenças* - EDITORA HUCITEC - NUPENS/USP. São Paulo,1995.

BARATA, R. B. (org)*Equidade e saúde: contribuições da Epidemiologia.*EDITORA FIOCRUZ – ABRASCO. Rio de Janeiro. 1997 (série Epidemiológica).

FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S.& WAGNER,E. H. *Epidemiologia Clínica: bases científicas da conduta médica.*– 4ª ed. Artes Médicas,Porto Alegre, 2006.

BHOPAL,R.*Concepts of Epidemiology*. Oxford University Press, 2003.

HENNEKENS, C. H. & BURING, J. E. *Epidemiology in Medicine*. Lippincott Willians&Wilkins, Philadelphia, 1987.

ALMEIDA FILHO, N. & ROUQUAYROL, M. Z. *Introdução à Epidemiologia*. 3 ed. MEDSI, Rio de Janeiro, 2002

Periódicos disponíveis no Portal CAPES

FARMACOLOGIA I (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Estudar, conhecer e identificar os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos principais grupos de fármacos e as interações farmacológicas existentes.

OBJETIVOS:

- Estudar os mecanismos envolvidos na farmacocinética e na farmacodinâmica;

Proporcionar ao aluno conhecimentos dos mecanismos de ação dos fármacos, bem como a sua interação com o organismo; Identificar os principais grupos farmacológicos de drogas e suas utilizações; Adquirir noções da utilização racional dos fármacos; Evidenciar interações farmacológicas existentes entre os diferentes grupos de drogas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOODMAN L.S. , GILMAN A.G. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Mc Graw Hill Interamericana do Brasil Ltda; 2012. 2079p.

KATSUNG, Bertrom G. Farmacologia Básica e Clínica. 13ª. ed. Porto Alegre:AMGH Editora/McGraw-Hill e ArtMed; 2015.

KOROLKOVAS, Andrejus. Dicionário Terapêutico Guanabara ed.2013/2014 20ª ed. Guanabara Koogan; 2013. 724p.

RANG H.P.,DALE M.M., RITTER, J.M,, FLAUER, R.J. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Elsevier; 2011. 768p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R. M.; PLANETA, C. S.; GALLACCI, M.; AVELLAR, M.C.W., (Eds). Farmacologia Integrada. *5ª*. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2014. 3781p.

DEF Dicionário de Especialidades Farmacêuticas EPUC Editora de Publicações Científicas Ltda, 38ª ed. 2015.

FAUCI Anthony S. Harrison Medicina Interna 18ª ed. Mc Graw Hill Interamericana do Brasil Ltda; 2013

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8ª Edição, Ed. Guanabara Koogan; 2010.

The Merk Manual of Diagnosis and Therapy. 19ª ed. New Jersey, USA:Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc Whitehouse Station; July 2011.

ZANINI,A.C.& OGA, Seizi Farmacologia Aplicada. 6ª ed. São Paulo, Atheneu;2004

BIBLIOGRAFIA ELETRÔNICA SUGERIDA

Fundamentos farmacológico clínicos de medicamentos de uso corrente. Livro eletrônico da ANVISA (acessar por www.anvisa.gov.br-: anvisa divulga- publicações)

Compêndio eletrônico British Nacional Formulary (BNF 2004): www.bnf.org

Compêndio de Bulas de Medicamento (acessar www.anvisa.gov.br) MICROMEDEX Integrated Index–USP-DI principal formulário sobre medicamentos aprovados nos Estados

Unidos e Canadá. Só é acessado através de instituições públicas pelo site www. capes.periodicos.gov.br

PATOLOGIA GERAL (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Principais alterações anatomopatológicas básicas. Preparações macroscópicas e microscópicas para o estudo da patologia.

OBJETIVOS:

Descrever as generalidades dos processos patológicos básicos e familiarizar o aluno com a terminologia da patologia.

Conhecer os principais processos patológicos básicos

Buscar integração dos conceitos básicos em patologia com outras áreas básicas, como anatomia, fisiologia e histologia

Conhecer as principais técnicas de processamento histológicos e colorações utilizadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA;

ROBBINS. Patologia. Bases Patológicas das Doenças. 9ª ed. Elsevier, Rio de Janeiro: 2016.

Brasileiro Filho G – *Bogliolo – Patologia*. 6ª 91d., Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 2.000.

Lopes de Faria J – *Patologia Especial com Aplicações Clínicas*. 2ª 91d., Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Rubin's Pathology, edição 2008.

General and Systematic Pathology, J.C.E. Underwood, 4ª edição, Editora Churchill Livinstone.

Colour Atlas of Anatomical Pathology, Robin A. Cooke & Bryan Stewart, 3ª edição,

Churchill Livinstone.

Color Atlas of Pathology - Pathologic Principles Pathology Illustrated

Timm, L.L. Técnicas rotineiras de preparação e análise de lâminas histológicas. Caderno La Salle XI, Canoas, v.2, nº 1, 231 - 239, 2005

www.anatpat.unicamp.br; www.pathology.com.br; www.pathguy.com; www.pathologyoutlines.com; www.pathologylinks.com e www.path.uiowa.edu/virtualslidebox

Técnicas histológicas: Uma abordagem prática. Fiocruz. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RlyTg64AT9E

HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA III (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Estudo da Histologia e Fisiologia Humana do Sistema digestório e do controle do metabolismo, dando ao aluno do curso de Medicina a visão morfofuncional de cada um desses sistemas assim bem como a integração dos mesmos objetivando uma visão mais ampla da fisiologia humana e do organismo como um todo.

OBJETIVOS:

Contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de aplicar as informações teóricas de modo a observar os mecanismos envolvidos nos processos fisiológicos digestive e do controle do metabolismo, e relacioná-los com os fatores interligados, permitindo concluir quais as causas e conseqüências dos mecanismos que mantém a normalidade das funções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Guyton, A.C. & Hall, J.E. – Tratado de Fisiologia Médica – 11a edição– Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2006.

- Silverthonr , U. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 2a edição – Editora

Manole, São Paulo, 2003.

- Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- Aires, M.M. – Fisiologia – 2a edição – Rio de Janeiro – Editora Guanabara Koogan, 1999.

- Berne, R.M., Levy, M.N., Koeppin, B.M. & Stanlon, B.A. – Fisiologia – 5o edição – Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004.

- West, J.B. – Fisiologia Respiratória – 6a edição – Willians and Wedkins, 2002.

- Kandel, Eric R.; Schwartz, James H.; Jessell, Thomas M. Principles of Neural Science – Ed. Appletton & Lange, 1991.

- McArdle, William D.; Katch, Frank I.; Katch, Victor L. Fisiologia do Exercício 5. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

- Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

- Lent, R. – Cem Bilhões de Neurônios. – 1o edição, - Atheneu, São Paulo, 2001.

- Martin, J.H. – Neuroanatomia Texto e Atlas. 1a edição, Artes Médicas, Porto Alegre, 1998.

- Douglas, C.R. – Tratado de Fisiologia Aplicada á Ciências da Saúde 6a edição – Rio de Janeiro – Editora Guanabara koogan, 2006.

SEMILOGIA II (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Fornecer os conhecimentos básicos da metodologia do exame clínico, incluindo: a relação médico-paciente, anamnese, ectoscopia, exame físico geral e dos diferentes aparelhos e sistemas.

OBJETIVOS:

Fazer o aluno adquirir raciocínio clínico e ferramentas necessárias para a elaboração da anamnese, permitindo-lhe fazer uma reflexão crítica por meio da abordagem dos assuntos da EMENTA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Porto, C.C. – Bases para a prática clínica, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2000.

Bevilacqua, Bensoussan, Jansen, Spinola. Manual do Exame Clínico. Editora Cultura Médica; 12a edição, 2000

EPTEINS , O.; PERKIN, G. D.; BONO, D. P. & COOKSON J. Exame Clínico. Artmed; 2a edição, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FORBES, JACKSON. Atlas Colorido e Texto de Clínica Médica. Editora Manole Ltda; 2a edição, 1999

TALLEY , Exame Clínico – Guia prático para o diagnóstico clínico; Editora Revinter; 2a edição, 2000.

Junior, J.R. – Semiotécnica da observação Clínica, Editora Sarvier, São Paulo.

Lopes, A. C. – Semiologia Cardiovascular baseada em evidências, Editora Atheneu.

Mattos, W. – Semiologia do Adulto – Diagnóstico Clínico Baseado em Evidências, Editora Medbook

Porto, C. C. – Exame Clínico, Editora Guanabara

Bickley, L. S. - Bates - Propedêutica Médica – Essencial, Editora Guanabara

INTRODUÇÃO ÀS DOENÇAS PARASITARIAS (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Introdução ao estudo clínico, epidemiológico, fisiopatológico e dos métodos de

diagnóstico, tratamento e profilaxia das principais doenças infecciosas e parasitárias prevalentes na região e no país. Tem como propósito ensinar o estudante como se conduzir em relação aos pacientes portadores de doenças infecciosas ou parasitárias, familiarizando-o com os procedimentos diagnósticos, conduta terapêutica e medidas de controle.

OBJETIVOS:

Descrever as generalidades das doenças infecciosas virais, bacterianas, por protozoários, fungos e espiroquetas.

Conhecer as bases dos acidentes com animais peçonhentos.

Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos dos mecanismos de ação e de resistência dos principais grupos antibióticos e quimioterápicos.

Acompanhar o atendimento ambulatorial e de enfermaria no hospital de referência de doenças infecciosas e parasitárias do Estado

Participar das discussões dos casos clínicos relacionados às doenças infecciosas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

R. Veronesi. Tratado de Infectologia, 2005.

J. R. Coura. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, 2006.

NEVES, D. P.; MELO, A. L.; GENARO, O.; LINARDI, P. M. Parasitologia humana. 12º ed., São Paulo: Atheneu, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A.C. Lopes. Tratado de Clínica Médica, 2006.

Doenças Infecciosas: Conduta Diagnóstica e Terapêutica. Mauro Schechter/Denise Marongoni, 1998.

Tonelli – Doenças Infecciosas na Infância, 2000

MANDELL, G.L.; BENNETT, J.E. DOLIN, R. (Eds.) Principles and practice of Infectious

Diseases. 7th. Ed. New York, Churchil Livingstone Inc, 2002

VERONESI, R. (Ed.) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 11 Ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 2.000

GENÉTICA HUMANA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Frequências, classificação e impacto das doenças genéticas. Malformações congênitas. Anomalias cromossômicas numéricas e estruturais e suas consequências clínicas. Erros inatos do metabolismo. Aspectos genéticos e distúrbios da diferenciação sexual. Infertilidade e abortamentos de repetição. Neurogenética. Etiologia Genéticas das Neoplasias. Triagem de heterozigotos. Triagem neonatal. Tratamento das doenças genéticas. Diagnóstico pré-natal. Aconselhamento genético. Aspectos éticos e legais

OBJETIVOS:

A Disciplina de Genética Humana objetiva propiciar ao aluno o conhecimento sobre os princípios básicos da genética molecular, mecanismos da herança dos caracteres normais e patológicos, dinâmica populacional e despertar o aluno para as aplicações clínicas desses conhecimentos. No término da disciplina, o aluno deverá possuir a capacidade de reconhecer ao alcance da genética médica na análise, no diagnóstico, no tratamento e prevenção de doenças

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SCHAEFER, G. B.; THOMPSON, J. N. Genética médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: AMGH, 2015. 384 p.

VIEIRA, T.; GIUGLIANI, R. (Org.). Manual de genética médica para atenção primária à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2013. 104 p

JORDE, Lynn B.; CAREY, John C.; BAMSHAD, Michael J. Genética Medica. 5ª EDIÇÃO. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NUSSBAUM, R. L.; MCLNNES, R. R.; WILLARD, H. Thompson e Thompson Genetica Medica-8ª EDIÇÃO. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER, 2016.

MALUF, S. W. et al. **Citogenética humana**. Porto Alegre: Artmed, 2011. 334p

Griffiths, Antohony J.F. Wessler, Susan R. Carroll, Sean B. Doebley, John. Introdução À Genética. 10° Edição -. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.736.

Krebs, Jones B. Goldstein, Elliott S. Kilpatrick, Stephen T. Lewin's Genes XI (2014). Editora JONES BARTLETT.

Snustad, D. Peter. Fundamentos da Genética - 6ª Ed. 2013. Editora: Guanabara Koogan.

Joseph S. Bertino; Angela Kashuba; Joseph D. Ma; Uwe Fuhr; C. Lindsay DeVane. Pharmacogenomics. An Introduction and Clinical Perspective (2012). Editora: McGraw-Hill Livros.

Pasternak, Jack J. Uma Introdução à Genética Molecular Humana - Mecanismos das Doenças Hereditárias. 2º Edição, 2007. Editora: Guanabara Koogan.

Texto de periódicos: Textos avulsos de revistas de divulgação científica como Ciência Hoje, Superinteressante, Galileu, Saúde e outras.

MÓDULO INTEGRATIVO IV (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

5º PERIODO

FARMACOLOGIA II (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Estudar e aprofundar os conhecimentos dos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos principais grupos de fármacos e as interações farmacológicas existentes, com ênfase na terapêutica e discussão de casos clínicos.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno conhecimentos dos mecanismos de ação dos fármacos, bem como a sua interação com o organismo;

Identificar os principais grupos farmacológicos de drogas e suas utilizações;

Adquirir noções da utilização racional dos fármacos;

Evidenciar interações farmacológicas existentes entre os diferentes grupos de drogas;

Conhecer outros métodos terapêuticos de tratamentos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOODMAN L.S. , GILMAN A.G. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Mc Graw Hill Interamericana do Brasil Ltda; 2012. 2079p.

KATSUNG, Bertrom G. Farmacologia Básica e Clínica. 13ª. ed. Porto Alegre:AMGH Editora/McGraw-Hill e ArtMed; 2015.

KOROLKOVAS, Andrejus. Dicionário Terapêutico Guanabara ed.2013/2014 20ª ed. Guanabara Koogan; 2013. 724p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RANG H.P.,DALE M. M., RITTER, J.M,, FLAUER, R. J. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Elsevier; 2011. 768p.

DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R. M.; PLANETA, C. S.; GALLACCI, M.; AVELLAR, M.C.W., (Eds). Farmacologia Integrada. *5ª*. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2014. 3781p.

DEF Dicionário de Especialidades Farmacêuticas EPUC Editora de Publicações Científicas Ltda, 38ª ed. 2015.

FAUCI Anthony S. Harrison Medicina Interna 18ª ed. Mc Graw Hill Interamericana do Brasil Ltda; 2013

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8ª Edição, Ed. Guanabara Koogan; 2010.

The Merk Manual of Diagnosis and Therapy. 19ª ed. New Jersey, USA:Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc Whitehouse Station; July 2011.

ZANINI,A.C.& OGA, Seizi Farmacologia Aplicada. 6ª ed. São Paulo, Atheneu;2004

PATOLOGIA SISTEMICA (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Principais alterações anatomopatológicas que ocorrem em vários órgãos e sistemas, seus mecanismos fisiopatológicos, correlações apropriadas de sinais, sintomas, achados laboratoriais e farmacológicos.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno o conhecimento teórico e prático dos principais processos patológicos sistêmicos, através:

1. Estudo da patologia dos diversos sistemas orgânicos;

2. Estudo dos seus mecanismos patogenéticos;

3. Estudo das correlações anátomo-clínicas dos processos analisados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROBBINS. Patologia. Bases Patológicas das Doenças. 9ª ed. Elsevier, Rio de Janeiro: 2016.

Brasileiro Filho G – *Bogliolo – Patologia*. 6ª 99d., Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 2.000.

Lopes de Faria J – *Patologia Especial com Aplicações Clínicas*. 2ª 99d., Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Rubin's Pathology, edição 2008.

General and Systematic Pathology, J.C.E. Underwood, 4ª edição, Editora Churchill Livinstone.

Colour Atlas of Anatomical Pathology, Robin A. Cooke & Bryan Stewart, 3ª edição, Churchill Livinstone.

Color Atlas of Pathology - Pathologic Principles

Pathology Illustrated

www.anatpat.unicamp.br; www.pathology.com.br; www.pathguy.com; www.pathologyoutlines.com; www.pathologylinks.com e www.path.uiowa.edu/virtualslidebox

Técnicas histológicas: Uma abordagem prática. Fiocruz. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RlyTg64AT9E

Timm, L.L. Técnicas rotineiras de preparação e análise de lâminas histológicas. Caderno La Salle XI, Canoas, v.2, nº 1, 231 - 239, 2005

ETICA MEDICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Estudo das normas que regem a prática da Medicina e seus desdobramentos Éticos. Compreensão do conteúdo do Código de Ética Médica com a finalidade de preparar futuros médicos a exercer a profissão dentro dos postulados éticos que norteiam a Medicina, seja nas relações com outros médicos, seja nas relações com pacientes, seja nas relações sociais, de uma forma global.

OBJETIVO:

Refletir a esfera ética e moral da profissão, a partir dos conflitos de valores vivenciados no dia-a-dia do exercício profissional, inserindo temas atuais e aproveitando as experiências

individuais. Desenvolver o interesse pelas questões éticas, demonstrando a importância social e a dimensão humanitária da temática, buscando respostas para os dilemas éticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1 – O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

2 – O CÓDIGO DO PROCESSO ÉTICO PROFISSIONAL

3 – O CÓDIGO CIVIL

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERRER, J. J.; ÁLVAREZ, J. C. Para fundamentar a Bioética: teorias e paradigmas teóricos na Bioética contemporânea. São Paulo: Loyola, 2005.

FONSECA, A. C. da C. (Obra de autoria coletiva). Cinema, Ética e Saúde. Porto Alegre: Editora Bestiário, 2012.

RUSS, Jackeline. *Pensamento ético contemporâneo*. São Paulo: Paulus: 2003, p. 88-95.

SINGER, Peter (ed.). *Compendio de Ética.* Madrid, Alianza, 2004. (Tradução de *A Companion to Ethics.* Malden; Oxford; Victória: Blackwell, 1993). Capítulos: 1 a 3; 10 a 22; 39 e 40.

PORTO, D.. GARRAFA, V; MARTINS, G.Z; BARBOSA, S. do N. Bioética, poderes e injustiças, 10 anos depois. Brasília: CFM\Catedra UNESCO de Bioética, 2012.DINIZ, D; SUGAI, A; GUILHEM, D; SQUINES, F. Ética em Pesquisa, temas globais. Brasília: Letras Livres, 2008.

Revista Brasileira de Bioética

Periódicos de Ética e Bioética disponíveis no Portal Periódicos CAPES

SAÚDE DO ADULTO I (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Descrição dos principais das principais síndromes em Nefrologia e Gastroenterologia com

sua classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos. Fundamentos do diagnóstico em Nefrologia e Gastroenterologia . Bases da terapêutica em Nefrologia e Gastroenterologia.

OBJETIVOS:

Ampliar e integrar os conhecimentos obtidos ao longo do curso bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes, visando a formação do médico generalista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Medicina Interna de Harrison - 18ª Ed, 2013

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7ª Ed, 2013

Gastroenterologia essencial - Renato Dani

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Doenças do fígado e vias biliares - Luís Carlos Gayotto.

Condutas em gastroenterologia - Federação Brasileira de Gastroenterologia.

Gastroenterologia e Hepatologia - Moysés Mincis.

Terapêutica em Gastroenterologia - Galvão Alves E Renato Dani

Tratado de hepatologia – AngelomMattos E Esther Dantas

Doença inflamatória intestinal - Wilton Cardozo e Carlos Walter Sobrado

Tratado de hepatites virais - Roberto Focaccia

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

www.gastroenterology.com

www.hepatology.com

BASES DA CLÍNICA CIRURGICA (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Noções sobre a cirurgia, sua história e evolução. Comportamento do cirugião frente ao paciente e colegas. Cirurgia experimental, animal de experimentação e biotério. Assepsia e anti-sepsia, paramentação, instrumental cirúrgico e sala cirúrgica. Técnica cirúrgica: instrumentação cirúrgica e cuidados com o paciente. Atos operatórios fundamentais: diérese, hemostasia e síntese. Punção venosa, traqueostomia, punção torácica e abdominal. Cicatrização de feridas. Pré-operatório. Agressão cirúrgica. Choque. Principais doenças cirúrgicas, diagnóstico e exames complEMENTAres. Cuidados pós-operatórios.

OBJETIVOS:

Contribuir para a formação do médico generalista oferecendo informações gerais sobre a clínica cirúrgica.

O aluno deve saber os Princípios Fundamentais da Técnica Operatória comuns a todos os atos operatórios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SABISTON, DC. Tratado de Cirurgia. 19ª Edição. Elsevier, 2014.

SCHWARTZ, S.L. Princípios de Cirurgia, 9ª Edição, 2013

Saad Jr, R; Vianna, Rars; Carvalho, Wr; Moreira, A. Tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões). 1ª Edição, Editora Atheneu, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R. Clínica Cirúrgica. Volume 1 e 2. 1ª Edição, Editora Manole, 2008

Goldenberg, S. Bevilacqua, R. G. Bases da Cirurgia. São Paulo: EPU,1984.

GOFFI. Técnica cirúrgica. São Paulo: Atheneu, 2000.

MARQUES, R.G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2005.

FONSECA, F.P. Cirurgia Ambulatorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.

MAGALHÃES, H. P. De. Técnica cirúrgica e cirurgia experimental. Porto Alegre: Artmed, 1998

ZOLLINGER & ZOLLINGER Atlas de Cirurgia Guanabara Koogan

SAUDE DA CRIANÇA I (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Oferecer ao aluno oportunidade de aprendizado na área de Saúde da Criança, englobando o conceito da atenção integral à saúde da criança. Capacitar o aluno a:

Atendimento individual do recém-nascido e da criança com aprendizado em anamnese e exame físico; Formulações de hipóteses diagnósticas e condutas adequadas em doenças prevalentes na infância, baseado em evidencias cientificas. Capacitar o aluno na prevenção, diagnóstico e tratamento específico em patologias mais comuns no período neonatal e na infância. Sensibilização e elaboração das vivências psicológicas relacionadas a relação médico-paciente no processo de profissionalização. Reconhecimento da adequação e organização dos serviços, identificando os problemas mais comuns entre as crianças da região e suas necessidades individuais de saúde

OBJETIVOS:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas e semiologia pediátrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1) MURAHOVSCHI ,J. PEDIATRIA: Diagnóstico + Tratamento, 7. ed., editora SARVIER, autor:. 2013

2) COSTA VAZ, Flávio Adolfo; MARCONDES, Eduardo; RAMOS, José Lauro Araujo. PEDIATRIA BÁSICA - TOMO III, PEDIATRIA CLINICA ESPECIALIZADA, editora SARVIER, autor

3) LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 3.ed. Editora Manole, 20. Vol. 1 e 2. 2014

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIGUEIRA, Fernando. PEDIATRIA: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), Quarta edição, 2011, Editora Medbook.

KLIEGMAN, JENSON, BEHRMAN. Tratado de Pediatria –Nelson , 19. ed. 2013. Editora Elsevier.

SITE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Documentos e Informações. Disponível em: HTTP://www.sbp.com.br

Manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde. 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à Saúde do Recém-Nascido (manual). 2.ed. 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Essa disciplina tem por finalidade trabalhar os conceitos fundamentais e processo de trabalho da vigilância do campo da saúde e desenvolver no aluno a capacidade de identificar, analisar e intervir nos problemas que se apresentam no campo da Vigilância à Saúde, em especial aquelas relacionadas à vigilância Epidemiológica, Ambiental e

Sanitária, habilitando-o para atuar nos diferentes níveis do sistema. O projeto de ensino terá como referência as reais necessidades de saúde da população, contribuindo para a construção do Sistema Único de Saúde, possibilitando que o aluno seja capaz de uma leitura e avaliação críticas dos diferentes Modelos de Atenção à saúde.

OBJETIVOS:

Apresentar uma síntese dos temas que compõem o conteúdo programático, com ênfase nos aspectos mais importantes para a prática do médico no contexto do modelo tecno-assistencial de vigilância em saúde como eixo que estrutura a formação do conhecimento nessa área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAMPOS. G.W.S. (Org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2ª ed. rev. aum. São Paulo: Hucitec, 2012. 968p. ISBN 978-85-64806-56-6.

FONSECA. A.F. (Org.). O território e o processo saúde-doença. / Organizado por Angélica Ferreira Fonseca e Ana Maria D'Andrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

GONDIM, R. (Org.). Qualificação de gestores do SUS. / organizado por Roberta Gondim, Victor Grabois e Walter Mendes – 2. ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro, RJ: EAD/Ensp, 2011. 480 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TEIXEIRA, C. F. O futuro da prevenção. Salvador, BA: Casa da Qualidade Editora, 2001. ISBN: 85-85651-58-X.

ROSENFELD, S., 2000. Fundamentos da Vigilância Sanitária. Rio de Janeiro: Fiocruz.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/.**

COSTA, E. A. Vigilância Sanitária: Proteção e Defesa da Saúde. São Paulo: Hucitec, 1999.

CUNHA, R. V. A saúde no Brasil em 2033. Cenário futuros e desafios atuais. UFMS, 2013. Disponível em: **www.youtube.com/watch?v=WBoiXxJRoNg**

IMAGEM (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Capacitar o discente a realizar o diagnóstico baseado na Segurança Radiológica e o uso racional dos exames de imagem. Identificar através dos métodos de imagem as Patologias mais frequentes do Sistema de Saúde, assim como conhecer os métodos de abordagem de diagnóstico e tratamento guiadas por imagem. Capacitar o estudante a escolher o melhor método na prática clínica que o auxilie a realizar o correto diagnóstico. Evitar o uso indiscriminado da radiação e conscientizar da importância para a sociedade.

OBJETIVO:

Proporcionar o conhecimento teórico e prático do diagnóstico guiado por imagem através do estudo dos métodos radiológicos. Abordar a Segurança Radiológica nas Oficinas durante as aulas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FELSON Radiologia Torácica..

Edson Marchiori Fundamentos da Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Paul e Juhl Interpretaçao Radiológica. 2 volumes

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Neurorradiologia. Cláudia da Costa Leite. Edson Amaro Junior.

Série Radiologia CBR. www.radiopedia.org

Artigos atuais da plataforma BVS, Pubmed e Scielo

_____.Radiação. Fundação Osvaldo Cruz. FIOCRUZ 2016 http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html Acesso em 15 de junho de 2016l

_____. Reglamento para el transporte seguro de materiales radioactivos, Edición de 2009. Normas de Seguridad del OIEA, Serie No. TS-R-1. OIEA: Viena, 2009. Organismo Internacional de EnergiaAtômica. [consultado em 31 de julho de 2012]. Disponívelem: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1384s_web.pdf

_____.Effects of IonizingRadiation [Internet]. UNSCEAR 2008 Reporttothe General Assembly, withscientificannexes, Vols. I and II. UN: Nova York; 2011 Nações Unidas. Comitê Científico das Nações Unidas para o Estudo dos Efeitos das RadiaçõesAtômicas. [consultado em 29 de junho de 2016]. Disponívelem: Vol. I: http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_1.html Vol. II: http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_2.html

_____. Normas básicas internacionais de segurança para a proteção contra a radiação ionizante e para a segurança das fontes de radiação. Colección de Seguridad No. 115, OIEA, Viena (1997). Agência de Energia Nuclear da Organização para Cooperação e DesenvolvimentoEconômico (AEN/OCDE), Organismo Internacional de EnergiaAtômica (OIEA), Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). [consultado em 9 de junho de 2016]. Disponívelem: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS-115s-Web/Start.pdf.

MÓDULO INTEGRATIVO V (40 horas-aula – 2 créditos)

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

6º PERIODO

AÇOES PROGRAMATICAS (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

A construção de um modelo de saúde em novas bases, substituindo o modelo tradicional e levando a saúde para mais perto do indivíduo e de suas famílias, com prioridade para as ações de educação, prevenção e recuperação da saúde de forma integral e contínua a grupos específicos. Medicina Preventiva. Métodos de Prevenção. Ciclos de vida. Ações Programáticas.

OBJETIVO:

Proporcionar aos alunos da graduação a oportunidade de contato com ações programáticas de saúde, para grupos específicos da população, desenvolvidas no âmbito Sistema Único de Saúde - SUS, pelo Ministério da Saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, G., LOPES, J. M. C. Tratado de medicina da família e comunidade: princípios, formação e prática. Vol. 1 e 2. – Porto Alegre: Artmed. 2012.

JEKEL, J. F., et al. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Ed. Artmed. 2ª Ed. Vol. Único. – Porto Alegre: Artmed. 2005.

NORMAN, A. H. TESSER, C. D. Prevenção quaternária na atenção primária à saúde: uma necessidade do Sistema Único de Saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(9): 2012-2020, set, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica Saúde do Idoso. – Brasília, 2010.

BRASIL. Cadernos de Atenção Básica. Disponíveis em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes. Acesso em

setembro de 2015.

BRASIL. Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Gestões e gestores de políticas públicas de atenção à saúde da criança: 70 anos de história. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 2005.

BRASIL. Plano Nacional de mobilização e intensificação das ações para a eliminação da hanseníase e controle da tuberculose. Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. - 2ª edição - Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002.

BRASIL. Política nacional de atenção integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Reforma Psiquiátrica e política de Saúde Mental no Brasil. Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

MEDICINA LEGAL (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Compreender a aplicação da Medicina Legal na identificação e elucidação dos ilícitos penais por meio do estudo da Traumatologia, Tanatologia, Sexologia e Psicopatologia; Reconhecer e Analisar os diagnósticos médico-legais nos fenômenos cadavéricos imediatos e consecutivos, bem como nos fenômenos transformativos, e nas lesões produzidas intra-vitam e post-mortem; Identificar e interpretar as perícias médico-legais tendo por base o conhecimento dos conceitos, terminologias e técnicas médico-legais; Conhecer a relação entre a Medicina e o Direito; Identificar os documentos médico-legais e as suas devidas utilizações e necessidades; Compreender Antropologia Forense como forma de identidade e identificação; Reconhecer a Estrutura dos órgãos periciais do Estado de Rondônia e o papel do Médico, do Advogado e do jurista na solicitação e interpretação crítica dos laudos periciais. O preenchimento correto da Declaração de Óbito pelo Médico

OBJETIVOS:

Fornecer aos estudantes conceitos atualmente aplicados ao campo da Medicina Legal; familiarização com o léxico Médico Legal vigente; aplicabilidade de ações Médico-Legais no cotidiano da Medicina; familiarização com as técnicas utilizadas pela perícia Médico-Legal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de Medicina Legal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

EPIPHANIO, E.B.; VILELA, J.R.P.X. Perícias Médicas – Teoria e Prática. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009

LEME, Chou-En-Lay Paes. Medicina Legal Prática Compreensível. 1ª Ed. Barra do Garças,MT: ED. Do Autor, 2010.

BICLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

GALVÃO, Luis Carlos Cavalcante. Medicina Legal. 1ª Ed. São Paulo: Editora Santos, 2008.

HERCULES, Hygino de C. Medicina Legal – Texto e Atlas. 1ª Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.

CARDOSO, Leonardo Mendes. Medicina Legal para o Acadêmico de Direito. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2009.

FREIRE, José Josefran Berto. Medicina Legal: Fundamentos Filosóficos. 1ª Ed. São Paulo: Editora Leud, 2010.

MARANHÃO, Odon Ramos. Curso Básico de Medicina Legal. 8ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2005.

SAUDE DO ADULTO II (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Descrição dos principais das principais síndromes em Pneumologia e Cardiologia com sua classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos. Fundamentos do diagnóstico em Pneumologia e Cardiologia . Bases da terapêutica em Pneumologia e Cardiologia.

OBJETIVOS:

Ampliar e integrar os conhecimentos das principais patologias cardiopulmonares obtidos ao longo do curso bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes, visando a formação do médico generalista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Medicina Interna de Harrison - 18ª Ed, 2013

Tratado de Cardiologia Socesp – 3ª Ed. – 2015

Lopes, A.C. – Condutas em Cardiologia – 1º Ed. Atheneo, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7ª Ed, 2013

Timerman, Sérgio – Eletrocardiograma na sala de emergência – 2ª Ed Manole., 2014

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

SAUDE DA MULHER I (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos sobre o ciclo de vida feminino, para atuação do médico generalista na estratégia da saúde da família, contemplando as Ações Programáticas Estratégicas na Saúde da Mulher; Mortalidade Materna; Organismo feminino normal; Semiologia Ginecológica; Planejamento Familiar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Violência Sexual; Prevenção do Câncer Ginecológico; Organismo gravídico fisiológico; Assistência Pré-natal; Assistência ao Parto e Puerpério de Baixo Risco

OBJETIVOS:

Possibilitar ao aluno da graduação apropriar-se de conhecimentos teóricos e práticos da semiologia ginecológica e obstétrica, sedimentar os conhecimentos de anatomia e fisiologia da saúde da mulher; intervir na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação dos problemas de saúde considerados estratégicos na saúde da mulher. Fornecerá conhecimentos sobre estratégias preventivas para a manutenção da saúde das mulheres por meio de triagem das principais neoplasias da mulher.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1- Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.

2- Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016

3- Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1- Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora Revinter, 2011.

2- Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

3- Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da Mulher).

4- PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Ministério da Saúde,1985.

5- http://www.aids.gov.br/pagina/publicacoes (área técnica de DST)

6- Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

SAUDE DA CRIANÇA II (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Oferecer ao aluno oportunidade de aprendizado na área de Saúde da Criança, englobando o conceito da atenção integral à saúde da criança. Capacitar o aluno a:

Atendimento individual da criança com aprendizado em anamnese e exame físico

Formulações de hipóteses diagnósticas e condutas adequadas em doenças prevalentes na infância, baseado em evidencias cientificas.

Capacitar o aluno na prevenção, diagnóstico e tratamento específico nos acidentes mais comuns na infância.

Sensibilização e elaboração das vivências psicológicas relacionadas a relação médico-paciente no processo de profissionalização.

Discussão de temas relacionados a puberdade e adolescência em seus aspectos práticos

Reconhecimento da adequação e organização dos serviços, identificando os problemas mais comuns entre as crianças da região e suas necessidades individuais de saúde

OBJETIVOS:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas e semiologia pediátrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1) PEDIATRIA: Diagnóstico + Tratamento, 7. ed. 2013, editora SARVIER, autor: Jaime Murahovschi.

2) PEDIATRIA BÁSICA: Oitava edição, 1994, editora SARVIER, autor Eduardo Marcondes

3) LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 3.ed. Editora Manole, 20. Vol. 1 e 2.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIGUEIRA, Fernando. PEDIATRIA: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), Quarta edição, 2011, Editora Medbook.

KLIEGMAN, JENSON, BEHRMAN. Tratado de Pediatria –Nelson , 19. ed. 2013. Editora Elsevier.

SITE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Documentos e Informações. Disponível em: HTTP://www.sbp.com.br

Manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde. 2010. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à Saúde do Recém-Nascido (manual). 2.ed. 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf

CLINICA CIRURGICA I (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Descrição do conhecimento das principais patologias cirúrgicas digestivas, urológicas e oftalmológicas com ênfase em características clínicos-epidemiologicos, mecanismos fisiopatológicos e principais métodos diagnósticos. Descrição sucinta da terapêutica cirúrgica.

Oferecer conhecimentos teórico-práticos essenciais de Clínica Cirúrgica: semiologia, propedêutica e terapêutica das principais afecções de tratamento habitualmente cirúrgico (cirurgia geral não traumática e urologia).

Oferecer conhecimentos teórico-práticos de Clínica Cirúrgica: pela discussão e acompanhamento dos casos clínicos dos pacientes cirúrgicos (pré e pós-operatório) no ambulatório de especialidades da Unir (Posto Rafael Vaz e Silva).

OBJETIVOS:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas em clínica cirúrgica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Figueiredo, Ferreira e Monteiro; Tratado de oncologia – 1 ed. REVINTER

Mello & Rodrigues; Manual de cirurgia oncológica – 2 ed TECMEDD-PROMOÇÃO

Rapoport, Priscila Bogar; Manual de Otorrinolaringologia Para Médicos Generalistas

Editora ROCA, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brandão, Lenine Garcia; Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Fundamentos Para a Graduação Médica. Editora: SARVIER

Harley E.A. Bicas, André A.H. Jorge; Oftalmologia: fundamentos e aplicações – São Paulo: Tecmedd, 2007;

Jack J. Kanski e Brad Bowling; Oftalmologia Clínica: uma abordagem sistemática - Tradução – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012;

Manual de condutas em oftalmologia – Unifesp: Atheneu, 2008.

Delcio Matos; Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Coloproctologia. Unifesp. et Al.. Editora Manole. 2004.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Autores corporativos do American College of Surgeons. Manual do aluno, 9a Edição, 2010.

Mattox K, Feliciano DV, Moore, Ernest E. Trama- 4a Edição, editora Revinter, 2005.

Sabiston, DC. Tratado de Cirurgia. 18a Edição. Elsevier, 2009.

SCHWARTZ, S.L, Princípios de Cirurgia- 8a Edição, 2001

Luiz Rohde, Rotinas em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Artmed Editora 2005.

Saad Jr, R; Vianna, Rars; Carvalho, Wr; Moreira, A., Tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões). 1a Edição, Editora Atheneu, 2009.

Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R- Clínica Cirúrgica.. Volume 1 e 2. 1a Edição, Editora Manole, 2008

MÓDULO INTEGRATIVO VI (40 horas-aula – 2 créditos)

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

7º PERIODO

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias existentes em nossa região e no Brasil, inclusive as doenças emergentes causadas por vírus, bactérias, protozoários, helmintos e fungos. A disciplina focaliza especialmente os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, de controle e profilaxia. Noções sobre terapêutica das diversas doenças infectoparasitárias.

OBJETIVOS:

A disciplina Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) tem por OBJETIVO oferecer aos estudantes de graduação conhecimentos básicos sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias existentes em nossa região e no Brasil, inclusive as doenças emergentes causadas por vírus, bactérias, protozoários, helmintos e fungos. A disciplina focaliza especialmente os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, de controle e profilaxia. São ensinadas noções sobre terapêutica das diversas doenças infectoparasitárias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

R. Veronesi. Tratado de Infectologia, 2005.

J. R. Coura. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, 2006.

Doenças Infecciosas: Conduta Diagnóstica e Terapêutica. Mauro Schechter/Denise Marongoni, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A.C. Lopes. Tratado de Clínica Médica, 2006.

Doenças Infecciosas: Conduta Diagnóstica e Terapêutica. Mauro Schechter/Denise Marongoni, 1998.

Tonelli – Doenças Infecciosas na Infância, 2000

MANDELL, G.L.; BENNETT, J.E. DOLIN, R. (Eds.) Principles and practice of Infectious Diseases. 7th. Ed. New York, Churchil Livingstone Inc, 2002

Cook, C.G. (Eds.) Manson´s Tropical Diseases. Twentieht Ed. London, SW Saunders, 2.002

SAÚDE DO ADULTO III

Descrição dos principais das principais síndromes em Endocrinologia e Dermatologia com sua classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos.

Fundamentos do diagnóstico em Endocrinologia e Dermatologia.

Bases da terapêutica em Endocrinologia e Dermatologia

OBJETIVOS:

Ampliar e integrar os conhecimentos obtidos ao longo do curso bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes, visando a formação do médico generalista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Medicina Interna de Harrison - 18ª Ed, 2013

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7ª Ed, 2013

Bandeira e col. Endocrinologia e Diabetes - 2ª Ed. , Medbook 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Chacra AR. Endocrinologia Unifesp - 1ª Ed. , Manole 2009

Joslin. Diabetes Melito - 14ª.ed, Artmed, 2009

Greenspan G: Basic and Clinical Endocrinology – 9ª edição Mc Graw Lange Hill, New York, 2011

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

CLINICA CIRÚRGICA II (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Contribuir para a formação do médico generalista oferecendo informações gerais sobre cirurgia pediátrica, cabeça e pescoço e otorrinolaringologia. Noções de exames subsidiários para diagnóstico das doenças cirúrgicas mais prevalentes. Indicações terapêuticas das doenças cirúrgicas. Propedêutica cirúrgica para diagnóstico.

OBJETIVO:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas em clínica cirúrgica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SABISTON, DC. Tratado de Cirurgia. 19ª Edição. Elsevier, 2014.

SCHWARTZ, S.L. Princípios de Cirurgia: 9ª Edição, 2013

Manual de condutas em oftalmologia – Unifesp: Atheneu, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Harley E.A. Bicas, André A.H. Jorge; Oftalmologia: fundamentos e aplicações – São

Paulo: Tecmedd, 2007;

Jack J. Kanski e Brad Bowling; Oftalmologia Clínica: uma abordagem sistemática -Tradução – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012;

Mello & Rodrigues; Manual de cirurgia oncológica – 2 ed TECMEDD-PROMOÇÃO

Delcio Matos; Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Coloproctologia. Unifesp. Editora Manole. 2004.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Autores corporativos do American College of Surgeons. Manual do aluno, 9a Edição, 2010.

Mattox K, Feliciano DV, Moore, Ernest E. Trama- 4a Edição, editora Revinter, 2005.

Luiz Rohde, Rotinas em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Artmed Editora 2005.

Saad Jr, R; Vianna, Rars; Carvalho, Wr; Moreira, A., Tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões). 1a Edição, Editora Atheneu, 2009.

Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R- Clínica Cirúrgica.. Volume 1 e 2. 1a Edição, Editora Manole, 2008

RODRIGUES, J J; MACHADO, MC C; SAMIR, R. Clínica Cirúrgica. Gama- Volume 1 e 2. 1ª Edição, Editora Manole, 2008

SAÚDE DA MULHER II (120 horas-aula – 6 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos sobre a ginecologia geral e oncológica, bem como patologias obstétricas e parto distócico, que possibilite a atuação do médico generalista no âmbito do SUS.

OBJETIVO:

Possibilitar ao aluno da graduação apropriar-se de conhecimentos teóricos e práticos dos principais agravos oncológicos e urgências relacionadas à saúde da mulher, com ênfase na epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.
2. Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016
3. Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1- Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora Revinter, 2011.

2- Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

3-Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da Mulher).

4-PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Ministério da Saúde,1985.

5- http://www.aids.gov.br/pagina/publicacoes (área técnica de DST)

6- Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

Periódicos:

American Journal of Obstetrics & Gynecology

New England

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Breast Journal

Gynecologic Oncology

SAÚDE DA CRIANÇA III (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Oferecer ao aluno oportunidade de aprendizado na área de Saúde da Criança, englobando o conceito da atenção integral à saúde da criança. Capacitar o aluno a:

Atendimento individual da criança com aprendizado em anamnese e exame

Formulações de hipóteses diagnósticas e condutas adequadas em doenças prevalentes na infância, baseado em evidencias cientificas. Capacitar o aluno na prevenção, diagnóstico e tratamento específico nos acidentes mais comuns na infância.

Sensibilização e elaboração das vivências psicológicas relacionadas a relação médico-paciente no processo de profissionalização. Discussão de temas relacionados a puberdade e adolescência em seus aspectos práticos. Reconhecimento da adequação e organização dos serviços, identificando os problemas mais comuns entre as crianças da região e suas necessidades individuais de saúde

OBJETIVO:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas e semiologia pediátrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURAHOVSCHI, J. PEDIATRIA: Diagnóstico + Tratamento, 7. ed., editora SARVIER, 2013

MARCONDES , E. PEDIATRIA BÁSICA. 8 edição, editora SARVIER. 1994

LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 3.ed. Editora Manole, 20. Vol. 1 e 2.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à Saúde do Recém-Nascido (manual). 2.ed. 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIGUEIRA, Fernando. PEDIATRIA: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), Quarta edição, 2011, Editora Medbook.

KLIEGMAN, JENSON, BEHRMAN. Tratado de Pediatria –Nelson , 19. ed. 2013. Editora Elsevier.

SITE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Documentos e Informações. Disponível em: HTTP://www.sbp.com.br

Manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde. 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.

Periódicos disponíveis no Portal Periódicos CAPES

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Essa disciplina tem por finalidade a abordagem à respeito da gestão e planejamento em saúde, contextualizando os marcos e normativas legais do processo de descentralização da saúde, culminando nas formas de operacionalização deste processo atualmente. O projeto de ensino deverá ter como referência as reais necessidades de saúde da população, contribuindo para a construção do Sistema Único de Saúde, possibilitando que o aluno seja capaz de uma leitura e avaliação críticas da gestão descentralizada em saúde. Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de relacionar a importância da gestão e do planejamento em saúde, no contexto do cuidado em saúde, exercitando o planejamento estratégico em saúde, organizando o processo de trabalho na assistência ao usuário e na gestão dos serviços.

OBJETIVOS:

Discutir os marcos conceituais e legais dos processos de descentralização e de regionalização dos Serviços de Saúde; entender a relação entre o cuidado em saúde e a gestão dos serviços de saúde; adquirir noções de gerenciamento e planejamento em saúde; elaborar um plano de ação e apresentar de maneira escrita, na forma de relatório, e oral; dar continuidade às discussões referentes ao Sistema Único de Saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIAR, Zenaide Neto. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percurso, perspectiva e desafios. São Paulo: Martinari, 2011. 192p.

GONDIM, Roberta (Org.). Qualificação de gestores do SUS. / organizado por Roberta Gondim, Victor Grabois e Walter Mendes – 2. ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro, RJ: EAD/Ensp, 2011. 480 p.

PIANCASTELLI, Carlos Haroldo; FARIA, Horácio Pereira de; SILVEIRA, Marília Rezende da. O Trabalho em Equipe.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMPINAS. Onze Passos do Planejamento Estratégico-Participativo. Texto de apoio didático ao Curso de Gestão Estratégica Pública - Turma 2005. Prefeitura Municipal de Campinas.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

_____. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/9/1990, Página 18055. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-norma-pl.html. Acesso em: 28 jan. 2013.

_____. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm Acesso em: 28 jan. 2013.

_____. Decreto nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm. Acesso em: 25 jan. 2013.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Sistema de planejamento do SUS: uma construção coletiva: instrumentos básicos – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

_____. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.io Oficial da União - Seção 1 - 20/9/1990, Página 18055. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-norma-pl.html. Acesso em: 28 jan. 2013.

MÓDULO INTEGRATIVO VII (40 horas-aula – 2 créditos)

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

8º PERIODO

INTRODUTÓRIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (40 horas-aula – 2 créditos)

O Treinamento Introdutório em Saúde da Família visa discutir os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF) a fim de instrumentalizar os acadêmicos na organização inicial do seu processo de trabalho no internato em Saúde de Família e Comunidade.

OBJETIVOS:

Capacitar os acadêmicos para que possam avaliar, junto com a comunidade, a situação de saúde, no que se refere aos aspectos demográficos, sócioeconômicos, ambientais e sanitários de sua área de abrangência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CZERESNIA, Dina; FREIAS, Carlos Machado (org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. 2ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. 229p. ISBN 978-85-326-0579-5.

FONSECA. A.F. (Org.). O território e o processo saúde-doença. / Organizado por Angélica Ferreira Fonseca e Ana Maria D'Andrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, Serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. ISBN 85-87853-72-4.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FREIRE, Paulo; NOGUEIRA Adriano. Que fazer: Teoria e prática em educação popular. 10ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2009. 150p. ISBN 978-85-326-0579-5.

VIANA, Lucila Amaral. Processo Saúde – Doença. Especialização em saúde da Família. UNA-SUS/UNIFESP. Disponível em: http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_6.pdf Acesso em: 10/07/2014.

BATISTELLA, Carlos. Cap. 1 Saúde, Doença e Cuidado: complexidade teórica e necessidade histórica. IN: O território e o processo saúde-doença. Angélica Ferreira (Org.). Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

FLISCH, Tácia Maria Pereira et al. Como os profissionais da atenção primária percebem e desenvolvem a Educação Popular em Saúde? Interface (Botucatu), Botucatu, v.18, supl. 2, p. 1255-1268, 2014. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/icse/v18s2/1807-5762-icse-18-s2-1255.pdf. Acesso em 03 abr. 2017. http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622013.0344.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 150p. ISBN 978-85-7753-020-5.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Educação Permanente em Saúde: um movimento instituinte de novas práticas no Ministério da Saúde: Agenda 2014 – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 120 p. : il.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436 de 21 de Setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília: MS, 2017. Disponível em: http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017 Acesso em: 28/09/2017.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção básica. Manual de Uso do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC v2.2.0 (Preliminar) Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus/manual_pec_2_2/index.php

PSIQUIATRIA (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Descrição dos principais sintomas psiquiátricos, síndromes e transtornos. Sua Classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos. Fundamentos do diagnóstico psiquiátrico. Bases da terapêutica psiquiátrica.

OBJETIVOS:

Ampliar e integrar os conhecimentos da Psiquiatria obtidos ao longo do curso bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes, visando a formação do médico generalista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Cordás, T. A. ; Moreno, R. A. Condutas em Psiquiatria: Consulta Rápida - Cordás - 2ª edição. Artmed, 2018.

Toy, E. C.; Klamen, D. Casos Clínicos em Psiquiatria - Toy - 4ª edição. McGraw, 2014.

Cantilino, A. Psiquiatria Clínica - Um Guia Para Médicos e Profissionais de Saúde Mental - Cantilino - 1ª edição. Medobook, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Medina, A. Elementos de Psiquiatria - Uma Perspectiva Conceitual - Medina - 1ª edição. Dilivros, 2016.

Taborda JGV, Prado Lima P e Busnello Ed. Rotinas em Psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas,1995

Nunes P, Bueno JR e Nardi, AE.Psiquiatria e Saúde Mental. São Paulo:Editora Atheneu, 1996

New England Journal Of Medicine www.nejm.org

British Medical Journal www.bmj.com

SAUDE DO ADULTO IV (80 horas-aula – 4 créditos)

EMENTA:

Descrição dos principais das principais síndromes em Hematologia e Reumatologia com sua classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos.

Fundamentos do diagnóstico em Hematologia e Reumatologia .

Bases da terapêutica em Hematologia e Reumatologia.

OBJETIVOS:

Ampliar e integrar os conhecimentos das principais doenças hematológicas e reumatológicas obtidos ao longo do curso bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes, visando a formação do médico generalista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Medicina Interna de Harrison - 18a Ed, 2013

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7a Ed, 2013

Ausiello, D. e Goldman, L. Cecil Tratado de Medicina Interna 2 volumes. 25ª edição. Elsevier, 2018.

BIBLIOGRARIA COMPLEMENTAR:

Martins, M. A. Manual do Residente de Clínica Médica FMUSP - Martins - 2ª edição, Manole, 2017.

Nunes, Caio - Barros, Diego - Santana, Marcos Antonio Costa Campos de. 100 Casos Clínicos em Medicina - Esquematizados e Comentados. Sanar, 2015.

Sousa, A. Tratado de Doença Arterial Coronária. Atheneu, 2017.

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

CLINICA CIRÚRGICA III (100 horas-aula – 5 créditos)

EMENTA:

Contribuir para a formação do médico generalista oferecendo informações gerais sobre cirurgia plástica, oncológica, traumalologia e ortopedia. Noções de exames subsidiários para diagnóstico das doenças cirúrgicas mais prevalentes. Indicações terapêuticas das doenças cirúrgicas. Propedêutica cirúrgica para diagnóstico

OBJETIVO:

Construir as competências necessárias para as indicações terapêuticas em clínica cirúrgica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Thorne, C. H. Grabb & Smith's - Cirurgia Plástica. Revinter, 2018.

SABISTON, DC. Tratado de Cirurgia. 19ª Edição. Elsevier, 2014.

SBOT, Traumatologia Ortopédica , Revinter, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SCHWARTZ, S.L. Princípios de Cirurgia: 9ª Edição, 2013

SAAD JR, R; VIANNA, RARS; Carvalho, MOREIRA Wr; tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões)., A. 1ª Edição, Editora Atheneu, 2009.

Mattox K, Feliciano DV, Moore, Ernest E. Trauma- 4a Edição, editora Revinter, 2005.

Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R- Clínica Cirúrgica.. Volume 1 e 2. 1a Edição, Editora Manole, 2008

RODRIGUES, J J; MACHADO, MC C; SAMIR, R. Clínica Cirúrgica. Gama- Volume 1 e 2. 1ª Edição, Editora Manole, 2008

SAUDE DO ADULTO V (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

Descrição dos principais das principais síndromes em Neurologia e Oncologia Clínica com sua classificação, epidemiologia, fatores etiológicos e patogênicos.

Fundamentos do diagnóstico em Neurologia e Oncologia clínica .

Bases da terapêutica em Neurologia e Oncologia clínica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos em ectoscopia das principais síndromes clínicas, bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes frente ao paciente e suas queixas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Duus Diagnóstico Topográfico em Neurologia - 5ª Ed, Dilivros, 2015

Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP-EPM, Neurologia - 1ª Ed, Manole, 2011

Brazis, Masdeu e Biller - Localização em Neurologia Clínica - 6a Ed, Dilivros, 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Nitrini e Bacheschi - A Neurologia que Todo Médico Deve Saber - 3a Ed, Atheneu, 2015

Campbell - Dejong O Exame Neurológico - 6a Ed, Guanabara Koogan, 2007

Sanvito - Propedêutica Neurológica Básica - 2a Ed, Atheneu, 2010

Machado - Neuroanatomia Funcional - 3a Ed, Atheneu, 2013

Neto e Takayanagi - Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia - 2a Ed, Elsevier, 2013

Adams and Victor - Principles of Neurology - 10a Ed, McGraw-Hill, 2014

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

Portal de Periódicos da Capes

PUBMED - www.pubmed.org

Arquivos Brasileiros de Neuropsiquiatria - www.scielo.org

Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia - www.sbn.com.br

Jornal Brasileiro de Neurocirurgia - www.abnc.org

Neurology - www.neurology.org

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS (60 horas-aula – 3 créditos)

EMENTA:

A medicina de emergência e as habilidades e competências necessárias ao exercício profissional. Abordagem inicial ao paciente crítico e potencialmente crítico, visando a sistematização do atendimento inicial. Grandes temas em medicina de emergência, a partir da abordagem da medicina baseada em evidências. Introdução aos principais conceitos relacionados ao suporte básico e avançado em emergências cardiovasculares. Desenvolvimento de raciocínio clínico sistematizado frente ao atendimento das principais emergências clínicas que se apresentam a Sala de Emergência, conforme preconizado pela Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em medicina.

OBJETIVOS:

A disciplina propõe oportunizar aos alunos a construção e aquisição de saberes teóricos e práticos relacionados ao diagnóstico e tratamento das principais emergências clínicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARTINS, H.S.; NETO, R.A.B.; VELASCO, I.T. Medicina de Emergência – Abordagem Prática. 12ª ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

FRIEDMANN. A.A., et al. Diagnóstico Diferencial no Eletrocardiograma. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2011.

SCHETTINO, G., et al. Paciente Crítico – Diagnóstico e Tratamento. Hospital Sírio-Libanês. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.

KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 4ª ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2016.

LINK, M.S., et al. Part 7: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S444-S464

MENDES, C.L.; AZEVEDO, L.C.P.; MACHADO, F.M. Sepse. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 19, vol. 22, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2014.

MENDES, C.L., et al. Cuidados Neurointensivos. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 18, vol. 19, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2013.

Periódicos:

New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org

JAMA: https://jamanetwork.com/journals/jama

Critical Care Medicine: https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx

Intensive Care Medicine: http://icmjournal.esicm.org/index.html

INFORMÁTICA MÉDICA (40 horas-aula – 2 créditos)

EMENTA:

Apresentar ao aluno temas de Informática Médica e ferramentas de informática para apoio ao futuro médico em suas atividades.

OBJETIVO:

A Informática Médica ou Informática em Saúde (em Inglês Medical Informatics) é definida

por Blois e Shortliffe (1990) como "um campo de rápido desenvolvimento científico que lida com armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimento biomédicos para a resolução de problemas e tomada de decisão".

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Journal of Health Informatics http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/index

Journal of the American Medical Informatics Association - JAMIA http://jamia.oxfordjournals.org

International Journal of Medical Informatics http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-medical-informatics/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Medical Image Analysis http://www.medicalimageanalysisjournal.com

Journal of Medical Internet Research

Medical Decision Making

Journal of Biomedical Informatics

BMC Medical Research Methodology

Artificial Intelligence in Medicine

CIN: Computers Informatics Nursing.

MÓDULO INTEGRATIVO VIII (40 horas-aula – 2 créditos)

Momento de integração dos conteúdos dos componentes curriculares do período corrente, problematizando conforme realidade local e complexidade de aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Todos os títulos utilizados nos demais componentes curriculares do período.

9º PERIODO

INTERNATO

A carga horária total do internato é de 3600 horas/aula, respeitando a determinação de no mínimo 35% da carga horária total do curso, sendo que 800 horas são desenvolvidas na atenção básica (dois estágios específicos, de 300 horas cada um e 200 horas de atividades da Saúde da Criança e da Saúde da Mulher, que são desenvolvidas na Atenção Básica) e 540 horas estágio na urgência e emergência (um módulo específico de 300 horas e 240 horas dos módulos de clínica médica e cirurgia), também conforme o que estabelecem as DCN: no mínimo 30% da carga horária total do internato deve ser desenvolvida na Atenção Básica e na Urgência e Emergência, sendo que a maior parte deve ser realizada na Estratégia da Saúde da Família (art. 24 das DCN). Como os estágios nestas áreas totalizam 1340 horas, correspondem a 37% da carga horária total do internato.

PEDIATRIA I (300 horas-aula – 15 créditos)

Caracterização da assistência ao paciente pediátrico, reconhecendo suas peculiaridades desde o nascimento ao início da idade adulta, em todos os níveis de atenção: promoção à saúde, prevenção de doenças, atendimento das enfermidades mais prevalentes na infância e recuperação e reabilitação com ênfase na assistência integral de acordo com as necessidades individuais e coletivas em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar na região amazônica a partir do desenvolvimento de habilidades, competências, de princípios éticos e do relacionamento interdisciplinar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811 p.

LOPEZ, F. A.; CAMPOS JÚNIOR, D. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 3000 p.

CAMPOS JÚNIOR D. TRATADO DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO, RIO DE JANEIRO: EDITORA MANOLE, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :

BICKLEY LS. BATE'S GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING. 10TH. LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINGS, 2008.

CARVALHO E; SILVA LR; FERREIRA CT. GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

CLOHERTY J; EICHENWALD E.C; HANSEN A.R.; STARK A. MANUAL OF NEONATAL CARE. LIPPIMCOTT WILLIANS & WILKINS, 2012

GLEASON CA; DEVASKAR S. AVERY'S DISEASES OF THE NEWBORN. 9A EDIÇÃO. SAUNDERS 2011

MARTIN RJ, FANAROFF A A, .WALSH M. FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL-PERINATAL MEDICINE: DISEASES OF THE FETUS AND INFANT .9A EDIÇÃO. EDITORA SAUNDER ELSEVIER, 2010

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

OBJETIVOS:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, Gustavo;LOPES, José Mauro; Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Ed. ARTMED 1º Edição 2012.

DUCAN, Bruce. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª Edição. Editora Artmed.

WAGNER, Gastão Tratado de Saúde da Família e Comunidade

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TENORIO, Gustavo, A clinica ampliada na atenção básica.

ESTARFIELD, Barbara , Atenção Primaria

WONCA, definições e diretrizes da Medicina de Família

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Condutas Médicas. Universidade de São Paulo, 2002.

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Ed. Medsi, 6a Edição, 2003.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 7a Edição, 2003

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA I

EMENTA:

Organismo feminino normal; Semiologia Ginecológica; Planejamento Familiar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Violência Sexual; Prevenção do Câncer Ginecológico; Organismo gravídico fisiológico; Assistência Pré-natal; Assistência ao Parto e Puerpério de Baixo Risco.

OBJETIVOS:

Possibilitar ao aluno de graduação atividades eminentemente práticas a nível de Ginecologia básica e Obstetrícia de baixo risco possibilitando interação com equipe multidisciplinar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.

Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016

Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora Revinter, 2011.

Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da Mulher).

PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Ministério da Saúde,1985.

http://www.aids.gov.br/pagina/publicações (área técnica de DST)

Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

PERIÓDICOS:

American Journal of Obstetrics & Gynecology

New England of Journal

International Journal of Gynecology & Obstetrics

CLINICA MEDICA I (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

O vasto universo de enfermidades contempladas pela grande área de Clínica Médica / Medicina Interna e suas especialidades permite oferecer um internato médico onde se pode exercitar o espírito crítico, a assimilação de conhecimentos científicos, a prática do

raciocínio clínico e a definição diagnóstica seguida de condutas bem definidas, com a devida supervisão, proporcionando a verdadeira ação médica. O compromisso do serviço com a proficiência profissional, com a seriedade do ensino médico. Estudo global das enfermidades clínicas mais comuns. Medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica.

OBJETIVOS:

Treinamento intensivo na identificação e tratamento das enfermidades clínicas mais comuns e aplicação de medidas de prevenção. Desenvolver no aluno a capacidade de abordar os problemas dos pacientes sob o ponto de vista de cuidado global , através da aplicação prática dos conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas afins, propondo planos diagnósticos, terapêuticos e educacionais para os mesmos. Importante revisitar as bases da Medicina, principalmente a Semiologia – anamnese e exame físico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Milton de Arruda e outros. Clínica Médica – FMUSP Vol 1,2,3,4,5,6,7 –; Editora Manole

HARRISON - MEDICINA INTERNA - 2 VOLUMES - 17ª EDIÇÃO

BRAUNWALD, LOSCALZO, FAUCI, HAUSER, JAMESON, KASPER, LONGO - Editora Mcgraw Hill

CECIL MEDICINA - EXPERT CONSULT - 2 VOLUMES - 23ª EDIÇÃO - 2011

GOLDMAN, LEE - Editora Elsevier

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA - 3 VOLUMES - 2ª EDIÇÃO

ANTONIO CARLOS LOPES - Editora Roca

STEPHEN MCPHEE, MAXINE PAPADAKIS - Current Medical Diagnosis and Treatment Editora Mcgraw Hill 2010 - 49ª Edição

DIRETRIZES DAS SOCIEDADES BRASILEIRAS DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS

- http://publicacoes.cardiol.br/consenso/ - Sociedade Brasileira de Cardiologia

- www.projetodiretrizes.org.br - Diretrizes AMB / CFM

Principais periódicos de medicina / clínica médica

www.nejm.org - New England Journal of Medicine

www.lancet.com – The Lancet

www.annals.org – Annals of Internal Medicine

www.jama.ama-assn.org - The Journal of American Medical Association

www.archinte.ama-assn.org – Archives of Internal Medicine

www.ccjm.org - Cleveland Clinic Journal of Medicine

CLINICA CIRURGICA I (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Princípios gerais: avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico; distúrbios hidroeletrolíticos do paciente cirúrgico; equilíbrio hidro-salino e ácido-básico; complicações da ferida operatória; hematomas, seromas, infecções de sítio cirúrgico, deiscência.
Cirurgia geral: complicações em cirurgia gastrointestinal (mais frequentes); doença litiásica das vias biliares; hérnias da parede abdominal; neoplasia de cólon e estômago; Urologia: Nefrolitíase e Hiperplasia Prostática Benigna; Proctologia: Noções gerais das patologias orificiais

OBJETIVOS:

Desenvolver atividades teórico-práticas em nível hospitalar como parte da formação médica;

Possibilitar o adestramento prático supervisionado, hospitalar e ambulatorial, propiciando ao aluno a aquisição de conhecimentos preliminares em cirurgia para empregar na prática médica;

Desenvolver e aperfeiçoar as de atitudes adequadas à assistência aos pacientes;

Possibilitar a prática da assistência integral, através da inter-relação dos diversos profissionais da equipe de saúde;

Estimular a formação que motive os futuros médicos a melhorar continuamente suas habilidades;

Proporcionar uma formação ética dentro dos mais elevados padrões morais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1- Tratado de Cirurgia. SABISTON, DC. 18ª Edição. Elsevier, 2009.

2- Princípios de Cirurgia . SCHWARTZ, S.L.: 8ª Edição, 2001

3- Manual de cirurgia oncológica. Eduardo Linhares Riolo de Melo. 2ª Edição. Editora Tecmedd. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Coloproctologia. Unifesp. Delcio Matos et Al.. Editora Manole. 2004.

Rotinas em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Luiz Rohde. Artmed Editora 2005.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Autores corporativos do American College of Surgeons. Manual do aluno, 9ª Edição, 2010

Tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões). Saad Jr, R; Vianna, Rars; Carvalho, Wr; Moreira, A. 1ª Edição, Editora Atheneu, 2009.

Trauma. Mattox, K; Feliciano, DV; Moore, Ernest, E. . 4ª Edição, editora Revinter, 2005.

Clínica Cirúrgica. Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R. Volume 1 e 2. 1ª Edição, Editora Manole, 2008

MEDICINA DE EMERGÊNCIA

EMENTA:

Este estágio objetiva desenvolver competências relacionadas ao futuro exercício profissional, com ênfase nas Urgências e Emergências Clínicas. Desta forma, o estágio proporcionará aos alunos do 5º ano, ambientes de aprendizagem em serviço capazes de contribuir no desenvolvimento de capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas ao realizar o cuidado ao nível da atenção secundária e terciária, ressaltando a integralidade da assistência médica, com conhecimento da realidade da população local em todos os seus aspectos, compreendendo as possibilidades e limites do serviço (gerenciais, organizacionais e administrativos), aproximação com diferentes instituições, com a equipe de saúde e os diversos atores sociais envolvidos nas diversas ações em saúde.

OBJETIVOS:

Este estágio objetiva desenvolver competências relacionadas ao futuro exercício profissional, com ênfase nas Urgências e Emergências Clínicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARTINS, H.S.; NETO, R.A.B.; VELASCO, I.T. Medicina de Emergência – Abordagem Prática. 12ª ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

FRIEDMANN. A.A., et al. Diagnóstico Diferencial no Eletrocardiograma. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2011.

SCHETTINO, G., et al. Paciente Crítico – Diagnóstico e Tratamento. Hospital Sírio-Libanês. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC / Ministério da Saúde, Secretaria

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.

KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 4a ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2016.

LINK, M.S., et al. Part 7: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S444-S464

MENDES, C.L.; AZEVEDO, L.C.P.; MACHADO, F.M. Sepse. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 19, vol. 22, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2014.

MENDES, C.L., et al. Cuidados Neurointensivos. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 18, vol. 19, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2013.

Periódicos:

New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org

JAMA: https://jamanetwork.com/journals/jama

Critical Care Medicine: https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx

Intensive Care Medicine: http://icmjournal.esicm.org/index.html

10º PERIODO

INTERNATO

A carga horária total do internato é de 3600 horas/aula, respeitando a determinação de no mínimo 35% da carga horária total do curso, sendo que 800 horas são desenvolvidas na atenção básica (dois estágios específicos, de 300 horas cada um e 200 horas de atividades da Saúde da Criança e da Saúde da Mulher, que são desenvolvidas na Atenção Básica) e 540 horas estágio na urgência e emergência (um módulo específico de 300 horas e 240 horas dos módulos de clínica médica e cirurgia), também conforme o que estabelecem as DCN: no mínimo 30% da carga horária total do internato deve ser

desenvolvida na Atenção Básica e na Urgência e Emergência, sendo que a maior parte deve ser realizada na Estratégia da Saúde da Família (art. 24 das DCN). Como os estágios nestas áreas totalizam 1340 horas, correspondem a 37% da carga horária total do internato.

PEDIATRIA I (300 horas-aula – 15 créditos)

Caracterização da assistência ao paciente pediátrico, reconhecendo suas peculiaridades desde o nascimento ao início da idade adulta, em todos os níveis de atenção: promoção à saúde, prevenção de doenças, atendimento das enfermidades mais prevalentes na infância e recuperação e reabilitação com ênfase na assistência integral de acordo com as necessidades individuais e coletivas em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar na região amazônica a partir do desenvolvimento de habilidades, competências, de princípios éticos e do relacionamento interdisciplinar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811 p.

LOPEZ, F. A.; CAMPOS JÚNIOR, D. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 3000 p.

CAMPOS JÚNIOR D. TRATADO DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO, RIO DE JANEIRO: EDITORA MANOLE, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :

BICKLEY LS. BATE'S GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING. 10TH. LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINGS, 2008.

CARVALHO E; SILVA LR; FERREIRA CT. GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

CLOHERTY J; EICHENWALD E.C; HANSEN A.R.; STARK A. MANUAL OF NEONATAL CARE.

LIPPIMCOTT WILLIANS & WILKINS, 2012

GLEASON CA; DEVASKAR S. AVERY'S DISEASES OF THE NEWBORN. 9A EDIÇÃO. SAUNDERS 2011

MARTIN RJ, FANAROFF A A, .WALSH M. FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL-PERINATAL MEDICINE: DISEASES OF THE FETUS AND INFANT .9A EDIÇÃO. EDITORA SAUNDER ELSEVIER, 2010

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

OBJETIVOS:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro; Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Ed. ARTMED 1º Edição 2012.

DUCAN, Bruce. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª Edição. Editora Artmed.

WAGNER, Gastão Tratado de Saúde da Família e Comunidade

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TENORIO, Gustavo, A clinica ampliada na atenção básica.

ESTARFIELD, Barbara , Atenção Primaria

WONCA, definições e diretrizes da Medicina de Família

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Condutas Médicas. Universidade de São Paulo, 2002.

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Ed. Medsi, 6a Edição, 2003.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 7a Edição, 2003

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA I

EMENTA:

Organismo feminino normal; Semiologia Ginecológica; Planejamento Familiar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Violência Sexual; Prevenção do Câncer Ginecológico; Organismo gravídico fisiológico; Assistência Pré-natal; Assistência ao Parto e Puerpério de Baixo Risco.

OBJETIVOS:

Possibilitar ao aluno de graduação atividades eminentemente práticas a nível de Ginecologia básica e Obstetrícia de baixo risco possibilitando interação com equipe multidisciplinar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.

Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016

Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora

Revinter, 2011.

Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da Mulher).

PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Ministério da Saúde,1985.

http://www.aids.gov.br/pagina/publicações (área técnica de DST)

Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

PERIÓDICOS:

American Journal of Obstetrics & Gynecology

New England of Journal

International Journal of Gynecology & Obstetrics

CLINICA MEDICA I (300 horas-aula – 15 créditos)

O vasto universo de enfermidades contempladas pela grande área de Clínica Médica / Medicina Interna e suas especialidades permite oferecer um internato médico onde se pode exercitar o espírito crítico, a assimilação de conhecimentos científicos, a prática do raciocínio clínico e a definição diagnóstica seguida de condutas bem definidas, com a devida supervisão, proporcionando a verdadeira ação médica. O compromisso do serviço com a proficiência profissional, com a seriedade do ensino médico. Estudo global das enfermidades clínicas mais comuns. Medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica.

OBJETIVOS:

Treinamento intensivo na identificação e tratamento das enfermidades clínicas mais comuns e aplicação de medidas de prevenção. Desenvolver no aluno a capacidade de

abordar os problemas dos pacientes sob o ponto de vista de cuidado global , através da aplicação prática dos conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas afins, propondo planos diagnósticos, terapêuticos e educacionais para os mesmos. Importante revisitar as bases da Medicina, principalmente a Semiologia – anamnese e exame físico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Milton de Arruda e outros. Clínica Médica – FMUSP Vol 1,2,3,4,5,6,7 –; Editora Manole

HARRISON - MEDICINA INTERNA - 2 VOLUMES - 17ª EDIÇÃO

BRAUNWALD, LOSCALZO, FAUCI, HAUSER, JAMESON, KASPER, LONGO - Editora Mcgraw Hill

CECIL MEDICINA - EXPERT CONSULT - 2 VOLUMES - 23ª EDIÇÃO - 2011

GOLDMAN, LEE - Editora Elsevier

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA - 3 VOLUMES - 2ª EDIÇÃO

ANTONIO CARLOS LOPES - Editora Roca

STEPHEN MCPHEE, MAXINE PAPADAKIS - Current Medical Diagnosis and Treatment Editora Mcgraw Hill 2010 - 49ª Edição

DIRETRIZES DAS SOCIEDADES BRASILEIRAS DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS

- http://publicacoes.cardiol.br/consenso/ - Sociedade Brasileira de Cardiologia

- www.projetodiretrizes.org.br - Diretrizes AMB / CFM

Principais periódicos de medicina / clínica médica

www.nejm.org - New England Journal of Medicine

www.lancet.com – The Lancet

www.annals.org – Annals of Internal Medicine

www.jama.ama-assn.org - The Journal of American Medical Association

www.archinte.ama-assn.org – Archives of Internal Medicine

www.ccjm.org - Cleveland Clinic Journal of Medicine

CLINICA CIRURGICA I (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Princípios gerais: avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico; distúrbios hidroeletrolíticos do paciente cirúrgico; equilíbrio hidro-salino e ácido-básico; complicações da ferida operatória; hematomas, seromas, infecções de sítio cirúrgico, deiscência.

Cirurgia geral: complicações em cirurgia gastrointestinal (mais frequentes); doença litiásica das vias biliares; hérnias da parede abdominal; neoplasia de cólon e estômago; Urologia: Nefrolitíase e Hiperplasia Prostática Benigna; Proctologia: Noções gerais das patologias orificiais

OBJETIVOS:

Desenvolver atividades teórico-práticas em nível hospitalar como parte da formação médica;

Possibilitar o adestramento prático supervisionado, hospitalar e ambulatorial, propiciando ao aluno a aquisição de conhecimentos preliminares em cirurgia para empregar na prática médica;

Desenvolver e aperfeiçoar as de atitudes adequadas à assistência aos pacientes;

Possibilitar a prática da assistência integral, através da inter-relação dos diversos profissionais da equipe de saúde;

Estimular a formação que motive os futuros médicos a melhorar continuamente suas habilidades;

Proporcionar uma formação ética dentro dos mais elevados padrões morais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1- Tratado de Cirurgia. SABISTON, DC. 18ª Edição. Elsevier, 2009.

2- Princípios de Cirurgia . SCHWARTZ, S.L.: 8ª Edição, 2001

3- Manual de cirurgia oncológica. Eduardo Linhares Riolo de Melo. 2ª Edição. Editora Tecmedd. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Coloproctologia. Unifesp. Delcio Matos et Al.. Editora Manole. 2004.

Rotinas em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Luiz Rohde. Artmed Editora 2005.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Autores corporativos do American College of Surgeons. Manual do aluno, 9ª Edição, 2010

Tratado de cirurgia do CBC (Colégio Brasileiro DOS Cirurgiões). Saad Jr, R; Vianna, Rars; Carvalho, Wr; Moreira, A. 1ª Edição, Editora Atheneu, 2009.

Trauma. Mattox, K; Feliciano, DV; Moore, Ernest, E. . 4ª Edição, editora Revinter, 2005.

Clínica Cirúrgica. Gama-Rodrigues, J J; Machado, Mc C; Samir, R. Volume 1 e 2. 1ª Edição, Editora Manole, 2008

MEDICINA DE EMERGÊNCIA (300 horas-aula – 15 créditos

EMENTA:

Este estágio objetiva desenvolver competências relacionadas ao futuro exercício profissional, com ênfase nas Urgências e Emergências Clínicas. Desta forma, o estágio proporcionará aos alunos do 5º ano, ambientes de aprendizagem em serviço capazes de contribuir no desenvolvimento de capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas ao realizar o cuidado ao nível da atenção secundária e terciária, ressaltando a integralidade da assistência médica, com conhecimento da realidade da população local em todos os

seus aspectos, compreendendo as possibilidades e limites do serviço (gerenciais, organizacionais e administrativos), aproximação com diferentes instituições, com a equipe de saúde e os diversos atores sociais envolvidos nas diversas ações em saúde.

OBJETIVOS:

Este estágio objetiva desenvolver competências relacionadas ao futuro exercício profissional, com ênfase nas Urgências e Emergências Clínicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARTINS, H.S.; NETO, R.A.B.; VELASCO, I.T. Medicina de Emergência – Abordagem Prática. 12ª ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

FRIEDMANN. A.A., et al. Diagnóstico Diferencial no Eletrocardiograma. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2011.

SCHETTINO, G., et al. Paciente Crítico – Diagnóstico e Tratamento. Hospital Sírio-Libanês. 2ª ed. São Paulo, SP: Manole, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.

KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 4a ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2016.

LINK, M.S., et al. Part 7: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S444-S464

MENDES, C.L.; AZEVEDO, L.C.P.; MACHADO, F.M. Sepse. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 19, vol. 22, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2014.

MENDES, C.L., et al. Cuidados Neurointensivos. Clínicas em Medicina Intensiva Brasileira, ano 18, vol. 19, ed. Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 2013.

Periódicos:

New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org

JAMA: https://jamanetwork.com/journals/jama

Critical Care Medicine: https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx

Intensive Care Medicine: http://icmjournal.esicm.org/index.html

---

11º PERIODO

INTERNATO

PEDIATRIA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Caracterização da assistência ao paciente pediátrico, reconhecendo suas peculiaridades desde o nascimento ao inicio da idade adulta, em todos os níveis de atenção: promoção à saúde, prevenção de doenças, atendimento das enfermidades mais prevalentes na infância e recuperação e reabilitação com ênfase na assistência integral de acordo com as necessidades individuais e coletivas em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar na região amazônica a partir do desenvolvimento de habilidades, competências, de princípios éticos e do relacionamento interdisciplinar.

OBJETIVOS:

Habilitar o aluno ao atendimento integral da criança e do adolescente, como complemento a formação de um medico generalista, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e pelo desenvolvimento do raciocínio diagnostico e da capacidade terapêutica em pediatria no atendimento as doenças prevalentes na infância com respeito aos preceitos éticos e humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1- BEHRMAN RE, KLIEGMAN E E JENSON HB - NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS - EDITORA ELSEVIER LOPEZ

2- FA, CAMPOS JR. D E COLS - TRATADO DE PEDIATRIA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA) - EDITORA MANOLE
3- HAY W, LEVIN M, DETERDING R, SONDHEIMER J. - CURRENT: DIAGNOSIS AND TREATMENT PEDIATRICS - EDITORA THE MCGRAW HILL (ISBN: 978-0071827348)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :

PIVA J; GARCIA PCR - MEDICINA INTENSIVA EM PEDIATRIA: PIVA E CELINY - EDITORA REVINTER (ISBN: 9788537206010)

LEÃO, E; CORÊA, E.J.; MOTA, J.A.C; VIANA, M.B. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte. Coopmed. 2005.1034p

ALVES CAD. FLUXOGRAMAS: ENDOCRINOLOGIA PARA O PEDIATRA. UFBA, 2011

BICKLEY LS. BATE'S GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING. 10TH. LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINGS, 2008.

CARVALHO E; SILVA LR; FERREIRA CT. GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

CLOHERTY J; EICHENWALD E.C; HANSEN A.R.; STARK A. MANUAL OF NEONATAL CARE. LIPPIMCOTT WILLIANS & WILKINS, 2012

COATES V, BEZNOS G, FRANÇOSO L. MEDICINA DO ADOLESCENTE. 2ª EDIÇÃO. EDITORA SARVIER, SÃO PAULO, 2003.

CRESPIN J, RENATO LFN. HEBEATRIA: MEDICINA DA ADOLESCÊNCIA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA ROCA. SÃO PAULO, 2007.

CROCETTI M, BARONE M. FUNDAMENTOS DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO. EDITORA GUANABARA KOOGAN, 2007.

FREIRE LMS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM PEDIATRIA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2008.

GLEASON CA; DEVASKAR S. AVERY'S DISEASES OF THE NEWBORN. 9A EDIÇÃO. SAUNDERS 2011 ISSLER H.

O ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO ATUAL: POLÍTICAS, PRÁTICA E BASES CIENTÍFICAS. EDITORA SARVIER, 2008.

CAMPOS JÚNIOR D. TRATADO DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO, RIO DE JANEIRO: EDITORA MANOLE, 2010.

MARCONDES E; VAZ FAC; RAMOS JLA; OKAY Y. PEDIATRIA BÁSICA. 9ª EDIÇÃO, SÃO PAULO: EDITORA SARVIER, 2002.

MARTIN RJ, FANAROFF A A, .WALSH M. FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL-PERINATAL MEDICINE: DISEASES OF THE FETUS AND INFANT .9A EDIÇÃO. EDITORA SAUNDER ELSEVIER, 2010

OLIVEIRA RG. BLACKBOOK – PEDIATRIA. 3 ED. BLACK BOOK EDITORA. 640P. 2005.

SAITO MI, SILVA LEV, LEAL MM. ADOLESCÊNCIA: PREVENÇÃO E RISCO. 2ª EDIÇÃO. EDITORA ATHENEU, SÃO PAULO, 2008.

SILVA LR; CARVALHO E; FERREIRA CT. HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

SILVA LR. DIAGNÓSTICO EM PEDIATRIA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2009.

SILVA LR, MENDONÇA DR, MOREIRA DEQ. PRONTO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA. 2ª ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2006.

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primária nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde neste município.

OBJETIVOS:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro; Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Ed. ARTMED 1º Edição 2012.

DUCAN, Bruce. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª Edição. Editora Artmed.

WAGNER, Gastão Tratado de Saúde da Família e Comunidade

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TENORIO, Gustavo, A clinica ampliada na atenção básica.

ESTARFIELD, Barbara , Atenção Primaria

WONCA, definições e diretrizes da Medicina de Família

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Condutas Médicas. Universidade de São Paulo, 2002.

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Ed. Medsi, 6a Edição, 2003.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 7a Edição, 2003

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos sobre a ginecologia geral e específica, bem como patologias obstétricas e parto distócico, que possibilite a atuação do médico generalista no âmbito do SUS.

OBJETIVOS:

Possibilitar ao aluno da graduação atividades eminentemente práticas a nível da atenção primária, secundária e terciária e assim consolidando o conhecimento teórico-prático adquirido nas disciplinas de pré-requisitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.

Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016

Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1- Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora Revinter, 2011.

2- Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

3-Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da Mulher).

4- http://www.aids.gov.br/pagina/publicacoes (área técnica de DST)

5- Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

CLINICA MEDICA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Estudo de temáticas e práticas que articulam a produção do conhecimento na grande área da clínica médica com treinamento em serviço, supervisionado por docente, objetivando adquirir conhecimentos sobre as patologias clínicas mais prevalentes, além da aquisição do manejo prático nas situações clínicas ambulatoriais, emergenciais e de pacientes internados em enfermarias em hospital geral.

OBJETIVOS:

Capacitar o interno quanto as seguintes competências e habilidades:

- Ampliar e integrar os conhecimentos obtidos ao longo do curso de graduação na grande área da Clínica Médica, com vistas à formação do médico generalista;

- Conhecer as doenças mais freqüentes, seus aspectos epidemiológicos, diagnósticos e terapêuticos;

- Aprimorar o adestramento em técnicas e habilidades indispensáveis aos exercícios de atos médicos básicos e de emergência no paciente clínico;

- Desenvolver o raciocínio clínico de diagnóstico e realizar diagnósticos diferenciais;

- Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;

- Tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos e de práticas;

- Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, com vistas à resolução do problema de saúde;

- Adquirir autonomia e postura investigadora, atualizada e crítica, tendo em vista a medicina como uma atividade de aprendizagem independente e permanente;

- Trabalhar em equipe multiprofissional promovendo a prática da assistência integrada, resolutiva e de qualidade;

- Aprimorar a relação médico-paciente;

- Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CECIL MEDICINA - EXPERT CONSULT - 2 VOLUMES - 23ª EDIÇÃO - 2011 *GOLDMAN, LEE - Editora Elsevier*

TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA - 3 VOLUMES - 2ª EDIÇÃO *ANTONIO CARLOS LOPES - Editora Roca*

STEPHEN MCPHEE, MAXINE PAPADAKIS Current Medical Diagnosis and Treatment 2010 -

49ª Edição - Editora Mcgraw Hill

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Clínica Médica – FMUSP Vol 1,2,3,4,5,6,7 – Milton de Arruda e outros ; Editora Manole

HARRISON - MEDICINA INTERNA - 2 VOLUMES - 17ª EDIÇÃO *BRAUNWALD, LOSCALZO, FAUCI, HAUSER, JAMESON, KASPER, LONGO - Editora Mcgraw Hill*

DIRETRIZES DAS SOCIEDADES BRASILEIRAS DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS

- http://publicacoes.cardiol.br/consenso/ - Sociedade Brasileira de Cardiologia

- www.projetodiretrizes.org.br - Diretrizes AMB / CFM

Principais periódicos de medicina / clínica médica

www.nejm.org - New England Journal of Medicine

www.lancet.com – The Lancet

www.annals.org – Annals of Internal Medicine

www.jama.ama-assn.org - The Journal of American Medical Association

www.archinte.ama-assn.org – Archives of Internal Medicine

www.ccjm.org - Cleveland Clinic Journal of Medicine

CLINICA CIRURGICA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Reconstruções em oncologia. Principios de cirurgia oncológica. Câncer gástrico. Câncer de cólon. Nódulo de tireóide e câncer de tireóide. Câncer de boca. Câncer de laringe. Sarcoma de partes moles. Melanoma. Câncer colorretal. GIST. Traqueostomias. Câncer de pele. Câncer de canal anal. Câncer de fígado e pâncreas. Procedimentos diagnósticos em imaginologia. Pé diabético. Doença arterial periférica obstrutiva. TVP. Diagnóstico e tratamento dos principais tipos de Fraturas. Imobilizações. Lesões ligamentares do joelho.

Abdome agudo não traumático. ATLS. Trauma abdominal. Trauma craniano. Trauma Raquimedular. Trauma de membros. Trauma tórax. Trauma cervical.

OBJETIVOS:

Treinar, de forma intensiva, os estudantes, na identificação e tratamento das enfermidades cirúrgicas mais comuns, com ênfase na abordagem pré e pós-operatória.

Desenvolver no aluno a capacidade de abordar os problemas dos pacientes sob o ponto de vista de cuidado global, através da aplicação prática dos conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas afins, propondo planos diagnósticos, terapêuticos e educacionais para os mesmos.

Atender de forma integral ao doente portador de problemas cirúrgicos mais comuns em enfermarias e ambulatórios;

Planejar a terapêutica de acordo com as evidências

Indicar internação hospitalar e conhecer os critérios de alta

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SABISTON, Tratado de cirurgia, 18 ed. ELSEVIER

FIGUEIREDO, FERREIRA E MONTEIRO, Tratado de oncologia – 1 ed. REVINTER

BRANDÂO, Lenine Garcia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Fundamentos Para a Graduação Médica. Editora: SARVIER

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Richard L. Drake; A. Wayne Vogl; Adam W. M. Mitchell. Gray's Anatomy for Students. Canada. Churchill Livingstone Elsevier: 2010

Courtney M. Towsend; Daniel Beauchamp; Mark Evers; Kenneth L. Mattox. Sabiston Textbook of Surgery - The biological basis of modern surgical practice Elsevier Saunders: 2012

Alan J. Wein; Louis R. Kavoussi; Andrew C. Novick; Alan W. Partin; Craig A. Peters. Campbell-Walsh UROLOGY. Philadelphia, PA, Elsevier Saunders: 2012

Nelson Rodrigues Netto Jr. Urologia Prática. São Paulo Editora Roca: 2008

Joaquim José Gama-Rodrigues; Marcel Cerqueira Cesar Machado; Samir Rasslan. Clínica Cirúrgica. São Paulo Editora Manole: 2008

Artigos científicos temas dos seminários.

OPCIONAL (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Neste módulo do internato, o estudante escolhe a área e o local, dentre aqueles conveniados com a UNIR, para o desenvolvimento de treinamento específico, podendo ser, inclusive, fora da unidade federada, respeitando os critérios para credenciamento da instituição, estabelecidos no Regimento do Internato.

OBJETIVOS:

Propiciar ao estudante a oportunidade de conhecer outros serviços, na área de interesse que mais lhe aprouver.

12º PERIODO

INTERNATO

PEDIATRIA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Caracterização da assistência ao paciente pediátrico, reconhecendo suas peculiaridades desde o nascimento ao inicio da idade adulta, em todos os níveis de atenção: promoção à saúde, prevenção de doenças, atendimento das enfermidades mais prevalentes na infância e recuperação e reabilitação com ênfase na assistência integral de acordo com as

necessidades individuais e coletivas em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar na região amazônica a partir do desenvolvimento de habilidades, competências, de princípios éticos e do relacionamento interdisciplinar.

OBJETIVOS:

Habilitar o aluno ao atendimento integral da criança e do adolescente, como complemento a formação de um medico generalista, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e pelo desenvolvimento do raciocínio diagnostico e da capacidade terapêutica em pediatria no atendimento as doenças prevalentes na infância com respeito aos preceitos éticos e humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811 p.

LOPEZ, F. A.; CAMPOS JÚNIOR, D. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.ed. Barueri: Manole, 2009. 3000 p.

BEHRMAN, R.E.; et al. Tratado de Pediatria – Nelson. 18. ed. São Paulo: Elsevier, 2009. 3568 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :

LEÃO, E; CORÊA, E.J.; MOTA, J.A.C; VIANA, M.B. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte. Coopmed. 2005.1034p

ALVES CAD. FLUXOGRAMAS: ENDOCRINOLOGIA PARA O PEDIATRA. UFBA, 2011

BICKLEY LS. BATE'S GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING. 10TH. LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINGS, 2008.

CARVALHO E; SILVA LR; FERREIRA CT. GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

CLOHERTY J; EICHENWALD E.C; HANSEN A.R.; STARK A. MANUAL OF NEONATAL CARE. LIPPIMCOTT WILLIANS & WILKINS, 2012

COATES V, BEZNOS G, FRANÇOSO L. MEDICINA DO ADOLESCENTE. 2ª EDIÇÃO. EDITORA SARVIER, SÃO PAULO, 2003.

CRESPIN J, RENATO LFN. HEBEATRIA: MEDICINA DA ADOLESCÊNCIA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA ROCA. SÃO PAULO, 2007.

CROCETTI M, BARONE M. FUNDAMENTOS DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO. EDITORA GUANABARA KOOGAN, 2007.

FREIRE LMS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM PEDIATRIA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2008.

GLEASON CA; DEVASKAR S. AVERY'S DISEASES OF THE NEWBORN. 9A EDIÇÃO. SAUNDERS 2011 ISSLER H.

O ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO ATUAL: POLÍTICAS, PRÁTICA E BASES CIENTÍFICAS. EDITORA SARVIER, 2008.

CAMPOS JÚNIOR D. TRATADO DE PEDIATRIA. 2ª EDIÇÃO, RIO DE JANEIRO: EDITORA MANOLE, 2010.

MARCONDES E; VAZ FAC; RAMOS JLA; OKAY Y. PEDIATRIA BÁSICA. 9ª EDIÇÃO, SÃO PAULO: EDITORA SARVIER, 2002.

MARTIN RJ, FANAROFF A A, .WALSH M. FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL-PERINATAL MEDICINE: DISEASES OF THE FETUS AND INFANT .9A EDIÇÃO. EDITORA SAUNDER ELSEVIER, 2010

OLIVEIRA RG. BLACKBOOK – PEDIATRIA. 3 ED. BLACK BOOK EDITORA. 640P. 2005.

SAITO MI, SILVA LEV, LEAL MM. ADOLESCÊNCIA: PREVENÇÃO E RISCO. 2ª EDIÇÃO. EDITORA ATHENEU, SÃO PAULO, 2008.

SILVA LR; CARVALHO E; FERREIRA CT. HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA. EDITORA MANOLE, 2012.

SILVA LR. DIAGNÓSTICO EM PEDIATRIA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2009.

SILVA LR, MENDONÇA DR, MOREIRA DEQ. PRONTO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA. 2ª ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2006.

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primária nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde neste município.

OBJETIVOS:

Treinamento sob supervisão local (preceptoria) e da UNIR (tutoria) em atenção primaria nas Unidades de Saúde de Porto Velho, com a finalidade de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a capacidade de atuação na atenção primaria e articulação de serviços de saúde nestes municípios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro; Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Ed. ARTMED 1º Edição 2012.

DUCAN, Bruce. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª Edição. Editora Artmed.

WAGNER, Gastão Tratado de Saúde da Família e Comunidade

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TENORIO, Gustavo, A clinica ampliada na atenção básica.

ESTARFIELD, Barbara , Atenção Primaria

WONCA, definições e diretrizes da Medicina de Família

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Condutas Médicas. Universidade de São Paulo, 2002.

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. Ed. Medsi, 6a Edição, 2003.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 7a Edição, 2003

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Conhecimentos básicos sobre a ginecologia geral e específica, bem como patologias obstétricas e parto distócico, que possibilite a atuação do médico generalista no âmbito do SUS.

OBJETIVOS:

Possibilitar ao aluno da graduação atividades eminentemente práticas a nível da atenção primária, secundária e terciária e assim consolidando o conhecimento teórico-prático adquirido nas disciplinas de pré-requisitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Rezende, Obstetrícia. Montenegro e Rezende Filho. 13ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2017.

Zugaib, Obstetrícia. Zugaib. 3ª edição. Editora Manole, 2016

Bereck e Novak, Tratado de Ginecologia. 15ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1- Chagas CR, Menke CH, Vieira RJS, Boff RA. Tratado de Mastologia da SBM- 2 vols. Editora Revinter, 2011.

2- Martinelli SE, Facina G, Araújo Neto JT. Mastologia Condutas Atuais. 1ª edição. Editora Manole, 2016.

3-Manuais do Ministério da Saúde, disponíveis: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=152 (área técnica da Saúde da

Mulher).

4- http://www.aids.gov.br/pagina/publicacoes (área técnica de DST)

5- Manuais da FEBRASGO. Disponível em htpp: www.febrasgo.org.br

CLINICA MEDICA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Estudo de temáticas e práticas que articulam a produção do conhecimento na grande área da clínica médica com treinamento em serviço, supervisionado por docente, objetivando adquirir conhecimentos sobre as patologias clínicas mais prevalentes, além da aquisição do manejo prático nas situações clínicas ambulatoriais, emergenciais e de pacientes internados em enfermarias em hospital geral.

OBJETIVOS:

Capacitar o interno quanto as seguintes competências e habilidades:

- Ampliar e integrar os conhecimentos obtidos ao longo do curso de graduação na grande área da Clínica Médica, com vistas à formação do médico generalista;

- Conhecer as doenças mais freqüentes, seus aspectos epidemiológicos, diagnósticos e terapêuticos;

- Aprimorar o adestramento em técnicas e habilidades indispensáveis aos exercícios de atos médicos básicos e de emergência no paciente clínico;

- Desenvolver o raciocínio clínico de diagnóstico e realizar diagnósticos diferenciais;

- Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;

- Tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos e de práticas;

- Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, com vistas à resolução do problema de saúde;

- Adquirir autonomia e postura investigadora, atualizada e crítica, tendo em vista a medicina como uma atividade de aprendizagem independente e permanente;

- Trabalhar em equipe multiprofissional promovendo a prática da assistência integrada, resolutiva e de qualidade;

- Aprimorar a relação médico-paciente;

- Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CECIL MEDICINA - EXPERT CONSULT - 2 VOLUMES - 23ª EDIÇÃO - 2011 *GOLDMAN, LEE - Editora Elsevier*

TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA - 3 VOLUMES - 2ª EDIÇÃO *ANTONIO CARLOS LOPES - Editora Roca*

STEPHEN MCPHEE, MAXINE PAPADAKIS Current Medical Diagnosis and Treatment 2010 - 49ª Edição - Editora Mcgraw Hill

BIBLIOGRAFIA COMPLEMETNAR

Clínica Médica – FMUSP Vol 1,2,3,4,5,6,7 – Milton de Arruda e outros ; Editora Manole

HARRISON - MEDICINA INTERNA - 2 VOLUMES - 17ª EDIÇÃO *BRAUNWALD, LOSCALZO, FAUCI, HAUSER, JAMESON, KASPER, LONGO - Editora Mcgraw Hill*

DIRETRIZES DAS SOCIEDADES BRASILEIRAS DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS

- http://publicacoes.cardiol.br/consenso/ - Sociedade Brasileira de Cardiologia

- www.projetodiretrizes.org.br - Diretrizes AMB / CFM

Principais periódicos de medicina / clínica médica

www.nejm.org - New England Journal of Medicine

www.lancet.com – The Lancet

www.annals.org – Annals of Internal Medicine

www.jama.ama-assn.org - The Journal of American Medical Association

www.archinte.ama-assn.org – Archives of Internal Medicine

www.ccjm.org - Cleveland Clinic Journal of Medicine

CLINICA CIRURGICA II (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Reconstruções em oncologia. Principios de cirurgia oncológica. Câncer gástrico. Câncer de cólon. Nódulo de tireóide e câncer de tireóide. Câncer de boca. Câncer de laringe. Sarcoma de partes moles. Melanoma. Câncer colorretal. GIST. Traqueostomias. Câncer de pele. Câncer de canal anal. Câncer de fígado e pâncreas. Procedimentos diagnósticos em imaginologia. Pé diabético. Doença arterial periférica obstrutiva. TVP. Diagnóstico e tratamento dos principais tipos de Fraturas. Imobilizações. Lesões ligamentares do joelho. Abdome agudo não traumático. ATLS. Trauma abdominal. Trauma craniano. Trauma Raquimedular. Trauma de membros. Trauma tórax. Trauma cervical.

OBJETIVOS:

Treinar, de forma intensiva, os estudantes, na identificação e tratamento das enfermidades cirúrgicas mais comuns, com ênfase na abordagem pré e pós-operatória.

Desenvolver no aluno a capacidade de abordar os problemas dos pacientes sob o ponto de vista de cuidado global, através da aplicação prática dos conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas afins, propondo planos diagnósticos, terapêuticos e educacionais para os mesmos.

Atender de forma integral ao doente portador de problemas cirúrgicos mais comuns em enfermarias e ambulatórios;

Planejar a terapêutica de acordo com as evidências

Indicar internação hospitalar e conhecer os critérios de alta

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SABISTON, Tratado de cirurgia, 18 ed. ELSEVIER

FIGUEIREDO, FERREIRA E MONTEIRO, Tratado de oncologia – 1 ed. REVINTER

BRANDÂO, Lenine Garcia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Fundamentos Para a Graduação Médica. Editora: SARVIER

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Richard L. Drake; A. Wayne Vogl; Adam W. M. Mitchell. Gray's Anatomy for Students. Canada. Churchill Livingstone Elsevier: 2010

Courtney M. Towsend; Daniel Beauchamp; Mark Evers; Kenneth L. Mattox. Sabiston Textbook of Surgery - The biological basis of modern surgical practice Elsevier Saunders: 2012

Alan J. Wein; Louis R. Kavoussi; Andrew C. Novick; Alan W. Partin; Craig A. Peters. Campbell-Walsh UROLOGY. Philadelphia, PA, Elsevier Saunders: 2012

Nelson Rodrigues Netto Jr. Urologia Prática. São Paulo Editora Roca: 2008

Joaquim José Gama-Rodrigues; Marcel Cerqueira Cesar Machado; Samir Rasslan. Clínica Cirúrgica. São Paulo Editora Manole: 2008

Artigos científicos temas dos seminários.

OPCIONAL (300 horas-aula – 15 créditos)

EMENTA:

Neste módulo do internato, o estudante escolhe a área e o local, dentre aqueles conveniados com a UNIR, para o desenvolvimento de treinamento específico, podendo ser, inclusive, fora da unidade federada, respeitando os critérios para credenciamento da

instituição, estabelecidos no Regimento do Internato.

OBJETIVOS:

Propiciar ao estudante a oportunidade de conhecer outros serviços, na área de interesse que mais lhe aprouver.

BIBLIOGRAFIA:

Conforme a área ou especialidade selecionada.

2.7.10 Alterações da Matriz Curricular

As alterações da matriz curricular estão apresentadas no Apêndice 1, a cada um dos períodos, na previsão de compatibilização curricular. As alterações se referem ao reordenamento modular, estabelecimento do eixo da Saúde da Família e Integração Estudante-Sociedade como estruturante e integrador do percurso formativo, além da inclusão de atividades de integração horizontal e vertical, através das disciplinas "Módulo Integrativo". Além disto, a inclusão da tutoria acadêmica, com acompanhamento dos estudantes ao longo do curso por um tutor, também é uma inovação neste PPC.

2.7.11 Requisitos para integralização do currículo

Os estudantes de medicina deverão, para receber o diploma de graduação, ter desenvolvido todas as atividades obrigatórias, as atividades optativas e completar as horas previstas para atividades complementares. É requisito, para iniciar o internato, a partir do nono período, que o aluno tenha cumprido todas as disciplinas obrigatórias e a carga horária de disciplinas eletivas, além de 80% das atividades complementares e de extensão. Esta distribuição está demonstrada a seguir:

Atividades complementares e de extensão (conforme estabelecido neste PPC): 750 horas

Disciplinas optativas: 200 horas/aula

Demonstrativo resumido da carga horária do curso:

Carga horária do Curso	TEÓRICA	PRÁTICA	TOT	CR
Disciplinas obrigatórias:				
Pré-Internato	3050	1830	4880	244
Internato	720	2880	3600	180
Total	3770	4710	8480	424
Optativas			200	10
Total			8680	434
Complementares e de extensão		750		

Como a hora/aula na UNIR corresponde a 50 minutos, para verificar a adequação ao estabelecido na legislação quanto à carga horária mínima do curso de graduação em

Medicina, apresentamos a seguir a correção, fazendo a equivalência em horas inteiras (60 minutos).

Correspondência a horas*			
Carga horária do Curso	TEÓRICA	PRÁTICA	TOT
Obrigatórias:	3141*	3925*	7066*
Optativas			167*
Complementares			750
Total geral corrigido			7983

*Correção dado que a hora/aula na UNIR corresponde a 50 minutos

2.7.12 Avaliação do Curso de Medicina

Os cursos de Medicina, no Brasil, estão submetidos a diversas estratégias de avaliação. Uma delas é o Sistema de Acreditação das Escolas Médicas (SAEME), que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). É um sistema voluntário ao qual as escolas médicas solicitam a acreditação, desenvolvida em diversas etapas. O processo de acreditação do SAEME compreende uma etapa de autoavaliação com apresentação de evidências, análise de documentação, visita de três dias à instituição, elaboração de um relatório com recomendações para que a escola atinja seu melhor potencial, e entrega do parecer final. Este processo envolve um grupo de avaliação externa e uma comissão de acreditação. A qualificação e o comprometimento dos avaliadores externos são fundamentais, assim como a diversidade de olhares sob o processo de avaliação e acreditação. A inclusão de avaliadores externos obedece a critérios de diversidade regional, de formação, atuação e experiência na área da saúde e da educação. São avaliados cinco pontos: gestão educacional, programa educacional, infraestrutura, corpo docente e corpo discente. Nosso curso se candidatou e foi selecionado para o processo de acreditação, recentemente concluído, tendo sido considerado "**ACREDITADO**". O relatório da avaliação está no anexo 9.

A cada três anos os estudantes se submetem ao Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE) considerado componente curricular obrigatório para integralização curricular, conforme Lei 10.861/2004, quando for o caso de curso já reconhecido. No ENADE de 2016 a nota obtida foi 4. O ENADE entra no Conceito

Preliminar do Curso (CPC) e vai influenciar na renovação de reconhecimento do Curso. O último CPC recebido pelo curso de Medicina foi 4.

Além disto, em processo de implantação, por determinação legal, os estudantes de medicina a partir do segundo ano e, gradativamente, do quarto e do sexto anos, passarão pela Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM), instituída pela Portaria 982 de 25/08/2016, do INEP. Este também é considerado componente curricular obrigatório e comporá os critérios de acesso à Residência Médica.

2.7.13 Regulamento do Internato

O regulamento do internato em vigor, na forma de Ato Decisório 148 do Conselho Superior Acadêmico, aprovado em 27 de julho 2011, está apresentado no anexo 8. A seguir, apresentamos as necessidades de alteração do mesmo:

REGULAMENTO INTERNO DO INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Art. 1º - O Internato constitui-se no último ciclo do curso de graduação em Medicina da UNIR, durante o qual o estudante deve receber capacitação intensiva, contínua, sob supervisão docente, em instituições de saúde vinculadas ou conveniadas à escola médica.

§ 1º - Para iniciar o Internato, o aluno deverá, obrigatoriamente, ter cursado e sido aprovado em todas as disciplinas curriculares até o oitavo período da graduação e integralizado as 750 horas de atividades complementares e de extensão.

A ordem dos rodízios do Internato I e II será definida pela Comissão do Internato, em um período prévio ao pedido de matrícula, conforme prevê Calendário Acadêmico da UNIR;

§ 2º - Não serão aceitos alunos especiais, nos termos do Art. 87 do Regimento Geral da UNIR,

§3º - Nos casos de Mobilidade Acadêmica, serão aceitos alunos apenas para cursar a área opcional do Internato, com duração de oito semanas.

Art. 2º - O Internato representa a última etapa da formação escolar de graduação do médico generalista, com capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde prevalentes da população a que vai servir.

Art. 3º - Os objetivos do Internato são:

I - Desenvolver atividades teórico-práticas em nível hospitalar e ambulatorial como parte da formação médica;

II - Possibilitar o treinamento prático supervisionado, hospitalar e ambulatorial, propiciando ao aluno a aquisição de conhecimentos, para empregar na prática médica;

III - Desenvolver e aperfeiçoar atitudes e habilidades adequadas à assistência médica aos pacientes;

IV - Possibilitar a prática da assistência integral, através da inter-relação com os diversos profissionais da equipe de saúde;

V - Estimular a formação que motive os futuros médicos a melhorar continuamente suas habilidades;

VI - Proporcionar uma formação ética dentro dos mais elevados padrões morais;

VII - Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação;

VIII - Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das doenças;

IX - Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;

X - Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.

Art. 4º - O Internato I se desenvolverá durante o Nono e Décimo Período, em estágios rotatórios, com duração de oito semanas em cada uma das seguintes áreas:

a) Clínica Médica I;

b) Clínica Cirúrgica I;

c) Ginecologia e Obstetrícia I;

d) Pediatria I;

e) Medicina de Família e Comunidade I; e

f) Medicina de Urgência e Emergência

Parágrafo único - Cada grande área discriminada nas alíneas acima referidas poderá elaborar suas normas específicas de funcionamento, desde que estas não conflitem com o Regimento Geral da UNIR e a legislação vigente.

Art. 5º - O Internato II se desenvolverá durante o Décimo Primeiro e Décimo Segundo Períodos, em estágios rotatórios, com duração de oito semanas em cada uma das seguintes áreas:

a) Clínica Médica II;

b) Clínica Cirúrgica II;

c) Ginecologia e Obstetrícia II;

d) Pediatria II;

e) Medicina de Família e Comunidade II; e

f) Optativo

§1º - O aluno regularmente matriculado poderá cursar em outra instituição de ensino apenas a parte opcional do Internato, com duração de 08 semanas para o Optativo.

§2º - Cada grande área discriminada nas alíneas acima referidas poderá elaborar suas normas específicas de funcionamento, desde que estas não conflitem com o Regimento Geral da UNIR e a legislação vigente.

Art. 6º - Os estágios rotatórios do Internato I e II (Clínica Médica I e II; Clínica Cirúrgica I e II; Ginecologia e Obstetrícia I e II; Pediatria I e II; Medicina de Família I e II; Medicina de Urgência e Emergência) serão realizados no âmbito das unidades conveniadas de saúde do Estado e Municípios de Rondônia, nos diversos níveis de complexidade assistencial.

§1º - Para que o Internato possa se desenvolver fora do âmbito da Instituição de Ensino é pertinente a realização de convênio com os órgãos externos competentes.

§2º - O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais

condições operacionais, é da competência da UNIR, que considerará, para cadastramento das instituições prestadoras de serviços médicos, os seguintes critérios e/ou exigências:

I - Localização preferencial do campo de estágio no estado de Rondônia;

II - Prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas da instituição convenente, compatíveis com as exigências da formação a ser dispensada ao estagiário, a juízo da Comissão de Internato bem como a existência de pessoal médico capacitado para exercer a função de Preceptor;

III – Preferencialmente, deve-se procurar unidades que tenham Programas de Residência Médica reconhecidos nas áreas de estágio.

Art. 7º - Cada grande área do Internato (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade e Medicina de Urgência e Emergência) terá um coordenador e um vice-coordenador, indicado pela Chefia do DEPMED entre os docentes de suas respectivas disciplinas, sendo os referidos nomes submetidos à aprovação em reunião do Conselho Departamental de Medicina, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições:

I - Coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em sua respectiva área de atuação;

II - Elaborar o Programa do Internato;

III – Avaliar o desempenho dos alunos durante o desenvolvimento das atividades do Internato;

IV – Definir a nota final dos estágios previstos nos artigos 4 e 5, entregando as notas na DIRCA conforme calendário acadêmico.

V - Orientar os alunos em relação às suas atividades e a seus direitos e deveres;

VI - Coordenar as reuniões dos preceptores;

VII - Prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato.

Parágrafo único. O coordenador tem autonomia na definição dos preceptores e de critérios de avaliação, à partir da disponibilidade de recursos humanos dos serviços de saúde;

Art. 8º. A Reunião das grandes áreas do Internato constitui a Comissão do Internato, a qual é presidida pela Coordenação Geral e suas decisões são submetidas ao Conselho de Departamento.

Art. 9º - Os preceptores serão os professores da Universidade Federal de Rondônia, os profissionais médicos, médicos-residentes e outros profissionais de saúde que atuam em cada área, sendo designados a critério do Coordenador de Área, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições:

I - Acompanhar o desempenho dos alunos em suas atividades teóricas e práticas;

II – Auxiliar o Coordenador de Área na avaliação do desempenho dos Internos;

III - Desenvolver reuniões e demais eventos programados com os alunos;

IV - Prestar informações aos Coordenadores sobre o desenvolvimento dos Programas.

Art. 10 - Os Planos de Ensino de cada área do Internato serão elaborados pelo professor Coordenador, podendo ser discutido com os representantes dos alunos de cada área, estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação prévia da Comissão de Internato.

Art. 11 - O aluno será avaliado quanto aos seguintes aspectos, dentre outros:

a) Cognitivo;

b) Conhecimento teórico-prático e busca por conhecimento;

c) Ético (relação com paciente, preceptor, internos, pessoal da instituição de saúde e grupo multidisciplinar);

d) Assiduidade; pontualidade e permanência no serviço;

Parágrafo único. Caberá ao Coordenador de área definir a melhor metodologia de avaliação e apresentá-la ao Conselho de Departamento quando da conclusão dos Planos de Ensino

Art. 12 - É obrigatória a frequência integral em todas as atividades programadas para o Internato, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o abono de faltas;

Art. 13 - A falta não justificada ou não previamente autorizada pelo Coordenador

de Área e/ou Preceptor a qualquer atividade programada para o Internato I e II terá como consequência a reprovação do estágio em desenvolvimento;

Parágrafo único. Salvo motivo de força maior, todas as faltas deverão ser comunicadas ao Coordenador de Área e/ou Preceptor no prazo máximo de 48 horas.

Art. **14** - Em caso de reprovação em qualquer rodízio do Internato I e/ou II, o momento do estágio de recuperação/reavaliação será definido em tempo hábil pela Comissão do Internato, conforme disponibilidade de vagas na rede de serviços de saúde.

Parágrafo único. Em caso de reprovação em qualquer dos estágios rotatórios do Internato I, previstos no art. 4 desta resolução, o aluno não poderá cursar o estágio rotatório II da respectiva área;

Art. 15 - Observada a disponibilidade de recuperação da abstenção no período das férias, será permitido que o aluno falte nas seguintes situações:

a) Incapacidade física temporária;

b) Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos, sendo permitido até sete dias;

c) Convocação pelo Poder Judiciário; e

d) Casamento do aluno, sendo permitido até sete dias;

§ 1º - Sob nenhuma hipótese as faltas previstas nas alíneas a, b, c e d poderão exceder a 25% do período de cada estágio, e sempre que as faltas excederem este limite o aluno será reprovado.

§ 2º - Em qualquer das hipóteses mencionadas nas alíneas acima citadas, o aluno deverá apresentar documento comprobatório à Comissão de Internato, ficando a seu critério aceitar a justificativa.

§ 3º – Todas as faltas previstas nas alíneas acima deverão ser repostas integralmente, conforme calendário estabelecido pelo Coordenador de Área;

Art. 16 – São deveres dos alunos internos:

I – Cumprir os horários estabelecidos, bem como os plantões que lhes forem destinados;

II – Cumprir o calendário elaborado pelo Departamento de Medicina (DEPMED/UNIR), pela Coordenação do Internato e pela Coordenação das respectivas Áreas;

III – Dedicar-se aos estudos e às atividades programadas;

IV - Frequentar os cursos, reuniões e outros eventos incluídos no Programa de Internato;

V – Relacionar-se ética e cortesmente com os pacientes, docentes, servidores, colegas e demais alunos das instituições de ensino;

VI – Cumprir as disposições contidas neste Regulamento, no Regimento da UNIR e nas normas de organização e funcionamento das instituições onde ocorre o Internato;

VII – Seguir à risca todas as recomendações das comissões intra-hospitalares, como a CCIH e outras;

VIII - Vestir roupa branca, jaleco e sapato fechado, fazendo uso obrigatório e rotineiro destes Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;

IX – Estar com o esquema vacinal atualizado e com o seguro obrigatório em dia;

X - Realizar todo e qualquer ato médico apenas e sob a orientação do preceptor;

XI – Não praticar ou permitir qualquer violação do prontuário médico.

Art. 17 - Os alunos terão direito a dois representantes com direito a voz e voto nas reuniões da Comissão do Internato, cabendo-lhes:

I - Reunir-se regularmente com os alunos para efeito de conhecimento do desenvolvimento do Programa;

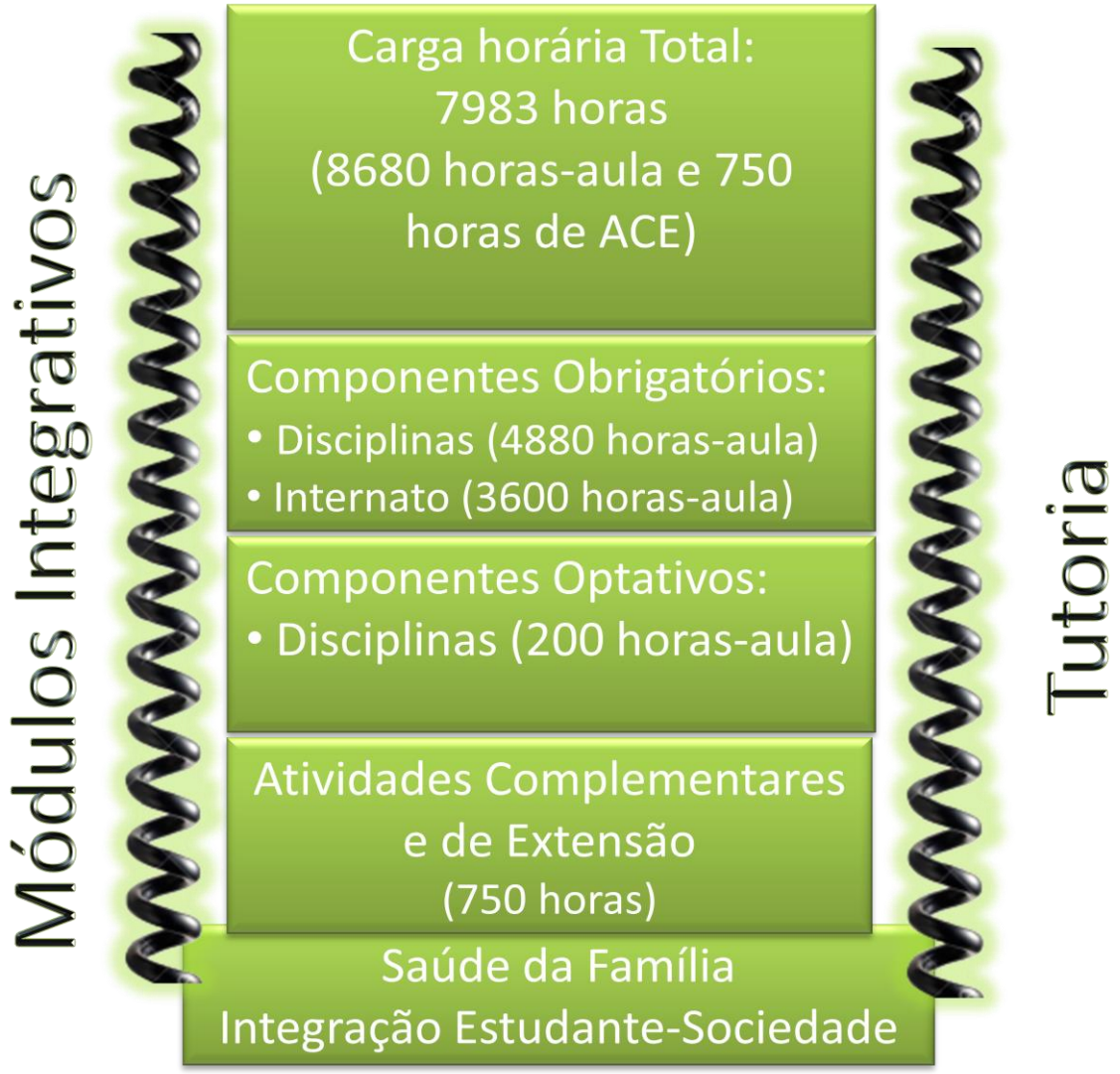
II - Submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Internato as reivindicações dos alunos.

Art. 18 – Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Internato, cabendo recurso ao Conselho de Departamento e às demais instâncias de deliberação, conforme o Regimento Geral da UNIR.

2.8 Representação gráfica do perfil de formação

Na Figura a seguir consta uma ilustração do percurso curricular:

Figura 6: Representação gráfica do percurso curricular do curso de medicina da UNIR.



A seguir, está o organograma atualizado do currículo, no qual está o explicitado o percurso formativo, visando a integralização da carga horária.

Figura 7 - Síntese do percurso curricular

ANO		SAÚDE E SOCIEDADE	MORFOFUNCIONAL	PRÁTICA MÉDICA
1	a	Humanidades em Medicina Introdução à pesquisa científica, Bioestatística	Anatomia, Embriologia, Biologia celular aplicada à medicina, Biofísica de sistemas Bioquímica, Histofisiologia dos Sistemas, Imunologia Médica, Microbiologia Médica	Introdução ao SUS, Introdução à Saúde Mental Introdução ao Suporte Básico de Vida, Atenção Primária à Saúde
	b	Libras. Inglês. Português	Homeostasia dos fluidos corpóreos. Tópicos especiais em bioquímica. Tópicos especiais em biologia celular Tópicos especiais em genética	
2	a	Epidemiologia, Bioética	Histofisiologia dos sistemas, Bioquímica clínica, Patologia Geral, Imunologia, Parasitologia médica Farmacologia	Semiologia, Introdução às doenças infecto-parasitárias Semiotécnica
	b	História da medicina.	Tópicos especiais de biofísica Tópicos especiais em imunologia. Imunologia clínica avançada	Ferramentas moleculares para diagnóstico laboratorial. Diagnóstico laboratorial de parasitologia.
3	a	Ética Médica e Exercício Profissional, Medicina Legal, Vigilância em Saúde, Ações Programáticas	Patologia Sistêmica, Farmacologia Genética Humana	Saúde do Adulto, Clínica Cirúrgica, Imagem, Saúde da Mulher, Saúde da Criança
	b	Ciências humanas. Ciências sociais aplicadas.Ciências Exatas e da Terra. Ciências da saúde	Fisiologia do exercício. Tópicos em fisiologia cárdio-vascular	Semiotécnica neurológica Métodos de diagnóstico em pneumologia e cardiologia: eletrocardiograma e provas de função respiratória
4	a	Gestão dos Serviços de Saúde, Informática Médica Introdutório à Saúde da Família		Saúde do Adulto, Psiquiatria, Clínica Cirúrgica, Emergências Clínicas, Saúde da Mulher, Doenças Infecto-Parasitárias, Saúde da Criança
	B	Interconsulta psicológica Fundamentos da saúde do trabalhador Direitos humanos e medicina Responsabilidade jurídica pelo ato médico	Farmacologia clínica	Osteometabolismo. Emergências endocrinológicas. Introdução à medicina genômica. Interpretação de casos clínicos em medicina interna. Acupuntura Cuidados paliativos
5		Internato I	Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Medicina de Urgência e Emergência	
6		Internato II	Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Optativo	

a - Obrigatórias b - Optativas

Módulo Integrativo tutoria prática

2.9 Acompanhamento e atualização do Projeto Pedagógico

Atualmente, o currículo do curso tem funcionando com a inserção de diferentes conteúdos em um módulo, fundamentalmente através das diversas disciplinas. Cada conteúdo é ministrado por um ou mais professores, ligados aos Departamentos da UNIR, que é o responsável por aquele conteúdo, incluindo a elaboração do plano de ensino do conteúdo e a avaliação do aprendizado dos alunos. A proposição é que cada módulo tenha um professor coordenador, responsável pela integração entre os conteúdos e pela avaliação final somativa dos alunos no módulo (de acordo com a integração de conteúdos, avaliações globais serão realizadas pelo coordenador do módulo).

Dos diferentes coordenadores de módulo é escolhido um professor coordenador da fase, que deve atuar conciliando os conteúdos de diferentes módulos da fase (integração horizontal), particularmente relacionando a vivência dos alunos nas atividades de Saúde da Família e integração estudante e sociedade, aos demais módulos da fase. Além disso, os coordenadores das diferentes fases devem atuar conjuntamente, de modo a conciliar seus conteúdos em uma escala de complexidade, evitando repetições desnecessárias de conteúdos e aprofundando a cada fase o desenvolvimento cognitivo, de habilidades e competências dos alunos (integração vertical).

2.9.1 Reuniões da Rede Docente Assistencial

A cada semestre serão realizadas reuniões entre os professores das atividades de saúde da família e formação clínica e integração estudante e sociedade com os médicos preceptores dos alunos em atividade nas Unidades de Saúde.

2.9.2 Seminários de Formação dos Professores e Seminários de Avaliação do Currículo

No primeiro semestre de cada ano ocorrerá o Seminário dos Professores do Curso de Medicina, momento de integração em que a Coordenação do Curso e o NDE organizarão atividades de capacitação docente e avaliação do processo de implantação

do Projeto Pedagógico, incluindo a análise e incorporação dos resultados obtidos no ENADE.

No segundo semestre de cada ano ocorrerá o Seminário de Avaliação do Currículo, organizado pelo corpo discente, em que serão reunidas as impressões dos alunos sobre a situação corrente do Curso de Medicina e encaminhadas propostas e sugestões ao NDE.

2.9.3 Acompanhamento dos Egressos

O acompanhamento dos egressos será feito através de inquéritos anuais realizados utilizando as redes sociais e outros instrumentos de comunicação, visando identificar a inserção profissional e acadêmica e as percepções acerca da formação recebida. O objetivo deste acompanhamento é traçar o perfil sociodemográfico e de formação e sua inserção no mercado de trabalho. Este acompanhamento proporcionará um *feedback* acerca do desempenho do curso, e obter subsídios para o desenvolvimento e adequação do currículo, e outras ofertas formativas, retroalimentando o processo e mudanças na formação. Este acompanhamento produzirá um banco de dados pessoais, acadêmicos e profissionais. Com isso o DEPMED poderá verificar a inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho, obter indicadores confiáveis sobre a adequação dos conteúdos curriculares às necessidades do mundo do trabalho, conhecer propostas dos egressos para o Curso de Graduação em Medicina. Para este acompanhamento serão adotadas as seguintes estratégias metodológicas:

- Criação do link “Egressos MEDUNIR” e divulgação para os alunos ainda no processo de formação, no site do departamento (http://www.depmed.unir.br/);
- Pesquisa de Acompanhamento do Egresso, por meio do Questionário do Egresso do Curso de Medicina da UNIR, a ser aplicado durante dois anos consecutivos a partir do desligamento do acadêmico, sendo a periodicidade de aplicação anual. O questionário será aplicado por meio virtual, disponibilizado no site do DEPMED/UNIR, respondido e enviado pelo egresso ao email do departamento (depmed@unir.com.br). Este questionário foi baseado no apresentado no PPC da Enfermagem da UNIR.
- Análise quanti e qualitativa do material coletado, com disponibilização de resultados no link “Egressos MEDUNIR”;

- São considerados egressos MEDUNIR os acadêmicos do curso de graduação que tenham colado grau, portanto, portadores do diploma de médico; desistentes, ou que abandonaram o curso e transferidos.

2.9.4 Avaliação da aprendizagem

Utilizar-se-á do sistema de avaliação da aprendizagem como oportunidade de avaliar e aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, a avaliação deverá permear todas as etapas do processo, ocorrendo antes (diagnóstica), durante (formativa) e no fim (somativa) de momentos determinados de ensino-aprendizagem. A avaliação do discente deverá ser processual, cumulativa e contínua, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme dispõe a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 que regulamenta o sistema de avaliação discente na UNIR. Em cada plano de ensino estará previsto o processo avaliativo, que será apresentado aos alunos no início do período.

No internato, além das avaliações somativas, os alunos são avaliados pelos preceptores do serviço que os acompanham, conforme ficha de avaliação disponível em https://drive.google.com/file/d/0B4QCuNgyBDTYcWZfdWlXZnM4YVU/edit?pli=1 (apêndice 7). As notas obtidas compõem a nota final do aluno, conforme o que estabelece o regimento do internato, disponível em **https://drive.google.com/file/d/0B4QCuNgyBDTYcWZfdWlXZnM4YVU/edit?pli=1.** Explicitamente, o regimento do internato estabelece que

> Art. 11 - O aluno será avaliado quanto aos seguintes aspectos, dentre outros:
> a) Cognitivo;
> b) Conhecimento teórico-prático e busca por conhecimento;
> c) Ético (relação com paciente, preceptor, internos, pessoal da instituição de saúde e grupo multidisciplinar);
> d) Assiduidade; pontualidade e permanência no serviço;
> Parágrafo único. Caberá ao Coordenador de área definir a melhor metodologia de avaliação e apresentá-la ao Conselho de Departamento quando da conclusão dos Planos de Ensino.

Também compõe a avaliação a *Objective, Structured Clinical Examination* (OSCE) no final do primeiro e do segundo anos, compondo as notas de cada um dos módulos. Esta estratégia de avaliação é, hoje, internacionalmente reconhecida como altamente válida, fidedigna, acurada e eficaz. Em uma “OSCE” típica, os examinandos percorrem, em alternância, várias “estações”, onde devem desempenhar tarefas clínicas diferentes. Em

cada uma dessas estações, o desempenho do educando é cuidadosamente observado, permitindo que o domínio de habilidades clínicas possa ser avaliado. As estações podem envolver a execução de tarefas clínicas relativamente simples, como a obtenção de partes da história clínica ou a realização do exame físico focalizado de um órgão ou aparelho, ou podem ser estruturadas de modo a requerer a abordagem "completa" de um(a) paciente, com a realização da anamnese e do exame físico, seguidos pela orientação do paciente quanto ao diagnóstico. Questões ou tarefas escritas podem ser acrescentadas, de modo a permitir a avaliação dos aspectos cognitivos inerentes ao raciocínio clínico. Pelas suas características de flexibilidade e de versatilidade, a OSCE tem sido considerada antes um "modelo" de avaliação de habilidades clínicas, do que como método específico.

Para garantir que o exame preencha os requisitos de validade, a estruturação de cada estação é previamente elaborada de modo que contenha situações ou contextos clínicos habituais, em grau apropriado de dificuldade, bem como envolva habilidades clínicas relevantes, no nível adequado de complexidade. A fidedignidade é garantida pela composição de um número mínimo de estações, pelo preparo ou treinamento prévios dos pacientes e dos próprios avaliadores, bem como pela elaboração minuciosa dos protocolos de observação, que devem conter descrições detalhadas dos comportamentos esperados, indicativos do domínio das habilidades que estão sendo avaliadas. Adicionalmente, contribui para maior fidedignidade o fato de todos os examinandos serem avaliados nas mesmas condições. Nesse sentido, adquire importância o preparo ou treinamento do(a) paciente, para que forneça a mesma história, ou se comporte sempre da mesma maneira, ao ser abordado, sucessivamente, por dez ou por cinquenta examinandos.

Para garantir desempenho uniforme e de boa qualidade por parte do(a) paciente, desenvolveu-se a técnica dos "standardized patients", ou "pacientes padronizados", que são pacientes reais, ou pessoas sem qualquer doença, que são preparadas para protagonizar "casos" com características adequadas à avaliação. A partir do início do seu desenvolvimento, na década de 1960, este recurso sofreu extraordinária difusão e passou a ser empregado, extensivamente, na avaliação de habilidades clínicas e, sobretudo, no ensino de habilidades de comunicação e de interação médico-paciente (Anderson & Kassenbaum, 1993).

2.10 Avaliação institucional interna do Curso de Medicina

Através da Comissão Permanente de Avalição da UNIR, serão aplicados os instrumentos adequados de avaliação do curso, além da avaliação docente, discente e de técnicos-administrativos. A avaliação interna do curso seguirá as normas estabelecidas no manual de procedimentos disponível em http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/uploads/87878787/2017_Guia%20da%20Avaliacao%20Curso%20Interna.pdf. Conforme estas normativas, compete ao NDE do curso coordenar todos os procedimentos envolvidos, desde a mobilização até a execução da avaliação interna. Após elaboração do calendário anual de avaliação, o presidente do NDE encaminhará à CPAv a solicitação de apoio, inclusive para disponibilizar os formulários obrigatórios, através dos links específicos. Estes procedimentos estão inclusos e discriminados no anexo 10.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

Atualmente o Departamento de Medicina é chefiado pelos Professores Doutores José Odair Ferrari (CPF 35436247920) e Rodolfo Luís Korte (CPF 04918518800). O primeiro compõe o quadro de docentes da grande área da Clínica Médica e o segundo da Cirurgia, além de ser também o coordenador geral do Internato. O perfil acadêmico de ambos pode ser acessado nos seus currículos lattes http://lattes.cnpq.br/9706052157708759 e http://lattes.cnpq.br/1736751700554915.

José Odair Ferrari possui graduação em MEDICINA pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1981) e mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1996). Doutorado em Bioética na Universidade do Porto. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia onde exerceu a função de Chefe do Departamento de Medicina no biênio 2008/2009 e foi reeleito para o biênio 2010/2011. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cancerologia. Em 2016 foi eleito para dirigir o Curso de Medicina para o biênio 2016/2017.

Rodolfo Luis Korte possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1987), mestrado em Medicina (Cirurgia) pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2004) e doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente é médico - atua como professor da disciplina técnica cirúrgica, componente

de cirurgia plástica e Anatomia no curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia, médico cirurgião plástico do Governo do Estado de Rondônia. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia Plástica Reparadora e Estética, e cirurgia do trauma. Atualmente atua também no tratamento cirúrgico das moléstias infecciosas, como lobomicose, blastomicose, leishmaniose e cromomicose e tratamento de câncer de pele unto ao Hospital do Câncer de Barretos, unidade de Porto Velho.

Há um estagiário e um técnico administrativo cedido pelo IPEPATRO para apoio às atividades administrativas. A estrutura física está localizada no mesmo bloco de funcionamento do curso, no mesmo andar das salas de aula, possuindo uma sala de coordenação, uma sala de coordenação do internato e da Residência Médica, uma sala de reuniões e uma secretaria.

3.1. Conselho do Departamento de Medicina

Subordinado ao Núcleo de Saúde, o Conselho de Departamento de Medicina, é o órgão normativo máximo do Curso de Graduação em Medicina, tendo também caráter consultivo e de assessoramento, conforme estabelece o Regimento Geral da UNIR, nos artigos 38 a 42.

O Conselho de Departamento de Medicina, órgão que congrega todos os docentes, os servidores técnicos e administrativos e os representantes discentes duas vezes a cada semestre, por convocação do presidente, o chefe do Departamento. Estas reuniões seguem a pauta de convocação, sendo os assuntos elencados e dado conhecimento dos mesmos com antecedência. Nestas reuniões são apreciados os projetos de pesquisa e extensão, os pedidos de afastamento, o plano de capacitação docente, as alterações da matriz curricular, solicitações da comunidade acadêmica, além de propostas de credenciamento de professores colaboradores eventuais e de preceptores. Também são apreciadas nas reuniões as propostas de convênio ou cooperação com outras instituições. As reuniões são públicas, sendo franqueada a palavra a todos os conselheiros. Demais participantes também podem se manifestar, após anuência do conselho. As votações são abertas, exceto quando estabelecida outra forma nas normas da instituição, como no caso de alteração de regime de trabalho, quando o voto é secreto. O funcionamento e as atribuições seguem o estabelecido no Estatuto e no

Regimento Geral da Universidade. Foram constituídas as coordenações de área (morfofuncional, medicina social e educação, clínica, cirurgia, saúde da mulher e da criança, além da coordenação geral do internato). Estas coordenações reúnem com seus pares para os encaminhamentos e deliberações da área e estas deliberações são encaminhadas ao Conselho de Departamento. As coordenações de área reúnem-se com a chefia do Departamento uma vez ao mês.

3.1.1. Coordenações de área

O Departamento de Medicina é responsável pelo curso de Graduação em Medicina, pelos cursos e programas de pós-graduação (atualmente Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental – Mestrado e Doutorado, Mestrado Profissional em Saúde da Família) e pelos Centros e Grupos de Pesquisa vinculados (Centro de Estudos em Saúde do Índio, Centro de Estudos e Pesquisas em Transplantes, Centro de Pesquisa em Biomoléculas), além da Residência em Medicina de Família. Gerencia os laboratórios didáticos, além de coordenar a interface com os serviços de saúde, visando assegurar campos de prática e de estágios. Para fins de assegurar esta gama de atividades, está organizado em coordenações das seguintes grandes áreas: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Cirurgia, Clínica Médica, Educação e Medicina Social, Morfo-funcional. Cada área tem um coordenador, designado pelo Conselho de Departamento e formalizado segundo portaria 061/2016/NUSAU.

3.1.2. Comissão do Internato do Curso de Graduação em Medicina

A Comissão do Internato tem atribuições gerenciais sobre o Internato Médico e também se encarrega de sugerir às áreas que compõem o Departamento de Medicina e que são responsáveis pelos módulos do Internato (Clínica Médica, Cirurgia, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Medicina de Família e Comunidade e Urgência e Emergência) medidas que visem maior eficiência docente e discente nas atividades do internato. O Internato Médico é regido pelo Regimento do Internato, aprovado através do Ato

Decisório 148/CONSEA/2011. A comissão do internato atual foi designada por ato do Diretor do NUSAU, conforme Portaria 062/2016/NUSAU.

3.1.3 Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina, instituído em 2012, será composto por todos os coordenadores de áreas e por professores representantes dos departamentos da UNIR que ministram conteúdos nos módulos do curso de Medicina. O NDE se reúne quinzenalmente com a missão de consolidar e aprimorar a implantação do Projeto Pedagógico, propor e receber propostas de ajustes curriculares, implantar e executar as mudanças que forem aprovadas junto ao Departamento de Medicina e estimular os programas de formação docente. O NDE também é o colegiado responsável por lidar com os resultados das avaliações institucionais, além de avaliar os resultados das avaliações do SINAES/ENADE e da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM). Atualmente é composto por indicação das áreas e aprovado pelo conselho de Departamento, indicados pelos pares, e formalizado conforme Portaria 059/2016/NUSAU.

3.2 Recursos Humanos

3.2.1 Corpo Docente

Atualmente estão lotados no Departamento de Medicina 56 professores, distribuídos conforme Tabela a seguir:

Tabela 5: Distribuição do corpo docente por área e titulação.

ÁREA	TITULAÇÃO	CH	Nº	ÁREA	TITULAÇÃO	CH	Nº
MORFO-FUNCIONAL			**13**	**SAÚDE DA MULHER**			**3**
	DOUTOR		**7**		**DOUTOR**		**1**
		20	3			20	1
		DE	4		**MESTRE**		**2**
	ESPECIALISTA		**1**			20	2
		20	1	**EDUCAÇÃO E MEDICINA SOCIAL**			**10**
	MESTRE		**5**		**DOUTOR**		**4**
		20	1			20	2
		DE	3			DE	2
		40	1		**ESPECIALISTA**		**2**
CIRURGIA			**11**			40	1
	DOUTOR		**4**		**GRADUAÇÃO**		**2**
		20	3			20	2
	ESPECIALISTA		**1**		**MESTRE**		**2**
		20	1			20	1
	MESTRE		**6**			40	1
		20	5	**SAÚDE DA CRIANÇA**			**6**
		40	1		**ESPECIALISTA**		**3**
CLÍNICA			**15**			20	3
	DOUTOR		**2**		**MESTRE**		**3**
		20	1			20	2
		40	1			DE	1
	ESPECIALISTA		**8**	**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			**1**
		20	8		ESPECIALISTA		
	MESTRE		**5**			20	1
				Total Geral			**60**
		20	4				
		40	1				

A seguir, apresentamos a relação nominal dos docentes, com seus dados, conforme exigência da Resolução 278/CONSEA:

Quadro 8: Detalhamento do corpo docente (dados funcionais) do curso de Medicina

NOME	CPF	E-mail	Tel.	Titulação	Função -	Regime de Trabalho	Vínculo empregatício
1. ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS	022.878.144-26	alessandro.prudente@unir.br	(69)98115-4955	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
2. ALEXANDRE LEITE CARVALHO	183.378.305-06	alexleite@unir.br	(69)99981-4305	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
3. ANA ELLEN DE QUEIROZ SANTIAGO	511.031.763-15	ellensantiago@hotmail.com	(69)99334-4747	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
4. ANA LÚCIA ESCOBAR	325.313.460-15	ana@unir.br	(69)99245-6144	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
5. ANDONAI KRAUZE DE FRANÇA	599.528.062-72	andonai@unir.br	(69)99973-3614	MESTRADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
6. ANDRÉ LUIS PETERMANN	069.937.417-09	petermann@unir.br	(69) 98135-3377	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
7. ANDREA BARBIERI DE BARROS	806.728.251-04	andreabb@unir.br	(69)99999-6750	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
8. ANDRESA TUMELERO	811.949.190-49	atumelero@gmail.com	(69)99999-9943	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
9. ANITA SPERANDIO PORTO	509.702.322-68	anita.porto@unir.br	(69)99952-0084	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
10. ANTONIETA FERREIRA MACHADO DE OLIVEIRA	771.860.442-04	antonietamachado@unir.br	(69)99911-8262	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
11. ANTONIO COUTINHO NETO	086.036.018-01	antonio.neto@unir.br	(69)99227-7338	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
12. ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT	110.306.235-20			DOUTORADO			
13. CARLOS ALEXANDRE GRACAO RAMAGEM	902.279.727-91	carlosramagem@globo.com	(69)99257-0886	MESTRADO	Docente	Parcial – T20	Estatutário
14. CAROLINA NEGRÃO BALDONI	049.356.686-44	carolnb@unir.br	(69)98410-0001	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
15. CHRISTIAN COLLINS KUEHN	784.202.372-72	christian.collins@unir.br	(69)99299-3443	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
16. CHRYSTIANO CAMPOS FERREIRA	018.748.084-22	chrystiano_campos@yahoo.com.br	(69)98119-0225	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
17. CIPRIANO FEREIRA DA SILVA	478.992.473-49	drciprianoferreira@hotmail.com	(69)98113-3308	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
18. Josenir Lopes Detoni	079.596.397-10			DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
19. CLESON OLIVEIRA DE MOURA	878.233.224-04	cleson.moura@hotmail.com	(69)99285-9630	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
20. DHELIO BATISTA PEREIRA	895.246.756-68	dbpfall@gmail.com	(69)99901-8006	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
21. ELZA GABRIELA DE BARROS PEREIRA	858.510.272-15	elzits@gmail.com	(69) 98112-6216	GRADUAÇÃO	Docente	Parcial - T20	CLT – Prof. Temporário

22. EUGÊNIA DE CASTRO NEVES		dradecastro@gmail.com	(69)99903-5175		Docente	Parcial - T20	Estatutário
23. EULÁLIA GONÇALVES DE AQUINO	231.003.382-00	eulalia.aquino@gmail.com	(69)99982-6730	MESTRADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
24. FILIPE SOUZA DE AZEVEDO	011.148.342-54	filipe.souza@unir.br	(69)99912-3395	GRADUAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
25. GISELE MARTINS GONÇALVES	286.303.638-60	gisele.gonçalves@unir.br	(69)99222-8789	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
26. GLEICILAINE APARECIDA SENA CASSEB	257.877.828-01	gsenacasseb@gmail.com	(69)98487-1718	MESTRADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
27. GRACIELA FÁTIMA LOURENÇO JOCA	510.008.732-34	graciela.joca@unir.br	(69)98112-9409	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
28. HÉVILA TAMAR ROLIM LIMA	008.400.464-99	hevilarolim@unir.br	(69) 99954-2004	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
29. HORACIO TAMADA	015.720.848-63	hhtamada@hotmail.com	(69)99206-9992	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
30. IDA PEREA MONTEIRO	022.875.282-53	idaperea@gmail.com	(69)984026940	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
31. IVANICE FERNANDES BARCELOS GEMELLI	592.840.800-53	igemelli500@hotmail.com	(69)99323-9686	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
32. IZAURA RODRIGUES CÉZAR DE CAMPOS		dr@izaura.med.br	(69)98475-3671		Docente	Parcial - T20	Estatutário
33. JANDRA CIBELE RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA LEITE	759.504.804-49	jandra.cibele@unir.br	(69)98402-3605	MESTRADO	Docente	Integral - T40	Estatutário
34. JANNE CAVALCANTE MONTEIRO	332.986.372-20	jannemonteiro@unir.br	(69)98131-0500	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
35. GILLS VILAR LOPES				DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
36. JOHNATHAN DE SOUSA PARREIRA	727.604.271-53	johnathan.parreira@unir.br	(69)99947-4048	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
37. JOSE CARLOS COURI	193.864.436-00	josecarloscouri@yahoo.com.br	(69)98404-8262	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
38. JOSE CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA	951.794.708-97	jccoli@hotmail.com	(69)99912-2741	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Integral - T40	Estatutário
39. JOSE ODAIR FERRARI	354.362.479-20	jose.ferrari10@gmail.com	(69)99984-1452	DOUTORADO	Docente	Integral - T40	Estatutário
40. JOSE WILSON SERBINO JUNIOR	183.302.048-04	serbinojr@hotmail.com	(69)98116-0004	MESTRADO	Docente	Integral - T40	Estatutário
41. JUAN MIGUEL SALCEDO VILLALOBOS	508.535.892-91	juanitto2001@yahoo.com.br	(69)99981-7026	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
42. JULIANA PAVAN ZULIANI	180.464.188-03	zuliani.juliana@gmail.com	(69) 99231-4132	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
43. KATIA REGINA PENA SCHESQUNI	373.501.882-34	katiaschesquini@hotmail.com	(69)98115-9729	MESTRADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
44. LEONARDO DE AZEVEDO CALDERON	026.810.686-06	calderon@unir.br	(69)99991- 5412	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário

45. LILIANA ANGELICA BANDOS BENITTEZ	023.964.009-83	lilianabandos@hotmail.com	(69)99344-6464	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
46. MAILLENE RODRIGUE LISBOA	172.170.082-04	maillenelisboa@gmail.com	(69)98111-4740	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
47. NAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA	264.849.862-15	nakuxe@bol.com.br	(69)99981-4137	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
48. OTINO JOSE ARAUJO DE FREITAS	705.362.107-30	otinojaf@yahoo.com.br	(69)98105-4155	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
49. PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA	805.226.537-15	pchemato@bol.com.br	(69)99223-6068	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
50. PEDRO DI TARIQUE BARRETO CRISPIM	021.864.509-09			MESTRADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
51. RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA	878.217.889-53	rafaeloftalmo@uol.com.br	(69)98115-7915	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
52. REGINALDO FERNANDES LOURENÇO	478.778.202-91	rflcba@terra.com.br	(69)99255-9058	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
53. RENATO RORIZ DA SILVA	579.407.201-63	renatororiz@hotmail.com	(69)98119-0946	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
54. RICARDO TORRES NEGRAES	896.957.044-68	ranegra@globo.com	(69)98404-1139	MESTRADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
55. RODOLFO LUÍS KORTE	049.185.188-00	rlkorte@usp.br	(69)99284-8554	Doutorado	Docente	Parcial - T20	Estatutário
56. RODRIGO GUERINO STABELI	261.282.458-89	stabeli@unir.br		DOUTORADO	Docente	Parcial - T21	Estatutário
57. Maria Cristina Vitorino França				DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
58. ROSELY VALERIA RODRIGUES	070.585.738-75	valeria@valfarma.com.br	(69)98115-1001	DOUTORADO	Docente	INTEGRAL - DE	Estatutário
59. SHARON ROSE ARAGÃO MACEDO OLIVEIRA		sharon@unir.br	(69)98107-3089	MESTRADO	Docente	Integral - T40	CLT – Prof. Substituto
60. TARCIA LUCENA BRIDGHET	457.369.360-20	tarciapvh2@hotmail.com	(69)99222-2427	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
61. TATIARA BUENO PARREIRA	779.202.792-91	tatiarabueno@hotmail.com	(69)98170-4800	ESPECIALIZAÇÃO	Docente	Parcial - T20	Estatutário
62. THAMY YAMASHITA SHIBAYAMA	313.811.268-47	thamy@unir.br	(69)98126-7675	DOUTORADO	Docente	Parcial - T20	Estatutário

Quadro 9: Corpo docente, lattes, disciplinas e estágios

NOME	SIAPE	Departamento	Endereço do currículo Lattes	Disciplina/módulos que leciona	Estágios aos quais está vinculado	Tempo de vínculo institucional em anos	Tempo Mag.Sup. ou Exp na EDUC. Profissional (anos)	Tempo Fora Mag. (Exp. Profiss.(anos)	Tempo no ensino Básico (Exp. Profiss.) (anos)
ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS	1969239	Medicina	http://lattes.cnpq.br/1247501188727780	Anatomia I e II, CLÍNICA CIRÚRGICA I E II, INTERNATO DE CLINICA CIRÚRGICA I1	Internato de CLINICA CIRÚRGICA	3	7	15	0
ALEXANDRE LEITE CARVALHO	1529975	Medicina	http://lattes.cnpq.br/5205574919948596	Anatomia, Semiologia	Clínica Médica	10	12	31	
ANA ELLEN DE QUEIROZ SANTIAGO	1294434	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8078969063032908	CIRURGIA I e II.	Cirurgia (Anestesiologia)	10	10	15	
ANA LÚCIA ESCOBAR	396635	Medicina	http://lattes.cnpq.br/0896127016242466	Epidemiologia, Saúde Coletiva	Saúde Coletiva	26	27	34	
ANDONAI KRAUZE DE FRANÇA	1802890	Medicina	http://lattes.cnpq.br/0325134694482937	Genética, Genética Médica		6	10	7	8
ANDRÉ LUIS PETERMANN	1283871	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9337785347981208	Semiologia 1, 2, Clinica Médica 2 e internato		6	8	20	0
ANDREA BARBIERI DE BARROS	2017427	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7204262107515914	Clínica Médica, Doenças Infecciosas e Parasitárias	Clínica Médica	1			
ANDRESA TUMELERO	1647706	Medicina	http://lattes.cnpq.br/2618840344475082	Saúde da Criança	Pediatria	8	10	16	0
ANITA SPERANDIO PORTO	1807969	Medicina	http://lattes.cnpq.br/5819668469537380	PATOLOGIA GERAL E PATOLOGIA SISTÊMICA		6	7	13	9
ANTONIETA FERREIRA MACHADO DE OLIVEIRA	2257669	Medicina	http://lattes.cnpq.br/3209402957011632	Clínica Médica, Semiologia	Clínica Médica	0			
ANTONIO COUTINHO NETO	1854068	Medicina	http://lattes.cnpq.br/2544969941465695	Fisiologia		5	9	12	2
ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT		Sociologia	http://lattes.cnpq.br/6344056419837518	Antropologia Médica, História da Medicina		31	35	32	
CARLOS ALEXANDRE GRACAO RAMAGEM	1524242	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6518188977313289	CIRURGIA I e II.	INTERNATO II	10	12	5	
CAROLINA NEGRÃO BALDONI	1692475	Medicina	http://lattes.cnpq.br/3282463905794222	Métodos de diagnóstico e Imagenologia	Internato Clínica Médica e Clínica Cirúrgica	1			

CHRISTIAN COLLINS KUEHN	2148421	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6590442392256649	Parasitologia, Microbiologia		2	4	3	
CHRYSTIANO CAMPOS FERREIRA	1371464	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6214396903315123	ANATOMIA II, CLÍNICA CIRÚRGIVA I E II, INTERNATO DE CLINICA CIRÚRGICA I2	INTERNATO DE CLINICA CIRÚRGICA I2 - MÓDULO CIRURGIA ONCOLÓGICA NO H. CANCER DE BARRETOS	2	7	12	
CIPRIANO FEREIRA DA SILVA		Medicina	http://lattes.cnpq.br/8986452147499839	Clínica Médica, Semiologia	Internato de Clínica Médica	10	11	14	0
CLARIDES HENRICH DE BARBA		Filosofia	http://lattes.cnpq.br/4572407003327880	Filosofia		26	27	27	
CLESON OLIVEIRA DE MOURA	1844948	Medicina	http://lattes.cnpq.br/3309450050995617	Introdução a Atenção básica I; Introdução a atenção básica II; Saúde coletiva I; Saúde coletiva II; Gestão dos serviços de saúde.	Introdução a atenção básica I; Introdução a atenção básica II	5	14	17	2
DHELIO BATISTA PEREIRA	1786399	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7206230938221234	Informática Médica/Internato em SFC II		6	74	19	
ELZA GABRIELA DE BARROS PEREIRA	2154754	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6881005816214909	Medicina Preventiva, Internato de Saúde Coletiva I	Internato de Saúde Coletiva I	2	3	12	
EUGÊNIA DE CASTRO NEVES		Medicina							
EULÁLIA GONÇALVES DE AQUINO	396862	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8712096307133941	Métodos de diagnóstico e Imagenologia		26	27	8	
FILIPE SOUZA DE AZEVEDO	**2015687**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9801314498533747	Medicina Preventiva, Internato de Saúde Coletiva I	Internato de Saúde Coletiva I	1			
GISELE MARTINS GONÇALVES	6282165	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9777639107461667	Citologia e Embriologia, Biologia Molecular, Microbiologia		2	3	5	36
GLEICILAINE APARECIDA SENA CASSEB	**1550889**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6821407875964159	Citologia e Embriologia, Biologia Molecular, Microbiologia		10	16	12	
GRACIELA FÁTIMA LOURENÇO JOCA	1486315	Medicina	http://lattes.cnpq.br/2119877042552825	Clínica Médica	Internato de Clínica Médica	0			
HÉVILA TAMAR ROLIM LIMA	2246432	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7412501130778659	Medicina Preventiva, Internato de Saúde Coletiva I	Internato de Saúde Coletiva I	1			
HORACIO TAMADA	1528655	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8903095499345972	Bases da Clínica Cirúrgica	Internato Cirurgia	10	13	35	

IDA PEREA MONTEIRO	713032	Medicina	http://lattes.cnpq.br/0001215580335377	Saúde da Mulher	Internato Saúde da Mulher	2	6	36	22
IVANICE FERNANDES BARCELOS GEMELLI	1146175	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9692281142128168	Saúde da Mulher	Saúde da Mulher	2	6	24	
IZAURA RODRIGUES CÉZAR DE CAMPOS	2054532	Medicina							
JANDRA CIBELE RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA LEITE	1877825	Medicina	http://lattes.cnpq.br/5668287631633606	Procedimentos Básicos de Enfermagem, Introdução à Atenção Básica,	Sim	2	12	24	
JANNE CAVALCANTE MONTEIRO	2494861	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9817693608900183	Introdução a Atenção básica I; Introdução a atenção básica II; Gestão dos serviços de saúde, saúde do trabalhador.		10	17	24	
JOÃO PAULO SARAIVA LEAO VIANA		Sociologia	http://lattes.cnpq.br/8707855201746217	Sociologia		2	11	9	
JOHNATHAN DE SOUSA PARREIRA	2245703	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9736364667131325	NEUROLOGIA, SEMIOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA		1			
JOSE CARLOS COURI	1273746	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7941623665633825	Fisiologia, Clínica Médica	Internato de Clínica Médica	10	11	37	0
JOSE CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA	1552467	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8173007310224356	Ética Médica e Exercício Profissional, Medicina Preventiva	Internato de Saúde Coletiva I	9	11	27	0
JOSE ODAIR FERRARI	446608	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9706052157708759	ANATOMIA + SEMIOLOIA + BIOÉTICA + CLÍNICA MÉDICA	Internato de Clínica Médica	14	14	36	0
JOSE WILSON SERBINO JUNIOR	1527173	Medicina	http://lattes.cnpq.br/2549126487527880	Clínica Cirúrgica	Internato de Cirurgia	10	10	22	0
JUAN MIGUEL SALCEDO VILLALOBOS	1349543	Medicina	http://lattes.cnpq.br/5978913916143327	Introdução às DIP	Internato Clínica Médica	14	27	31	0
JULIANA PAVAN ZULIANI	1726461	Medicina	http://lattes.cnpq.br/9093880214338747	Imunologia		7	11	12	
KATIA REGINA PENA SCHESQUNI	**1279443**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7311452994883299	Saúde da Criança	Internato de Saúde da Criança	10	11	20	
LEONARDO DE AZEVEDO CALDERON	**1522184**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6910026933721706	Bioquímica, Biofísica		7	17	11	
LILIANA ANGELICA BANDOS BENITTEZ	**2151599**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8456391361455648	Saúde da Criança	Internato de Saúde da Criança	2	3	7	

MAILLENE RODRIGUE LISBOA	1524781	Medicina	http://lattes.cnpq.br/3231416721419042	SM3 / Internato GO 2/ Anatomia 1	Saúde da Mulher	10	12	19	
NAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA	2151090	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7887422481013407	Semiologia 1, 2, Clinica Médica 2 e internato	Internato Clínica Médica	2	10	10	0
OTINO JOSE ARAUJO DE FREITAS	396819	Medicina		Medicina Legal		29	27	32	1
PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA	969896	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7659364816627936	Clínica Médica	Clínica Médica	10	13	22	
PEDRO DI TARIQUE BARRETO CRISPIM		Medicina	http://lattes.cnpq.br/3149283996555023	Estatísticas de Saúde		10	15	15	
RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA	2695574	Medicina	http://lattes.cnpq.br/1494388455169773	Anatomia, Cirurgia	Cirurgia (Ofatlmologia)	2	10	17	
REGINALDO FERNANDES LOURENÇO	1995691	Medicina	http://lattes.cnpq.br/7834752988851652	Internato Saúde da Criança	Internato Saúde da Criança	3	5	11	16
RENATO RORIZ DA SILVA	**1505764**	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6747941274803699	CIRURGIA I e II.	Internato Cirurgia	11	14	20	
RICARDO TORRES NEGRAES	1524330	Medicina	http://lattes.cnpq.br/6439179519986553	Saúde da Criança	Internato Saúde da Criança	10	12	18	
RODOLFO LUÍS KORTE	1728620	Medicina	http://lattes.cnpq.br/1736751700554915	Coordenador Geral do Internato	Internato Cirurgia	6	10	22	
RODRIGO GUERINO STABELI		Medicina	http://lattes.cnpq.br/9479420856670926	Afastado (Vice-Presidente da FIOCRUZ)		11			
ROSA MARIA APARECIDA NECHI VERCEZE		Linguas Vernáculas		Língua Portuguesa		12	21	21	
ROSELY VALERIA RODRIGUES	396888	Medicina	http://lattes.cnpq.br/4906885238111741	Farmacologia		27	27	27	
SHARON ROSE ARAGÃO MACEDO OLIVEIRA		Medicina							
TARCIA LUCENA BRIDGHET	1527415	Medicina	http://lattes.cnpq.br/0922666232377452	Psicologia Médica, Psiquiatria	Clínica Médica	10	12	26	
TATIARA BUENO PARREIRA	2151168	Medicina	http://lattes.cnpq.br/8336255129681762	Clínica Médica, Semiologia	Clínica Médica	2	3	8	
THAMY YAMASHITA SHIBAYAMA	1979832	Medicina	http://lattes.cnpq.br/2252040283211484	PATOLOGIA GERAL E PATOLOGIA SISTÊMICA		2	5	11	11

Para duplicar as vagas oferecidas, além da ampliação de infraestrutura, com salas de aula, laboratórios, espaços de estudo, entre outros, será necessário que o MEC cumpra com o acordo feito de destinar mais 27 vagas de docentes, que deveriam ter sido já aportados ao DEPMED desde o ano de 2015.

3.2.2. CORPO DISCENTE

O processo seletivo para ingresso se dá pelo vestibular, que é realizado anualmente pela instituição. Para tal é utilizada a nota obtida pelo candidato no ENEM, respeitando a política de cotas. São realizadas atividades de recepção dos ingressantes tanto pela instituição como pelo Centro Acadêmico, respeitando o Guia do Estudante da UNIR. Todas as atividades são acompanhadas pela coordenação.

Os estudantes do curso de graduação são estimulados desde o seu ingresso a participarem das atividades de iniciação científica, através de sua vinculação aos grupos de pesquisa existentes.

Quanto aos programas de apoio à permanência, a PROCEA publica Editais anuais de seleção de discentes em situação de vulnerabilidade econômica. São distribuídas as seguintes bolsas: TIPO DE AUXÍLIO (BOLSA) Auxílio Alimentação R$ 132,00 mensais disponíveis no Cartão de Alimentação Auxílio Creche R$ 200,00 mensais em depósito ao beneficiário Auxílio moradia R$ 250,00 mensais em depósito ao beneficiário Auxílio transporte (Campus José Ribeiro Filho) 40 créditos mensais disponíveis no Cartão Leva Eu Auxílio transporte/alimentação (Campi) R$ 240,00 mensais em depósito ao beneficiário Bolsa permanência R$ 400,00 mensais em depósito ao beneficiário.

A transferência estudantil ocorre uma vez ao ano, quando as vagas são disponibilizadas para ingresso através de processo seletivo (Nota do ENEM). Há ampla divulgação de edital. Através do Programa de Mobilidade Estudantil, da ANDIFES, os alunos podem cumprir até 4 semestres do curso (exceto o internato) em outras universidades federais. Temos também convênios de cooperação com instituições para receber os alunos durante o internato optativo (2 meses). As instituições conveniadas são Hospital Nossa Senhora das Graças / Curitiba-PR, Hospital Sírio Libanês / SP, UNIFESP,

UFPB, UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados / MS, UFG, UFMT, UEL, UFMS, FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília, UNESP / Botucatu. Em tramitação convênios com USP/Ribeirão Preto.

Os estudantes participam do Conselho de Departamento na proporção de 15% da composição do colegiado, nos termos da lei. Há espaço destinado para o Centro Acadêmico, organizado e mantido exclusivamente pelos estudantes.

É estimulada a participação dos estudantes em eventos nacionais, proporcionando (na medida da disponibilidade de recursos) passagens e ajuda de custo para os mesmos. Sempre para os que vão apresentar trabalhos nos eventos.

E obrigatória a atualização e apresentação da carteira de vacinação atualizada, sem o que o estudante não tem acesso aos campos de prática.

Quanto à tutoria/mentoring, está previsto, a partir da implantação deste PPC, o início do programa, através do qual todos os alunos serão acompanhados por um tutor, ao longo do curso. Cada tutor poderá acompanhar até cinco estudantes.

3.2.3. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

O Departamento conta com um assistente administrativo e um estagiário para apoio às atividades. Atuam nos laboratórios um técnico de laboratório, um técnico em necropsia e uma auxiliar de limpeza. Para apoio ao funcionamento do ambulatório contamos com duas médicas pediatras. As duas enfermeiras lotadas no DENF passarão a atuar no apoio ao Laboratório de Habilidades, para apoio ao desenvolvimento das atividades práticas.

Para viabilizar a ampliação das vagas, é necessário que o MEC cumpra o acordado, destinando ao Departamento oito TA classe D e 12 TA Classe E.

Segue o quadro nominal dos servidores e demais informações.

Quadro 10: Servidores Técnicos do Departamento de Medicina

Nome	CPF	SIAPE	Cargo	Escolaridade	Local de trabalho
ANA EULÁLIA PIMENTEL FERNANDES RIBEIRO	457344883-72	2346267	MÉDICA	MESTRE	Grande Área de Pediatria
DOUGLAS MORO PIFFER	526.920.272-72	1647495	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	ESPECIALISTA	Laboratório de Anatomia Humana
IDELZUITA DA SILVA		0396532	SERVENTE DE LIMPEZA	ENSINO TÉCNICO	Laboratórios de Técnicas Cirúrgicas e Habilidades Clínicas
JAIMESSON FERREIRA DE OLIVEIRA	787.549.762-00	2165774	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	ENSINO TÉCNICO	Laboratórios de Anatomopatologia e Laboratório de Histologia, Embriologia e Patologia
MAIKON VENÍCIUS DA SILVA GIANIZELLI	927.284.132-15	2279931	ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO	SUPERIOR INCOMPLETO	Secretaria do DEPMED
MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DE FRANÇA	132.027.154-53	0396747	MÉDICA	MESTRE	Grande Área de Pediatria

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Descrição da estrutura administrativa do Curso

Como já citado anteriormente (item 3, p. 146-149), o Departamento de Medicina é responsável pelo curso de Graduação em Medicina, pelos cursos e programas de pós-graduação (atualmente Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental – Mestrado e Doutorado, Mestrado Profissional em Saúde da Família) e pelos Centros e Grupos de Pesquisa vinculados (Centro de Estudos em Saúde do Índio, Centro de Estudos e Pesquisas em Transplantes, Centro de Pesquisa em Biomoléculas), além da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Gerencia os laboratórios didáticos, além de coordenar a interface com os serviços de saúde, visando assegurar campos de prática e de estágios. Para fins de assegurar esta gama de atividades, está organizado em coordenações das seguintes grandes áreas: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Cirurgia, Clínica Médica, Educação e Medicina Social, Morfo-funcional. Cada área tem um coordenador, designado pelo Conselho de Departamento e formalizado segundo portaria 061/2016/NUSAU.

Os laboratórios de Anatomia Humana, Fisiologia e Biofísica, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Anatomopatologia, Técnica Cirúrgica Farmacologia, Citologia, Histologia e Patologia e de Habilidades Clínicas compõem a estrutura disponível para o curso.

Atualmente encontram-se em execução as seguintes pesquisas, todos com participação de estudantes de graduação, através do Programa de Iniciação Científica:
23118.002121/2016-40 - Aspectos clínicos-epidemiológicos dos acidentes ofídicos em Rondônia atendido no CEMETRON de 2010 a 2015.Prof. Dr. Rodolfo Luis Korte

23118.001717/2016-22 - Avaliação oftalmológica e acompanhamento de neonatos em serviço oftalmológico da cidade de Porto Velho, Sudoeste da Amazônia
Prof. Dr. Hévila Tamar Rolim Lima

23118.001750/2016-52 - Prevalência das mal formações congênitas em duas maternidades públicas no município de Porto Velho

Prof. Dr. Horácio Tamada

23118.001849/2016-54 - Caracterização clínico-laboratorial da "Hepatite C" acompanhados no ambulatório especializado de hepatites do Centro de Pesquisa e Medicina Tropical de Rondônia
Prof. Dr. Juan Miguel Villalobos Salcedo

23118.001944/2016-58 - Correlação entre exame oftalmológico e OCT em pacientes portadores de edema macular tratados com antiangiogênicos e corticoides intravítreos
Prof. Dr. Rafael Cardoso de Oliveira

23118.002117/2016-81 - Perfil epidemiológico dos exames colpocitológicos com diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical e carcinoma, realizados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho/RO
Profa. Dra. Thamy Yamashita Shibayama
Profa. MS. Anita Sperandio Porto

23118.001943/2016-11 - Prospecção e avaliação de interação de biomoléculas contra alvos enzimáticos da malária auxiliados por bioinformática
Prof. Dr. Antônio Coutinho Neto
Prof. Dr. Leonardo de Azevedo Calderon

23118.001946/2016-47 - Conhecimento dos profissionais sobre primeiros socorros em escola de ensino fundamental da Região Amazônica
Prof. MS. Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite

23118.001817/2016-59 - Correlação entre exame oftalmológico e OCT em pacientes portadores de DMRI exsudativo tratados com antiangiogênicos
Prof. Dr. Rafael Cardoso de Oliveira

23118.002919/2012-68 – As iniquidades e os determinantes sociais da saúde e da doença dos indígenas Wari' – Rondônia

Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar

23118.002157/2016-23 - Aprendizado baseado em problemas: Experiência da introdução do método em grupos de estudantes de medicina da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho/RO

Profa. Ms. Anita Sperandio Porto

Profa. Thamy Yamashita Shibayama

23118.001802/2016-91 - Screening mutacional e espectro clínico de pacientes com suspeita de doenças neurodegenativas raras (DNRs) e seus aspectos psicossociais na Amazônia Ocidental, Brasil

Prof. Ms. Andonai Krauze de França

23118.001948/2016-36 - Prevalência de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes assistidas em um ambulatório de planejamento familiar para adolescentes na Amazônia Ocidental

Prof. Ms. Ida Perea Monteiro

23118.001879/2016-61 - Neoplasias cutâneas raras: perfil de incidência, conduta e evolução de casos atendidos no Hospital de Câncer de Barretos - Porto Velho

Prof. Dr. Rodolfo Luis Korte

23118.001457/2016-95 - Acidentes de trânsito em Porto Velho/ RO: incidência e fatores de risco

Prof. Dr. Horácio Tamada

23118.000679/2012-67 – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ

Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar

Além dos projetos de pesquisa, são conduzidos projetos e programas de extensão, como “Transplantes de Órgãos e Tecidos no Estado de Rondônia: Ações de capacitação e educação em saúde para enfrentar desafios atuais e futuros”, coordenado pelo Prof. Dr. Alessandro Prudente. Também acompanha o desenvolvimento das atividades das diversas Ligas Acadêmicas, conduzidas pelos estudantes e acompanhadas pelos docentes das áreas.

Há um técnico e um estagiário para apoio às atividades administrativas. A estrutura física está localizada no mesmo bloco de funcionamento do curso, no mesmo andar das salas de aula, possuindo uma sala de coordenação, uma sala de coordenação do internato e da Residência Médica, uma sala de reuniões e uma secretaria.

Subordinado ao Núcleo de Saúde, o Conselho de Departamento de Medicina, é o órgão normativo máximo do Curso de Graduação em Medicina, tendo também caráter consultivo e de assessoramento, conforme estabelece o Regimento Geral da UNIR, nos artigos 38 a 42.

O Curso de Medicina conta com infraestrutura adequada de salas de aula. São cinco salas com capacidade para até 50 alunos, climatizadas e com acesso à internet por wifi. Todas as salas estão equipadas com mesas e cadeiras, quadro branco e datashow. Foi estruturada e equipada, no ambiente da DIRED, uma sala de teleconferência, que faz parte da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). Esta sala tem capacidade para até 30 alunos e possui computadores, cadeiras, lousa digital e equipamento para vídeo e teleconferência. Também estão disponíveis, por agendamento, três laboratórios de informática, que atendem às necessidades acadêmicas do curso.

Os laboratórios e centros de pesquisa possuem salas destinadas aos docentes, tanto para atividades de pesquisa, estudo e como de orientação acadêmica.

4.2. Descrição do suporte administrativo: DIRCA e Núcleo de Saúde

A DIRCA (Diretoria de Registro e Controle Acadêmico) é responsável pelo registro e guarda dos documentos referentes à vida acadêmica dos estudantes. Contamos com o apoio dos servidores quanto à gestão acadêmica do curso.

O Núcleo de Saúde/NUSAU, implantado pela Resolução nº 027/CONSEPE, de 18 de outubro de 1989, congrega os Cursos de Graduação e Pós-Graduação vinculados à área de Ciências da Saúde. Na graduação são os Cursos de Educação Física (www.def.unir.br),

Enfermagem (www.denf.unir.br), Medicina (www.depmed.unir.br) e Psicologia (www.depsi.unir.br) e na Pós-Graduação strictu sensu o Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental (www.pgbioexp.unir.br), o Mestrado Acadêmico em Psicologia (mestrado - www.mapsi.unir.br), o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde (www.cienciasdasaude.unir.br) e o Mestrado Profissional em Saúde da Família (www.profsaude.unir.br).

Os departamentos vinculados são os de Educação Física (DEF), Enfermagem (DENF), Medicina (DEPMED), Psicologia (DEPSI) e Saúde Coletiva (DESC).

A equipe é composta pelo Diretor, Prof. Dr. José Juliano Cedaro, Vice-diretora, Profa. Dra. Janne Cavalcante Monteiro, Secretária Executiva, Waldenice Nascimento Freitas, Administradora, Letíca Leite dos Santos, Assistente administrativo, Jeferson Araújo Sodré, Estagiárias, Victória Katrine Lobato (manhã) e Débora Damasceno (vespertino).

No NUSAU há técnicos administrativos que dão suporte eventual às demandas do departamento. É o órgão responsável pela gestão e pelo planejamento das atividades gerais da área de Saúde. É este Núcleo o responsável pelas articulações com o SUS visando assegurar os campos de prática, uma vez que a UNIR não dispõe de unidades de saúde próprias. Esta unidade é gerida pela direção, e submetida ao Conselho de Núcleo, composto pelos chefes de Departamento vinculados, por representantes docentes e discentes e dos projetos especiais, na forma do Regimento Geral da UNIR.

4.3. Equipamentos e laboratórios

O Departamento de Medicina conta atualmente com estrutura de laboratórios equipados de forma adequada para atender as necessidades de formação dos estudantes do curso de Medicina e demais cursos atendidos pelos professores, quando da oferta de disciplinas para os mesmos. De forma sintética, conta com os seguintes laboratórios:

Laboratório	Equipado	A ser equipado
Anatomia Humana	X	
Fisiologia Humana	x	
Farmacologia		X
Biotério		X
Técnica Cirúrgica	X	
Habilidades Clínicas	X	
Anatomopatologia	X	
Citologia, Histologia e Patologia	X	
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia	X	

As salas de aula (cinco) disponíveis para o curso são equipadas com mobiliário e equipamento de multimídia. Há salas para professores nos laboratórios e Centros de Pesquisa, além de uma sala para professores de uso coletivo cujos mobiliários estão em processo de aquisição. A estrutura física do Departamento inclui as salas de administração do curso, além de sala de reuniões. Há auditórios e laboratórios de informática para uso por agendamento, em quantidade suficiente para atender à demanda do curso. A biblioteca possui acervo importante e em constante processo de atualização, para atender às necessidades do curso. É importante destacar o acesso aos periódicos CAPES, além do acesso pela internet a inúmeros títulos em meio digital utilizados como referência, sendo boa parte de domínio público. Ressalte-se que seguimos protocolos institucionais quando do uso de animais em experimentos e as resoluções da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, acompanhadas através do Comitê de Ética em Pesquisa do NUSAU.

Segue o detalhamento dos laboratórios e demais estruturas utilizadas no curso de Medicina.

4.3.1 Biotério

Tipo de instalações	Biotério
Identificação	Biotério da UNIR
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR
Instalação	Localizado Atrás do Laboratório de Anatomia Humana, contendo 3 salas de Experimentação Animal, 1 ambulatório, 3 salas para colônia, 1 quarentena, uma sala de limpeza suja, 1 sala de limpeza limpa, almoxarifado, estoque, sala de apoio técnico, sala de administração, 2 banheiros
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	26 indivíduos
Tipo de capacidade	2 técnicos, 4 estagiários, 20 alunos
Área total em m²	200 m2
Equipamentos	Em aquisição

4.3.2 Laboratório de Anatomia Humana

Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Anatomia Humana – BLOCO 3B – SALAS 102, 103, 105 e 106
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3B
Instalação	PRÉDIO TÉRREO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO (ANFITEATRO), 1 SALAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (SALA DOS BONECOS), 1 SALA DE PREPARO, DISSECAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E AULAS PRÁTICAS

	(SALA DOS TANQUES), 1 SALA DE ALMOXARIFADO, 1 SALA DE APOIO TÉCNICO.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	ANATOMIA I – MEDICINA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE ANATOMIA II – MEDICINA – 40 ALUNOS – 2º SEMESTRE ANATOMIA – ENFERMAGEM – 30 ALUNOS – 2º SEMESTRE ANATOMIA – PSICOLOGIA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE ANATOMIA – ED. FÍSICA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE
Tipo de capacidade	ANFITEATRO – 50 ALUNOS SALA DOS BONECOS – 15 ALUNOS SALA DE PREPARO – 20 ALUNOS
Área total em m²	185 m^2
OBS:	Laboratório Didático Pedagógico

Foto 1 – Fachada e Entrada Principal Foto 2 – Placa de Identificação Foto 3 – Calçadas à Esquerda e Direita

Foto 4 – Vista Lateral Direita (Entrada para Sala de Preparo)	Foto 5 – Vista Lateral Esquerda (Entrada para Lab. de Habilidades)

Foto 6 - Hall (Recepção)

4.3.3 Laboratório de Técnicas Cirúrgicas

Laboratório de Ensino (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3A – SALA 101
Instalação	LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM – 40 ALUNOS – 3º PERÍODO BASES DA CLINICA CIRURGICA – MEDICINA – 40 ALUNOS – 5º PERÍODO CLINICA CIRURGICA I – MEDICINA – 40 ALUNOS – 6º PERÍODO CLINICA CIRURGICA II – MEDICINA – 40 ALUNOS – 7º PERÍODO CLINICA CIRURGICA III – MEDICINA – 40 ALUNOS – 8º PERÍODO
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	

4.3.4 Laboratório de Anatomopatologia

Laboratório de Ensino (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)

Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Anatomopatologia – BLOCO 3A – SALA 102
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3A
Instalação	LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	PATOLOGIA GERAL – MEDICINA – 40 ALUNOS – 4º SEMESTRE PATOLOGIA SISTÊMICA – MEDICINA – 40 ALUNOS – 5º SEMESTRE PATOLOGIA – ENFERMAGEM – 30 ALUNOS – 3º SEMESTRE
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	

4.3.5 Laboratório de Fisiologia Humana

Laboratório de Ensino	
Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Fisiologia Humana – BLOCO 3A – SALA 103
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3ª
Instalação	LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	FISIOLOGIA E BIOFÍSICA I – MEDICINA – 40 ALUNOS – 3º SEMESTRE FISIOLOGIA E BIOFÍSICA II – MEDICINA – 40 ALUNOS – 4º SEMESTRE FISIOLOGIA – ENFERMAGEM – 30 ALUNOS – 2º SEMESTRE FISIOLOGIA – PSICOLOGIA – 40 ALUNOS – 2º SEMESTRE FISIOLOGIA – ED. FÍSICA – 40 ALUNOS – 2º SEMESTRE
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	

4.3.6 Laboratório de Farmacologia

Laboratório de Ensino	
Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Farmacologia – BLOCO 3A – SALA 104
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3ª
Instalação	LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	FARMACOLOGIA – MEDICINA – 40 ALUNOS – 4º SEMESTRE FARMACOLOGIA – ENFERMAGEM – 30 ALUNOS – 3º SEMESTRE
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	Em fase de aquisição de equipamentos

4.3.7 Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia

Laboratório de Ensino	
Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia – BLOCO 3A – SALA 204
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3ª
Instalação	LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	Histologia e Embriologia (medicina) – 80 horas – 2º SEMESTRE; Histologia e Embriologia (enfermagem) – 20 hs – 2º SEMESTRE; Citologia Biologia celular (medicina) – 40 hs – 1º SEMESTRE; Patologia Geral (enfermagem) – 20hs – 3º SEMESTRE; Patologia Geral(medicina) – 40 hs – 4º SEMESTRE; Patologia Sistêmica (Medicina) – 40 hs – 5º SEMESTRE; Biologia Geral (Educação Fisica) - 20 hs – 1º SEMESTRE.
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	

4.3.8 Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia

Laboratório de Ensino	
Tipo de instalações	Laboratório Didático Pedagógico
Identificação	Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia – BLOCO 3A – SALA 205
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3A
Instalação	LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Quantidade	Vide item acima
Capacidade	Microbiologia e Imunologia – Enfermagem (03) – 60 HORAS – 3º SEMESTRE Microbiologia – Medicina (03) – 60 HORAS – 4º SEMESTRE Imunologia – Medicina (03) – 60 HORAS – 3º SEMESTRE Imunologia – Enfermagem (02) – 60 HORAS – 3º SEMESTRE Parasitologia – Medicina (05) – 100 HORAS – 3º SEMESTRE Parasitologia – Enfermagem (03) – 80 HORAS – 3º SEMESTRE Métodos de Diagnóstico Laboratorial e Imagem (05) – 100 HORAS – 5º SEMESTRE Bioquimica – Medicina (5) – 100 HORAS – 1º SEMESTRE Bioquimica – Enfermagem (3) – 80 HORAS – 1º SEMESTRE
Tipo de capacidade	SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES
Área total em m²	Aproximadamente 90 m^2
OBS:	

4.3.9 Laboratório de habilidades	
Tipo de instalações	Laboratório de Habilidades
Identificação0	Laboratório de Habilidades Clínicas – Bloco 3B Sala 101
Disponibilidade	Imóvel de Propriedade da UNIR – Bloco 3B
Instalação	Localizado no primeiro pavimento, contendo 1 recepção, 5 salas para aulas práticas, 1 área comum com pias e 1 sala para guarda de materiais e equipamentos.
Quantidade	01
Capacidade	100 alunos
Tipo de capacidade	50 alunos por turno; 5 docentes; 03 técnico administrativo
Área total em m²	Aproximadamente 210 m^2
OBS: (preenchimento obrigatório)	O laboratório dispõe de 50 simuladores e acesso à internet.

Foto 01. Entrada do Lab. de Habilidades Clínicas		Foto 02. Placa de Identificação da Unidade
Foto 03. Stand de exame de face, ouvido, vias respiratórias, fundo		**Foto 04. Stand de simulação realística em paciente robotizado**

de olho - Inf. e Adt.		
Foto 05. Stand de simulação em Ginecologia e Obstetrícia		**Foto 06. Stand de simulação em Ginecologia e Obstetrícia - Atenção ao RN**
Foto 07. Stand de sondagens e cateterismos		**Foto 08. Stand de punções**

4.4 Protocolos de experimentos

Não são realizados experimentos com animais ou com seres humanos durante as atividades de ensino do curso de graduação, em nenhum dos componentes curriculares. Quando há experimentos, os mesmos são realizados no bojo de projetos de pesquisa, coordenados pelos Centros de Pesquisa da instituição, e sob a responsabilidade ética dos mesmos.

OBS: (preenchimento obrigatório)	Os protocolos e projetos de pesquisa são analisados e aprovados pelo Conselho de Departamento de Medicina e submetidos ao Conselho de Núcleo e Conselho Superior Acadêmico, após submissão ao Comissão de Ética em Pesquisa da UNIR. São utilizadas todas as normas internacionalmente aceitas e integradas à Plataforma Brasil. A Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIR (CEUA-UNIR) foi instituída em 27/06/2014. Suas atribuições e competências são definidas conforme o disposto na Lei 11.794/08 e em resoluções do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) (Processo 23118.002670/2011-18). É uma Comissão ligada ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET), com regimento próprio, aprovado pela Câmara de Legislação e Normas (Parecer 272/CLN) e pelo CONSAD (Resolução 122/2014).Todos os projetos de pesquisa e planos de aulas práticas envolvendo a utilização de animais (filo Chordata, subfilo Vertebrata), no âmbito do curso de Medicina da UNIR, devem ser submetidos à análise pelo Comitê de ética de Animais da UNIR (CEUA), e só podem ser executados mediante sua prévia aprovação.

4.5 Comitê de ética em pesquisa

Os protocolos e projetos de pesquisa são analisados e aprovados pelo Conselho de Departamento de Medicina e submetidos ao Conselho de Núcleo e Conselho Superior Acadêmico, após submissão ao Comissão de Ética em Pesquisa da UNIR. São utilizadas todas as normas internacionalmente aceitas e integradas à Plataforma Brasil. Todas as pesquisas que envolvem docentes ou estudantes dos cursos do Departamento de Medicina, incluindo a graduação, a residência e as pós-graduações são submetidas ao Comitê de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - é um colegiado multi e transdisciplinar, independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos

(Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde).

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) está cadastrado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.É coordenado Pelo Professor Edson Farias. Contato: Telefones: (69) 2182 2111 ou 9 8434 4761. E-mail: cepunir@yahoo.com.br
O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está baseado nas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) e brasileiras (Res. CNS 466/12 e complementares). De acordo com estas diretrizes: "toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um CEP"

As atribuições do CEP são de papel consultivo e educativo, visando contribuir para a qualidade das pesquisas, bem como a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada.É credenciado pela CONEP, integrado à Plataforma Brasil.

4.6. Biblioteca

A biblioteca central da UNIR tem natureza científica, cultural e técnica e compreende a Biblioteca Roberto Duarte Pires (em Porto Velho) e seis Bibliotecas Setoriais dos Campi. O horário de funcionamento é das 8h às 21h. Atualmente, a diretoria do Sistema de Bibliotecas da UNIR é composta por duas bibliotecárias e uma equipe técnica de oito bibliotecárias e duas estagiárias. O quadro funcional da Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" é composto por 18 servidores, conta com 3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa na internet. A área física está assim distribuída no térreo e no primeiro piso. No térreo há Circulação (2 postos de atendimento), Auditório (50 assentos), Gerência de Atendimento, Guarda Volumes (300 vagas), Espaço Digital (17 computadores e 4 pufs), 2 Banheiros. No primeiro piso há Circulação (3 postos de atendimento), Área do acervo, Salão de Estudo (92 mesa e 413 cadeiras), 1 Sala de Treinamentos (12 computadores), 6 Salas de Estudo em Grupo (1 mesa e 4 cadeiras cada), 5 Cabines de Estudo Individual, Espaço Deleite (16 poltronas e 7 pufs), 3 Banheiros (masculino, feminino, cadeirante).

A Biblioteca Central possui aproximadamente 33.000 mil títulos nas áreas da saúde e ciências sociais, sendo Ciências da Saúde 5.687 exemplares, Ciências Biológicas 2.899 exemplares, Ciências Sociais e Aplicadas 30.510 exemplares e Ciências Ambientais 748 exemplares. Em relação aos periódicos, possui 14 fascículos da área das Ciências da Saúde, quatro das Ciências Biológicas e 87 fascículos e periódicos das Ciências Sociais Aplicadas. O número de periódicos é pequeno, mas tal deficiência é compensada com o acesso irrestrito ao portal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e o funcionamento da Biblioteca Digital que pode ser utilizado pelos acadêmicos e professores do Curso de Graduação em Enfermagem. A UNIR possui aceso ao portal CAPES, com possibilidade de uso em qualquer computador interligado à rede. Estão disponíveis no portal:

- MEDICINA I. CANCEROLOGIA = 427 TÍTULOS
- MEDICINA I. CARDIOLOGIA = 438 TÍTULOS
- MEDICINA I. CLÍNICA MÉDICA = 1.506 TÍTULOS
- MEDICINA I. DERMATOLOGIA = 149 TÍTULOS
- MEDICINA I. ENDOCRINOLOGIA= 304 TÍTULOS

- MEDICINA I. FISIATRIA = 211 TÍTULOS
- MEDICINA I. GASTROENTEROLOLOGIA= 260 TÍTULOS
- MEDICINA I. MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA = 70 TÍTULOS
- MEDICINA I. NEFROLOGIA = 287 TÍTULOS
- MEDICINA I. PNEUMOLOGIA= 222 TÍTULOS
- MEDICINA I. ALEORGOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA = 245 TÍTULOS
- MEDICINA II. ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA = 248 TÍTULOS
- MEDICINA II. DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS = 388 TÍTULOS
- MEDICINA II. HEMATOLOGIA = 176 TÍTULOS
- MEDICINA II. NEUROLOGIA = 746 TÍTULOS
- MEDICINA II. PEDIATRIA= 2 TÍTULOS
- MEDICINA II. PSIQUIATRIA = 812 TÍTULOS
- MEDICINA II. RADIOLOGIA MÉDICA = 303 TÍTULOS
- MEDICINA II. REUMATOLOGIA= 114 TÍTULOS
- MEDICINA II. SAÚDE MATERNO - INFANTIL= 300 TÍTULOS
- MEDICINA III. ANESTESIOLOGIA= 101 TÍTULOS
- MEDICINA III. CIRURGIA - 527 TÍTULOS
- MEDICINA III. OTORRINOLARINGOLOGIA= 181 TÍTULOS
- MEDICINA III. TRAUMATOLÓGICA= 1 TÍTULO
- MEDICINA III. GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA= 337 TÍTULOS
- MEDICINA III. NEUROCIRURGIA= 1 TÍTULO
- MEDICINA III. OFTALMOLOGIA= 147 TÍTULOS
- MEDICINA III. ORTOPEDIA= 229 TÍTULOS
- MEDICINA III. MEDICINA. GERIATRIA. GERONTOLOGIA= 122 TÍTULOS

Conforme informado pela coordenação da Biblioteca, estão disponíveis aproximadamente dois mil títulos de livros para atender ao curso de Medicina, distribuídos entre títulos das Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde.

4.7. Infraestrutura básica utilizada no ensino.

O Departamento de Medicina utiliza atualmente cinco salas de aula, localizadas no terceiro andar do Bloco 3ª. Cada uma das salas tem capacidade para até 50 alunos. Atualmente estão equipadas com mobiliário para 40 alunos, quadro branco, ar condicionado e datashow em cada uma das salas. Nos andares inferiores estão instalados os laboratórios de Patologia, Histologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, Técnicas Cirúrgicas e Farmacologia. No Bloco 3B estão instalados os laboratórios de Habilidades e de Anatomia. Todas as salas e laboratórios são cobertos pela rede de internet sem fio da instituição, mantido pela RNP. Os alunos e professores têm acesso aos laboratórios de informática da instituição, através de agendamento prévio, sendo suficientes para atender às necessidades pedagógicas. Temos uma sala da Rede Universitária de Telemedicina, equipada para vídeo e webconferências, computadores e

lousa digital. Temos acesso à Plataforma Moodle, sendo que alguns componentes curriculares incluem atividades à distância, utilizando a mesma.

Tipo de instalações	**Salas de aula amplas, iluminadas e arejadas, com capacidade para até 50 alunos.**
Identificação (nome do local)	**SALAS DE AULA – BLOCO 3A – SALAS 301, 302, 303, 305, 306 e 307**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**5x40=200 cadeiras, 5x40=200 carteiras, 5 armários, 5 suportes para Datashow, 4 datashows, 5 aparelhos de ar condicionado de 60mil Btus.**
Quantidade	**5 (cinco)**
Capacidade (quantidade de alunos)	**150x5=750 alunos em turnos de 250 alunos cada**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**50x5=250 alunos por turno.**
Área total em m²	**60x6=360 m²**
OBS: (Preenchimento obrigatório: Descrever o ambiente, tamanho, equipamentos existentes e suas quantidades, etc.)	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro no mesmo piso e banheiros.**

Além da estrutura disponível na UNIR, o curso de Medicina conta com as instalações de saúde do Estado e do município de Porto Velho, para as atividades práticas. A UNIR possui convênio com a SESAU e com a SEMUSA de porto Velho, que asseguram nosso acesso e prioridade de uso da rede do SUS.

As atividades práticas de formação priorizam o enfoque na atenção básica, especialmente nas áreas: clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, saúde coletiva, em unidades básicas de saúde, ambulatórios (de nível secundário e terciário), e unidades de internação, dentro do enfoque da hierarquização dos serviços de saúde e da atenção médica, e elas são, em sua **totalidade**, supervisionadas pelos

docentes das respectivas disciplinas e pelos preceptores credenciados. As atividades práticas são desenvolvidas nas UBS de nosso território, no Ambulatório Rafael Vaz e Silva, na Policlínica Oswaldo Cruz, nas unidades hospitalares do Estado e na maternidade municipal. Nossos docentes médicos atuam na assistência destas unidades e acompanham as atividades práticas dos alunos.

4.8. Acessibilidade

O conceito de acessibilidade refere-se ao acesso por meio da diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física, de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando à qualidade e acesso a universidade. A estrutura física das salas de aulas do bloco do Curso de Graduação em Medicina possui rampa de acesso e banheiro para cadeirantes. Porém, esta rampa não atende a todas as limitações físicas, fazendo-se necessária a providência de um elevador no prédio de aulas para, assim garantir o acesso a todos os acadêmicos, professores/servidores e comunidade em geral. No que se refere à formação de recursos humanos, é oferecida a disciplina de LIBRAS que visa contribuir para minimizar as barreiras na comunicação.

5. BIBLIOGRAFIA.

Referências

IBGE, 2016. Grandes Regiões e Unidades da Federação: Esperança de vida ao nascer segundo projeção populacional: 1980, 1991-2030 - Ambos os sexos. Acessado em 20/03/2016.
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000243.pdf

CFM, 2016. Estatística. Acessado em 19/04/2016. http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_estatistica

DATASUS, 2016. CNES - Recursos Humanos - Ocupações - Segundo CBO 2002 - Rondônia. Acessado em 18/04/2016. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/proc02ro.def

Departamento de Medicina. Projeto de Implantação do Curso de Medicina da UNIR.

CNE, 2014. Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina. Acessado em 23/08/2016. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15874-rces003-14&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192

Brasil, 2013. Lei 12.871. Lei do Mais Médicos. Acessado em 23/08/2016. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12871-22-outubro-2013-777279-publicacaooriginal-141521-pl.html

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) ADERSON M.B., KASSENBAUN D.G. Proceedings of the AAMC's Consensus Conference in the use of standardized patients. The teaching and evaluation of clinical skills. **Academic Medicine**. Philadelphia, v.68, n.6, p. 437-483, 1993.

2) HARDEN, R.M. Assessment of clinical competence using objective structured clinical examination. **British Medical Journal**. London, v.1, n.5955, p. 447-451, 1975.

3) NEWBLE D.J. Assessing clinical competence at the undergraduate level. **Medical Education**. Chicago, v.26, n.6, p.504-11, 1992.

4) PETRUSA E.R., BLACKWELL T.A., AINSWORTH M.A. Reliability and validity of an objective structured clinical examination for assessing the clinical performance of residents. **Archives of Internal Medicine**. Chicago, v.150, n.3, p.573-7, 1990.

5) RESNICK R.K. et al. An objective structured clinical examination for the licenciate: report of the pilot project of the Medical Council of Canada. Academic Medicine. Philadelphia, v.67, n.8, p.487-494, 1992.

6) TRONCON L.E.A. et al. Avaliação de habilidades clínicas por exame objetivo estruturado por estacões, com emprego de pacientes padronizados: uma aplicação no Brasil. **Revista Brasileira de Educação Médica**. Rio de Janeiro, v.20, n.2/3, p.53-60, 1996.

7) TRONCON L.E.A. et al. Implantação de um programa de avaliação terminal do desempenho dos graduandos para estimar a eficácia do currículo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. **Revista da Associação Médica Brasileira**. São Paulo, v.45, n.3, p.217-224, 1999.

8) VIANNA H.M. Avaliação Educacional. **Cadernos de Pesquisa**. São Paulo v.80, n.1, p.100-5, 1992.

9) ZIV A., et al. Lessons learned from six years of international administration of the ECFMG's SP- based clinical skills assessment. **Academic Medicine**. Philadelphia, v.73, n.1, p.84-91, 1998.

ANEXOS

Anexo 1 – Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Competências Gerais:

- **Atenção à saúde**: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo;
- **Tomada de decisões**: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;
- **Comunicação**: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
- **Liderança**: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
- **Administração e gerenciamento**: os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
- **Educação permanente**: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profisssionais dos serviços.

Conhecimento, Competências e Habilidades Específicas:

- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social;
- Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos primário e secundário;
- Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus familiares;
- Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação;
- Realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico;
- Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução;
- Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação médica;
- Reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance da sua formação geral;
- Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus aspectos;
- Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em evidências científicas;
- Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção;
- Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e continuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- Atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do processo de morte;
- Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases do ciclo biológico;
- Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos técnicos-científicos e a participação na produção de conhecimentos;
- Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de saúde;

- Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos de referência e contra-referência;
- Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como médico;
- Considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta as reais necessidades da população;
- Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de política e de planejamento em saúde;
- Atuar em equipe multiprofissional;
- Manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.

Com base nestas competências, a formação do médico deverá contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em equipe.

3. CONTEÚDOS CURRICULARES

Os conteúdos essenciais do curso de graduação em Medicina devem guardar estreita relação com as necessidades de saúde mais freqüentes referidas pela comunidade e identificadas pelo setor saúde. Devem contemplar:

- Conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;
- Compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;
- Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção;
- Compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-paciente;
- Diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica;
- Promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e ambiental.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.

As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do Curso de Graduação em Medicina para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação,

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural.

O Currículo do Curso de Graduação em Medicina poderá incluir aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região.

A organização do Curso de Graduação em Medicina deverá ser definida pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular.

A estrutura do curso de graduação em medicina deverá:

- ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo setor saúde;
- utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência;
- incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania;
- promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais;
- inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua futura vida profissional;
- utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional;
- propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde desde o inicio de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na graduação com o internato;
- através da integração ensino-serviço vincular a formação médico-acadêmica as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS.

5. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

- **Estágios**

A formação médica incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão direta dos docentes da própria Escola/Faculdade, com duração mínima de 2700 horas.

O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço incluirá necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área.

O Colegiado do Curso de Medicina poderá autorizar, no máximo de 25% da carga horária total estabelecida para este estágio, a realização de treinamento supervisionado fora da unidade federativa, preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em Instituição conveniada que mantenha programas de Residência

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de pós-graduação.

- **Atividades Complementares**

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de Graduação em Medicina e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância.

Podem ser reconhecidos:

- Monitorias e Estágios,
- Programas de Iniciação Científica;
- Programas de Extensão;
- Estudos Complementares;
- Cursos realizados em outras áreas afins.

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares de medicina devem ser acompanhados e permanentemente avaliados, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento.

As avaliações somativa e formativa do aluno deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos curriculares.

O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação definido pela IES à qual pertence.

Anexo 2 – Carga horária mínima:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 (*)(**)

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no art. 9º, do § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fulcro no Parecer CNE/CES nº 8/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 13 de junho de 2007, RESOLVE:

Art. 1º Ficam instituídas, na forma do Parecer CNE/CES nº 8/2007, as cargas horárias mínimas para os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, constantes do quadro anexo à presente.

Parágrafo único. Os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário.

Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do art. 1º, deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por curso, bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações:

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei nº 9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo;

II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada em horas, passando a constar do respectivo Projeto Pedagógico;

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma:

a)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h:
Limites mínimos para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos.

b)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h:
Limites mínimos para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos.

c)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h:
Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos.

d)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h:
Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos.

e)Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h:
Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos.

IV – a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua adequação.

Art. 3º O prazo para implantação pelas IES, em quaisquer das hipóteses de que tratam as respectivas Resoluções da Câmara de Educação Superior do CNE, referentes às Diretrizes Curriculares de cursos de graduação, bacharelados, passa a contar a partir da publicação desta.

(*) Resolução CNE/CES 2/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de junho de 2007, Seção 1, p. 6.
(**) Republicada no DOU de 17/09/2007, Seção 1, pág. 23, por ter saído no DOU de 19/06/2007, Seção 1, pág. 6, com incorreção no original.

Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e desta Resolução, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos termos da Portaria Normativa nº 1/2007, bem como atender ao que institui o Parecer CNE/CES nº 261/2006, referente à hora-aula.

Art. 5º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do MEC nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e supervisão, no que for pertinente à matéria desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Antônio Carlos Caruso Ronca
Presidente da Câmara de Educação Superior

ANEXO

Carga horária mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial	
Curso	***Carga Horária Mínima***
Administração	*3.000*
Agronomia	*3.600*
Arquitetura e Urbanismo	*3.600*
Arquivologia	*2.400*
Artes Visuais	*2.400*
Biblioteconomia	*2.400*
Ciências Contábeis	*3.000*
Ciências Econômicas	*3.000*
Ciências Sociais	*2.400*
Cinema e Audiovisual	*2.700*
Computação e Informática	*3.000*
Comunicação Social	*2.700*
Dança	*2.400*
Design	*2.400*
Direito	*3.700*
Economia Doméstica	*2.400*
Engenharia Agrícola	*3.600*
Engenharia de Pesca	*3.600*
Engenharia Florestal	*3.600*
Engenharias	*3.600*
Estatística	*3.000*
Filosofia	*2.400*
Física	*2.400*
Geografia	*2.400*
Geologia	*3.600*
História	*2.400*
Letras	*2.400*
Matemática	*2.400*
Medicina	*7.200*
Medicina Veterinária	*4.000*
Meteorologia	*3.000*
Museologia	*2.400*
Música	*2.400*
Oceanografia	*3.000*
Odontologia	*4.000*
Psicologia	*4.000*
Química	*2.400*
Secretariado Executivo	*2.400*
Serviço Social	*3.000*
Sistema de Informação	*3.000*
Teatro	*2.400*

Anexo 3 – Reconhecimento do Curso de Medicina

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA
UNIR
CGC. 04. 418.943/0001-90 http://www.unir.br
DIRCA – DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO / dirca@unir.br
Fone: 0(xx69) 2182-2185 Fax: 0(xx69) 2182-2186

DECLARAÇÃO

UNIR DIRCA

Declaramos para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR – PORTO VELHO. Criada pela Lei nº 7.011 de 08 de julho de 1982 e DOU de 09 de julho de 1982, oferece o CURSO DE MEDICINA – HABILITAÇÃO: MÉDICO, reconhecido pela Portaria SESU/MEC nº 141 de 30 de janeiro de 2009 e DOU de 03 de fevereiro de 2009, no horário integral das 7h50 às 12h10 e das 13h50 às 18h10.

Porto Velho-RO, 19 de novembro de 2010.

Glaciangela Marques de Souza
Coordenadora de Registro de Diplomas e Certificados / DIRCA / UNIR

Disciplina ou Área Profissional/Nome	Nota Final	Colocação	Situação Final
Construção Civil / Estradas (Maracanã)			
Antônio José Rocha Lazardo	6,15	1º	Classificado
Sérgio Falcometa Neves	5,96	2º	Aprovado
Turismo / Hotelaria (Maracanã)			
Ismara Albuquerque Giffoni	6,28	1º	Classificado
Telecomunicações (Nova Iguaçu)			
Marcelo Pereira da Silva	6,47	1º	Classificado
Amaro Azevedo de Lima	6,46	2º	Classificado
Tito Gonçalves de Sousa	4,80	3º	Classificado
Física - Perfil 2 (Nova Friburgo)			
Leonardo Machado de Moraes	7,86	1º	Classificado
Leonardo de Sousa Grigorio	6,96	2º	Classificado
Rubens Mussolini	6,51	3º	Aprovado
Bruno Souza de Paula	6,14	4º	Aprovado
Bernardo Muniz Tavares	5,80	5º	Aprovado
Informática (Nova Friburgo)			
Anderson Amendoeira Nunes	7,64	1º	Classificado
Thiago Delgado Faria	5,20	2º	Classificado
Carlos Eduardo Parreja	5,25	3º	Aprovado
Pedro Costa Nucci	5,11	4º	Aprovado
Inglês (Nova Friburgo)			
Alexandra Mitie Sgallanzani	8,98	1º	Classificado
Suzana de Carvalho Barroso	8,40	2º	Classificado
Roberta Boechat Albertino	8,18	3º	Aprovado
Marcia Telesca Keckhoff	7,93	4º	Aprovado
Valéria Ladeira Farinha	7,68	5º	Aprovado
Carla Regina do Valle Bastos	7,43	6º	Aprovado
Cláudia Maria Vasconcelos Lopes	7,40	7º	Aprovado
Karina dos Santos Domingues	6,83	8º	Aprovado
Leandro Luiz da Silva	6,60	9º	Aprovado
Turismo / Hotelaria (Nova Friburgo)			
Rodrigo de Benedictis Delphino	6,07	1º	Classificado
Informática (Petrópolis)			
Glauco Fiorott Amorim	7,69	1º	Classificado
Thibert Motta Monteiro	6,40	2º	Aprovado
Matemática (Petrópolis)			
Leandro Tavares da Silva	6,78	1º	Classificado
Turismo / Teoria Geral do Turismo (Petrópolis)			
Gheyza Lemos Gonçalves Gama	7,11	1º	Classificado

MIGUEL BADENES PRADES FILHO

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

RETIFICAÇÃO

Na Portaria n.º 169 de 19 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União do dia 22 de dezembro de 2008, Seção 1, página 118, onde se lê: JOÃO HENRIQUE CARDOSO MEIRELES, leia-se: JOÃO HENRIQUE CARDOSO MEIRELES DA COSTA.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

PORTARIA Nº 28, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, combinado com o art. 2º da Portaria Normativa MEC nº 12, de 14 de agosto de 2006, e a Resolução nº 9, de 14 de junho de 2006, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, bem como o mérito do pedido, conforme consta do respectivo processo, resolve:

Art. 1º - Aditar, nos termos do art. 10, § 4º do referido Decreto, o ato autorizativo abaixo discriminado, no que tange a denominação de curso superior de tecnologia.

Número de Processo	Ato autorizativo em aditamento			Alterações
	Portaria Nº/Data / D.O.U/Data	Instituição mantenedora/ Instituição mantida	Denominação anterior do Curso	Nova denominação do Curso
23000.020896/2009-61	103 de 20/01/04 DOU de 22/01/04	Ministério da Educação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná	Gestão Comercial Elétrica	Eletrotécnica Industrial

Art. 2º - A instituição deverá observar a carga horária mínima constante do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, conforme Art. 43 do Decreto 5.773/2006, bem como as disposições do Art. 3º da Portaria Normativa nº 12, quanto às adequações pertinentes ao projeto pedagógico respectivo, em decorrência das alterações ocorridas, garantindo a manutenção dos padrões de qualidade.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA Nº 29, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, da competência que lhe foi outorgada pelo Decreto nº 5.773, de 09/05/2006, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12/12/2007, tendo em vista a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12/12/2007, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pedido, conforme consta do Processo e-MEC nº , do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º - Reconhecer, nos termos do art. 10, § 3º , do referido Decreto nº 5.773/2006, o Curso Superior de Tecnologia em Marketing, constante do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, com duzentas vagas totais anuais, distribuídas nos períodos diurno e noturno, ofertado pela Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba, estabelecida à Rua Santa Madalena Sofia Barat, nº 809, Bairro Alto, no Município de Curitiba, Estado de São Paulo, mantida pela IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.

Art. 2º - Nos termos do art. 10, § 7º , do mesmo Decreto nº 5.773/2006, o reconhecimento é válido até o ciclo avaliativo seguinte.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

RETIFICAÇÃO

No 63, anexo da Portaria nº .870, de 16 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de julho de 2008, seção 1, página 13, onde se lê: "Técnico em Serviços Imobiliários", leia-se: "Técnico em Transações Imobiliárias".

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 141, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG nº 018/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.002335/2006-61, Registro SAPIENS nº 20050013711, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Medicina, bacharelado, ministrado pela Universidade Federal de Rondônia, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, mantida pela União, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º , do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.

Art. 2º Conforme deliberação da Comissão de Especialistas para Supervisão dos Cursos de Medicina, instituída pela Portaria SESu nº 344, de 9 de maio de 2008, em reunião de 16 de janeiro de 2009, este curso permanecerá sob monitoramento da SESu, até o próximo ciclo avaliativo do SINAES.

Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA Nº 143, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG nº 0065/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.002146/2007-70, Registro SAPIENS nº 20060010247, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Pedagogia, licenciatura, com 100 (cem) vagas totais anuais, turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade de Educação São Brás, situada à Rua Antônio Escorsin, nº 1.650, bairro São Brás, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, mantida pelo Instituto Superior de Educação da América Latina S/S Ltda., com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA Nº 144, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme consta do Processo nº 23000.027256/2007-44, Registro E-MEC nº 20079714, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Teologia, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, a ser ministrado pela Faculdade Católica de Anápolis, na Rua 05, nº 580, bairro Cidade Jardim, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, mantida pela Fundação São Miguel Arcanjo, com sede na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA Nº 145, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme consta do Processo nº 23000.006582/2008-07, Registro E-MEC nº 200800374, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Nutrição, bacharelado, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac, na Rua Dr. Satamini, nº 245, bairro Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela União Social Camiliana, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA Nº 146, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme consta do Processo nº 23000.007709/2008-05, Registro E-MEC nº 200801114, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Enfermagem, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, a ser ministrado pela Faculdade Interamericana de Porto Velho, na Avenida Mamoré, nº 1.520, bairro Cascalheira, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, mantida pela União das Escolas Superiores de Rondônia Ltda., com sede na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA Nº 147, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme consta do Processo nº 23000.009055/2008-46, Registro E-MEC nº 200803196, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Farmácia, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas do Oeste de Minas, na Rua Santos Dumont, nº 1.001, bairro do Carmo, na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, mantida pela Sociedade Educacional e Cultural de Divinópolis Ltda., com sede na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

Anexo 4 – Matriz curricular 2002 e suas adaptações:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO

Currículo do Curso

Curso : MEDICINA
Currículo : 2002 MEDICINA
Habilitação : 2002 MEDICINA

Documentação

Objetivo :

Diplomado em

Período de Conclusão do Curso	Mínimo: 0	Médio : 0	Máximo : 0
Créditos Obrigatórios	Geral : 430		
Número de Aulas Semanais	Mínimo: 3	Médio : 3	Máximo : 100

1ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDSOCO	SOCIOLOGIA	OB	3	60		PSISOG1	
MEDBIQU	BIOQUIMICA	OB	5	100			
MEDESAS	ESTATISTICA DA SAUDE	OB	4	80		COTEST	
MEDANAT	ANATOMIA I	OB	9	180			
MEDCEMO	CITOLOGIA E BIOLOGIA MOLECULAR	OB	5	100			
MEDIAB1	INTRODUCAO A ATENCAO BASICA I	OB	4	80			
MEDMEC	METODOLOGIA CIENTIFICA	OB	3	60		ADM31024	
MEDFILO	FILOSOFIA	OP	3	60		CBIFILO	

2ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDLIPO	LINGUA PORTUGUESA	OP	3	60		LETPORI	
MEDANA2	ANATOMIA II	OB	8	160	MEDANAT		
MEDIAB2	INTRODUCAO A ANTENCAO BASICA II	OB	3	60	MEDIAB1		
MEDHIEM	HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA	OB	9	180	MEDCEMO		
MEDPSME	PSICOLOGIA MEDICA	OB	2	40			
MEDANM	ANTROPOLOGIA MEDICA	OB	3	60			
MEDGENE	GENETICA E EVOLUÇÃO	OB	4	80	MEDCEMO	PSIGEV	

3ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDHIME	HISTORIA DA MEDICINA	OP	2	40			
MEDIMUN	IMUNOLOGIA	OB	3	60			
MEDBIOE	BIOETICA	OB	3	60			
MEDPBE	PROCEDIMENTOS BASICO DE ENFERMAGEM	OB	3	60			
MEDSCO1	SAUDE COLETIVA I	OB	2	40			
MEDFIB1	FISIOLOGIA E BIOFISICA I * MEDANA2 E MEDANAT E MEDHIEM	OB	9	180	*		
MEDPEM	PARASITOLOGIA E ENTOMOLOGIA MEDICA	OB	5	100	MEDHIEM		
MEDSEM1	SEMIOLOGIA I	OB	3	60	MEDANA2 E MEDANAT		

4ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDIDP	INTRODUCAO AS DOENCAS PARASITARIAS	OB	6	120	MEDPEM		

Currículo do Curso

Curso : MEDICINA
Currículo : 2002 MEDICINA
Habilitação : 2002 MEDICINA

MEDMIC	MICROBIOLOGIA	OB	3	60	
MEDEPI1	EPIDEMIOLOGIA I	OB	3	60	
MEDFAR	FARMACOLOGIA	OB	5	100	MEDBIQ [illegible] MEDFIS1
MEDFIS2	FISIOLOGIA E BIOFISICA II	OB	3	60	MEDFIS1
MEDSEM2	SEMIOLOGIA II	OB	9	180	MEDSEM1
MEDPTG	PATOLOGIA GERAL	OB	6	120	MEDFIS1 E MEDFIS

5ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDGAM1	SAUDE DA MULHER I	OB	3	60	MEDPTG E MEDFIS2		
MEDGOC	BASES DA CLINICA CIRURGICA * MEDPTG E MEDFIS2 E MEDFAR	OB	5	100	*		
MEDGCM	BASES CLINICA MEDICA * MEDFAR E MEDPTG E MEDFIS2	OB	5	100	*		
MEDGMEP	ETICA MEDICA E EXERCICIO PROFISSIONAL	OB	3	60	MEDSEM		
MEDEPI2	EPIDEMIOLOGIA II	OB	3	60	MEDEPI1		
MEDMDIM	METODOS DE DIAG.E IMAGENOLOGIA * MEDIMUN E MEDPTG E MEDFIS2	OB	5	100	*		
MEDPASI	PATOLOGIA SISTEMICA	OB	6	120	MEDPTG		
MEDGAC1	SAUDE DA CRIANCA I * MEDPTG E MEDFIS2 E MEDSEM2	OB	3	60	*		
MEDTPCV	TOPICOS EM FIS.CARDIO-VASCULAR * MEDIMUN E MEDPTG E MEDFIS2	OP	2	40	*		

6ª Fase

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MEDGAM2	SAUDE DA MULHER II	OB	6	120	MEDGAM1		
MEDCME1	CLINICA MEDICA I	OB	7	140	MEDGCM		
MEDGME	GENETICA MEDICA	OB	3	60	MEDGEN2		
MEDCCI1	CLINICA CIRURGICA I	OB	6	120	MEDGOC		
MEDMEL	MEDICINA LEGAL	OB	4	80	MEDFIS1 E MEDPTG		
MEDSCO2	SAUDE COLETIVA II	OB	3	60	MEDSCO1		
MEDGAC2	SAUDE DA CRIANCA II	OB	5	100	MEDGAC1		

7ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31001	CLINICA CIRURGICA II	OB	7	140	MEDCCI1		
MED31002	SAUDE DA MULHER III	OB	5	100	MEDGAM1 E MEDGAM2		
MED31003	SAUDE DA CRIANCA III	OB	5	100	MEDGAC1 E MEDGAC2		
MED31002	SAÚDE DA FAMÍLIA	OP	3	60			
MED31000	COMUNICACAO CIENTIFICA	OB	3	60			
MED31004	CLINICA MEDICA II	OB	7	140	MEDCME1		
MED31005	MEDICINA PREVENTIVA	OB	4	80	MEDEPI2 E MEDSCO2		

8ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	OB	3	60			

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO

Currículo do Curso

Curso : MEDICINA
Currículo : 2002 MEDICINA
Habilitação : 2002 MEDICINA

MED31004	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OP	3	60	
MED31001	FUNDAMENTOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	OP	2	40	
MED31006	ACUPUNTURA	OP	3	60	
MED31008	PSIQUIATRIA	OB	3	60	[illegible]
MED31009	CLINICA MEDICA III	OB	7	140	MED31004
MED31010	CLINICA CIRURGICA III	OB	7	140	MED31001
MED31011	DIP	OB	7	140	[illegible]
MED31012	INFORMATICA MEDICA	OB	3	60	

9ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31019	INTERNATO - I	OB	44	880	*		
	* MED31010 E MED31009 E MED31011 E MED31013 E MED31012 E MED31008 E MED31002 E MED31000						
MED31023	INTERNATO I - PEDIATRIA	RS	15	300			
MED31024	INTERNATO I - SAUDE COLETIVA	RS	15	300			
MED31025	INTERNATO I - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	RS	15	300			
MED31026	INTERNATO I - CLINICA MEDICA	RS	15	300			
MED31027	INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA	RS	15	300			
MED31028	INTERNATO I - OPCIONAL	RS	15	300			

10ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31023	INTERNATO I - PEDIATRIA	RS	15	300			
MED31022	INTERNATO	RS	44	880			
MED31024	INTERNATO I - SAUDE COLETIVA	RS	15	300			
MED31025	INTERNATO I - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	RS	15	300			
MED31026	INTERNATO I - CLINICA MEDICA	RS	15	300			
MED31027	INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA	RS	15	300			
MED31028	INTERNATO I - OPCIONAL	RS	15	300			

11ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31050	INTERNATO II - OPCIONAL	RS	15	300			
MED31021	INTERNATO II	RS	44	880	*		
	* MED31024 E MED31025 E MED31026						
MED31031	INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA	RS	15	300			
MED31030	INTERNATO II - CLINICA MEDICA	RS	15	300			
MED31033	INTERNATO II - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	RS	15	300			
MED31035	INTERNATO II - PEDIATRIA	RS	15	300			
MED31034	INTERNATO II - SAUDE COLETIVA	RS	15	300			

12ª FASE

Disciplina		Tipo	Cred	C.H.	Pré-Requisitos	Equivalentes	Bloco
MED31034	INTERNATO II - SAUDE COLETIVA	RS	15	300	MED31024		
MED31033	INTERNATO II - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	RS	15	300	MED31025		
MED31035	INTERNATO II - PEDIATRIA	RS	15	300	MED31023		
MED31030	INTERNATO II - CLINICA MEDICA	RS	15	300	MED31026		

Currículo do Curso

Curso : MEDICINA
Currículo : 2002 MEDICINA
Habilitação : 2002 MEDICINA

MED31031	INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA	ES	16	300	MED1027
MED31050	INTERNATO II - OPCIONAL	ES	16	300	

OBSERVAES: Reconhecido pela Portaria/SESu/MEC nº 141 de 30/01/2009.D.O.U de 03/02/2009.

Anexo 5 – Coordenações de Área do Curso de Medicina

Portaria nº 061/2016/NUSAU. Porto Velho, 19 de agosto de 2016.

O Diretor do Núcleo de Saúde, no uso das atribuições conferidas pela Porta 1076/GR/2015, e considerando memorando 226/DEPMED/UNIR, de 08/08/2016.

RESOLVE:

Art. 1º- **Designar** os docentes abaixo como coordenadores das várias áreas que comp Departamento de Medicina:

Área Morfo-funcional: Prof. Dr. **CHRISTIAN COLLINS KUEHN**
Educação e Medicina Social: Profa. DRA. **JANNE CAVALCANTE MONTEIRO**
Clínica Médica: Prof. Ms. **ANDRÉ LUIS PETERMANN**
Saúde da Mulher: Profa. Esp. **MAILLENE RODRIGUES LISBOA**
Saúde da Criança: Profa. Ms. **KATIA REGINA PENA SCHESQUINI**
Cirurgia: Prof. Dr. **HORACIO TAMADA**
Coordenação geral do internato: Prof. Dr. **RODOLFO LUIS KORTE**
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Anexo 6 – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina

Portaria nº 059/2016/NUSAU. Porto Velho, 17 de agosto de 2016.

O Diretor do Núcleo de Saúde, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 1076/GR/2015, e considerando o que consta no Memorando 225/DEPMED/UNIR, de 08/08/2016,

RESOLVE:

Art. 1º- **Alterar** parcialmente a Portaria 014/NUSAU, de 05/03/2015, publicada no BS nº 21, de 10/03/2015, que trata da composição do Núcleo Docente Estruturante/NDE do curso de Medicina, com mandato entre 25/02/2015 a 24/02/2018, com relação ao que segue:

I – SUBSTITUIR o nome da servidora docente **JULIANA ZULIANI** pelo nome da servidora docente **GISELLE MARTINS GONÇALVES**;

II – incluir o nome do servidor docente **RENATO RORIZ DA SILVA**.

Parágrafo único. A Comissão do caput, após a alteração, fica com a seguinte composição:

Profa. Dra. **Ana Lúcia Escobar** - DE
Profa. Dra. **Gisele Martins Gonçalves** – DE
Prof. Dr. **Rodolfo Korte** – DE
Prof. Ms **André Luis Peterman** – T20
Profa. Ms. **Kátia Regina Schesquini Roriz** - DE
Prof. Ms. **Dhelio Batista Pereira** – T20
Profa. Ms. **Andressa Tumelero** – T20
Profa. Esp. **Maillene Rodrigues Lisboa** - T-20
Prof. Ms**. Renato Roriz da Silva** – T - 20
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Anexo 7 – Coordenação do Internato da Medicina

Portaria nº 062/2016/NUSAU . Porto Velho, 19 de agosto de 2016.

O Diretor do Núcleo de Saúde, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 1076/GR/2015, e considerando memorando 227/DEPMED/UNIR, de 08/08/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - **Revogar** a Portaria 073/NUSAU, de 20/08/2015, publicada no BS nº 76, de 20/08/2016.

Art. 2º- Designar os docentes abaixo como coordenadores do Internato de Medicina com a seguinte composição:

Coordenação Geral do Internato: Prof. Dr. **RODOLFO LUIS KORTE**

Coordenação de Urgência e Emergência: Profa. Ms**. ANDRESA TUMELERO**

Coordenação da Cirurgia I: Prof.Ms. **ALESSANDRO PRUDENTE DOS SANTOS**

Coordenação da Cirurgia II: Prof. Esp. **CHRYSTIANO CAMPOS FERREIRA**

Coordenação da Saúde da Mulher I: Profa. Ms. **IDA PEREA MONTEIRO**

Coordenação da Saúde da Mulher II: Profa. Esp. **MAILLENE RODRIGUES LISBOA**

Coordenação da Clínica Médica I: Prof. Ms. **JOSÉ ODAIR FERRARI**

Coordenação da Clínica Médica II: Prof. Ms. **CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR**

Coordenação da Pediatria I: Prof. Esp**. REGINALDO FERNANDES LOURENÇO**

Coordenação da Pediatria II: Prof. Ms **RICARDO TORRES NEGRAES**

Coordenação da Medicina de Família e Comunidade I: Profa. Dra. **HÉVILA TAMAR ROLIM LIMA**

Coordenação da Medicina de Família e Comunidade II: Profa. **ELZA GABRIELA DE BARROS PEREIRA**

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Anexo 8 – Regimento do Internato

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Ato Decisório 148/CONSEA, de 27 de julho de 2011.

Regimento Interno do Internato do Curso de Medicina

O Presidente do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.000499/2011-02;
- Parecer 1103/CGR, relator Conselheiro Júlio César Barreto Rocha;
- Solicitação da Coordenação geral do Internato de Medicina;
- Parecer 1111/CGR, relator Conselheiro Adilson Siqueira de Andrade – por pedido de vistas;
- Memorando 044/SECONS;

D E C I D E *AD REFERENDUM* DO PLENÁRIO:

HOMOLOGADO NA 55ª SESSÃO DO CONSEA, EM 25/08/2011.

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Internato do Curso de Medicina, em anexo.

Art. 2º - Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data.

Conselheiro José Januário de Oliveira Amaral

Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ANEXO DO ATO DECISÓRIO 148/CONSEA, DE 27 DE JULHO DE 2011.

REGULAMENTO INTERNO DO INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Art. 1º - O Internato constitui-se no último ciclo do curso de graduação em Medicina da UNIR, durante o qual o estudante deve receber capacitação intensiva, contínua, sob supervisão docente, em instituições de saúde vinculadas ou conveniadas à escola médica.

§ 1º - Para iniciar o Internato, o aluno deverá, obrigatoriamente, ter cursado e sido aprovado em todas as disciplinas curriculares até o oitavo período da graduação.

A ordem dos rodízios do Internato I e II será definida pela Comissão do Internato, em um período prévio ao pedido de matrícula, conforme prevê Calendário Acadêmico da UNIR;

§ 2º - Não serão aceitos alunos especiais, nos termos do Art. 87 do Regimento Geral da UNIR,

§3º - Nos casos de Mobilidade Acadêmica, serão aceitos alunos apenas para cursar a área opcional do Internato, com duração de quatro ou oito semanas,

Art. 2º - O Internato representa a última etapa da formação escolar de graduação do médico generalista, com capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde prevalentes da população a que vai servir.

Art. 3º - Os objetivos do Internato são:

I - Desenvolver atividades teórico-práticas em nível hospitalar e ambulatorial como parte da formação médica;

II - Possibilitar o treinamento prático supervisionado, hospitalar e ambulatorial, propiciando ao aluno a aquisição de conhecimentos, para empregar na prática médica;

III - Desenvolver e aperfeiçoar atitudes e habilidades adequadas à assistência médica aos pacientes;

IV - Possibilitar a prática da assistência integral, através da inter-relação com os diversos profissionais da equipe de saúde;

V - Estimular a formação que motive os futuros médicos a melhorar continuamente suas habilidades;

VI - Proporcionar uma formação ética dentro dos mais elevados padrões morais;

VII - Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação;

VIII - Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das doenças;

IX - Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;

X - Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.

Art. 4º - O Internato I se desenvolverá durante o Nono e Décimo Período, em estágios rotatórios, com duração de oito semanas em cada uma das seguintes áreas:

g) Clínica Médica I;
h) Clínica Cirúrgica I;
i) Ginecologia e Obstetrícia I;
j) Pediatria I;
k) Saúde Coletiva I; e
l) Optativo I

§1º - O aluno regularmente matriculado poderá cursar em outra instituição de ensino apenas a parte opcional do Internato, com duração de 04 ou 08 semanas para o Optativo I.

§2º - Cada grande área discriminada nas alíneas acima referidas poderá elaborar suas normas específicas de funcionamento, desde que estas não conflitem com o Regimento Geral da UNIR e a legislação vigente.

Art. 5º - O Internato II se desenvolverá durante o Décimo Primeiro e Décimo Segundo Períodos, em estágios rotatórios, com duração de oito semanas em cada uma das seguintes áreas:

g) Clínica Médica II;
h) Clínica Cirúrgica II;
i) Ginecologia e Obstetrícia II;
j) Pediatria II;
k) Saúde Coletiva II; e
l) Optativo II

§1º - O aluno regularmente matriculado poderá cursar em outra instituição de ensino apenas a parte opcional do Internato, com duração de 04 ou 08 semanas para o Optativo II.

§2º - Cada grande área discriminada nas alíneas acima referidas poderá elaborar suas normas específicas de funcionamento, desde que estas não conflitem com o Regimento Geral da

UNIR e a legislação vigente.

Art. 6º - Os estágios rotatórios do Internato I e II (Clínica Médica I e II; Clínica Cirúrgica I e II; Ginecologia e Obstetrícia I e II; Pediatria I e II; Saúde Coletiva I e II;) serão realizados no âmbito das unidades conveniadas de saúde do Estado e Municípios de Rondônia, nos diversos níveis de complexidade assistencial.

§1º - Para que o Internato possa se desenvolver fora do âmbito da Instituição de Ensino é pertinente a realização de convênio com os órgãos externos competentes.

§2º - O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais condições operacionais, é da competência da UNIR, que considerará, para cadastramento das instituições prestadoras de serviços médicos, os seguintes critérios e/ou exigências:

I - Localização preferencial do campo de estágio no estado de Rondônia;

II - Prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas da instituição convenente, compatíveis com as exigências da formação a ser dispensada ao estagiário, a juízo da Comissão de Internato bem como a existência de pessoal médico capacitado para exercer a função de Preceptor;

III – Preferencialmente, deve-se procurar unidades que tenham Programas de Residência Médica reconhecidos nas áreas de estágio.

Art. 7º - Cada grande área do Internato (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Coletiva) terá um coordenador e um vice-coordenador, indicado pela Chefia do DEPMED entre os docentes de suas respectivas disciplinas, sendo os referidos nomes submetidos à aprovação em reunião do Conselho Departamental de Medicina, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições:

I - Coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em sua respectiva área de atuação;

II - Elaborar o Programa do Internato;

III – Avaliar o desempenho dos alunos durante o desenvolvimento das atividades do Internato;

IV – Definir a nota final dos estágios previstos nos artigos 4 e 5, entregando as notas na DIRCA conforme calendário acadêmico.

V - Orientar os alunos em relação às suas atividades e a seus direitos e deveres;

VI - Coordenar as reuniões dos preceptores;

VII - Prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato.

Parágrafo único. O coordenador tem autonomia na definição dos preceptores e de critérios de avaliação, à partir da disponibilidade de recursos humanos dos serviços de saúde;

Art. 8º. A Reunião das grandes áreas do Internato constitui a Comissão do Internato, a qual é presidida pela Coordenação Geral e suas decisões são submetidas ao Conselho de Departamento.

Art. 9º - Os preceptores serão os professores da Universidade Federal de Rondônia, os profissionais médicos, médicos-residentes e outros profissionais de saúde que atuam em cada área, sendo designados a critério do Coordenador de Área, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições:

I - Acompanhar o desempenho dos alunos em suas atividades teóricas e práticas;

II – Auxiliar o Coordenador de Área na avaliação do desempenho dos Internos;

III - Desenvolver reuniões e demais eventos programados com os alunos;

IV - Prestar informações aos Coordenadores sobre o desenvolvimento dos Programas.

Art. 10 - Os Planos de Ensino de cada área do Internato serão elaborados pelo professor Coordenador, podendo ser discutido com os representantes dos alunos de cada área, estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação prévia da Comissão de Internato.

Art. 11 - O aluno será avaliado quanto aos seguintes aspectos, dentre outros:

e) Cognitivo;

f) Conhecimento teórico-prático e busca por conhecimento;

g) Ético (relação com paciente, preceptor, internos, pessoal da instituição de saúde e grupo multidisciplinar);

h) Assiduidade; pontualidade e permanência no serviço;

Parágrafo único. Caberá ao Coordenador de área definir a melhor metodologia de avaliação e apresentá-la ao Conselho de Departamento quando da conclusão dos Planos de Ensino

Art. 12 - É obrigatória a frequência integral em todas as atividades programadas para o Internato, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o abono de faltas;

Art. 13 - A falta não justificada ou não previamente autorizada pelo Coordenador de Área e/ou Preceptor a qualquer atividade programada para o Internato I e II terá como conseqüência a reprovação do estágio em desenvolvimento; **Parágrafo único.** Salvo motivo de força maior, todas as faltas deverão ser comunicadas ao Coordenador de Área e/ou Preceptor no prazo máximo de 48 horas.

Art. **14** - Em caso de reprovação em qualquer rodízio do Internato I e/ou II, o momento do estágio de recuperação/reavaliação será definido em tempo hábil pela Comissão do Internato, conforme disponibilidade de vagas na rede de serviços de saúde.

Parágrafo único. Em caso de reprovação em qualquer dos estágios rotatórios do Internato I, previstos no art. 4 desta resolução, o aluno não poderá cursar o estágio rotatório II da respectiva área;

Art. 15 - Observada a disponibilidade de recuperação da abstenção no período das férias, será permitido que o aluno falte nas seguintes situações:

e) Incapacidade física temporária;

f) Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos, sendo permitido até sete dias;

g) Convocação pelo Poder Judiciário; e

h) Casamento do aluno, sendo permitido até sete dias;

§ 1º - Sob nenhuma hipótese as faltas previstas nas alíneas a, b, c e d poderão exceder a 25% do período de cada estágio, e sempre que as faltas excederem este limite o aluno será reprovado.

§ 2º - Em qualquer das hipóteses mencionadas nas alíneas acima citadas, o aluno deverá apresentar documento comprobatório à Comissão de Internato, ficando a seu critério aceitar a justificativa.

§ 3º – Todas as faltas previstas nas alíneas acima deverão ser repostas integralmente, conforme calendário estabelecido pelo Coordenador de Área;

Art. 16 – São deveres dos alunos internos:

I – Cumprir os horários estabelecidos, bem como os plantões que lhes forem destinados;

II – Cumprir o calendário elaborado pelo Departamento de Medicina (DEPMED/UNIR), pela Coordenação do Internato e pela Coordenação das respectivas Áreas;

III – Dedicar-se aos estudos e às atividades programadas;

IV - Frequentar os cursos, reuniões e outros eventos incluídos no Programa de Internato;

V – Relacionar-se ética e cortesmente com os pacientes, docentes, servidores, colegas e demais alunos das instituições de ensino;

VI – Cumprir as disposições contidas neste Regulamento, no Regimento da UNIR e nas normas de organização e funcionamento das instituições onde ocorre o Internato;

VII – Seguir à risca todas as recomendações das comissões intra-hospitalares, como a CCIH e outras;

VIII - Vestir roupa branca, jaleco e sapato fechado, fazendo uso obrigatório e rotineiro destes Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;

IX – Estar com o esquema vacinal atualizado e com o seguro obrigatório em dia;

X - Realizar todo e qualquer ato médico apenas e sob a orientação do preceptor;

XI – Não praticar ou permitir qualquer violação do prontuário médico.

Art. 17 - Os alunos terão direito a dois representantes com direito a voz e voto nas reuniões da Comissão do Internato, cabendo-lhes:

I - Reunir-se regularmente com os alunos para efeito de conhecimento do desenvolvimento do Programa;

II - Submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Internato as reivindicações dos alunos.

Art. 18 – Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Internato, cabendo recurso ao Conselho de Departamento e às demais instâncias de deliberação, conforme o Regimento Geral da UNIR.

Anexo 9 – Relatório do Processo de Acreditação do Curso de Medicina da UNIR (SAEME)

RELATÓRIO DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO

Processo de Acreditação	24 / 2015	Data	14/11/2016
Instituição de ensino	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
Cidade	Porto Velho	Estado	RO
Equipe de Avaliação	Felix Hector Rigoli (Coordenador do Grupo de Avaliadores)		
	KLEYTON DE ANDRADE BASTOS (Avaliador do SAEME)		
	Marynéa Silva do Vale (Avaliador do SAEME)		
Comissão de Acreditação	Carlos Rodrigues da Silva Filho		
	Lucieni de Oliveira Conterno		
	Milton de Arruda Martins		
	Patricia Zen Tempski		

DIMENSÃO GESTÃO EDUCACIONAL		
Indicador	**Conceito**	**Avaliação Qualitativa**
1. 01 Responsabilidade social	Suficiente	Responsabilidade Social da escola médica pode ser definida como uma decisão institucional de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável, expressada em ações que resultem em benefício da coletividade interna e externa à IES. Esse compromisso firmado entre a comunidade acadêmica e a sociedade deve ser parte da missão da UNIR e seu projeto pedagógico para o curso de Medicina, o que se evidencia nas relações estáveis entre o curso, os gestores municipais e estaduais e os representantes do controle social. Tanto gestores como usuários reafirmam a importância da instituição pública de ensino da medicina como uma peça de importância na conformação do SUS local.
1. 02 Integração entre ensino e serviço	Suficiente	Durante a visita foi possível identificar uma articulação orgânica com o sistema de saúde local, nos diferentes níveis de atenção. Foi verificada a parceria existente entre a IES, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e a estadual (SESAU) que declara, tanto a nível municipal com estadual, ter uma preferência pela relação com a UNIR. Os representantes dos usuários consultados também percebem positivamente a presença dos estudantes e dos preceptores no serviço.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
1. 03 Apoio a Políticas Públicas	Suficiente	A Universidade Federal de Rondônia é a principal parceira dos gestores públicos nas iniciativas relativas ao ensino-serviço, como Pro e Pet-saúde e mais recentemente Provab e Mais Médicos. Por localização e vocação também a UNIR é reconhecida como parceira importante de várias iniciativas de Vigilância Epidemiológica e de Saúde Indígena.
1. 04 Regulamentação de designação das autoridades acadêmicas	Suficiente	Existe um regimento de funcionamento que detalha este aspecto.
1. 05 Coordenação do Curso	Suficiente	Em relação à Coordenação do Curso de Medicina, o Saeme busca identificar um profissional com experiência na área médica e em educação médica, dedicado à gestão educacional do curso de Medicina. O currículo da atual coordenadora apresentado e seu reconhecimento pelo prestigio local e capacidade de liderança contempla este indicador em forma suficiente, sendo inclusive citado como ponto chave pelo Reitor da Universidade. A coordenadora atual tem atuação acadêmica nas áreas prioritárias do Curso de Medicina, assim como uma preocupação especial com a formação em Ciências da Saúde visando multiplicar as capacidades da área.
1. 06 Regime de trabalho do Coordenador do curso	Suficiente	Este indicador busca avaliar a dedicação do coordenador do curso à gestão educacional. Espera-se que atue em dedicação exclusiva, o que é o caso no Curso de Medicina da UNIR.
1. 07 Composição do colegiado de curso ou equivalente	Insuficiente	Composição de tipo colegiada, com 70% de docentes, entretanto, esse conselho não é composto através de eleição entre os pares e não possui regimentada sua renovação.
1. 08 Funcionamento do colegiado do curso ou órgão equivalente	Suficiente	Por triangulação de informações colhidas nas diversas instancias de consulta, o funcionamento de colegiado parece suficiente para assegurar conexões e participação entre as diversas instancias da IES, por mais que tenha preponderância dos docentes das áreas básicas.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
1. 14 Aprimoramento da qualidade do ambiente educacional	Suficiente	O Saeme entende como ambiente educacional tudo que se refere ao curso, como ele é vivenciado pelo professor e estudante no processo de ensino-aprendizagem, incluindo aspectos relacionais para além daqueles de infraestrutura e dos recursos disponíveis (Maudsley, 2001; Pai et al., 2014). As visitas no Campus mostram uma preocupação pelo ambiente educacional em variadas esferas de atividade, com existência de recursos que parecem suficientes, e às vezes sub-utilizados (como laboratórios e salas de informática).
DIMENSÃO PROGRAMA EDUCACIONAL		
Indicador	**Conceito**	**Avaliação Qualitativa**
2. 01 Perfil profissional do egresso	Suficiente	As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Graduação em Medicina homologadas em 20 de junho de 2014 estabelecem como perfil profissional do egresso: "Art. 3º O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença". Na avaliação dos gestores e representantes da comunidade com os quais tivemos contato, aparece claramente que o perfil previsto no Projeto Pedagógico é alinhado com as demandas das Diretrizes Curriculares Nacionais anteriores e as atuais, sendo também perceptível este tipo de alinhamento com as falas dos discentes nas diferentes instancias de plenária e grupo focal. Este perfil também é compartilhado e externado por diversos docentes das áreas básica e clínica.
2. 02 Objetivos educacionais	Suficiente	O curso tem uma vocação própria de servir a uma comunidade regional (mesmo que os estudantes provenham de muitos estados do Brasil) e por isso tem forte orientação pela epidemiologia e saúde comunitária, com integração até onde possível de ações preventivas, de promoção e curativas. Existe forte contato do aluno com o meio social e as necessidades de populações desatendidas, estando os objetivos educacionais coerentes com o perfil do egresso.
2. 03 Conteúdos curriculares	Suficiente	Os conteúdos curriculares são estruturados preponderantemente em disciplinas, agrupadas em módulos, especialmente nos primeiros dois anos. Esta distribuição disciplinar está em revisão para uma melhor integração.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
1. 09 Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)	Suficiente	O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi criado com o intuito de qualificar o envolvimento dos docentes no processo de concepção e consolidação do curso de graduação. Conjunto de professores, composto por pelo menos cinco docentes do curso, de elevada formação e titulação, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua realização do projeto pedagógico do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do curso e percebida na produção de conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas como importantes pela Instituição e que atuem no desenvolvimento do curso, contratados em tempo integral ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010).Os docentes do NDE da UNIR contemplam o perfil traçado neste indicador no que tange sua formação e dedicação ao curso, sendo de alta dedicação (exclusiva ou 20 horas) e com formação em ensino em ciências da saúde.
1. 10 Funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)	Suficiente	Núcleo docente estruturante se reuniu regularmente durante 2015 e 2016, com discussão das novas DCN e da reformulação do PPC. Além do mais, o funcionamento do NDE está regimentado e tem registro de suas discussões e encaminhamentos, contemplando este indicador.
1. 11 Núcleo de Desenvolvimento Docente	Insuficiente	Existem várias iniciativas de estimulo a formação nas áreas de ensino em ciências da saúde, incluindo Doutores na área, participação no Mestrado realizado na UNIR e as atividades da FAIMER, mas não existe Núcleo de Desenvolvimento Docente como tal, sendo ações de tipo individual.
1. 12 Ações institucionais de Desenvolvimento Docente	Suficiente	As evidências apresentadas demonstram que o curso tem o capital humano e o interesse da Universidade para desenvolver capacidades, tendo sido considerado suficiente este indicador.
1. 13 Autoavaliação institucional	Insuficiente	Existe uma preocupação pela avaliação, demostrada inclusive no convite ao SAEME, mas não encontramos evidencias que a Comissão Própria de Avaliação tenha uma penetração efetiva nas atividades do curso.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
2. 04 Métodos de ensino	Suficiente	As estratégias educacionais apresentadas no Projeto Pedagógico e na Autoavaliação do Curso nos permitem afirmar que elas são coerentes com os objetivos educacionais traçados. O curso oferece muitas oportunidades de vivência em campos de prática desde o início do curso, orienta-se pelo perfil epidemiológico regional, além de estimular a tomada de decisões baseadas em evidências científicas. O Projeto Pedagógico do Curso afirma ser o ensino centrado no aluno, e a evidência apresentada foi a proporção de carga horaria teórica e prática. Reconhecemos o esforço do corpo docente em materializar o Projeto Pedagógico no contexto da sua prática docente, e é possível identificar atividades educacionais centradas no estudante e transformadoras da realidade. No entanto, não podemos afirmar que estas atividades são predominantes ao longo do curso.
2. 05 Aprendizado Interprofissional	Insuficiente	Aprendizado interprofissional consiste em práticas educativas que envolvem duas ou mais profissões que aprendem uma com a outra, e sobre a outra, nos diferentes níveis de formação voltados para a qualidade da atenção (OMS - Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa, 2010). As evidências apresentadas demonstram a existência na UNIR de suficientes oportunidades e cenários para o aprendizado interprofessional, não somente pela existência de múltiplos cursos da própria universidade, mas porque a vocação de contato com a saúde comunitária e outros cenários, da muita interface aos diferentes estudantes e preceptores. O Pet-saúde é especialmente relevante neste aspecto, mas o aprendizado interprofissional (aprender juntos sobre o que as outras profissões fazem e sabem fazer) precisa algo mais estruturado que a simples justaposição de atividades.
2. 06 Cenários de aprendizagem	Suficiente	Embora exista concorrência dos cenários de aprendizagem entre a UNIR e as faculdades particulares locais, segundo o apontado pelos discentes, existe (pelas declarações dos envolvidos na gestão) uma prioridade para UNIR. Um ponto que precisa ser reforçado é o cenário amplo dos ambulatórios clínicos e de especialidades.
2. 07 Atividades práticas de ensino clínico	Suficiente	Devido aos problemas de concorrência de cenários de prática hospitalar com outras IES e a falta de um amplo e diversificado cenário ambulatorial, o conjunto de atividades de ensino clinico parece bem desenvolvido na urgência e emergência e na medicina familiar, com menos desenvolvimento em outras áreas. Este ponto é liminarmente suficiente, mas há observações em relação às deficiências que devem ser resolvidas.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
2. 08 Avaliação do desempenho do estudante	Insuficiente	Não foram encontradas evidencias de um esforço sistematizado de formatos de avaliação que possam garantir um acompanhamento coerente da aquisição de conhecimentos e competências, sem deixar de considerar que docentes de algumas disciplinas têm ideias claras neste aspecto e poderiam estender uma prática mais aprimorada neste quesito.
2. 09 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem	Insuficiente	Não existe uma sistemática de avaliação global do processo de ensino-aprendizagem. Esta equipe de avaliação tem poucos elementos de evidencia para propor mudanças.
2. 10 Integração curricular	Insuficiente	Espera-se que a integração curricular ocorra vertical e horizontalmente, relacionando conhecimentos teórico-práticos, diferentes especialidades médicas, diferentes níveis de atenção à saúde, além dos conceitos socioeconômicos e ambientais determinantes da saúde, com atividades clínicas desde o início do curso e das ciências básicas até o final dele. Existe um esforço de integração curricular principalmente nas etapas básicas, que deve ser modelo para as outras fases onde a estrutura disciplinar e a autonomia dos professores não favorecem a integração. A integração curricular via o "portfolio" de duas famílias acompanhadas desde o começo do Curso, é uma alternativa interessante, mas que deverá ser avaliada em relação ao seu impacto.
2. 11 Internato médico	Suficiente	Este indicador define como suficiente o internato médico de acordo com o disposto nas DCN (2014), com pelo menos dois anos da graduação, com estágios nos diferentes níveis de atenção à saúde nas áreas básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia-obstetrícia, saúde coletiva e saúde mental tendo 30% de sua carga horária total na atenção básica e em serviços de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), sob supervisão. A avaliação constatou que a UNIR apresenta essas caraterísticas, e existe contato clinico desde o início com as atividades da saúde da família. Entretanto não pode ser evidenciada a evolução dos conteúdos e da integração de conhecimentos nessas etapas, reforçando a necessidade de melhores práticas de avaliação do processo e dos resultados.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
2. 12 Atividades eletivas	Suficiente	As atividades eletivas vêm sendo estimuladas por diretrizes nacionais e internacionais como forma de estimular a autonomia do aluno, que exercita escolhas baseadas nas suas necessidades e interesses. Estas atividades devem ser apoiadas pelas IES com espaço livre na grade horária e oferta de vagas garantida, ao longo do curso, não se restringindo ao estágio eletivo durante o internato médico. As evidências apresentadas indicam que as atividades eletivas tanto em forma de disciplinas como de extensão parecem ser suficientes para responder ao disposto neste indicador.
2. 13 Atividades complementares	Insuficiente	Não tivemos evidencias de atividades complementares suficientes para apoiar o perfil de integralidade do discente.
2. 14 Atividades de Pesquisa	Suficiente	As evidencias demonstram que embora a vocação do Curso esteja mais vinculada com a docência e extensão do que com a pesquisa, há um conjunto de pesquisadores de áreas prioritárias, que incorporam estudantes nas atividades tanto na Iniciação Científica como em etapas mais especificas.
2. 15 Atividades de Extensão	Insuficiente	Não foram encontradas evidencias de atividades de extensão fora das que podem ser consideradas como extracurriculares. Pode ser devido a que o conjunto de conteúdos na grade e outros como Ligas, ocupam muito do tempo disponível.
2. 16 Distribuição da carga horária semanal	Suficiente	São consideradas "áreas verdes" períodos protegidos para estudo, desenvolvimento de atividades complementares, projetos de extensão ou pesquisa. Estas áreas devem estar contempladas e assinaladas na grade horária (Marcondes, 1996). As áreas verdes são garantia de autonomia para o estudante que decide como usar o seu tempo, e além disto são um indicador de cuidado à saúde mental do estudante. Embora não haja evidencias de como a atividade programada permita o equilíbrio entre seus diferentes componentes, a presença dos alunos nos mais diversos cenários (Campus, cenários de prática, conjunto de atividades eletivas e de pesquisa), permitem qualificar esta distribuição como suficiente.
2. 17 Domínio da língua inglesa	Insuficiente	Não foi evidenciado que haja previsão de atividades instrumentais de estímulo da língua inglesa ao longo do curso.
2. 18 Educação em saúde	Suficiente	Ainda que não exista um componente per se, várias evidências mostram que o programa educacional prevê atividades que capacitam o estudante para a prática da educação de adultos, que permitem compreender melhor o seu processo de formação e desenvolver processos de educação em saúde.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
2. 19 Oferta de programas culturais	Insuficiente	Embora existam iniciativas de atividades por parte do Centro acadêmico, as mesmas não parecem ir muito além da bateria do curso.
2. 20 Acesso a informações sobre o programa de ensino	Suficiente	O acesso a informações é assegurado pela constante comunicação dos docentes mais dedicados e o contato entre os estudantes o que parece garantir bastante bem este item, mas falta institucionalização. Existe um portal básico com informações operacionais básicas dos cursos mas no mesmo não se faz a gestão acadêmica
2. 21 Portal acadêmico	Suficiente	Um conjunto de informações (ementas, documentos, chamados) é disponibilizado.
DIMENSÃO CORPO DOCENTE		
Indicador	**Conceito**	**Avaliação Qualitativa**
3. 01 Titulação do corpo docente do curso para programas estruturados por disciplinas	Suficiente	O conceito suficiente neste indicador é atribuído quando a relação docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação por disciplina é igual ou superior a 2,0 e a relação doutores por disciplina é igual ou superior a 1,0. Na análise da UNIR esta relação é: relação docente doutor/disciplina: 0,67; Relação docente com pós-graduação/disciplina: 1,30.
3. 02 Titulação do corpo docente do curso para programas estruturados por módulos	Não se Aplica	
3. 03 Formação em educação na saúde	Suficiente	A análise da formação do corpo docente demonstra que aproximadamente 30% dos docentes tem formação em educação em ciências da saúde, em diferentes modalidades.
3. 04 Regime de trabalho do corpo docente do curso	Suficiente	A planilha de regime de trabalho do corpo docente do curso demonstra que mais de 35% dos docentes tem alta dedicação e o restante tem 20 horas semanais.
3. 05 Dedicação do corpo docente à IES	Suficiente	A análise da formação do corpo docente demonstra que todos os docentes têm dedicação com no mínimo 20 horas e 26% são de dedicação exclusiva.
3. 06 Plano de carreira docente	Suficiente	Existe um plano de progressão docente institucionalizado e regulamentado, desde 2013, com caraterísticas semelhantes aquelas encontradas nas demais Universidades Federais.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
3. 07 Relação entre o número de docentes e estudantes em atividades práticas que não envolvem pacientes	Suficiente	Em geral (com duas exceções) a média de alunos em atividades práticas que não envolvem paciente é de dez a 15.
3. 08 Relação entre o número de docentes e estudantes em atividades práticas que envolvem pacientes	Suficiente	A média de estudantes por atividade prática com pacientes é de três a quatro.
3. 09 Produção científica	Suficiente	Muito embora este indicador seja considerado suficiente de acordo com os currículos dos docentes, no entanto ressalta-se que grande parte da produção esta concentrada em pequeno número de pessoas que têm atividades em centros de pesquisa.
3. 10 Atividade de preceptoria	Suficiente	O Sistema Saeme assume como preceptor o profissional com formação de especialista, vinculado à IES, cuja função se caracteriza por supervisão direta das atividades práticas realizadas por estudantes nos vários níveis do sistema local de saúde onde se desenvolve o programa do curso. O problema da preceptoria é sistêmico, já que a formação em pedagogia de ciências da saúde e a remuneração dos profissionais são os pontos mais delicados. Devido ao fechamento do Pro-Internato, o problema tende a se agravar no futuro. Na visita conversamos com alguns dos preceptores cuja percepção da sua atividade de ensino foi positiva.
DIMENSÃO CORPO DISCENTE		
Indicador	**Conceito**	**Avaliação Qualitativa**
4. 01 Processo seletivo	Suficiente	Por ser uma Universidade publica e Federal, UNIR e o curso de Medicina seguem critérios gerais, com politica de cotas e uso da nota do ENEM.
4. 02 Recepção aos ingressantes	Suficiente	Existe um processo de informação institucional aos estudantes, mas a maior parte das atividades são dependentes da iniciativa de estudantes, que de momento parecem ser de boa qualidade, mas que não podem ser a única forma num curso que tem alta percentagem de estudantes de fora da cidade. O contato e dedicação da Coordenadora e de alguns docentes, e sobre tudo dos próprios estudantes permitem soluções emergenciais a eventuais problemas.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
4. 03 Programas de apoio à permanência	Suficiente	A UNIR apresenta um conjunto de sistemas de bolsas de apoio, e um setor especializado na tramitação destas ajudas de custos, somados a um sistema relativamente funcional de apoios em atividades de pesquisa ou extensão, permitem uma boa rede de suporte aos estudantes com dificuldades econômicas.
4. 04 Distribuição de bolsas estudantis	Suficiente	O curso de Medicina da UNIR oferece aos seus estudantes conjunto variado de bolsas estudantis, que segundo os entrevistados, mostra-se suficiente.
4. 05 Transferência estudantil	Suficiente	Existe um procedimento padrão e processo seletivo que é amplamente divulgado, e existe bastante uso das transferências.
4. 06 Mobilidade estudantil	Suficiente	A UNIR tem convênios de transferências com varias outras IES publicas e privadas.
4. 07 Políticas institucionais de não discriminação	Insuficiente	Não foi possível identificar que a UNIR tenha desenvolvido um programa especifico para as questões de não descriminação, o que pode ser origem de problemas no futuro.
4. 08 Direito à sindicância	Suficiente	O direito à sindicância está contemplado nas normas vigentes e segue padrões semelhantes aos da Administração publica. Pelo fato de existir representação múltipla em vários organismos de governo, este direito tem condições de ser exercido.
4. 09 Representatividade	Suficiente	Os estudantes participam do Conselho de Departamento na proporção de 15% da composição do colegiado.
4. 10 Organização estudantil	Suficiente	Considera-se suficiente este indicador, mas sugere-se melhoria do espaço físico ofertado ao centro acadêmico.
4. 11 Participação em eventos	Suficiente	Não temos números relativos à participação, mas dos diálogos e entrevistas parece existir uma disposição aberta a apoiar a participação ativa dos estudantes em eventos.
4. 12 Prevenção à saúde	Insuficiente	Não há evidencias de políticas de promoção da saúde dos estudantes, excetuando as vacinas. Prevenção da saúde dos estudantes também é um bom argumento para promover uma atitude de segurança do paciente.
4. 13 Cuidado à saúde	Insuficiente	Não foi possível identificar a existência de políticas especificas de cuidado a saúde, que são parte das obrigações da IES, como parte da função pedagógica de ensinar a cuidar da saúde dos outros.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
4. 14 Cuidado à saúde mental	Insuficiente	Poderia ser mais aproveitado a existência de recursos na área da psicologia da UNIR, mas parece haver uma certa resistência de parte dos estudantes, que preferem resolver seus problemas em contato com os professores e com coordenadora.
4. 15 Suporte psicopedagógico	Insuficiente	A evidência apresentada neste indicador demonstra que está disponível o recurso capaz de permitir um desenvolvimento mais sofisticado da experiência pedagógica, apoiando aos docentes a transformar seu papel em educadores, mas este recurso está sub utilizado no momento.
4. 16 Programa de Tutoria / Mentoring aos ingressantes	Insuficiente	A tutoria/mentoring é uma modalidade especial de relação de ajuda individual ou em grupos, em que essencialmente uma pessoa mais experiente na mesma área de formação, acompanha de perto, orienta, e estimula a partir de sua experiência, conhecimento e comportamento um jovem iniciante em seu desenvolvimento pessoal e profissional (Bellodi e Martins, 2005). Não foi evidenciado que este programa se encontre implementado de forma institucionalizada.
4. 17 Qualidade de vida	Insuficiente	A qualidade de vida é conceituada como a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas e padrões. Compreende quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiental (OMS/WHOQOL – Group, 1995). Não foram identificadas políticas institucionais, programas ou ações de promoção da qualidade de vida dos estudantes, no que tange sua saúde física, psicológica, suas relações sociais e seu ambiente. Evidências científicas demonstram que pensar na qualidade de vida do estudante aprimora a oferta de ensino e a formação do egresso, que de forma consciente cultivará os mesmos valores na sua prática clínica futura, orientando pacientes e a comunidade.
DIMENSÃO AMBIENTE EDUCACIONAL		
Indicador	**Conceito**	**Avaliação Qualitativa**
5. 01 Espaço de trabalho para professores em regime de tempo integral	Insuficiente	A estrutura da UNIR oferece poucos espaços e poucos eventos para reunir não só os professores de tempo integral, mas também os outros docentes, para que possam gradativamente se integrar aos núcleos, possibilitando projetar e atuar em um curso de medicina mais integrado.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
5. 02 Espaço de trabalho para a coordenação do curso e serviços acadêmicos	Suficiente	A coordenação do curso tem espaço de trabalho adequado para sua função, e para reunir a sua equipe na discussão das transformações futuras. Tivemos evidencias de uma lousa cheia de sugestões sobre como seria no futuro a integração em módulos.
5. 03 Sala de professores	Insuficiente	A presença um grande número de professores com alta dedicação a IES implica na existência de espaço adequado de convivência. Entretanto, nos parece que esta estrutura está em implementação.
5. 04 Salas de aula	Suficiente	A equipe de avaliação externa observou na visita que a as salas parecem adequadas e bem aparelhadas.
5. 05 Salas para pequenos grupos	Insuficiente	Não foi possível identificar salas para pequenos grupo. Sugerimos que seja previsto na reestruturação do programa, como um facilitador de mentoring e de atividades em grupos pequenos.
5. 06 Laboratórios de ensino	Suficiente	O curso dispõe de laboratórios multidisciplinares adequados para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida (anatomia, histologia, embriologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia/biofísica, técnica operatória e patologia), considerando os aspectos: espaço físico, equipamentos, sistema de segurança e material de consumo. Entretanto, não foi possível verificar se a utilização é a correta.
5. 07 Laboratórios de habilidades	Suficiente	Sugere-se aprimoramento deste espaço no tange sua ambientação mais próxima de cenários reais, como enfermarias, pronto atendimento, centro cirúrgico, urgência e emergência, ampliando a experiência de simulação. Outra oportunidade de melhoria seria implementar "sala de espelho" com sistema de áudio para treinamento de habilidades de comunicação. O laboratório de habilidades pode servir de cenário para a avaliação de competências ainda incipientes no curso de Medicina.
5. 08 Laboratório de Informática	Insuficiente	Rondônia necessita mais que outros estados o uso de telessaúde, no entanto achamos que o uso de informática está muito limitado a aplicações convencionais, e com o agravante do fuso horário, mesmo as teleconferências básicas são pouco utilizadas. Mais que uma reestruturação ou um aprimoramento dos Laboratórios, é necessário um programa de incorporação da telessaúde ao saber e fazer da prática medica.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
5. 09 Hospital de Ensino	Suficiente	Existe polêmica sobre a conveniência de ter um hospital de ensino, que permita a independência da UNIR em relação a concorrência com as outras IES na cidade. Este debate existe em quase todos os cursos de Medicina no mundo, e foi a origem dos hospitais de ensino de propriedade das Universidades, que resolvem alguns problemas e criam outros, às vezes piores.
5. 10 Ambulatório de ensino	Insuficiente	A carga de doenças que o ambulatório permite conhecer e muito mais ampla que no hospital. No entanto a UNIR tem problemas deste tipo de cenários, tanto na infraestrutura, como na variedade de preceptores.
5. 11 Unidades básica de saúde	Suficiente	O curso de Medicina conta com um conjunto adequado de Unidades Básicas de Saúde, pertencentes à rede municipal de saúde, nas quais o processo de ensino-aprendizagem acontece sob supervisão docente em conjunto com a equipe de saúde.
5. 12 Urgência e emergência	Suficiente	Existe um espaço importante de pratica de urgência e emergência no Hospital Joao Paulo II do Estado, que tem uma ampla cobertura e variadas oportunidades de atuação dos estudantes. No entanto, durante a visita a equipe de avaliação observou evidências de um cuidado pouco humanizado dispensado aos pacientes, relativizando a suficiência neste indicador.
5. 13 Biblioteca	Insuficiente	A biblioteca tem varias carências de disponibilidade, mas conta com planta física adequada e pessoal bem motivado, poderia ser um instrumento útil com pouco recurso adicional como melhora da internet.
5. 14 Acesso a periódicos	Suficiente	O curso de Medicina conta com acesso pelo portal CAPES mas não constatamos seu uso em forma corrente.
5. 15 Tecnologias de informação e comunicação	Insuficiente	O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação foi considerado insuficiente no curso de Medicina da UNIR, o que potencialmente é prejudicial à formação de médicos para atuarem nas demandas atuais de saúde e comunicação especialmente em Rondônia. Sugere-se fortemente que o processo de ensino-aprendizado absorva novas tecnologias de comunicação e informação, aprimorando a plataforma existente, estimulando seu uso e ampliando as suas atividades para outras disciplinas, seguindo tendências internacionais de ensino mediado por tecnologias (Flipped Classroom), para aproveitamento maior do tempo destinado às atividades presenciais (Charles Prober, 2012).

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Indicador	Conceito	Avaliação Qualitativa
5. 16 Espaço de convivência dos alunos	Insuficiente	Espaços de convivência para os estudantes estão previstos. Ressalta-se a urgência destas instalações, considerando a distância entre o campus e a cidade de Porto Velho bem como o longo período que os alunos permanecem no Campus.
5. 17 Acessibilidade	Suficiente	As instalações da IES garantem acessibilidade às pessoas com deficiência física, não observamos politicas para outro tipo de deficiência.
5. 18 Sustentabilidade Ambiental	Suficiente	Existem rotinas de gestão de resíduos com potencial patogênico.

Síntese da Avaliação

O processo de acreditação Saeme no curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia da iniciou com a autoavaliação e apresentação de evidências. Estes documentos foram analisados individualmente pelos membros de equipe de avaliação externa. As avaliações individuais foram consolidadas em reunião presencial e nortearam o planejamento e foco da visita.

Um elemento central das constatações da visita é a alta coerência de ideias e objetivos entre o corpo social da instituição, com a coordenadora, com o Reitor e com o Projeto Pedagógico. Observamos uma Coordenadora com forte presença, conhecimento, respeito na universidade, na gestão municipal e estadual, amigável, mas cobrando sempre respostas em prol do curso, dos estudantes e do interesse geral da comunidade. Um ponto relevante no quesito de capital humano são os estudantes. Vindos de muitas partes do pais, compartilham uma forte intenção de dar certo, (segundo eles) num curso de Medicina que não tem ainda nome prestigioso nem tradição, mas tem o interesse quase unanime de resolver os problemas e manter o que todos percebem como uma marcha ascendente. Existe um entendimento generalizado entre os estudantes que o curso esta cada vez melhor, mais integrado entre disciplinas, com melhores professores. Projeto pedagógico é interessante, se bem que algumas das linhas são mais enunciados e aspirações que realidades propriamente ditas. No entanto, as mesmas são aspirações compartilhadas pelos docentes e estudantes. Excelente inserção no SUS, possivelmente a maior fortaleza junto com a coerência da equipe central. Os gestores estadual e municipal e os representantes do controle social identificam nitidamente a UNIR como um parceiro central, com clara prioridade para o apoio ao curso de Medicina, em vários cenários de prática. Existe inserção precoce na atenção básica, com atividades gradativamente mais complexas. Todavia na mente dos estudantes (e também dos professores) persiste a ideia que a

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

"verdadeira clínica" é a que acontece no hospital. Existem no estado pouquíssimos médicos de família e comunidade e o modelo que se propaga em cartazes publicitários das universidades privadas na região é de um médico de hospital (um jovem branco com estetoscópio, perto de algum aparelho com botões e luzes). Uma iniciativa recente que solicita aos estudantes o acompanhamento ao longo do tempo de uma família, pode servir no médio prazo para vários objetivos: integração de disciplinas horizontal e vertical, humanização, mudança do foco de ensino para o cuidado ambulatorial.

Foram compreendidas como fragilidades do curso de Medicina da UNIR: Avaliação dos estudantes em forma não homogênea nem com linhas comuns, merece uma reflexão conjunta e deve-se aproveitar a riqueza do mestrado de educação em ciências da saúde (baseado na UNIR) para ter pelo menos algum tipo de alinhamento ou pilotos que possam ser institucionalizados. Falta de qualquer tipo de atividade interprofissional, mesmo tendo boas condições no Centro de Ciências da Saúde, e uma forte inserção na atenção básica, onde a prática interprofissional acontece naturalmente. Insegurança do futuro nos campos de prática. A forte concorrência com duas universidades particulares com poder econômico e político, se expressa na concorrência por lugares para internato. No momento (e possivelmente por bastante tempo) os gestores consultados reafirmam a prioridade da UNIR, firmada em convênios e resolução do Conselho Municipal de Saúde.

Aspectos ou observações que podem apoiar processos de melhoria de qualidade:

Pesquisa - O curso oferece inserção precoce no campo da pesquisa científica, com práticas que apoiam o aprendizado, sem no entanto se materializarem como publicações. Isto parece bem adequado para a missão da Universidade. Poderia, no entanto, ser mais sistematizado e não depender tanto das inquietações dos estudantes.

Acolhimento - o Curso recebe anualmente entre 30 a 50% de estudantes de fora da cidade e do estado. No entanto o acolhimento (que hoje todos avaliam como muito caloroso e respeitoso) acontece em grande medida por solidariedade espontânea dos estudantes. A universidade cumpre com os programas de bolsa-auxilio, mas poderia tentar organizar mais ativamente (ou dar suporte) a algumas atividades de acolhimento, com a finalidade que eventos perigosos como trotes ou segregação não aconteçam no futuro.

Desenvolvimento docente - também aqui a universidade cumpre suas normas e permite e promove especializações, mestrados e doutorados, sem no entanto, existir um pensamento discutido e formalizado de para onde deve caminhar o desenvolvimento docente.

Aspectos que parecem pouco desenvolvidos mesmo tendo boas condições:

Telemedicina e telessaúde - em um curso de medicina da região norte, num município maior que a Bélgica não pode deixar de utilizar muito ferramentas. Existem equipamentos e experiência,

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

mas no entanto a telessaúde parece ser sub-uitlizada. Mesmo existindo razões de fuso horário e outras, é uma área de oportunidade, possivelmente para o município e o Estado.
Saúde Mental - É bem conhecido que os aspectos de saúde mental estão presentes com grande peso em qualquer diagnostico populacional e são um problema frequente nos estudantes de medicina e em profissionais de saúde, neste sentido se propões a Saúde Mental como complementar ao enfoque de integralidade do cuidado, além de ser uma oportunidade de se trabalhar e aprender de forma interprofissional.

Principais recomendações

Dimensão Gestão Educacional

1. Continuar os esforços para que o desenvolvimento docente alcance aos docentes de todas as etapas do curso, com especial atenção às clínicas, com um formato programático que estabeleça um prazo para que todos os docentes participem
2. Organizar e institucionalizar um sistema de avaliação do estudante e do programa, como forma de repensar a prática educacional.

Dimensão Programa Educacional

1. Estabelecer diálogo com os outros cursos da UNIR na intenção de planejar e implementar educação interprofissional;
2. Ampliar a oferta de atividades culturais;
3. Ampliar a oferta de estratégias educacionais centradas no estudante e de interação nas aulas expositivas
4. Elaborar um sistema de avaliação do desempenho do estudante que contemple conhecimentos, habilidades e atitudes e garantia de feedback constante;

Dimensão Corpo Docente

1. Manter o estimulo à especialização dos professores em Educação na Saúde;

Dimensão Corpo Discente

1. Rever e planejar as estratégias de apoio e suporte ao estudante no curso de Medicina;
2. Estabelecer um programa de qualidade de vida para os estudantes;
3. Aprimorar as ações de prevenção e cuidado à saúde do estudante.

Dimensão Ambiente Educacional

1. Melhorar o uso da Tecnologia de informação e comunicação (TIC) nas estratégias de ensino-serviço

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

2. Planejar uma ampliação e reestrutura do uso do ambulatório com cenário relevante de aprendizagem
3. Completar as instalações do campus para que possam ser utilizadas como espaço de convivência e lazer.

Melhores práticas que podem ser compartilhadas com outras IES

1. Processo de relação estreita e continua com as autoridades municipal e estadual, mas principalmente com os organismos de controle social, que podem defender o papel da universidade pública em caso de mudanças políticas.
2. Promover dentro do próprio corpo dos docentes cursos de mestrado em educação, de forma de aliar oportunidades de aperfeiçoamento especifico como professores à motivação para se manter na UNIR.

Parecer Final

O Sistema de Acreditação das Escolas Médicas confere ao Curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia o parecer:

ACREDITADO COM RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO

Milton de Arruda Martins
Coordenador
Sistema de Acreditação das Escolas Médicas - SAEME

Sigisfredo Luis Brenelli
Presidente
Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM

Carlos Vital Tavares Corrêa Lima
Presidente
Conselho Federal de Medicina - CFM

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231
http://www.saeme.org.br – saeme@portalmedico.org.br

Anexo 10 – Guia de avaliação interna de curso.

Avaliação Interna de Curso

Guia de Execução

UNIR

Julho de 2017

Avaliação Interna de Curso

Guia de Execução

Aline Andriolo
Responsável Técnica
Secretaria-Executiva CPAv

Joscelr Lopes Deltoni
Coordenação Geral CPAv

UNIR

Julho de 2017

SUMÁRIO

BASE LEGAL 3

PROCEDIMENTOS 4

Quais períodos para a avaliação de Curso em atenção ao Ciclo Avaliativo da UNIR? 4

Quais as etapas e procedimentos referentes a Avaliação? 5

Quem coordena e decide sobre a avaliação do Curso? 5

Como será feita a avaliação de Curso? 5

Quem participa da avaliação de Curso? 6

Qual o resultado da avaliação? 7

FLUXOGRAMA 9

BASE LEGAL

A Avaliação Interna de Curso é o procedimento que todos os cursos devem realizar. Está determinado como atividade na Dimensão 1: Organização didático-pedagógica, item 1.17: ações decorrentes dos processos de avaliação do curso, para os cursos presenciais e para os cursos à distância, dos instrumentos de avaliação externa determinados pelo INEP, por meio da Portaria nº 386/2016/MEC, de 10 de maio de 2016.

Com a publicação da Resolução nº 474/CONSEA de 10 de abril de 2017, ficou instituído o ciclo avaliativo e as normas gerais para Avaliação Institucional Interna na UNIR. Este guia foi produzido com base nessa resolução e nos procedimentos informados no Memorando Circular 006/CPAv/2016.

Na UNIR, após a CPAv realizar oficinas de trabalho e pré-teste de instrumentos no ano de 2015 e 2016, a partir de junho deste último já ficaram definidos os instrumentos oficiais. Portanto, tais instrumentos são **oficiais e obrigatórios**, porque necessários e estabelecidos em coerência com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), formulários oficiais INEP, Projeto de Avaliação Institucional e no âmbito da competência da CPAv, amparada a partir da Lei 10.861/2015 e orientações seguintes, Resolução CONSUN 018/2014, Resolução CONSUN 021/2014.

LEMBRETE IMPORTANTE: O formulário para as avaliações internas dos Cursos da UNIR constituem-se dos elementos comuns. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante definir e solicitar à CPAv acréscimos inerentes às peculiaridades que julgue fundamental avaliar e não estejam contempladas nas questões gerais. As questões gerais serão alteradas somente após meta-avaliação de sua utilização. Este aspecto será objeto de continua reflexão nas oficinas e encontros a serem promovidos pela CPAv.

Os instrumentos a serem utilizados, (cursos presenciais e EAD) estão disponíveis no site da CPAv (http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/pagina/exibir/1661).

PROCEDIMENTOS

É importante que os cursos de graduação realizem suas avaliações anuais observando o ciclo avaliativo da unir, que tem como ano base o período agosto (ano anterior) – julho (ano atual). Portanto, o Ciclo Avaliativo cumpre o mesmo parâmetro de coleta de dados do INEP.

O papel da CPAv será de assessoramento aos cursos, oferecendo as condições relativas aos instrumentos e coleta de dados; disponibilizando, exclusivamente, o Relatório Preliminar e a base de dados, para a realização da avaliação do Curso. Cabe ao Curso, fazer a divulgação interna da avaliação e informar os links para os respondentes do questionário.

Ao final apresentamos um fluxograma que ilustra as orientações contidas neste Guia.

Quais períodos para a avaliação de Curso em atenção ao Ciclo Avaliativo da UNIR?

As avaliações do ciclo são procedidas do seguinte modo:

1. Mobilização e planejamento: Agosto do ano vigente. Exemplo: para o primeiro Ciclo, cujo ano base de avaliação é 2016.2 (agosto) - 2017.1 (julho), a mobilização ocorrerá no segundo semestre de 2017.2, ou seja: agosto de 2017.

2. Realização da Coleta e Avaliação: Setembro a Dezembro do ano vigente. Exemplo: Ciclo – Agosto de 2017 a Julho de 2018. Avaliação entre Setembro e Dezembro de 2018.

3. Entrega da versão final dos relatórios: Dezembro e Janeiro (do ano seguinte). Exemplo: Ciclo – Agosto de 2017 a Julho de 2018, logo após o Seminário o relatório é consolidado e até dezembro de 2018, máximo janeiro de 2019 o relatório é encaminhado para postagem na plataforma e-MEC como conteúdo da avaliação institucional e divulgação do relatório de curso.

Quais as etapas e procedimentos referentes a Avaliação?

A avaliação deverá seguir três etapas:

1 – Coleta de dados. Levantamento de informações quantitativas e qualitativas que estão definidas como necessárias para análise do sucesso da UNIR, roteirizados a partir do SINAES. Ocorre no período de setembro-outubro.

2 – Relatório Preliminar. Apresentação dos dados coletados pela CPAv, para conhecimento dos resultados obtidos. Elaborado no período de novembro e entregue para a equipe do NDE encaminhar.

3 – Seminário Interno de Avaliação. Evento público, com garantia de participação de todos os segmentos, com vistas a construção da análise do Relatório Preliminar e formulação das Proposições de Melhoria frente as metas institucionais e indicadores acolhidos pela comunidade, consagrando a efetiva avaliação DO CURSO. Essas proposições influenciam o relatório geral da avaliação institucional.

Quem coordena e decide sobre a avaliação do Curso?

É importante saber que o Conselho de Departamento que decidirá o momento para realizar a avaliação, mas será o Núcleo Docente Estruturante que irá coordenar a avaliação e, portanto, deve propor o cronograma. Tendo isto, a demanda deve ser encaminhada para a CPAv disponibilizar o formulário online, tendo o Departamento e o NDE do Curso a responsabilidade de realizar a divulgação e mobilização, apoiada pela CPAv, se desejar.

Como será feita a avaliação de Curso?

O presidente do NDE ou o chefe de departamento deverá solicitar da CPAv o link com os questionário de avaliação e o período de avaliação também deve ser informado, que será quando o formulário estará disponível. Ou seja: qual o dia que começa e encerra a coleta de dados

com o público desejado para participar da avaliação. **A avaliação é online e será assegurado o anonimato**.

Também se deve enviar para a CPAv lista de docentes e técnicos que irão receber os links para participar da avaliação. No caso dos alunos, serão enviados emails de acordo com lista de matricula.

LEMBRANDO: Na solicitação, se houver algo específico a serem avaliadas pelo curso, todas as questões devem ser enviadas para serem adicionadas na PARTE ESPECÍFICA do questionário.

Quem participa da avaliação de Curso?

Quem responde a Avaliação de Curso? Todos. Porque a situação de um curso diz respeito ao contexto da instituição onde todos participam e contribuem para o desenvolvimento institucional e da formação defendida no projeto do Curso.

DOCENTES: Professores vinculados ao curso e **todos os professores que atendem o curso**.

Exemplo: Um professor do Departamento de Letras Vernáculas que atende a um Curso na disciplina de Língua Portuguesa de outro Curso (não Letras) deve ser mobilizado a participar da avaliação e receber o link da avaliação.

TÉCNICOS: No caso do Departamento que oferta o Curso NÃO contar com pessoal técnico ou contar apenas com UM técnico, a avaliação do Curso deve ser realizada por todos os técnicos da Unidade à qual o Curso é vinculado. Exemplo: Supondo que no Departamento de Ciências Econômicas que faz gestão do Curso de Ciências Econômicas não tenha pessoal técnico lotado no departamento de modo que atenda ao Curso ou tenha somente UM técnico, todos os técnicos do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas participarão da avaliação.

ALUNOS: Os alunos também participam da avaliação. Podem-se **mobilizar inclusive os estudantes que "pagam" disciplina no curso.** Cabe a equipe que coordena se interessar por este processo e verificar as condições para este processo.

COMUNIDADE EXTERNA: Os cursos que desejarem atingir segmentos da comunidade que julguem fundamental para participar na avaliação do CURSO, devem produzir seu próprio formulário ou utilizar o da CPAv, indicando claramente a organização, as formas de comunicação e contato e o prazo de resposta. A CPAv não se responsabiliza por mobilizar a comunidade externa em torno da Avaliação de Curso, nem a logística para comunicação externa. As questões para a comunidade externa não devem superar 10 questões, em razão da prática da avaliação. Com a experiência acumulada, a CPAv recomenda fortemente que a comunidade externa participe da programação do Seminário de Avaliação, quando pode contribuir com o processo, em lugar de receber questionários para serem respondidos. Mas tal procedimento caberá exclusivamente ao Departamento do Curso decidir.

LEMBRETE: À medida que a prática da avaliação for se consolidando os ajustes ocorrerão. Isto será feito a partir da meta-avaliação, que se constituirá sobre uma questão aberta no instrumento com vistas à melhoria do mesmo.

Qual o resultado da avaliação?

De início teremos o benefício da memória institucional, a construção de uma base de dados importante para subsídio à tomada de decisão dos gestores e a influência na discussão referente às melhorias pedagógicas e administrativas. Por ser ato legítimo e legal, a CPAv encaminha e da conhecimento ao órgão regulador. Esta ação também favorecerá que a UNIR avance na construção de seus indicadores de sucesso e validação dos processos internos.

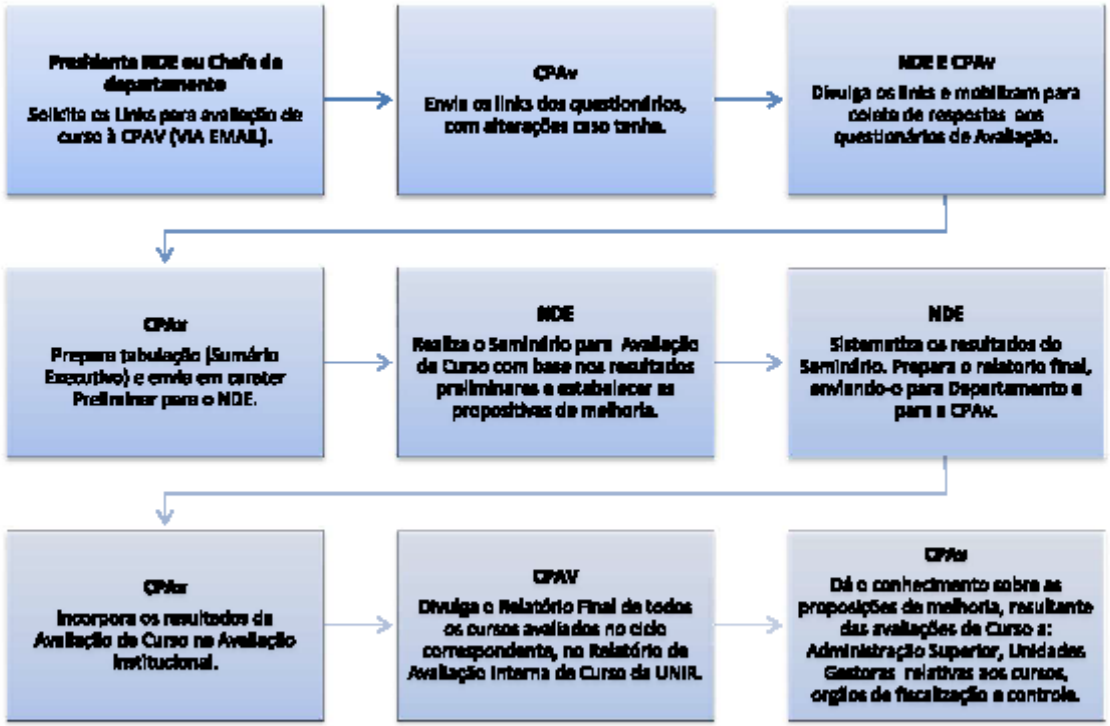
A força da avaliação está na qualidade das reflexões que possa produzir horizontes de melhorias e avanços a apontar e compromissos a obter em termos de financiamento, qualidade no estudo e no trabalho e acompanhamento dos resultados sociais sobre o que produza. Portanto, cada curso deve planejar cuidadosamente suas expectativas. A UNIR propôs no PDI em vigor, melhorar as pontuações na avaliação de seus cursos. Este também é um caminho.

LEMBRETES: O Relatório Final da Avaliação de todos os Cursos avaliados no ciclo correspondente será publicado separadamente por Campus e/ou Núcleo, em um documento a parte, no Relatório de Avaliação Interno de Curso da UNIR.

O Relatório Final de avaliação de curso entregue pelo NDE dos cursos farão parte do Relatório de Avaliação Institucional Interno da UNIR. Dessa forma, a Avaliação Institucional Interna da UNIR passa a ter um a panorama Geral da Universidade.

CPAv
Comissão Própria de Avaliação

FLUXOGRAMA



Anexo 11 – Ata de reunião do NDE

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA — NUSAU

NÚCLEO DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Depto. de Medicina UNIR Fl. 355 Ass.: DEPMED/NUSAU

ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE MEDICINA DA UNIR

Aos dez dias do mês de novembro reuniram-se, na sala de reuniões do Departamento de Medicina, os professores Ana Lúcia Escobar, Rodolfo Luis Korte, André Luís Petermann, Andresa Tumelero, Dhelio Batista Pereira, Maillene Rocrigues Lisboa, Katia Regina Pena Schesquini Roriz, membros do NDE, Janne Cavalcante Monteiro, da área de Educação e Medicina Social, e José Odair Ferrari, chefe do Departamento de Medicina, para reunião do Núcleo. Esta reunião foi conduzida pela professora Ana Lúcia Escobar. Após a abertura da reunião, foi feita a apresentação das linhas gerais do novo Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. Após as discussões e ponderações, o mesmo foi aprovado. Em seguida, foi apresentada a nova matriz curricular, que passou por diversos ajustes, tanto de alterações de disciplinas, períodos de oferta das mesmas e distribuição de carga horária. Após as discussões e ponderações, a nova matriz curricular foi aprovada, devendo ser submetida à reunião do Conselho de Departamento, para posterior tramitação conforme as normas institucionais. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada e a ata redigida por mim, que coordenei e secretariei.

Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar
Coordenadora do NDE
Portaria 059/2015/NUSAU

Anexo 12 – Ata de Reunião do DEPMED

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Reuniram-se extraordinariamente no dia vinte e três do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, no auditório do prédio da Fundação Universidade Federal de Rondônia – Centro, os membros docentes, discentes e técnicos administrativos do Conselho de Departamento de Medicina conforme lista de frequência, sob a presidência do professor Dr. José Odair Ferrari, para deliberar sobre a proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina; Apresentada pela Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE), Dr.a Ana Lúcia Escobar, após discussões e esclarecimentos sobre elementos pontuais da proposta, a mesma foi colocada em votação: Aprovada por unanimidade. Sem nada mais a ser deliberado, eu, José Odair Ferrari, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Técnico Douglas Piffer, que secretariou esta reunião do conselho de departamento.

Presidente: José Odair Ferrari _____

Secretário Condep-Medicina: Douglas Piffer _____

JOSÉ O. FERRARI
Chefe do Departamento de Medicina
Portaria 823/GR-UNIR

APÊNDICES

Apêndice 1 - Plano de Adaptação Curricular ao Novo Currículo do Curso de Graduação em Medicina da UNIR

A adaptação curricular dos discentes do curso será feita da seguinte forma:

1. Os alunos que ingressarem no curso a partir da aprovação deste PPC, cumprirão a nova matriz curricular;
2. Os alunos do 1º ao 12º período, ingressantes anteriormente à aprovação deste novo PPC, cumprem as cargas horárias e os créditos das disciplinas da estrutura curricular estabelecida pela Resolução n. 071/CONSEA, de 20 de dezembro de 2002 e as subsequentes alterações. A matriz curricular atual segue no Anexo I.
3. Os alunos que hoje estão nas turmas do 2º ao 12º períodos caso sejam reprovados, ingressarão automaticamente na turma menos adiantada, respectivamente, permanecendo na matriz curricular estabelecida pela resolução 071/CONSEA até a integralização do curso. Cumprirão as disciplinas, objeto de reprovação, quando do oferecimento destas de acordo com a matriz curricular à qual pertencem.
4. Os alunos que hoje estão na turma do primeiro período ou que ingressarem nesta, caso sejam reprovados, passarão a cumprir disciplinas da nova matriz curricular equivalentes às do currículo antigo (com as novas cargas horárias, créditos e nomenclaturas), quando do oferecimento destas na matriz curricular.
5. Alunos que forem reintegrados enquanto há turmas cursando disciplinas do currículo antigo, poderão ingressar nestas turmas, desde que não tenham pendências nos períodos anteriores aos que estiverem acontecendo em currículo antigo. Nos casos de pendências por disciplinas ou períodos, terão que ingressar no novo currículo para integralização do curso.
6. Alunos que reintegrarem após o término do oferecimento das disciplinas do currículo antigo procederão da maneira descrita no item 4.
7. Os casos omissos ou isolados de adaptação à nova Estrutura Curricular do Curso serão objeto de apreciação pelo NDE do Curso de Medicina.

Abaixo apresentamos o quadro demonstrativo de equivalência entre as disciplinas do currículo em vigor e as disciplinas do novo currículo, para fins de adaptação de alunos remanescentes do currículo antigo ao novo.

Quadro 11 Matriz de correspondência curricular

	Currículo antigo		Currículo Novo					
CÓDIGO	**Disciplina**	**CH**	**Disciplina**	**CH**	**DISCIPLINAS NOVAS OBRIGATÓRIAS**	**CH**	**DISCIPLINAS OPTATIVAS NOVAS**	
MEDANAT	ANATOMIA I	180	ANATOMIA I	160	INTRODUÇÃO AO SUPORTE BÁSICO DE VIDA	60	HOMEOSTASIA DOS FLUIDOS CORPÓREOS	40
MEDESAS	ESTATISTICA DA SAUDE	80	Bioestatística	60	EMBRIOLOGIA	40	Inglês INSTRUMENTAL	60
MEDSOCO	SOCIOLOGIA	60	Humanidades em medicina	80	MÓDULO INTEGRATIVO I	40		
MEDIAB1	INTRODUCAO A ATENCAO BASICA I	80	INTRODUÇÃO AO SUS	80	TUTORIA	5		
MEDMEC	METODOLOGIA CIENTIFICA	60	INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA	60				
MEDFILO	FILOSOFIA	60	Humanidades em medicina	80				
MEDCBMO	CITOLOGIA E BIOLOGIA MOLECULAR	100	BIOLOGIA CELULAR APLICADA A MEDICINA	80				
MEDBIQU	BIOQUIMICA	100	Bioquímica Fundamental	60				
MED31085	LIBRAS	60	OPTATIVA					
	2º Período							
MEDGENE	GENETICA E EVOLUÇÃO	80	eliminada					
MEDANA2	ANATOMIA II	160	ANATOMIA II	140	MÓDULO INTEGRATIVO II	40		
MEDHIEM	HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA	180	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA I	100	TUTORIA	5	Tópicos especiais em bioquímica.	40
MEDANM	ANTROPOLOGIA MEDICA	60	Humanidades em medicina	80			Ferramentas moleculares para diagnóstico laboratorial	40
MEDPSME	PSICOLOGIA MEDICA	40	INTRODUÇÃO A SAÚDE MENTAL	40			Tópicos especiais em genética	40
MEDIAB2	INTRODUCAO A ANTENCAO BASICA II	60	ATENÇÂO PRIMÁRIA A SAÚDE	60			Tópicos especiais em biologia celular	40
MEDLIPO	LINGUA PORTUGUESA	60	OPTATIVA					

	Currículo antigo		Currículo Novo					
CÓDIGO	**Disciplina**	**CH**	**Disciplina**	**CH**	**DISCIPLINAS NOVAS OBRIGATÓRIAS**	**CH**	**DISCIPLINAS OPTATIVAS NOVAS**	
	3º Período							
MEDIMUN	IMUNOLOGIA	60	IMUNOLOGIA MÉDICA	60	Biofísica de sistemas	40	TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOFÍSICA	40
MEDSEM1	SEMIOLOGIA I	60	SEMIOLOGIA I	120	MÓDULO INTEGRATIVO III	40	FISOLOGIA DO EXERCÍCIO	40
MEDFIB1	FISIOLOGIA E BIOFISICA I	180	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA II	100	TUTORIA	5	TÓPICOS ESPECIAIS EM IMUNOLOGIA	40
MEDSCO1	SAUDE COLETIVA I	40	ELIMINADA				Ciências humanas.	60
MEDHIME	HISTORIA DA MEDICINA	40	OPTATIVA				Ciências sociais aplicadas.	60
MEDPBE	PROCEDIMENTOS BASICO DE ENFERMAGEM	60	SEMIOTÉCNICA	60			Ciências da saúde	60
MEDPEM	PARASITOLOGIA E ENTOMOLOGIA MEDICA	100	PARASITOLOGIA MÉDICA	80			Ciências exatas e da terra	60
MEDBIOE	BIOETICA	60	Bioética	40				
	4º Período							
MEDFAR	FARMACOLOGIA	100	FARMACOLOGIA I	80	MÓDULO INTEGRATIVO IV	40		
MEDEPI1	EPIDEMIOLOGIA I	80	EPIDEMIOLOGIA	100	TUTORIA	5	DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PARASITOLOGIA	40
MEDPTG	PATOLOGIA GERAL	120	PATOLOGIA GERAL	100			IMUNOLOGIA CLINICA AVANÇADA	40
MEDSEM2	SEMIOLOGIA II	180	SEMIOLOGIA II	120				
MEDIDP	INTRODUCAO AS DOENCAS PARASITARIAS	120	INT.DOENÇAS PARASITARIAS	100				
MEDFIB2	FISIOLOGIA E BIOFISICA II	60	HISTOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS – APLICADO A MEDICINA III	60				
MEDMIC	MICROBIOLOGIA	60	MICROBIOLOGIA MÉDICA	60				

	Currículo antigo		Currículo Novo					
CÓDIGO	**Disciplina**	**CH**	**Disciplina**	**CH**	**DISCIPLINAS NOVAS OBRIGATÓRIAS**	**CH**	**DISCIPLINAS OPTATIVAS NOVAS**	
	5º Período							
MEDPASI	PATOLOGIA SISTEMICA	120	PATOLOGIA SISTEMICA	120	FARMACOLOGIA II	60		
MEDEMEP	ETICA MEDICA E EXERCICIO PROFISSIONAL	60	ETICA MED E EXERC PROFIS	60	MÓDULO INTEGRATIVO V	40		
MEDTFCV	TOPICOS EM FIS.CARDIO-VASCULAR	40	OPTATIVA		TUTORIA	5		
MEDSAM1	SAUDE DA MULHER I	60	ELIMINADA					
MEDBCM	BASES CLINICA MEDICA	100	SAÚDE DO ADULTO I	80				
MEDBCC	BASES DA CLINICA CIRURGICA	100	BASES DA CLIN CIRURGICA	100				
MEDSAC1	SAUDE DA CRIANCA I	60	SAUDE DA CRIANÇA I	60				
MEDMDIM	METODOS DE DIAG.E IMAGEONOLOGIA	100	IMAGEM	80				
MEDEPI2	EPIDEMIOLOGIA II	60	ELIMINADA					
	6º Período							
MEDSAM2	SAUDE DA MULHER II	120	SAUDE DA MULHER I	120	MÓDULO INTEGRATIVO VI	40	Farmacologia clínica	60
MEDCCI1	CLINICA CIRURGICA I	120	CLINICA CIRURGICA I	120	TUTORIA	5	Métodos diagnósticos em pneumologia e cardiologia	40
MEDGME	GENETICA MEDICA	60	GENÉTICA HUMANA	60				
MEDSAC2	SAUDE DA CRIANCA II	100	SAUDE DA CRIANÇA II	100				
MEDCME1	CLINICA MEDICA I	140	SAUDE DO ADULTO II	140				
MEDSCO2	SAUDE COLETIVA II	60	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60				
MEDMEL	MEDICINA LEGAL	80	MEDICINA LEGAL	60				

	Currículo antigo		Currículo Novo					
CÓDIGO	**Disciplina**	**CH**	**Disciplina**	**CH**	**DISCIPLINAS NOVAS OBRIGATÓRIAS**	**CH**	**DISCIPLINAS OPTATIVAS NOVAS**	
	7º Período							
MED31002	SAUDE DA MULHER III	100	SAÚDE DA MULHER II	100	MÓDULO INTEGRATIVO VII	40	Interconsulta psicológica	60
MED31004	CLINICA MEDICA II	140	SAÚDE DO ADULTO III	80	TUTORIA	5	Direitos humanos e medicina	80
MED31005	MEDICINA PREVENTIVA	80	AÇOES PROGRAMATICAS	60			Introdução à medicina genômica.	40
MED31006	ACUPUNTURA	60	OPTATIVA					
MED31000	COMUNICACAO CIENTIFICA	60	ELIMINADA					
MED31003	SAUDE DA CRIANCA III	100	SAÚDE DA CRIANÇA III	100				
MED31001	CLINICA CIRURGICA II	140	CLINICA CIRURGICA II	120				
	8º Período							
MED31008	8 PSIQUIATRIA	60	PSIQUIATRIA	60	INTRODUTÓRIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	40	Fundamentos da saúde do trabalhador	60
MED31009	9 CLINICA MEDICA III	140	SAUDE DO ADULTO IV	80	SAUDE DO ADULTO V	60	Emergências endocrinológicas.	20
MED31011	1 DIP	140	DIP	140	MÓDULO INTEGRATIVO VIII	40	Cuidados paliativos	40
MED31010	0 CLINICA CIRURGICA III	140	CLINICA CIRÚRGICA III	100	TUTORIA	5	Osteometabolismo.	20
MED31013	3 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60	GESTÃO DOS SERV DE SAUDE	80				
MED31012	2 INFORMATICA MEDICA	60	INFORMÁTICA MÉDICA	40				
MED31006	ACUPUNTURA	60	OPTATIVA					
MED31081	FUNDAMENTOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	60	OPTATIVA					
MED31013	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	60	EMERGÊNCIAS CLÍNICAS	60				
MED31082	SAÚDE DA FAMÍLIA	60						

	Currículo antigo		Currículo Novo				
CÓDIGO	**Disciplina**	**CH**	**Disciplina**	**CH**	**DISCIPLINAS NOVAS OBRIGATÓRIAS**	**CH**	**DISCIPLINAS OPTATIVAS NOVAS**
	9º e 10º períodos						
	INTERNATO I						
MED31023	INTERNATO I - PEDIATRIA	300	PEDIATRIA	300			
MED31024	INTERNATO I - SAUDE COLETIVA	300	MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	300			
MED31025	INTERNATO I - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	300	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	300			
MED31026	INTERNATO I - CLINICA MEDICA	300	CLINICA MEDICA	300			
MED31027	INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA	300	CLINICA CIRURGICA	300			
MED31028	INTERNATO I - OPCIONAL	300	ELIMINADO		MEDICINA DE EMERGÊNCIA	300	
	11º e 12º períodos						
	INTERNTATO II						
MED31035	INTERNATO II - PEDIATRIA	300	PEDIATRIA II	300			
MED31034	INTERNATO II - SAUDE COLETIVA	300	Medicina de Família e Comunidade II	300			
MED31033	INTERNATO II - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	300	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA II	300			
MED31030	INTERNATO II - CLINICA MEDICA	300	CLINICA MEDICA II	300			
MED31031	INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA	300	CLINICA CIRURGICA II	300			
MED31050	INTERNATO OCPIONAL	300	OPCIONAL	300			

Apêndice 2 – Detalhamento da Infraestrutura

Campus José Ribeiro Filho Curso: Medicina Data do Preenchimento: 16/02/2017
Sala de professores e/ou tutores (Espaço do docente/tutor)

Identificação (nome do local)	Sala Multiuso - Departamento de Medicina – BLOCO 3A – SALA 301
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	1 mesa oval com capacidade para até 14 cadeiras para reuniões, 2 armários tipo balcão, 1 refrigerador, 1 microondas, 1 cafeteira, 1 bebedouro refrigerado para garrafão de água mineral, acesso wifi para notebooks, tables e smartphones, 1 impressora multifuncional de médio porte, 1 projetor multimídia (datashow), 1 lousa branca, além de climatização compartilhada com as demais dependências do depto.
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	15 professores
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	Utilizada pelos Professores do Curso de Medicina
Cursos atendidos	Medicina
Área total em m²	32 m^2
Observação:	a referida sala também é utilizada para reuniões pedagógicas e/ou administrativas
*Se houver mais de uma sala de professores, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Sala de professores e/ou tutores (Espaço do docente/tutor)

Identificação (nome do local)	Sala dos Professores BLOCO 3A – SALA 203
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	A sala ainda não está equipada. Serão adquiridos 5 armários com 60 guarda-volumes para pertences particulares, 2 mesas circulares com 8 cadeiras para reuniões, 3 estações de trabalho com 3 computadores com acesso à internet e 1 impressora multifuncional de médio porte, 2 sofás, 1 televisor, 1 geladeira, 1 microondas, 1 cafeteira, 2 armários tipo balcão, e 2 aparelhos de ar condicionado de 18mil BTus.
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	60(20 por turno)
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	Utilizada pelos Professores do Curso de Medicina

Cursos atendidos	Medicina
Área total em m²	32 m^2
Observação:	a referida sala está temporariamente sendo utilizada para armazenamento de bens inservíveis, contudo corre junto ao NUSAU processo de aquisição de equipamentos e mobiliários para atendimento desta demanda).
*Se houver mais de uma sala de professores, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Gabinete de trabalho para professores

Identificação (nome do local)	Coordenação do LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIAE PARASITOLOGIA Sala 1
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Sala dos docentes que utilizam o laboratório. Possui**02 computadores; 1 impressora Hp laser Jet 1020 com conectividade deInternet, Armário 2 portas MDF Armário 2 portas em aço Suporte para CPU Mesa MDF (sem gavetas) Mesa MDF (com 3 gavetas e chave) Cadeira Girotec (estofado verde - fixa) Cadeira Girotec (estofado verde)- giratória Armário arquivo em aço (4 gavetas)
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**4 professores**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Utilizado pelos docentes dos cursos de graduação que desenvolvem atividades práticas no laboratório**
Cursos atendidos	**Medicina e Enfermagem**
Área total em m²	
Observação:	
*Se houver mais de um gabinete, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Gabinete de trabalho para professores

Identificação (nome do local)	Coordenação do Laboratório deFarmacologia Sala 1
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Sala dos docentes que utilizam o laboratório. Possui**02 computadores; 1 impressora Hp laser Jet 1020 com conectividade deInternet, Armário 2 portas MDF Armário 2 portas em aço

	Suporte para CPU Mesa MDF (sem gavetas) Mesa MDF (com 3 gavetas e chave) Cadeira Girotec (estofado verde - fixa) Cadeira Girotec (estofado verde)- giratória Armário arquivo em aço (4 gavetas)
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**4 professores**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Utilizado pelos docentes dos cursos de graduação que desenvolvem atividades práticas no laboratório**
Cursos atendidos	**Medicina e Enfermagem**
Área total em m²	
Observação:	
*Se houver mais de um gabinete, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Gabinete de trabalho para professores

Identificação (nome do local)	Coordenação do Laboratório de Patologia Sala 1
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Sala dos docentes que utilizam o laboratório. Possui**02 computadores; 1 impressora Hp laser Jet 1020 com conectividade deInternet, Armário 2 portas MDF Armário 2 portas em aço Suporte para CPU Mesa MDF (sem gavetas) Mesa MDF (com 3 gavetas e chave) Cadeira Girotec (estofado verde - fixa) Cadeira Girotec (estofado verde)- giratória Armário arquivo em aço (4 gavetas)
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**4 professores**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Utilizado pelos docentes dos cursos de graduação que desenvolvem atividades práticas no laboratório**
Cursos atendidos	**Medicina e Enfermagem**
Área total em m²	
Observação:	
*Se houver mais de um gabinete, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 302**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores,	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1**

equipamentos, etc)	**suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**
Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 303**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1 suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**
Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 304**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1 suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**
Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 305**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1 suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**
Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 306**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1 suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**
Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Salas de aula

Identificação (nome do local)	**Bloco 3-A Sala 307**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**40 cadeiras, 40 carteiras, 1 armários, 1 suportes para Datashow, 1 datashows, 1 aparelhos de ar**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Curso de medicina**
Área total em m²	**60 m²**

Observação:	**As salas de aula estão situadas no terceiro piso do bloco 3A, possuindo acesso a bebedouro e banheiros no mesmo piso**
*Havendo mais salas de aula, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Sala de estudos (individual ou em grupo)

Identificação (nome do local)	**Salas de Estudo da Biblioteca**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Há seis salas para grupos (com cerca de 9 m² cada uma) com uma mesa redonda e 6 cadeiras em cada uma) cabines individuais para estudo e saguão com 100 mesas e 400 cadeiras. Laboratório de informática com 10 computadores para uso dos alunos.**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**500 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Utilização para cursos presenciais. Agendamento de uso conforme ordem de chegada.**
Área total em m²	**1000 m²**
Observação:	**A Biblioteca Central possui 490 lugares, com 150 mesas, 10 computadores para usuários realizarem suas pesquisas. O Acervo está dividido em Obras Gerais (para os cursos de Porto Velho), Coleções especiais, periódicos impressos. Dispõe também de computadores para pesquisa a base SINGU-Módulo Biblioteca. Possui 6 salas de estudo em grupo. e rede wi-fi disponível a todos os usuários, facilitando o acesso aos livros digitais e Portal de Periódicos da CAPES.**
*Havendo mais salas, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Sala de coordenação do curso

Identificação (nome do local)	**Departamento de Medicina – BLOCO 3A – SALA 301**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Três salas, sendo uma da chefia, outra da coordenação do internato e da COREME e Recepção/Secretaria: 2 mesas tipo estação de trabalho em "L", 1 armário baixo tipo balcão para suprimentos, 3 cadeiras tipo secretária, 2 computadores, 1 impressora multifuncional de médio porte, 1 scanner de alta capacidade, 1 aparelho de ar condicionado 18mil BTus, e 1 quadro de avisos.** **Coordenação: 1 mesa em "L" tipo**

	presidente, 1 cadeira tipo presidente, 1 cadeira tipo secretária, 2 armário médios, 1 armário baixo tipo balcão, 1 computador, 1 impressora monocromática, além de climatização compartilhada com as demais dependências **Coordenação do internato: 1 mesa em "L" tipo presidente, 1 cadeira tipo presidente, 1 cadeira tipo secretária, 2 armário médios, 1 armário baixo tipo balcão, 1 computador, 1 impressora monocromática, além de climatização compartilhada com as demais dependências**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**60**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Exclusivamente presencial. Também é utilizado pela COREME**
Área total em m²	**30 m²**
Observação:	
*Havendo mais de uma coordenação, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Espaço do funcionário

Identificação (nome do local)	**Sala de Apoio Técnico - Sala 104 do Bloco 3B**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**1 Mesa, 2 Cadeira, 1 Armário, 1 Computador, 1 Ar Condicionado 18mil BTUs**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**4 funcionários**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Uso dos funcionários de apoio técnico**
Área total em m²	**18 m2**
Observação:	

Espaço Multimeios

Identificação (nome do local)	**Telessaúde - Sala 19 da Diretoria de Educação à Distância**	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**	
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**20 carteiras escolares com braço, 2 ar condicionados de 18 mil BTUs, 10 mesas para computadores, 10 cadeiras tipo secretária, 10 computadores, 1 lousa digital, 1 sistema completo de video-conferências, 1 datashow**	
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos**	
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Compartilhado EAD e Presencial**	
Área total em m²	**42 m2**	

Observação:	**Ambiente preparado para práticas didáticas incluindo RUTE e Telemedicina**	

Espaço para atividades administrativas

Identificação (nome do local)	**Secretaria do Depto. de Medicina Sala 301-A, 2º Andar do Bloco 3A**	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**	
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**2 computadores, 1 impressora laser, 1 escâner de alto desempenho, 1 armário baixo, 4 cadeiras giratórias tipo secretária, 1 ar condicional 18mil BTUs, 1 ramal de telefone.**	
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**2 funcionários e até 8 alunos**	
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Presencial**	
Área total em m²	**24 m2**	
Observação:	**O ambiente também funciona como recepção da Coord. doDepto. de Medicina, Coord. de Internato e Coord. de Residência Médica**	

Espaço Cultural

Identificação (nome do local)	**HALL do Bloco 3B**	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**	
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**4 lousas tipo expositor para fixação de banners**	
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50 alunos**	
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Presencial**	
Área total em m²	**80 m2**	
Observação:	**Ambiente reservado à mostras de trabalhos, exposição de banners e anexo ao anfiteatro (sala 101 do bloco 3B) também utilizado para pequenas palestras, minicursos, workshop e aulas prático-expositivas de anatomia humana.**	

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Identificação (nome do local)	**AUDITÓRIO PAULO FREIRE**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Auditório com poltronas, equipamentos áudio-visuais, mesa principal, cadeiras**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**500**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Compartilhado entre cursos presenciais e à distância**
Área total em m²	**200**
Observação:	**PRINCIPAL CENTRO DE ENCONTROS EM GERAL DO CAMPUS DA UNIR em Porto Velho**

Biblioteca

Identificação (nome do local)	Biblioteca Central Prof. Roberto Duarte Pires
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	própria
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, estantes, número do acervo, equipamentos, etc)	A Biblioteca Central possui 490 lugares, com 150 mesas, 10 computadores para usuários realizarem suas pesquisas. O Acervo está dividido em Obras Gerais (para os cursos de Porto Velho), Coleções especiais, periódicos impressos. Dispõe também de computadores para pesquisa a base SINGU-Módulo Biblioteca. Possui 6 salas de estudo em grupo. e rede wi-fi disponível a todos os usuários, facilitando o acesso aos livros digitais e Portal de Periódicos da CAPES.
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	600 alunos por turno
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	Exclusivamente presencial
Área total em m²	1000
Observação:	A Biblioteca Central possui 490 lugares, com 150 mesas, 10 computadores para usuários realizarem suas pesquisas. O Acervo está dividido em Obras Gerais (para os cursos de Porto Velho), Coleções especiais, periódicos impressos. Dispõe também de computadores para pesquisa a base SINGU-Módulo Biblioteca. Possui 6 salas de estudo em grupo. e rede wi-fi disponível a todos os usuários, facilitando o acesso aos livros digitais e Portal de Periódicos da CAPES.

Restaurante Universitário

Identificação (nome do local)	**Restaurante do campus**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Estrutura física própria, operado por empresa selecionada por licitação**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	**Restaurante com mesas, cadeiras, equipamentos de cozinha, incluindo fogão, geladeira, etc**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**300**
Cursos atendidos	**Todos**
Área total em m²	**100**
Observação:	**Novo restaurante em construção (fase final)**

Quantidade de computadores no campus/núcleo destinados ao uso dos discentes:	50

Laboratório de Informática

Identificação (nome do local)	**101-1C - Laboratório de Informática DACC2 (Informática)**
Tipo: (x) ensino ( ) pesquisa ( ) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	***Sala refrigerada, contendo 20 computadores desk top com monitor, 1 quadro branco, 21 mesas, 21 cadeiras, 1 central de ar-condicionado.**

Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**presencial**
Cursos atendidos	**Todos os cursos**
Área do conhecimento	**Todas**
Área total em m²	**42 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**20 computadores desk top com monitor, 1 quadro branco, 21 mesas, 21 cadeiras, 1 central de ar-condicionado. Manutenção feita por empresa terceirizada. Equipamentos atendem às necessidades**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Laboratório de ensino

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Anatomia Humana – BLOCO 3B – SALAS 102, 103, 105**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Próprio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**PRÉDIO TÉRREO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO (ANFITEATRO), 1 SALAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (SALA DOS BONECOS), 1 SALA DE PREPARO, DISSECAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E AULAS PRÁTICAS (SALA DOS TANQUES), 1 SALA DE ALMOXARIFADO, 1 SALA DE APOIO TÉCNICO.** **AR CONDICIONADO SPLIT 6** **Armário 2** **Banco Giratório 6** **Bebedouro 3** **Botija Gás 1** **Cadeira 17** **Cadeira Palhinha 10** **Carteira 49** **Chuveiro lava-olho 1** **Cilindro Conservação 4** **CPU 2** **Mesa 1** **Mesa Estudo Anatomia 6** **Mesa para Necropsia 1** **Mesa Redondo 4** **Modelo Anatômico Coluna 6** **Modelo Anatômico Coração 8** **Modelo Anatômico Olho 5**

	Modelo Anatômico Ouvido 4 **Modelo Anatômico Pele 8** **Modelo Articulações Braço 4** **Modelo Desenv. Fetal 7** **Modelo Musculatura Braço 8** **Modelo Musculatura Perna 8** **Modelo Pélvis Feminina 5** **Modelo Pélvis Masculina 6** **Modelo Púlmão+Coração 7** **Modelo Sistema Urinário 6** **Modelo Torso Feminino 1** **Monitor de Vídeo 2** **Projetor (Datashow) 2** **RACK 2** **Tanque conservação 2** **Televisor 1**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**ANFITEATRO – 50 ALUNOS** **SALA DOS BONECOS – 15 ALUNOS** **SALA DE PREPARO – 20 ALUNOS**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Presencial**
Cursos atendidos	**ANATOMIA I – MEDICINA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE** **ANATOMIA II – MEDICINA – 40 ALUNOS – 2º SEMESTRE** **ANATOMIA – ENFERMAGEM – 30 ALUNOS – 2º SEMESTRE** **ANATOMIA – PSICOLOGIA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE** **ANATOMIA – ED. FÍSICA – 40 ALUNOS – 1º SEMESTRE**
Área do conhecimento	**Ciências da Saúde–Morfo-funcional**
Área total em m²	**185 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos.**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Técnicas Cirúrgicas - Bloco 3A – SALA 101**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Próprio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO**

	TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. **AFASTADOR 11** **AGULHA 2** **APARELHO ANESTESIA 1** **AR CONDICIONADO 2** **ARMÁRIO 1** **ARMÁRIO VITRINE 1** **ASPIRADOR 2** **AUTOCLAVE 1** **BANCO - 30(EM LOTE) 1** **BONECO SIMULADOR 1** **CABO PARA BISTURI 2** **CABO PARA SERRA GIGLI (PAR) 1** **CADEIRA 7** **CAIXA CIRURGICA 2** **CISALHA 1** **CPU 1** **CUBA 2** **ESTUFA 1** **FOCO CLÍNICO 4** **MARTELO CIRURGICO 1** **MESA 3** **MESA AÇO INOX 4** **MESA AUXILIAR 5** **MESA DE MAYO 4** **MONITOR DE VIDEO 2** **NOBREAK 1** **PINÇA 29** **REFRIGERADOR 1** **RUGINA 1** **SERRA DE GIGLI 1** **TAMBOR ESTERILIZAÇÃO 2** **TESOURA 8** **TREPANO CIRURGICO 1** **VALVA DE DOYEN 1**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO – 30 ALUNOS** **SALA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO – 3 SERVIDORES** **SALA DE GUARDA DE MAT. E EQUIPAMENTOS – 3 SERVIDORES**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Presencial**
Cursos atendidos	**Medicina**
Área do conhecimento	**Cirurgia**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos.**

3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Anatomopatologia – BLOCO 3A – SALA 102**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Próprio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.** **APARELHO DE AR CONDICIONADO 1** **ARMARIO 1** **AUTOCLAVE 1** **BALANÇA 1** **BALANÇA ANALITICA 1** **BANCO 14** **BANHO-MARIA 1** **CADEIRA 3** **CPU 1** **DESUMIDIFICADOR 3** **DISPENSADOR 1** **ESTUFA 1** **MESA 2** **MICROSCÓPIO 2** **MICROTOMO 1** **MONITOR DE VIDEO 1** **PHMETRO MEDIDOR DE PH BANCADA 1** **PROCESSADOR AUTOMÁTICO DE TECIDOS 1** **RELÓGIO 1** **SISTEMA DE INCLUSÃO DE PARAFINA 1**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos por turno**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**Presencial**
Cursos atendidos	**Medicina e Enfermagem**
Área do conhecimento	**Ciências da Saúde - Patologia**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos e por empresa contratada para manutenção dos equipamentos**

*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia – BLOCO 3A – SALA 205**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.** **Agitador 1** **Aglutinoscópio 1** **Aglutinoscópio mod. AGDSD2 1** **Aparelho de ar condicionado 1** **Armário 6** **Armário Vitrine 1** **Arquivo 1** **Autoclave cap. 18lts 1** **Autoclave cap. 18lts RIOMAR 1** **BACTÉRIA P/MEDICINA. 2** **Banco 2** **Banco 9** **Banho Maria 1** **Cadeira 2** **Cadeira estofada verde giratória - Girotec 2** **Capela de Fluxo Laminar 1** **Carteira escolar em madeira 1** **Centrifuga clínica 2** **Contador de colônias 2** **Contador diferencial de células 2** **Contador diferencial de células Sanguineas – marca Kacil 2** **CPU MARCA DELL 1** **Cronometro digital marca Cronobio 2** **Desumidificador de Ar – Arsec 250 1** **ESTUFA 2** **Estufa Bacteriológica 1** **Estufa de secagem e Esterilização 1** **Estufa Incubadora p/ BOD 1** **Fonte de alimentação 600VA- NOBREAK 1** **Impressora Laser Jet 1020 HP 1** **Mesa 2** **Mesa p/ impressora 1** **Microcomputador Romaze c/ processador AMD 1** **Micropipeta 2** **Micropipeta Auto digi VV 0,5 A 10 UL - marca Digepet 1** **Micropipeta Auto digi VV 2 A 20 UL - marca Digepet 1**

	Micropipeta mono VA 10 A 100 MCL –marca Digepet 1 **Micropipeta mono VA 100 A 1000 UL –marca Digepet 1** **Micropipeta mono VA 1000 A 5000 UL –marca Digepet 1** **Micropipeta mono VA 20 A 200 MCL –marca Digepet 1** **Microscópio 1** **Microscópio Binocular 1** **Microscópio Trinocular – L2000 1** **Monitor de vídeo – cor preto 1** **Nobreak 1** **Pipetador (aspirador) 2** **RECIPIENTE LABORATORIAL 1** **Refratometro 2** **Refratometro Clinico mod. RPT2CACT 2** **Refrigerador FrostFree 440 LTS – Eletrolux DF45 1** **Relógio p/Laboratório – marcador de tempo – marca Kacil 1** **Termometro digital 6**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos por turno.**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**presencial**
Cursos atendidos	**Medicina e enfermagem**
Área do conhecimento	**Ciências da saúde - Morfofuncional**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos e por empresa contratada para manutenção dos equipamentos**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Fisiologia Humana – BLOCO 3A – SALA 103**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	Aparelho de ar condicionado de 18000 BTUS tipo bi-split, sendo 2 unid. Internas de 9000BTUS 1 Armário MDFD – marca Girotec mod.GM-2165 1 Audimetro portátil c/ caixa acústica e impressora HP

	Deskjet 843 C acoplada. 1 Balança Antropométrica 1 Balança Pediátrica digitalBalmax mod. MP25BB 1 Bancos em madeira e Fórmica 70x30 (tamburetes) 24 Cadeira na cor verde – marca Girotec mod. FG20ESX 2 Centrifuga de bancada SISLAB Mod. FA2104 1 CPU Processador Intel P4-30GAZ HT 2 Eletrocardiógrafo Digital Portátil 110/220 volt 1 Espirômetro Computadorizadomod.OneFlow marca Clarke 1 Estufa de Esterilização 1 Impressora Laser – marca Lexmark T430 DN 1 Kit de Sistema de Aquisição de dados Fisiológicos PTB401- Powerlab 2 Mesa MDF marca Girotec mod.GM-2150 1 Monitor Cardiaco 3 deriv. (sinais vitais) 1 Monitor de vídeo 17' – marca LG 2 Nobreak MARCA SMS 1,4 KVA 2 Oxímetro de pulso – marca Dixtalmod.DX 2405 1
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos por turno.**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**presencial**
Cursos atendidos	**Medicina e enfermagem**
Área do conhecimento	**Ciências da saúde - Morfofuncional**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos e por empresa contratada para manutenção dos equipamentos**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Farmacologia – BLOCO 3A – SALA 104**

Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**LOCALIZADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.** **Equipamentos em aquisição**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos por turno.**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**presencial**
Cursos atendidos	**Medicina e enfermagem**
Área do conhecimento	**Ciências da saúde - Morfofuncional**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Laboratório em implantação. Não há equipamentos ainda disponíveis. Apenas o espaço físico.**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia**
Tipo: (x) ensino (x) pesquisa (x) extensão	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA DE ESTUDO TEÓRICO/PRÁTICO, 1 SALAS DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, E 1 SALA PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS** APARELHO DE AR CONDICIONADO 1 BANCO GIRATÓRIO 40 CADEIRA 1 CPU 1 DESUMIDIFICADOR 1

	MICROSCOPIO 30 MICROSCÓPIO 21 MONITOR DE VIDEO 1 NOBREAK 1 RETROPROJETOR 1
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20 alunos por turno.**
Utilização (somente para curso à distância, ou só para curso presencial, ou compartilhado entre os dois)	**presencial**
Cursos atendidos	**Medicina e enfermagem**
Área do conhecimento	**Ciências da saúde - Morfofuncional**
Área total em m²	**90 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório) Descrever: 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Quantidade adequada. Todos atualizados e em boas condições. Empresas de limpeza e vigilância terceirizadas. Manutenção dada pelos próprios técnicos e por empresa contratada para manutenção dos equipamentos**
*Havendo mais de um laboratório, copiar e colar e acrescentar logo abaixo.	

Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial

Identificação (nome do local)	**Hospital de Base DrAry Pinheiro**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Hospital geral público de referência terciária estadual, com 570 leitos, nas clínicas básicas e várias especialidades. Detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**200**
Área total em m²	**9500**
Observação:	Oferece residência em Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Urologia, UTI, Infectologia, UTI Neo-Natal. **Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino do hospital, atendendo às necessidades da UNIR (no mínimo 5 leitos para cada aluno do internato) e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	**Hospital Infantil Cosme e Damião**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**

Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Hospital e Pronto Socorro Infantil, estadual, com 136 leitos. Detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20**
Área total em m²	**4200**
Observação:	**Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino do hospital, atendendo às necessidades da UNIR (no mínimo 5 leitos para cada aluno do internato) e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Hospital de urgência e emergência, referência estadual, porta de entrada das unidades estaduais. Possui 187 leitos. Detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20**
Área total em m²	**2200**
Observação:	**Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino do hospital, atendendo às necessidades da UNIR (no mínimo 5 leitos para cada aluno do internato) e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDONIA
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Hospital de referência estadual para doenças tropicais e demais infecciosas. Possui 99 leitos. Detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**10**
Área total em m²	**2300**
Observação:	
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	**Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino do**

	hospital, atendendo às necessidades da UNIR (no mínimo 5 leitos para cada aluno do internato) e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.

Identificação (nome do local)	POLICLINICA OSWALDO CRUZ
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Policlínica especializada, com ambulatórios das diversas especialidades médicas, acessada pelo sistema de regulação estadual, de referência, com 45 clínicas especializadas, além de sala para pequenas cirurgias. Mais detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 20 alunos por turno**
Área total em m²	**5600**
Observação:	**Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino da unidade, atendendo às necessidades da UNIR e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	CAPS II ESTADUAL MADEIRA MAMORE
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Centro de |Apoio Psico-Social. Detalhes no link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxkZXBtZWR8Z3g6MWM0YTMwZDg2NjZmNWVhYg**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade compartilhada por todos os estudantes dos cursos de saúde de Porto Velho. A distribuição das vagas por instituição e por curso é feita por comissão de ensino da unidade, atendendo às necessidades da UNIR e, em havendo vagas, as mesmas são disponibilizadas para as demais instituições.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade Básica Pedacinho de Chão
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio com a SEMUSA de Porto Velho**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade Básica de Saúde, com ESF. Oferece espaço para a Residência em Medicina de Família e Comunidade, para as práticas das diversas disciplinas do curso e para o internato em SF. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020&VSubUni=&VComp=00**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade Básica Ernandes C Coutinho
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio com a SEMUSA de Porto Velho**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade Básica de Saúde, com ESF. Oferece espaço ara as práticas das diversas disciplinas do curso e para o internato em SF. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020&VSubUni=&VComp=00**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade Básica Aponiã
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio com a SEMUSA de Porto Velho**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade Básica de Saúde, com ESF. Oferece espaço ara as práticas das diversas disciplinas do curso e para o internato em SF. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020&VSubUni=&VComp=00**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade Básica Agenor de Carvalho
Disponibilidade (própria, alugada,	**Disponível através de convênio com a SEMUSA de Porto**

cedida, etc.)	**Velho**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade Básica de Saúde, com ESF. Oferece espaço ara as práticas das diversas disciplinas do curso e para o internato em SF. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020&VSubUni=&VComp=00**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade Básica Socialista
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio com a SEMUSA de Porto Velho**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade Básica de Saúde, com ESF. Oferece espaço ara as práticas das diversas disciplinas do curso e para o internato em SF. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020&VSubUni=&VComp=00**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR.**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Identificação (nome do local)	Unidade de Pronto Atendimento (UPA Zona Sul)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Disponível através de convênio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Unidade de Pronto Atendimento. Características e infraestrutura disponível em http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1100202680017&VListar=1&VEstado=11&VMun=110020**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**Recebe 8 alunos por turno**
Área total em m²	**600**
Observação:	**Unidade de uso exclusivo da UNIR**
*Havendo mais de uma unidade hospitalar, acrescentar logo abaixo.	

Biotério

Identificação (nome do local)	**Biotério**
Disponibilidade (própria, alugada,	**Próprio**

cedida, etc.)	
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	**Localizado Atrás do Laboratório de Anatomia Humana, contendo 3 salas de Experimentação Animal, 1 ambulatório, 3 salas para colônia, 1 quarentena, uma sala de limpeza suja, 1 sala de limpeza limpa, almoxarifado, estoque, sala de apoio técnico, sala de administração, 2 banheiros**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**2 técnicos, 4 estagiários, 20 alunos**
Área total em m²	**200 m2**
Observação:	**Prédio construído. Equipamentos a serem adquiridos**

Laboratório de habilidades

Identificação (nome do local)	Laboratório de Habilidades Clínicas – Bloco 3B Sala 101
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Próprio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, computadores, equipamentos, etc)	Localizado no primeiro pavimento, contendo 1 recepção, 5 salas para aulas práticas, 1 área comum com pias e 1 sala para guarda de materiais e equipamentos. Aparelho de AR Condicionado Tipo Split 3 CAMA RECUPERACAO 2 FORNO MUFLA 6 MESA AUXILIAR 4 MODELOS 2 Módelos 1 SIMULADOR 51
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	50 alunos por turno; 5 docentes; 03 técnico administrativo
Área total em m²	**210 m²**
Observação:	**O laboratório dispõe de 50 simuladores e acesso à internet.** O Laboratório de Habilidades foi inaugurado no início de 2015 e se constitui no cenário das práticas do cuidar em medicina tendo em vista o desenvolvimento de competências. É um espaço de apoio pedagógico para atividades práticas de treinamento em ambiente simulado. As competências se dão a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes próprias para o

	exercício da profissão. O Laboratório de Habilidades atende as aulas práticas de diversas disciplinas e conta com professores e técnicos especializados para acompanhamento dos trabalhos, possui 06 salas de excelente qualidade, sendo quatro salas para realização de treinamento de habilidades com simuladores de menor fidelidade e duas salas para treinamento com simuladores de alta fidelidade. Os simuladores são montados em salas que oferecem o ambiente ideal para o treinamento do aluno. O laboratório está aprovisionado com equipamentos e instrumentos em quantidade e qualidade suficiente para a execução das atividades, de forma a garantir a formação prevista pelo programa das disciplinas que utilizam esse espaço. O laboratório possui iluminação e climatização planejada para proporcionar conforto aos docentes, técnicos e discentes de forma a garantir a climatização compatível com o clima da região por meio de 3 centrais de ar condicionado. Todos que utilizam o laboratório seguem as normas de biossegurança estabelecidas pelo Manual de Normas e rotinas do laboratório. Os alunos são divididos em grupos para a realização das aulas práticas, onde são propostas atividades relacionadas ao conteúdo teórico, previamente discutido em sala de aula. O professor realiza demonstrações e os alunos ficam livres para reproduzir a atividade prática e esclarecer dúvidas.

Área de lazer/Espaço livre

Identificação (nome do local)	**Tatuzão – área da Educação Física**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	Ginásio poliesportivo, com quadra de esportes, piscina, e outros equipamentos de uso do curso de Educação Física e compartilhado por agendamento com os demais cursos
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50**
Área total em m²	**1000**
Observação:	

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Identificação (nome do local)	**Cantina – Próximo ao Bloco I**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria, operada por empresa selecionada por licitação**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	**Cantina com cozinha, mesas e cadeiras**
Capacidade (quantidade de alunos	**50**

por turno)	
Área total em m²	**150**
Observação:	

Espaço de Convivência

Identificação (nome do local)	**Centros de Convivência**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	**Prédio construído, sem equipamentos**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	
Área total em m²	
Observação:	

Espaço de educação esportiva (quadra, ginásio, campos, vestiário, piscina, etc)

Identificação (nome do local)	**Tatuzão – área da Educação Física**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	Ginásio poliesportivo, com quadra de esportes, piscina, e outros equipamentos de uso do curso de Educação Física e compartilhado por agendamento com os demais cursos
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**50**
Área total em m²	**500**
Observação:	
Se houver mais de um espaço, copiar e colar e acrescentar logo abaixo	

Outros espaços

Identificação (nome do local)	**Centro Acadêmico da Medicina (CAMUFRO)**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Próprio**
Instalação (descrever tipo e quantidade de todos os móveis, aparelhos, equipamentos, etc)	**Localizado no Bloco 3ª – Terceiro andar, com sofás, mesas, cadeiras, som, jogos Jogos variados, 1 Mesa de bilhar, 1 mesa de pingo pong, 2 Televisor, 1 Geladeira, 1 Microondas, 1 Cafeteira, 1 Jogo de sofá 2 e 3 lugares, 2 poltronas tipo saco de feijão, prateleiras contendo literatura variada, 1 armário.**
Capacidade (quantidade de alunos por turno)	**20**
Área total em m²	**36**

Quanto à acessibilidade, marcar se possui ou não as seguintes estruturas:	SIM	NÃO
Banheiros adaptados	x	
Bebedouros e lavabos adaptados	x	
Entrada/Saída com dimensionamento	x	

Equipamento eletromecânico (elevadores, esteiras rolantes, etc)		x
Espaço para atendimento adaptado	x	
Mobiliário adaptado	x	
Rampa de acesso com corrimão	x	
Sinalização tátil		x
Sinalização visual	x	
Sinalização sonora		x
Ambientes desobstruídos que facilitem a movimentação de cadeirantes e pessoas com deficiência visual	x	
Observações		

Quanto a outras instalações, marcar se possui:	SIM	NÃO
Auditório/Teatro	x	
Bicicletário		x
Cantina/Lanchonete	x	
Campo para práticas esportivas	x	
Cinema		x
Estacionamento para aluno	x	
Estacionamento para docente/técnico administrativo	x	
Moradia estudantil		x
Piscina olímpica/semi-olímpica		x
Pista de atletismo		x
Posto de atendimento para primeiros socorros		x
Quadra poliesportiva	x	
Quadra coberta/Ginásio	x	
Rede sem fio para comunidade acadêmica	x	
Restaurante Universitário	x	
Serviços		
Vestiário		

Apêndice 3 - Listagem dos equipamentos dos Laboratórios

Equipamentos

Laboratório de Anatomia:

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO
27666	BOM	RACK	METALICO EM CHAPA DE AÇO PARA ACOMDAR COMPUTADOR E DATA- SHOW COM GAVETA PARA TECLADO, PORTAS NA PARTE INFERIOR COM PRATELEIRA REG.C/4 RODAS SENDO 2 FIXA E 2 GIRATORIA	Sala de Dissecação
64043	BOM	Chuveiro lava-olho	MATERIAL METAL E PVC, ACABAMENTO PINTADO, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO FIXAÇAO DIRETAMENTE NO CHAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLUNA SAIDA EM TUBO 1, CUBA CROMADA	Sala de Dissecação
65191	BOM	AR CONDICIONADO SPLIT	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSAO 220 V FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	Sala de Dissecação
22437	BOM	Mesa para Necropsia	Mesa para Necropsia em aço inox, com rodízios e torneira imbutida	Sala de Dissecação
3201	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
3340	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
3345	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
3560	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
3562	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
4001	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
4002	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia

13511	BOM	Cadeira Palhinha	FIXA C/ ASSENTO ENCOSTO EM PALHINHA ACO CROMADO	Sala de Estudos Anatomia
29238	BOM	Mesa Redondo	DE REUNIÃO REDONDA-TAMPO EM MDF NA COR ARGILA C/25MM. ESP.C/ BORDA ESTRUT.ATRAVES DE COLUNA ESTRUTURAL DIMENSÕES 1200 DIA METRO X 740MM. DE ALTURA	Sala de Estudos Anatomia
29239	BOM	Mesa Redondo	DE REUNIÃO REDONDA-TAMPO EM MDF NA COR ARGILA C/25MM. ESP.C/ BORDA ESTRUT.ATRAVES DE COLUNA ESTRUTURAL DIMENSÕES 1200 DIA METRO X 740MM. DE ALTURA	Sala de Estudos Anatomia
29242	BOM	Mesa Redondo	DE REUNIÃO REDONDA-TAMPO EM MDF NA COR ARGILA C/25MM. ESP.C/ BORDA ESTRUT.ATRAVES DE COLUNA ESTRUTURAL DIMENSÕES 1200 DIA METRO X 740MM. DE ALTURA	Sala de Estudos Anatomia
29243	BOM	Mesa Redondo	DE REUNIÃO REDONDA-TAMPO EM MDF NA COR ARGILA C/25MM. ESP.C/ BORDA ESTRUT.ATRAVES DE COLUNA ESTRUTURAL DIMENSÕES 1200 DIA METRO X 740MM. DE ALTURA	Sala de Estudos Anatomia
65180	BOM	AR CONDICIONADO SPLIT	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSAO 220 V FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	Sala de Estudos Anatomia
13095	BOM	Modelo Anatômico Coração	EM 02 PARTES, M/3B.	Sala de Estudos Anatomia
13822	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL COM BACIA E NERVO	Sala de Estudos Anatomia
13823	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL COM BACIA E NERVO	Sala de Estudos Anatomia
13824	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL COM BACIA E NERVO	Sala de Estudos Anatomia
15292	BOM	Modelo Torso Feminino	FEMININO C/GENITALIA REMOVIVEL MOD.B-6	Sala de Estudos Anatomia
64791	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64792	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10	Sala de Estudos

			PARTES	Anatomia
64793	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64794	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64795	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64796	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64797	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64798	BOM	Modelo Musculatura Perna	MUSCULATURA DA PERNA CONFECCIONADA EM PVC, COM 10 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64799	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64800	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64801	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64802	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64803	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64804	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64805	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64806	BOM	Modelo Musculatura Braço	MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM PVC COM 06 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64807	BOM	Modelo Articulações Braço	OSSOS, ARTICULAÇOES E LIGAMENTOS,CONFECCIONADOS EM RESINA PLASTICA RIGIGA	Sala de Estudos Anatomia
64808	BOM	Modelo Articulações Braço	OSSOS, ARTICULAÇOES E LIGAMENTOS,CONFECCIONADOS EM RESINA PLASTICA RIGIGA	Sala de Estudos Anatomia
64809	BOM	Modelo Articulações Braço	OSSOS, ARTICULAÇOES E LIGAMENTOS,CONFECCIONADOS EM RESINA PLASTICA RIGIGA	Sala de Estudos Anatomia

64810	BOM	Modelo Articulações Braço	OSSOS, ARTICULAÇOES E LIGAMENTOS,CONFECCIONADOS EM RESINA PLASTICA RIGIGA	Sala de Estudos Anatomia
64811	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL + PELVE + FEMUR	Sala de Estudos Anatomia
64812	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL + PELVE + FEMUR	Sala de Estudos Anatomia
64813	BOM	Modelo Anatômico Coluna	COLUNA VERTEBRAL + PELVE + FEMUR	Sala de Estudos Anatomia
64814	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64815	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64816	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64817	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64818	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64819	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64820	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64821	BOM	Modelo Anatômico Pele	CORTE DA PELE EM BLOCO 3D	Sala de Estudos Anatomia
64822	BOM	Modelo Anatômico Ouvido	ORELHA E OUVIDO HUMANO GIGANTE	Sala de Estudos Anatomia
64823	BOM	Modelo Anatômico Ouvido	ORELHA E OUVIDO HUMANO GIGANTE	Sala de Estudos Anatomia
64824	BOM	Modelo Anatômico Ouvido	ORELHA E OUVIDO HUMANO GIGANTE	Sala de Estudos Anatomia
64825	BOM	Modelo Anatômico Ouvido	ORELHA E OUVIDO HUMANO GIGANTE	Sala de Estudos Anatomia
64826	BOM	Modelo Anatômico Olho	OLHO GIGANTE EM 7 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64827	BOM	Modelo Anatômico Olho	OLHO GIGANTE EM 7 PARTES	Sala de Estudos

				Anatomia
64828	BOM	Modelo Anatômico Olho	OLHO GIGANTE EM 7 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64829	BOM	Modelo Anatômico Olho	OLHO GIGANTE EM 7 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
64830	BOM	Modelo Anatômico Olho	OLHO GIGANTE EM 7 PARTES	Sala de Estudos Anatomia
65202	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65203	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65204	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65205	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65206	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65207	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65208	BOM	Modelo Anatômico Coração	CORAÇAO HUMANO TAMANHO NATURAL, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65209	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65210	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65211	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65212	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65213	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA	Sala de Estudos Anatomia

			EMBORRACHADA	
65214	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65215	BOM	Modelo Desenv. Fetal	ANATOMICO : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO FETO EM 8 PARTES,MODELO,CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65216	BOM	Modelo Pélvis Feminina	ANATOMICO PELVIS FEMININA,CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	Sala de Estudos Anatomia
65217	BOM	Modelo Pélvis Feminina	ANATOMICO PELVIS FEMININA,CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	Sala de Estudos Anatomia
65218	BOM	Modelo Pélvis Feminina	ANATOMICO PELVIS FEMININA,CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	Sala de Estudos Anatomia
65219	BOM	Modelo Pélvis Feminina	ANATOMICO PELVIS FEMININA,CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	Sala de Estudos Anatomia
65220	BOM	Modelo Pélvis Feminina	ANATOMICO PELVIS FEMININA,CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	Sala de Estudos Anatomia
65221	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65222	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65223	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65224	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65225	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65226	BOM	Modelo Pélvis Masculina	ANATOMICO PELVIS MASCULINA,CONFECCIONADO EM PVC LAVAVEL E INQUEBRAVEL	Sala de Estudos Anatomia
65227	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65228	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65229	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia

65230	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65231	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65232	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65233	BOM	Modelo Pulmão+Coração	ANATOMICO PULMAO+CORAÇAO 7 PARTES MOVEIS. MODELO, CONFECCIONADO EM RESINA PLATICA EMBORRACHADA	Sala de Estudos Anatomia
65234	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
65235	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
65236	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
65237	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
65238	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
65239	BOM	Modelo Sistema Urinário	ANATOMICO SISTEMA URINARIO CLASSICO. PRODUZIDO EM MATERIAL DO TIPO PVC OU EMBORRACHADO, LAVAVEL E INQUEBRAVEL, MONTADO EM BASE DE PLASTICO.	Sala de Estudos Anatomia
22376	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22377	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22378	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22379	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22380	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA	Anfiteatro

			COMPENSADA	
22381	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22382	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22383	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22384	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22385	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22386	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22387	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22388	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22389	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22390	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22391	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22392	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22393	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22394	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22395	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22396	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22397	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro

22398	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22399	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22400	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22401	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22402	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22403	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22404	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22405	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22406	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22407	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22408	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22409	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22410	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22411	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22412	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22413	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22414	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22415	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA	Anfiteatro

			COMPENSADA	
22416	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22417	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22418	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22419	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22420	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22422	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22423	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22424	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22425	BOM	Carteira	ESCOLAR ESTRUTURA EM AÇO TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA	Anfiteatro
22592	BOM	Televisor	TELA 33" SELETOR 2 VOLT 110/220V	Anfiteatro
65117	BOM	AR CONDICIONADO SPLIT	18.000 BTU, TENSAO 220V	Coordenação
65116	BOM	AR CONDICIONADO SPLIT	18.000 BTU, TENSAO 220V	Coordenação
65082	BOM	AR CONDICIONADO SPLIT	18.000 BTU, TENSAO 220V	Apoio Técnico
14770	BOM	Armário	EM ACO COM 02 PORTAS COM 4 PART	Apoio Técnico
18610	BOM	Botija Gás	DE GÁS 13 KILOS	Apoio Técnico
20695	BOM	Armário	DE MADEIRA C2 PORTAS C/PUXADOR E CHAVES	Apoio Técnico
21631	BOM	Mesa	lisa em melaminico med 110cm x 80cm cor cinza, perfil em pvc	Apoio Técnico
28389	BOM	Projetor (Datashow)	1800 lumens	Apoio Técnico
28390	BOM	Projetor (Datashow)	1800 lumens	Apoio Técnico
43650	BOM	CPU	PROC.INTEL CORE 2DUO CLOCK MÍN.2,93GHz,CACH.L2 MÍN.3MB E FSB MÍN.1066MHz,OU AMD C/DESEMP.=OU SUPERIOR,MEM.2GB,HD250 GB, POSSUIR 02 SLOTS LIVR.PCI	Apoio Técnico

			VERS.2.3,PORT.USB V.2.0, 271-6070.	
43651	BOM	CPU	PROC.INTEL CORE 2DUO CLOCK MÍN.2,93GHz,CACH.L2 MÍN.3MB E FSB MÍN.1066MHz,OU AMD C/DESEMP.=OU SUPERIOR,MEM.2GB,HD250 GB, POSSUIR 02 SLOTS LIVR.PCI VERS.2.3,PORT.USB V.2.0, 271-6070.	Apoio Técnico
43653	BOM	Monitor de Vídeo	LCD "22 POLEGADAS WIDESCREEN, C/MOUSE.TECLADO WIND	Apoio Técnico
25477	BOM	Bebedouro	ELETRICO TIPO PRESSÃO GAB. EM AÇO INOX 2 TORN	Hall
25479	BOM	Bebedouro	ELETRICO TIPO PRESSÃO GAB. EM AÇO INOX 2 TORN	Hall
25480	BOM	Bebedouro	ELETRICO TIPO PRESSÃO GAB. EM AÇO INOX 2 TORN	Hall
27751	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27758	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27764	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27765	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27776	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27777	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27785	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27786	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27800	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27803	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27806	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27811	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27816	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27818	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall

27819	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27827	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall
27830	BOM	Cadeira	GIRATÓRIA COM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATOMICO	Hall

Laboratório de Técnicas Cirúrgicas

Equipamentos:

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO
24987	BOM	AFASTADOR	SENN MULLER	Laboratório
24988	BOM	AFASTADOR	BALFOUR	Laboratório
24989	BOM	AFASTADOR	WEITLANER agudo 14 cm	Laboratório
24990	BOM	AFASTADOR	LANGENBECK nº 1	Laboratório
24991	BOM	AFASTADOR	FAREBEUF 13 cm	Laboratório
24992	BOM	AFASTADOR	FARABEUF 15 cm	Laboratório
24993	BOM	VALVA DE DOYEN	45 X 90 mm	Laboratório
24994	BOM	AFASTADOR	TUFFIER	Laboratório
24995	BOM	AFASTADOR	Deaver NR.525mmx23cm	Laboratório
24996	BOM	AFASTADOR	JANSEN	Laboratório
24997	BOM	AFASTADOR	Descolador de FREER	Laboratório
24998	BOM	CABO PARA BISTURI	NR.3	Laboratório
24999	BOM	CABO PARA BISTURI	NR.4	Laboratório
25000	BOM	AFASTADOR	FINOCHIETTO 30x45x130x190	Laboratório
25001	BOM	PINÇA	Vascular de Baker anatômica 20cm	Laboratório
25002	BOM	PINÇA	Vascular de Baker atraumatica 15cm	Laboratório
25003	BOM	PINÇA	ALLIS 15CM	Laboratório
25004	BOM	PINÇA	ADSON c/dente 12cm	Laboratório
25005	BOM	PINÇA	ADSON c/serra 12cm	Laboratório

25006	BOM	PINÇA	BABCOCK 16cm	Laboratório
25007	BOM	PINÇA	BACKHUAS 10cm	Laboratório
25008	BOM	PINÇA	DISSECÇÃO c/ser 14cm	Laboratório
25009	BOM	PINÇA	DISSECÇÃO c/dente 14cm	Laboratório
25010	BOM	PINÇA	KELLY delic. Cv 14cm	Laboratório
25011	BOM	PINÇA	KELLY delic. Rt 14cm	Laboratório
25012	BOM	PINÇA	KELLY curva 16cm	Laboratório
25013	BOM	PINÇA	KELLY reta 16cm.	Laboratório
25014	BOM	PINÇA	KOCHER reta 16cm	Laboratório
25015	BOM	PINÇA	KOCHER curva 16cm	Laboratório
25016	BOM	PINÇA	MIXTER 17cm	Laboratório
25017	BOM	PINÇA	MIXTER-BABY 14cm	Laboratório
25018	BOM	PINÇA	H.MOSQUITO curva 12cm.	Laboratório
25019	BOM	PINÇA	H.MOSQUITO reta 12cm.	Laboratório
25020	BOM	PINÇA	CRILE curva 16cm	Laboratório
25021	BOM	PINÇA	CRILE reta 14cm	Laboratório
25022	BOM	PINÇA	DURVAL-COLLIN 20cm	Laboratório
25023	BOM	PINÇA	R. PEAN reta 18cm	Laboratório
25024	BOM	PINÇA	COPROSTÁTICA 2-RT e 2-CV 25cm	Laboratório
25025	BOM	PINÇA	BULLDOG 6cm reta	Laboratório
25026	BOM	PINÇA	de SATINSKI peq.16cm	Laboratório
25027	BOM	PINÇA	agulhas MAIO-HEGAR vid. 14cm	Laboratório
25028	BOM	PINÇA	agulhas MAIO-HEGAR vid. 18cm	Laboratório
25029	BOM	PINÇA	agulhas MAIO-HEGAR vid. 16cm	Laboratório
25030	BOM	TESOURA	IRIS FF cv 11cm. dur.	Laboratório
25031	BOM	TESOURA	MAYO (STILLE) reta 14cm.	Laboratório
25032	BOM	TESOURA	METZENABAUM curva 14cm	Laboratório
25033	BOM	TESOURA	METZENABAUM curva 20cm	Laboratório
25034	BOM	TESOURA	MAYO (STILLE) curva 16cm.	Laboratório

25035	BOM	TESOURA	para fios de aço 12cm	Laboratório
25036	BOM	TESOURA	MAYO (STILLE) reta 16cm	Laboratório
25037	BOM	TESOURA	POTTS-SMITH 20cm	Laboratório
25038	BOM	CISALHA	tipo LISTON	Laboratório
25039	BOM	ASPIRADOR	de YANKAUER	Laboratório
25040	BOM	TREPANO CIRURGICO	TREPANO CIRURGICO	Laboratório
25041	BOM	CABO PARA SERRA GIGLI (PAR)	CABO PARA SERRA GIGLI (PAR)	Laboratório
25042	BOM	SERRA DE GIGLI	SERRA DE GIGLI	Laboratório
25043	BOM	RUGINA	DOYEN Direta 18cm	Laboratório
25044	BOM	MARTELO CIRURGICO	de aço 200g.	Laboratório
25045	BOM	CAIXA CIRURGICA	18x08x05cm	Laboratório
25046	BOM	CAIXA CIRURGICA	28x14x06cm.	Laboratório
25047	BOM	TAMBOR ESTERILIZAÇÃO	7X1,5cm	Laboratório
25048	BOM	CUBA	Rim 26cm.	Laboratório
25049	BOM	CUBA	5cmx9cm.	Laboratório
25050	BOM	TAMBOR ESTERILIZAÇÃO	18cm por 14cm	Laboratório
25051	BOM	AGULHA	SATURA GR 11 (10-unid) GR 16 (10-unid) GR 05 (10-unid) GR 07 (20-unid) GR 09 (10-unid) GR 10 (unid) GR 12 (10-unid).	Laboratório
25052	BOM	AGULHA	Retangualar.	Laboratório
25311	BOM	BONECO SIMULADOR	medidas 110X56X36 cm. 25,0 kg.	Laboratório
25336	BOM	AUTOCLAVE	HORIZONTAL 39209/104 40X40X65CM.220X380V - 900 Nº.SÉRIE 5196	Laboratório
25337	BOM	BANCO - 30(EM LOTE)	GIRATÓRIO INOX COM ALTURA REGULÁVEL	Laboratório
25342	BOM	FOCO CLÍNICO	MARCA MEDICATE MOD. 500 SÉRIE Nº. 000500377M0001	Laboratório
25343	BOM	FOCO CLÍNICO	MARCA MEDICATE MOD. 500 SÉRIE Nº. 000500377M0001	Laboratório
25344	BOM	FOCO CLÍNICO	MARCA MEDICATE MOD. 500 SÉRIE Nº. 000500377M0001	Laboratório
25345	BOM	FOCO CLÍNICO	MARCA MEDICATE MOD. 500 SÉRIE Nº. 000500377M0001	Laboratório
25399	BOM	ARMÁRIO VITRINE	DE 2 PORTAS 0,65X3,6 MARCA ARTMED	Laboratório
25400	BOM	MESA DE MAYO	0,40X0,50 MARCA ARTMED	Laboratório

25401	BOM	MESA DE MAYO	0,40X0,50 MARCA ARTMED	Laboratório
25402	BOM	MESA DE MAYO	0,40X0,50 MARCA ARTMED	Laboratório
25403	BOM	MESA DE MAYO	0,40X0,50 MARCA ARTMED	Laboratório
25404	BOM	MESA AÇO INOX	C/SUPORTE SORO PAREDE	Laboratório
25405	BOM	MESA AÇO INOX	C/SUPORTE SORO PAREDE	Laboratório
25406	BOM	MESA AÇO INOX	C/SUPORTE SORO PAREDE	Laboratório
25407	BOM	MESA AÇO INOX	C/SUPORTE SORO PAREDE	Laboratório
25408	BOM	MESA AUXILIAR	0,75X0,45X0,80 MARCA ARTMED	Laboratório
25409	BOM	MESA AUXILIAR	0,75X0,45X0,80 MARCA ARTMED	Laboratório
25410	BOM	MESA AUXILIAR	TAMPO INOX 0,57X0,45X0,99 MARCA ARTMED	Laboratório
25411	BOM	MESA AUXILIAR	TAMPO INOX 0,57X0,45X0,99 MARCA ARTMED	Laboratório
25413	BOM	MESA AUXILIAR	TAMPO INOX 0,44X0,94X0,80.MARCA ARTMED	Laboratório
25481	BOM	REFRIGERADOR	DOMESTICO 280 L. 220V. DEGELO ALTOMATICO COR BRANCA	Laboratório
25777	BOM	AR CONDICIONADO	DE 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL SEM FIO, 220 V, GARANTIA DE 5 ANOS, SENDO 2 UNIDADES INTERNAS DE 9.000 BTUS	Laboratório
24932	BOM	ARMÁRIO	em aço,fostatizado pintura lisa cinza,2 un.c/dob.c/chave e puxador, lun. 1,98x1,10x0,50m. marca W.mod.403	Laboratório
25261	BOM	MONITOR DE VIDEO	17 POLEGADAS SÉRIE Nº.511SPLL93824.	Coordenação
25237	BOM	CPU	PROCESSADOR INTEL P4-30GAZ HT (ITEL 2 LOTE 1) SÉRIE Nº.0050700003019.	Coordenação
25285	BOM	NOBREAK	SMS 1.4KVA (ITEM 3 LOTE 1) SÉRIE Nº.275150002235.	Coordenação
24940	BOM	MESA	reunião redonda de madeira aglom. marca W3 mod.MMW509.	Coordenação
24936	BOM	CADEIRA	fixa c/esatrut. em tubo de aço cromado, marca Webfles,modelo Auxiliar.	Coordenação
24937	BOM	CADEIRA	fixa c/esatrut. em tubo de aço cromado, marca Webfles,modelo Auxiliar.	Coordenação
24938	BOM	CADEIRA	fixa c/esatrut. em tubo de aço cromado, marca Webfles,modelo Auxiliar.	Coordenação
24939	BOM	CADEIRA	fixa c/esatrut. em tubo de aço cromado, marca Webfles,modelo Auxiliar.	Coordenação
24960	BOM	MESA	p/professor c/tampo em MDF 25mm.revestimento c/laminado melamínico fosco med.1,20x0,60m.marca Girotec,mod.GM-2150.	Coordenação
24975	BOM	CADEIRA	interiocutor em espuma infetada revestida em tecido na cor verde,estrut.fixa em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod,.FG20ESx.	Coordenação
24976	BOM	CADEIRA	interiocutor em espuma infetada revestida em tecido na cor verde,estrut.fixa em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod,.FG20ESx.	Coordenação
24986	BOM	CADEIRA	professsor/gabinete em espuma enfetada,revestido em tecido	Coordenação

			verde,estrut.girat.em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod.GG36N.	
23664	BOM	APARELHO ANESTESIA	MARCA K TAKOAKA MOD. 70.2604.002.	Laboratório
23665	BOM	ASPIRADOR	MARCA K TAKOAKA MOD. 20.17200.100.	Laboratório
24961	BOM	MESA	p/professor c/tampo em MDF 25mm.revestimento c/laminado melamínico fosco med.1,20x0,60m.marca Girotec,mod.GM-2150.	Laboratório
43652	BOM	MONITOR DE VIDEO	LCD "22 POLEGADAS WIDESCREEN, C/MOUSE.TECLADO WIND.7. 320-1450	Laboratório

Laboratório de Anatomopatologia

Equipamentos:

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO
25250	BOM	CPU	PROCESSADOR INTEL P4-30GAZ HT (ITEL 2 LOTE 1) SÉRIE Nº.0050700003347.	Sala da Coordenação
25257	BOM	MONITOR DE VIDEO	17 POLEGADAS SÉRIE Nº.511SPNZ93827.	Sala da Coordenação
33899	BOM	BANHO-MARIA	HISTOLOGICO - REDONDO C/TERMOSTATO, EM RESINA DE ALTA RESTEN CIA E ALUMINIO, COM ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA ELETROTAS-TICA A PO DE ALTA RESISTENCIA, CUBA INTERNA DE AÇO CONT TEMP	Laboratório
33901	BOM	PHMETRO MEDIDOR DE PH BANCADA	POTENCIÔMETRO, PHMETRO DE BANCADA,PH/mV/TEMPERATURA FAIXA DE 0.0 A 14.00,MOD. PHS-3-B,CONTROLE E MONIT.DE PH/mV/TEMP.DIVE SAS ÁREAS.ESTRUT.MOLDADA PLÁST.ABS,DISPLEY DIG.AJUSTE SLOPE.	Laboratório

Laboratório de Fisiologia Humana

Equipamentos:

Nº Tomb.	Descrição do Equipamento	Estado de conservação

24379	Monitor Cardiaco 3 deriv. (sinais vitais)	**BOM**
24518	**Oxímetro de pulso – marca Dixtal mod.DX 2405**	**BOM**
24948	Armário MDFD – marca Girotec mod.GM-2165	**BOM**
24957	Mesa MDF marca Girotec mod.GM-2150	**BOM**
24973 e 24974	Cadeira na cor verde – marca Girotec mod. FG20ESX	**BOM**
	Cadeira na cor verde – marca Girotec mod. FG20ESX	**BOM**
25238 e 25252	CPU Processador Intel P4-30GAZ HT	**BOM**
25238 e 25252	CPU Processador Intel P4-30GAZ HT	**BOM**
25254 e 25273	Monitor de vídeo 17’ – marca LG	**BOM**
25254 e 25273	Monitor de vídeo 17’ – marca LG	**BOM**
25274 e 25281	Nobreak MARCA SMS 1,4 KVA	**BOM**
25274 e 25281	Nobreak MARCA SMS 1,4 KVA	**BOM**
25307	Impressora Laser – marca Lexmark T430 DN	**BOM**
25487 e 25488	Kit de Sistema de Aquisição de dados Fisiológicos PTB401- Powerlab	**BOM**
25487 e 25488	Kit de Sistema de Aquisição de dados Fisiológicos PTB401- Powerlab	**BOM**
25628	Espirômetro Computadorizado mod.One Flow marca Clarke	**BOM**
25735	Eletrocardiógrafo Digital Portátil 110/220 volt	**BOM**
25779	Aparelho de ar condicionado de 18000 BTUS tipo bi-split, sendo 2 unid. Internas de 9000BTUS	**BOM**
25804/01 a 25804/24	Bancos em madeira e Fórmica 70x30 (tamburetes)	**BOM**
25804/01 a 25804/24	Bancos em madeira e Fórmica 70x30 (tamburetes)	**BOM**
25895	Centrifuga de bancada SISLAB Mod. FA2104	**BOM**
25896	Estufa de Esterilização	**BOM**
25905	Balança Pediátrica digital Balmax mod. MP25BB	**BOM**
25906	Balança Antropométrica	**BOM**

22427	Audimetro portátil c/ caixa acústica e impressora HP Deskjet 843 C acoplada.	**REGULAR**

Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia

Equipamentos:

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO
25483	BOM	DESUMIDIFICADOR	Laboratório
25664	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25665	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25666	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25667	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25668	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25669	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25670	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25671	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25672	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25673	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25674	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25675	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25676	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25677	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25678	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25679	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25680	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25681	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
25682	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório

25683	BOM	MICROSCÓPIO	Laboratório
23397	BOM	RETROPROJETOR	Laboratório
25783	BOM	APARELHO DE AR CONDICIONADO	Laboratório
25519	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25520	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25521	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25523	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25524	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25525	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25526	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25527	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25528	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25529	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25530	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25531	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25532	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25534	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25537	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25538	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25539	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25540	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25541	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25543	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25544	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25545	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25546	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25548	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25549	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25550	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório

25551	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25553	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25554	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25555	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25556	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25557	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25558	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25559	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25561	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25562	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25564	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25565	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25566	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25568	BOM	BANCO GIRATÓRIO	Laboratório
25244	P	CPU	Coordenação
25256	P	MONITOR DE VIDEO	Coordenação
25292	P	NOBREAK	Coordenação
25444	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25445	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25446	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25447	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25448	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25449	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25450	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25451	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25452	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25453	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25454	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25455	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório

25456	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25457	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25458	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25459	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25460	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25461	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25462	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25463	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25464	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25465	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25466	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25467	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25468	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25469	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25470	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25471	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25472	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório
25473	BOM	MICROSCOPIO	Laboratório

Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia

Equipamentos:

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO
13448	Regular	Mesa p/ impressora	LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
14779	BOM	Carteira escolar em madeira	LABORATORIO DE BIOMEDICAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24928	BOM	Arquivo	Armário marca Padinem aço pesado para pasta suspensas com 4 gavetas marca Pandi modelo OF4-L. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

24933	BOM	Armário	Aço,fostatizado pintura lisa cinza,2 un.c/dob.c/chave e puxador, lun. 1,98x1,10x0,50m. marca W.mod.403. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24942	BOM	Armário	Em chapa MDFD 25mm, em laminado melamínico fosco, med. 1,60x0,90x0,40m,marca Girotec,mod.GM-2165. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24943	BOM	Armário	Em chapa MDFD 25mm, em laminado melamínico fosco, med. 1,60x0,90x0,40m,marca Girotec,mod.GM-2165. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24944	BOM	Armário	Em chapa MDFD 25mm, em laminado melamínico fosco, med. 1,60x0,90x0,40m,marca Girotec,mod.GM-2165. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24945	BOM	Armário	Em chapa MDFD 25mm, em laminado melamínico fosco, med. 1,60x0,90x0,40m,marca Girotec,mod.GM-2165. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24946	BOM	Armário	Em chapa MDFD 25mm, em laminado melamínico fosco, med. 1,60x0,90x0,40m,marca Girotec,mod.GM-2165. Lab.Med	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24949	BOM	Mesa	P/ professor c/tampo em MDF 25mm.revestimento c/laminado melamínico fosco med.1,20x0,60m.marca Girotec,mod.GM-2120. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24950	BOM	Mesa	P/ professor c/tampo em MDF 25mm.revestimento c/laminado melamínico fosco med.1,20x0,60m.marca Girotec,mod.GM-2120. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24963	BOM	Cadeira	Interiocutor em espuma infetada revestida em tecido na cor verde,estrut.fixa em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod,.FG20ESx. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24964	BOM	Cadeira	Interiocutor em espuma infetada revestida em tecido na cor verde,estrut.fixa em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod,.FG20ESx. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24979	BOM	Cadeira estofada verde giratória - Girotec	Professsor/gabinete em espuma enfetada,revestido em tecido verde,estrut.girat.em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod.GG36N. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
24980	BOM	Cadeira estofada verde giratória - Girotec	Professsor/gabinete em espuma enfetada,revestido em tecido verde,estrut.girat.em tupo de aço pintada em epoxi na cor preta,marca Girotec,mod.GG36N. Lab.Med.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25288	BOM	Nobreak	SMS 1.4KVA (ITEM 3 LOTE 1) SÉRIE Nº.275150002233. (CONVENIO N. º 007/2004/PGF) LAB.ANATOMIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25392	BOM	Armário Vitrine	DE PAREDE 0,50X0,65, MARCA ARTMED. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25414 a	BOM	Microscópio	BIOLOGICO BINOCULAR 4 OBJETIVAS ÓTICA ACROMÁTICA 1000X HALOGENIO 20 WATTS HORHLER 85A265VOLTS (BIVOLT AUTOMÁTICO)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

25443			MOD.L2000A. BIND: (BR 001). LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	
25474	BOM	Microscópio Trinocular – L2000	TRINOCULAR - 4 OBJETIVAS ÓTICA PLANACROMÁTICA INFINITA CORRIDA (IOS) 1000X LAMP.HANOGENIO 6V/20 WATTS KOEHLER ACOMP.CAMARA CCD COLORIDA RES.480 LINHAS COMPL. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25475	BOM	Refrigerador Frost Free 440 LTS – Eletrolux DF45	FROST FREE DE 440 L. DESCONGELAMENTO .ELECTROLUX, DF45.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25482	BOM	Desumidificador de Ar – Arsec 250	RELATIVO A 40/50% POSSUI UMIDOSTADO PINTURA EPOXI. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25489 a 25518	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25522	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25533	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25535	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25536	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25542	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25547	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25552	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25560	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25563	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25567	BOM	Banco	GIRATÓRIO IN0X ALTURA REGULÁVEL.	Laboratório de Microbiologia e

				Parasitologia
25630	BOM	Contador diferencial de células	LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25631	BOM	Contador diferencial de células	LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25632	BOM	Contador de colônias	LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25634	BOM	Estufa de secagem e Esterilização	P/SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA MARCA BIOPAR, MOD.S80SA.	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25635	BOM	Centrifuga clínica	CLÍNICA MOD.802b-CENTRIBIO. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25636	BOM	Centrifuga clínica	CLÍNICA MOD.802b-CENTRIBIO. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25644 a 25663	BOM	Microscópio Binocular	BINOCULAR,MOD.TIM 2005-OPTON. LAB.MICROB.PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25733	BOM	BACTÉRIA P/MEDICINA.	Conjunto de lâminas permanentes Bactéria p/ Medicina c/ 60 pçs mod. TIL-B-30. M.Antomic	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25734	BOM	BACTÉRIA P/MEDICINA.	Conjunto de lâminas permanentes Bactéria p/ Medicina c/ 60 pçs mod. TIL-B-30. M.Antomic	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25784	BOM	Aparelho de ar condicionado	DE 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL SEM FIO, 220 V, GARANTIA DE 5 ANOS, SENDO 2 UNIDADES INTERNAS DE 9.000 BTUS. TIPO BI-SPLIT,MOD.CONTURA WALL	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25805	BOM	Autoclave cap. 18lts	CAPACIDADE 18 LT TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE FISIOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25806	BOM	Estufa Incubadora p/ BOD	DE INCUBADORA PARA BOD TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE FISIOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25817	BOM	Estufa Bacteriológica	BACTERIOLOGICA TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

25899	BOM	Refratometro Clinico mod. RPT2CACT	CLÍNICO INSTRUTHERM, MODELO RPT2CACT Nº.05072600666790. LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25900	BOM	Refratometro Clinico mod. RPT2CACT	CLÍNICO INSTRUTHERM, MODELO RPT2CACT Nº.05072600666790. LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25901	BOM	RECIPIENTE LABORATORIAL	PEERMUTION. LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25903	BOM	Agitador	DE TUBO DE ENSAIO TIPO VOLTEX MODELO QL-901 SÉRIE Nº.7756. LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25904	BOM	Banho Maria	LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25907	BOM	Aglutinoscópio mod. AGDSD2	MODELO AGDSD2. LAB.MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28556	BOM	Fonte de alimentação 600VA- NOBREAK	600 VA NOBREAK. LAB.MICROB/PARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28577	BOM	Micropipeta	AUTOMÁTICA DIGITAL C/ VOLUME VARIAVEL - VOLUME DE 0,2 A 2 UL DIGITAL MONOCANAL C/ VOLUME VARIAVEL, AJUSTE CONTINUO, CABO ANATOMICO,EJETOR DE PONTEIRAS C/SUPORTE DE BANCADA.MICROBIOL - marca HTL	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28578	BOM	Micropipeta	AUTOMÁTICA DIGITAL C/ VOLUME VARIAVEL - VOLUME DE 0,2 A 2 UL DIGITAL MONOCANAL C/ VOLUME VARIAVEL, AJUSTE CONTINUO, CABO ANATOMICO,EJETOR DE PONTEIRAS C/SUPORTE DE BANCADA.MICROBIOL - marca HTL	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28582	BOM	Contador diferencial de células Sanguineas – marca Kacil	CONTAGEM DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS (08 TIPOS NO MIN) COM VALORES ABSOLUTOS E PERCENTUAIS LEOCÓCITOS. LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28583	BOM	Contador diferencial de células Sanguineas –	CONTAGEM DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS (08 TIPOS NO MIN) COM VALORES ABSOLUTOS E PERCENTUAIS LEOCÓCITOS. LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

		marca Kacil		
28586	BOM	Relógio p/Laboratório – marcador de tempo – marca Kacil	MULTI TIME PARA LABORATÓRIO - MARCADOR DE TEMPO MÚLTIPLO (TIPO MULTITRON) PARA LABORATÓRIO, PODENDO SER USADO POR VÁRIOS OPERADORES SIMULTANEAMENTE. ALARME SONORO.LAB. DE MIC	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28600	BOM	Microcomputador Romaze c/ processador AMD	ROMAZE C/ PROCESSADOR AMD. LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28603	BOM	Monitor de vídeo – cor preto	C/TECLADOABNT 2 CONCTOR PS2 COR PRETO. C/MOUSE BALL C/ SCROLL CONECTOR PS2 COR PRETO. C/PAR DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADOR,COR PRETA.LAB. DE MICROB	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28611	BOM	Impressora Laser Jet 1020 HP	LASER HP LASERJET 1020. LABGEOQUIM	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28677	BOM	Refratometro	MANUAL DENSIDADE E PROTEINA NA MOD.301BP:(DC-001). LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28678	BOM	Refratometro	MANUAL DENSIDADE E PROTEINA NA MOD.301BP:(DC-001). LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28679	BOM	Aglutinoscópio	TIPO DE ESPELHO CONVEXO. LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA (PHOENIX MODELO VP20)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
28735	BOM	Contador de Colônias	CONTADOR DE CELULAS MECÂNICAS. LAB. DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA (PHOENIX, CP602.)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29197	BOM	Capela de Fluxo Laminar	FLUXO LAMINAR - VERTICAL MOD. PCRT TAM 2 + BASE RODÍZIOS GI-RATÓRIOS E FREIO. LAB.DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29521	BOM	Cronometro digital marca Cronobio	DIGITAL MARCA CRONOBIO. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29522	BOM	Cronometro digital marca Cronobio	DIGITAL MARCA CRONOBIO. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29523	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

29524	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29525	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29526	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29527	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29528	BOM	Termometro digital	E MÁXIMA E MÍNIMA P/GELADEIRAS, ESTUFAS E FREEZER DE LABORA TORIO, MARCA INCOTERM. LABMICROBPARAS (marca Incoterm)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29616 a 29625	BOM	Micropipeta mono VA 1000 A 5000 UL –marca Digepet	MONO VA 1000 A 5000UL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29626 a 29635	BOM	Micropipeta mono VA 100 A 1000 UL –marca Digepet	MONO VA 100 A 1000MCL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29636 a 29645	BOM	Micropipeta mono VA 20 A 200 MCL –marca Digepet	MONO VA 20 A 200MCL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29646 a 29655	BOM	Micropipeta mono VA 10 A 100 MCL –marca Digepet	MONO VA 10 A 100MCL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29656 a 29660	BOM	Micropipeta Auto digi VV 0,5 A 10 UL - marca Digepet	AUTO DIGI VV 0,5 A 10UL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL VOLUME VARIAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29661 a	BOM	Micropipeta Auto digi VV 2 A 20 UL	AUTO DIGI VV 2 A 20UL, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL VOLUME VARIAVEL - MARCA DIGEPET. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia

29665		- marca Digepet		
29666 a 29683	BOM	Pipetador (aspirador)	P/PIPETAS (ASPIRADOR) SOROLÓGICAS DE 5 E 10 ML - MARCA PLAST BIO. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
29684 a 29701	BOM	Pipetador (aspirador)	P/PIPETAS (ASPIRADOR) SOROLÓGICAS DE 1 E 2 ML - MARCA PLAST BIO. LABMICROBPARAS	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
43647	BOM	CPU MARCA DELL	PROC.INTEL CORE 2DUO CLOCK MÍN.2,93GHz,CACH.L2 MÍN.3MB E FSB MÍN.1066MHz,OU AMD C/DESEMP.=OU SUPERIOR,MEM.2GB,HD250 GB, POSSUIR 02 SLOTS LIVR.PCI VERS.2.3,PORT.USB V.2.0, 271-6070. (DELL OPTIPLEX 780SFF. DPTO.MEDICINA)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
43654	BOM		LCD "22 POLEGADAS WIDESCREEN, C/MOUSE.TECLADO WIND.7. 320-1450 (MARCA: DELL MOD.E2210 DPTO.MEDICINA)	Laboratório de Microbiologia e Parasitologia
25805	BOM	Autoclave cap. 18lts RIOMAR	CAPACIDADE 18 LT TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE FISIOLOGIA	LABORATORIO DE FISIOLOGIA
25806	BOM	ESTUFA	DE INCUBADORA PARA BOD TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE FISIOLOGIA	LABORATORIO DE FISIOLOGIA
25817	BOM	ESTUFA	BACTERIOLOGICA TERMO DE ENTREGA 18/2006-RIOMAR LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Laboratório de habilidades

Equipamentos:

SETOR:			Laboratório de Habilidades	
LOCAL:			Bloco 3A - 1º Piso	
Responsável pelo bem:			Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite	
Nome do Inventariante:			Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite	

ITEM	SITUAÇÃO DO BEM*	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO
65192	BOM	Aparelho de AR Condicionado Tipo Split	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSAO 220 V	Laboratório de Habilidades
			FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS	
			ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE	
			REMOTO SEM FIO.	
			MARCA:ELETROLUX	
65193	BOM	APARELHO DE AR	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSAO 220 V	Laboratório de Habilidades
		CONDICIONADO TIPO	FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS	
		SPLIT	ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE	
			REMOTO SEM FIO.	
			MARCA:ELETROLUX	
65194	BOM	APARELHO DE AR	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSAO 220 V	Laboratório de Habilidades
		CONDICIONADO TIPO	FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS	
		SPLIT	ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE	
			REMOTO SEM FIO.	
			MARCA:ELETROLUX	
65240	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	
			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	
			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65241	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	

			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	
			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65242	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	
			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	
			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65243	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	
			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	
			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65244	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	
			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	

			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65245	BOM	FORNO MUFLA	MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4	Laboratório de Habilidades
			PRATELEIRAS VIDRO C/ ESPESSSURA, QUANTIDADE	
			PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA, FECHADURA	
			CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65M,	
			PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÃAO USO HOSPITALAR,	
			CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA	
			AÃO ESMALTADO.	
			MARCA: CAUMAQ	
65246	BOM	CAMA RECUPERACAO	HOSPITALAR, TIPO AMERICANA, MODELO C/CABECEIRA	Laboratório de Habilidades
			P/OBESOS ATE 250KG, DIMENSOES 1,90 X 0,70 X 0,80M,	
			MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA REFORÇADA,	
			CONTROLE ARTICULAÇAO POR CONTROLE ELETRICO	
			MANUAL, COMPONENTE ESCAMOTEAVEIS P/ MOVIMENTOS	
			FOWLER, ADICIONAIS SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
65247	BOM	CAMA RECUPERACAO	HOSPITALAR, TIPO AMERICANA, MODELO C/CABECEIRA	Laboratório de Habilidades
			P/OBESOS ATE 250KG, DIMENSOES 1,90 X 0,70 X 0,80M,	
			MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA REFORÇADA,	
			CONTROLE ARTICULAÇAO POR CONTROLE ELETRICO	
			MANUAL, COMPONENTE ESCAMOTEAVEIS P/ MOVIMENTOS	
			FOWLER, ADICIONAIS SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
65248	BOM	MESA AUXILIAR	HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ARMAÇAO AÇO	Laboratório de Habilidades
			INOXIDAVEL, TUBOS 1, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA	
			AÇO INOXIDAVEL, FORMATO BORDAS LATERIAIS P/ BAIXO E	

			P/DENTRO SEM ARESTAS, COMPRIMENTO TAMPO 80 CM,	
			LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS	
			ADICIONAIS PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
65249	BOM	MESA AUXILIAR	HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ARMAÇAO AÇO	Laboratório de Habilidades
			INOXIDAVEL, TUBOS 1, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA	
			AÇO INOXIDAVEL, FORMATO BORDAS LATERIAIS P/ BAIXO E	
			P/DENTRO SEM ARESTAS, COMPRIMENTO TAMPO 80 CM,	
			LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS	
			ADICIONAIS PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
65250	BOM	MESA AUXILIAR	HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ARMAÇAO AÇO	Laboratório de Habilidades
			INOXIDAVEL, TUBOS 1, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA	
			AÇO INOXIDAVEL, FORMATO BORDAS LATERIAIS P/ BAIXO E	
			P/DENTRO SEM ARESTAS, COMPRIMENTO TAMPO 80 CM,	
			LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS	
			ADICIONAIS PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
65251	BOM	MESA AUXILIAR	HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ARMAÇAO AÇO	Laboratório de Habilidades
			INOXIDAVEL, TUBOS 1, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA	
			AÇO INOXIDAVEL, FORMATO BORDAS LATERIAIS P/ BAIXO E	
			P/DENTRO SEM ARESTAS, COMPRIMENTO TAMPO 80 CM,	
			LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS	
			ADICIONAIS PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	
			MARCA: NUCLEOTEC	
		SIMULADOR		
			DE USO DIDATICO PARA AUSCULTA TORACICA,ESTE	

			SIMULADOR SOPROS CARDIACOS E RUIDOS	
			RESPIRATORIOS COM 16 TIPOS DIFERENTES DE	
			RUIDOS,ABRANGE DUAS EXTREMIDADES EXTERNAS DE	
			CAPTAÇAO DE SONS COM AS QUAIS OS ESTUDANTES	
			PODEM AUSCULTAR OS RUIDOS POR MEIO DE UM	
			ESTETOSCOPIO. A LIGAÇAO DE UNIDADES	
			AUSCULTATORIAS SUPLEMENTARES PERMITE ATE A 15	
			ESTUDANTES DE EFETUAR O EXAME AUSCULTATORIO	
			PERMITE LIGAR UM ALTOFALANTE(UMA CAIXA ACUSTICA). O	
			APARELHO DISPOE AINDA DE UM REGULADOR DO VOLUME	
65360			DOS SONS E DE DOIS DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED)	
			QUE SE ILUMINAM DURANTE SISTOLE(MENU CARDIACO)	
			RESPECTIVAMENTE DURANTE A EXPIRAÇAO(MENU	
			RESPIRATORIO).O APARELHO ACIONADO ATRAVES DE UMA	
			BATERIA 9 V.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W49400.	
65361	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREIN.DE EXAME FISICO EM	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MULTIPARAMETRO. MANEQUIM ADULTO BISSEXUAL PARA	
			TREINAMENTO COM 1.70 M DE ALTURA PROJETADO PARA	
			SIMULAR O CORPO HUMANO NAS DIVERSAS MODALIDADES	
			DE ESTUDO PRATICO .OS BRAÇOS, PERNAS E JUNTAS	
			REPRODUZEM MOVIMENTOS REALISTAS. PERMITE A	
			REMOÇAO DA COBERTURA DO PEITO E ABDOME	
			POSSIBILITA A VISUALIZAÇAO DOS ORGAOS INTERNOS,	
			CORRETAMENTE CONECTADOS EM SUA FORMA	
			ANATOMICA, COMO TRAQUEIA - PULMAO ESOFAGO -	

			ESTOMAGO, INTESTINO - RETO, ETC. OS PRINCIPAIS	
			ORGAOS INTERNOS, PULMAO, CORAÇAO, ESTOMAGO	
			BEXIGA, INTESTINO - SOA FACILMENTE VISUALIZADOS E AS	
			GENITALIAS MASCULINA E FEMININA SAO	
			INTERCAMBIAVEIS, POSSIBILITANDO A CONEXAO DA BEXIGA	
			E A SEÇAO INTESTINAL. A CABEÇA SE MOVIMENTA PARA	
			TRAS, PERMITINDO A ABERTURA DA BOCA, QUE POSSUI	
			LINGUA E PALATO (CONFECCIONADA COM MATERIAL	
			MACIO, DANDO MAIOR REALISMO A SIMULAÇÃO) E DENTES	
			(PROTESES REMOVIVEIS). A ABERTURA NASAL, BUCAL E	
			TRAQUEAL POSSUEM SUAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS	
			INTERNAS.	
			MARCA: SIMULACARE 52A.	
65362	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE EXAME FISICO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			EM ULTIPARAMETRO DE PACIENTE CONVALESCENTE.	
			MARCA: SIMULACARE 45CWA.	
65363	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE DIAGNOSTICO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MODELO - FACE COM DIVERSAS LESOES.SIMULADOR DE	
			ROSTO COM LESOES PARA DIAGNOSTICO.AMPLA	
			VARIEDADE DE LESOES DE PELE. PROPORCIONA UMA BASE	
			PARA DISCUSSAO DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS	
			PARA O SEU TRATAMENTO E NO PLANEJAMENTO DE	
			RETALHOS CUTANEOS E INCISOES.MODELO PROJETADO	
			PARA O DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO PARA OPERAÃOES	
			E INCISOES PRATICAS COM PADS INDIVIDUAIS	
			IDENTIFICAÃAO DE LESOES PLANEJAMENTO DOS	

			PROCESSOS COMPREENSAO DAS ESTRUTURAS INTERNAS	
			E EXTERNAS DA PELE. CARACTERISTICAS: APARENCIA E	
			SENSAÃAO TATIL REALISTAS CISTO SEBACEO NO COURO	
			CABELUDO CISTO SEBACEO NO LOBULO DA ORELHA CISTO	
			MEIBOMIAN NO INTERIOR DA TAMPA DO OLHO CISTO NA	
			BOCA QUERATOSE SEBORREICA TUMOR PAROTIDA TUMOR	
			LENTIGO CARCINOMA BASOCELULAR CERATOACANTOMA	
			MELANOMA MALIGNO CHONDRODERMATITIS NODULARIS	
			HELICOIDE QUERATOSE ACTINICA (SOLAR) ESTRANHAS	
			PROTUBERANCIAS FORNECIDO COM MARCADOR ESPECIAL	
			QUE MARCA E A TINTA DESAPA.	
			MARCA: LIMBS E THINGS 20001.	
65364	BOM	SIMULADOR	ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			FINALIDADE MONITORAÇAO POR ECG, PULSO DA ARTERIA	
			BRAQUIAL, TIPO MANEQUIM SIMULADOR ECG INFANTIL,	
			APLICAÇAO VENTILAÇAO ARTIFICIAL, INTUBAÇAO	
			ORAL/NASAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSAGEM	
			CARDIACA, MANDIBULA MOVEL, ACESSOS VENOS O	
			OUTROS COMPONENTES INTRODUÇAO OSSEA DE	
			AGULHAS, PULSAAO DE MEDULA OSSEA, ACESSORIOS	
			BOLSA PARA TRANSPORTE.	
			MARCA: NASCO LF03955U.	
65365	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE EXAME DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			OUVIDO, O SIMULADOR CONSISTE NUM MODELO DE UMA	
			CABEÇA COM 06 ORELHAS SUBSTITUIVEIS FEITAS DE UM	
			MATERIAL ELASTICO COM ESTRUTURAS EXTERNAS E	
			INTERNAS ANATOMICAMENTE REALISTAS. AS ESTRUTURAS	
			COLORIDAS EM CINCO DOS SEIS OUVIDOS POSSIBILITAM O	

			DIAGNOSTICO DE DIFERENTES CONDIÇOES PATOLOGICAS.	
			O OUVIDO SEM ESTRUTURAS COLORIDAS PODE SER	
			UTILIZADO PARA PRATICAR A REMOÇAO DE	
			CERUME.FORNECIDO COM 2 TUBOS DE CERUME	
			ARTIFICIAL, NOVE SLIDES DE 35 mm (PARA A PROJEÇAO	
			DAS 5 CONDIÇOES PATOLOGICAS CITADAS ABAIXO E DAS 4	
			CONDIÇOES PATOLOGICAS DO KIT COMPLEMENTAR) E	
			MALETA DE TRANSPORTE. ACOMPANHA OTOSCOPIO. AS	
			SEGUINTES CONDIÇOES NORMAIS E PATOLOGICAS PODEM	
			SER EXAMINADAS: MEMBRANA TIMPANICA NORMAL OTITE	
			MEDIA MUCOSA, OTITE MEDIA SEROSA COM ACUMULO DE	
			LIQUIDO , OTITE MEDIA CRONICA COM PERFURAÇAO	
			MEMBRANA TIMPANICA NORMAL COM MEATO ACUSTICO	
			INCLINADO.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44122	
65366	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			EXAME DE OUVIDO. MODELO COM OUVIDOS FLEXIVEIS.	
			ANATOMICAMENTE CORRETO, OFERECE 12 DIFERENTES	
			CONDIÇOES APRESENTADAS EM FORMAS DE FOTOGRAFIAS	
			ENDOSCOPICAS DA MEMBRANA TIMPANICA. AS 12	
			CONDIÇOES SAO:* MEMBRANA TIMPANICA NORMAL* *OTITE	
			AGUDA* *OTITE AGUDA LIMITADA* . RESOLUÇAO DE EFUSAO	
			MEDIA* *TIMPANOESCLEROSE* *TIMPANOSTOMIA TUBU*	
			CERUME DE PARAFINA *INFECÇAO AGUDA MEDIA* * OTITE	
			AQUOSA MEDIA*	
			* FLUIDO ATRAS DO TIMPANO* EXEMPLO ADICIONAL DE	
			OTITE AQUOSA* . PERFURAÇAO DO TIMPANO ACOMPANHA:	
			BROCHURA C/ INFORMATIVOS COMPLETOS E DETALHADOS	

			SOBRE A CONDIÇAO DE CADA OUVIDO.	
			MARCA: ADAM ROUILLY AR302.	
65367	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			EXAME DE OLHOS. SIMULADORA PARA TREINAMENTO DE	
			REINOPATIA.O SIMULADOR PERMITE EXPERIENCIA E	
			PRATICA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE OLHO USANDO	
			UM OFTALMOSCOPIO EM RETINOPATIA DIABETICA.	
			ACOMPANHA OFTALMOSCOPIO.PERMITE A IDENTIFICAÇAO	
			DE DOENÇAS QUE ESTAO APRESENTADAS NUM KIT DE 13	
			TRANSPARENCIAS INTERCAMBIAVEIS: *DEGENERAÇAO DE	
			MACULA SENIL* OCLUSAO DA VEIA RETINAL CENTRAL *	
			RETINOPATIA HIPERTENSIVA* PAPILODEMA * SANGRIA DO	
			DISCO* ATROFIA OTICA* RETINOPATIA DIABETICA DE FUNDO	
			SUAVE * RETINOPATIA DIABETICA DE FUNDO * RETINOPATIA	
			DIABETICA PREPROLIFERATIVA (1) * RETINOPATIA	
			DIABETICA PREPROLIFERATIVA (2) * RETINOPATIA	
			DIABETICA PREPROLIFERATIVA8 * RETINOPATIA DIABETICA*	
			RETINA NORMAL*.	
			MARCA: ADAM ROUILLY AR303.	
65368	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			AUSCULTA CARDIACA COM SMARSCOPE. PODE-SE	
			SELECIONAR DIFERENTES ESTADO ATRAVES DE UM	
			CONTROLE REMOTO. APOS A PALPAÇAO DOS LOCAIS DE	
			AUSCULTA CORRETOS, OS ESTUDANTES PODEM	
			AUSCULTAR OS RUIDOS CARDIACOS E RESPIRATORIOS	
			POR MEIO DE UM ESTETOSCOPIO ESPECIALIZADO. O	
			SIMULADOR APRESENTA 6 PONTOS DE AUSCULTA SOBRE O	
			CORAÇAO E OS PULMOES DO LADO ANTERIOR E 16	

			PONTOS DE AUSCULTA SOBRE OS PULMOES DO LADO	
			DORSAL. O CONTROLE REMOTO POSSUI UM ALCANCE	
			MAXIMO DE 30m. O SIMULADOR E FORNECIDO COM MALETA	
			DE TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO E UM	
			ESTETOSCOPIO SMARTSCOPE MONOAURAL E BINAURAL.	
			OPERADO POR DUAS BATERIAS DO TIPO AA E TRES	
			BATERIAS DO TIPO AAA(INCLUIDAS). O SIMULADOR	
			OFERECE OS SEGUINTES RUIDOS PARA A AUSCULTA:	
			RUIDOS CARDIACOS: 1. REGULAR, 2.INSUFICIENCIA	
			AORTICA, 3.ESTENOSE PULMONAR, 4.ESTENOSE MITRAL,	
			5.RUIDO HOLOSSISTOLICO, 6.RUIDO MESOSSISTOLICO, 7.3a	
			BULHA CARDIACA, GALOPE, 8. 4a BULHA	
			CARDIACA,GALOPE, 9.ESTALID.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44119.	
65369	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			DIAGNOSTICO, PROCEDIMENTO E EXAMES DE OUVIDO	
			PEDIATRICO.SIMULADOR PERMITE PRATICAR E TREINAR AS	
			HABILIDADES NECESSARIAS PARA OS DIVERSOS EXAMES	
			DE OUVIDO EM CRIANÇA AO UTILIZAR PISTAS VISUAIS QUE	
			PERMITEM DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMUNS,	
			PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DO CANAL AUDITIVO,	
			REMOÇAO DE CORPO ESTRANHO E EXECUÇAO DE	
			MIRINGOTOMIA COM INSERÇAO DE TUBO. DESENVOLVIDO	
			COM ANATOMIA CORRETA E REALISTA, ESTE EQUIPAMENTO	
			APRESENTA OUVIDOS(ORELHAS) REMOVIVEIS PARA	
			FACILITAR A MANUTENÇAO E ARMAZENAGEM. PERMITE	
			AINDA QUE O OUVIDO MEDIO SEJA PREENCHIDO COM	
			VARIOS FLUIDOS. O INSTRUTOR PODE CONTROLAR A	

			CONSISTENCIA E COLORAÇAO DESSES FLUIDOS. PERMITE	
			AINDA QUE O OUVIDO MEDIO SEJA PREENCHIDO COM	
			VARIOS FLUIDOS. O INSTRUTOR PODE CONTROLAR A	
			CONSISTENCIA E COLORAÇAO DESSES FLUIDOS. PERMITE	
			LIQUIDO - OTITE MEDIA CRONICA COM PEQUENAS E	
			GRANDES PERFURAÇOES DA M.	
			MARCA: NASCO / LF01090U.	
65370	BOM	SIMULADOR	AVANÇADO DE AUSCULTA COM MINIMO DE 2 8 SONS DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			CORAÇAO, 20 DE RESPIRAÇAO, 16 INTESTINAIS E 4 DE	
			SOPRO CAROTIDEO. COM ESTE SIMULADOR O	
			APRENDIZADO DE AUSCULTA CARDIACA E PULMONAR E	
			MUITO FACILITADO. ESTE SIMULADOR E CONSTITUIDO POR	
			UM TRONCO COM CABEÇA E PESCOÇO QUE GERA PULSO	
			CAROTIDEO ESQUERDO E SOPRO CAROTIDEO DIREITO. O	
			PULSO E IMPORTANTE PARA RECONHECER OS ELEMENTOS	
			DO CICLO CARDIACO. PERMITE AUSCULTA DOS SONS DO	
			CORAÇAO EM 4 DIFERENTES REGIOES ANATOMICAS COM	
			RUIDOS: AORTICA, VALVULAS PULMONARES, TRICUSPIDE E	
			MITRAL. CONTA COM UM SISTEMA REPRODUTOR QUE	
			PERMITE SE INTERCAMBIO OS DIFERENTES RUIDOS	
			POSSIVEIS: CARDIACOS, PULMONARES E INTESTINAIS EM	
			CONDIÇOES DE SAUDE OU DE ENFERMIDADE. CONTA COM	
			UM SISTEMA REPRODUTOR DE SOM QUE SEM A	
			NECESSIDADE DE APARELHOS DE AUDIO EXTERNOS	
			REPRODUZ SONS BASTANTE REALISTAS. O SIMULADOR	
			REPRODUZ E EMITE O SOM PARA OS RECEPTORES	
			(ESTETOSCOPIO) INFRAVERMELHOS. ASSIM, TODOS OS	
			ESTUDANTES ESCUTAM OS FENOMENOS QUE O	

			PROFESSOR...	
			MARCA: CARDIONICS 718-8800.	
65371	BOM	Módelos	ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			FINALIDADE MONITORAÃAO POR ECG, PULSO DA ARTERIA	
			BRAQUIAL, TIPO MANEQUIM SIMULADOR ECG INFANTIL,	
			APLICAÃAO VENTILAÃAO ARTIFICIAL, INTUBAÃAO	
			ORAL/NASAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSAGEM	
			CARDIACA, MANDIBULA MOVEL,ACESSOS VENOS O,	
			OUTROS COMPONENTES INTRODUÃAO OSSEA DE	
			AGULHAS, PULSAO DE MEDULA OSSEA, ACESSORIOS	
			BOLSA PARA TRANSPORTE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44608	
65372	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO NEONATAL DE SINAIS VITAIS.BONECA	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			PARA MEDIDAS DE REANIMAÇAO, RECEM-NASCIDO OSSOS	
			DA MAO ARTICULADOS AO RADIO,ULNA,UMERO,ESCAPULA	
			E CLAVICULA. APRESENTA TAMBEM MUSCULOS PRINCIPAIS,	
			NERVOS, VEIAS, ARTERIAS,LIGAMENTOS DO	
			OMBRO,COTOVELO E MAO. MOVIMENTO COMPLETO.BASE	
			INCLUIDA.	
			MARCA: SIMULACARE 140 RN	
65373	BOM	SIMULADOR	DE PACIENTE REAL ADULTO DE ALTA FIDELIDADE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			INTERATIVO COM RESPIRAÇAO ESPONTANEA E RESPOSTAS	
			FISIOLOGICAS AUTOMATICAS. SIMULADOR DE PACIENTE	
			REAL ADULTO CORPO INTEIRO COM SISTEMA WIRELESS 100	
			INTEGRADO PARA SIMULAÇAO EM ALTA FIDELIDADE.	
			CARACTERISTICAS MINIMAS DO SIMULADOR: SISTEMA	
			FISIOLOGICO E FARMALOGICO COMPLETAMENTE	
			INTEGRADO NO SIMILADOR COM RESPOSTAS FISIOLOGICAS	

			AUTOMATICAS PARA CADA INTERVENÇAO,ADMINISTRAÇAO	
			DE DROGAS E COMPLICAÇOES. AS RESPOSTAS	
			FISIOLOGICAS DEVEM VARIAR DE ACORDO COM AS	
			CARACTERISTICAS FISICAS E IDADE DO PACIENTE, ALEMDE	
			NAO SER NECESSARIO DIFERENTES GUIAS PARA	
			CONTROLE DAS VARIAVEIS. - PLATAFORMA	
			EXTREMAMENTE AMIGAVEL, POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇAO	
			E CRIAÇAO DE CENARIO MANUAL, PERMITINDO QUE O	
			INSTRUTOR ALTERAR E FACILMENTE TODOS OS	
			PARAMETROS E CONDIÇOES NO DECORRER DA	
			SIMULAÇAO. 100 WIRELESS, COM SISTEMAS DE FLUIDOS,	
			ELETRICOS E PNEUMATICOS INTERNOS PARA SIMULAÇAO	
			DE SANGRAMENTOS, PULSOS E OUTROS SINAIS VITAIS	
			REALISTICOS. RESPIRAÇAO ESPONTANEA, - SINAIS., COM	
			MACKBOOKE MONITOR.	
			MARCA: CAE MMP-200	
65374	BOM	SIMULADOR	CARDIACA E PULMONAR PROPORCIONA TAMBEM SONS DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			TOSSE, CHORO ENTRE OUTROS DE UMA CRIANÇA DE 4	
			ANOS. OPERA A PARTIR DE UM CONTROLE REMOTO SEM	
			FIO QUE TEM UM METODO SIMPLES LIGAR E SELECIONAR	
			OS SONS QUE VOCE DESEJA EMULAR E EM QUE RITMO. OS	
			SONS SAO EMITIDOS EM 10 PONTOS DE PULMAO E NO	
			CORAÇAO ATRAVES DE ALTO FALANTES E PODEM SER	
			AUSCULTADOS COM QUALQUER ESTETOSCOPIO.	
			MARCA: NASCO PP0002OU.	
65375		SIMULADOR	DE AUSCULTA DE SOPROS CARDIACOS E RUIDOS	Não localizado
			RESPIRATORIOS . ESTE SIMULADOR FACIL DE MANEJAR	
			GERA NAO SO SOPROS CARDIACOS MAS TAMBEM RUIDOS	

			RESPIRATORIOS E TORNA POSSIVEL A SUA DETERMINAÃAO	
			LIGANDO UM DE SEIS DIFERENTES MENUS (EXPLICADO DO	
			SEGUINTE MODO),DOS QUAIS CADA UM ABRANGE 16 TIPOS	
			DIFERENTES DE RUIDOS*. O ARTIGO ABRANGE DUAS	
			EXTREMIDADES EXTERNAS DE CAPTAÃAO DE SONS COM	
			AS QUAIS OS ESTUDANTES PODEM AUSCULTAR OS RUIDOS	
			POR MEIO DE UM ESTETOSCOPIO. A LIGAÃAO DE UNIDADES	
			AUSCULTATORIAS SUPLEMENTARES PERMITE ATE A 15	
			ESTUDANTES DE EFETUAR O EXAME AUSCULTATORIO	
			SIMULTANEAMENTE. COM TUDO ISSO SE	
			PODE LIGAR UM ALTOFALANTE(UMA CAIXA ACUSTICA). O	
			APARELHO DISPOE AINDA DE UM REGULADOR DO VOLUME	
			DOS SONS E DE DOIS DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED)	
			QUE SE ILUMINAM DURANTE A SISTOLE (MENU CARDIACO)	
			RESPECTIVAMENTE DURANTE A EXPIRAÃAO(MENU	
			RESPIRATORIO). O APARELHO E DE FACIL MANUTENÃAO E E	
			ACIONADO ATRAVES DE UMA BATERIA 9 V.* TODOS OS	
			DADOS CONTIDOS NO MENU TRATAM DE..	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W49000..	
65376	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	
			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	
			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	

			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65377	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	
			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	
			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	
			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65378	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	
			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	

			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	
			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65379	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	
			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	
			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	
			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65380	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	

			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	
			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	
			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65381	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA PUNÃAO INTRA VENOSA, MODELO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			MEMBRO SUPERIOR.ESTE BRAÃO DE TREINAMENTO	
			ABSOLUTAMENTE NOVO OFERECE TAMBEM, ALEM DE	
			TODOS OS ACESSOS AS VEIAS PARA A TERAPIA	
			INTRAVENOSA E A SEÃAO DE VEIA, OS PONTOS PARA	
			INJEÃAO INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA.UM AMPLO	
			SISTEMA VASCULAR 8 VEZES RAMIFICADO PERMITE AOS	
			ESTUDANTES O TREINAMENTO DE PUNÃOES VENOSAS EM	
			TODOS OS PONTOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS,	
			INCLUINDO A SUSPENSAO DE INFUSOES E A INTRODUÃAO	
			DE CATETERES PERIFERICOS DE LONGA DURAÃAO. O	
			SISTEMA VENOSO E DE FACIL UTILIZAÃAO, JA QUE TODAS	
			AS VEIAS SAO ABASTECIDAS JUNTAS DE SANGUE	
			ARTIFICIAL A PARTIR DE UMA UNICA BOLSA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44216	
65382	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA INSERÇAO DE CATETER	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			SUBCLAVICO, MODELO MEMBRO TORSO. O TORSO I.V.	
			PERMITE PRATICAR TECNICAS DE ACESSO	

			ENDOVENOSO.ELE FOI DESENHADO ESPECIALMENTE PARA	
			ATENDER AS METAS PRINCIPAIS DE ENSINO DOS	
			PROGRAMAS DE TREINAMENTO.VANTAGENS DO PRODUTO:	
			PERMITE AOS ALUNOS VIVENCIAR OS PROCEDIMENTOS DE	
			FORMA REALISTA. AS AREAS DE ACESSO I.V. SAO	
			SIMULADAS COM ALMOFADAS MACIAS,RECOBERTAS COM	
			PELE REALISTA,SIMULANDO TANTO QUANTO POSSIVEL O	
			TOQUE DA PELE HUMANA AS VEIAS SIMULADAS DENTRO	
			DAS ALMOFADAS PROPORCIONAM A RESISTENCIA	
			NATURAL DURANTE A PUNÇAO E O REFLUXO NATURAL DO	
			SANGUE.QUANDO A AGULHA E RETIRADA, AS VEIAS E A	
			PELE SE FECHAM POR SI, DE MODO QUE O LOCAL DA.	
			MARCA: LAERDAL 090019.	
65383	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE DRENAGEM	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			TORACICA. ESTE MODELO INOVADOR SIMULA NAO SO OS	
			TECIDOS DO CORPO DE MODO ALTAMENTE REALISTA MAS	
			TAMBEM OFERECE UMA ALTERNATIVA A UTILIZAÇAO DE	
			ANIMAIS.UMA CARACTERISTICA UNICA DESTE MODELO E A	
			ESTRUTURA DO TORSO. ELE CONSISTE EM UMA PAREDE	
			TORACICA SUBSTITUIVEL COM AS COSTELAS, QUE SE	
			ENCONTRAM ENVOLTAS DE UMA REPRESENTAÇAO	
			REALISTA DA MUSCULATURA.ESTA PARTE MUSCULAR E	
			SUBSTITUIVEL E PODE SER UTILIZADA PARA ATE 20 A 25	
			INCISOES.ELE SE ENCONTRA NUM RECPTACULO BRANCO	
			EM FORMA DE TORSO, O QUAL E FIRMEMENTE FIXADO E	
			POSSUI FORTES VENTOSAS PARA EVITAR QUALQUER	
			RISCO DE QUE RESVALE AO SER UTILIZADO SOBRE UMA	
			SUPERFICIE DE MESA. O TORSO REPRESENTA UM	

			PACIENTE DEITADO DE COSTAS. ACESSO CIRURGICO	
			LATERAL AO GRANDE PEITORAL PARA FACILITAR O	
			ACESSO, FOI ELIMINADO UM BRAÇO.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W19356.	
65384	BOM	SIMULADOR		ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE ACESSO	
			VENOSO POR CATETER CENTRAL DE INSERÇAO	
			PERIFERICA.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44017.	
			OBS: ESSE SIMULADOR ENCONTRA-SE SEM O ADESIVO DO	
			TOMBAMENTO.	
65385	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE PUNÇAO	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			LOMBAR E ANESTESIA ESPINHAL.ESTE MOLDE ACURADO	
			DA PORÇAO INFERIOR DAS COSTAS COM COLUNA	
			VERTEBRAL E INSERÇAO DE MEDULA ESPINHAL GARANTE	
			UMA RESISTENCIA REALISTA DURANTE A INTRODUÇAO DA	
			AGULHA E A PALPAÇAO EXATA DOS PONTOS DE	
			ORIENTAÇAO ANATOMICOS. O SIMULADOR PODE SER	
			UTILIZADO PARA PRATICAR AS DIFERENTES TECNICAS DE	
			APLICAÇAO DE INJEÇOES NA MEDULA ESPINHAL, INJEÇOES	
			EPIDURAIS, CAUDAIS,SACRAIS E LOMBARES. A COLUNA	
			VERTEBRAL DO MODELO PODE SER ENCHIDA DE AGUA	
			PARA SIMULAR O LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO. O	
			SIMULADOR PODE SER POSICIONADO EM POSIÇAO	

			SENTADA OU DEITADA. A PORÇAO FUNCIONAL DO MODELO	
			ABRANGE A 3a A 5a VERTEBRA LOMBAR (L1 E L12 ESTAO	
			VISIVEIS), ASSIM COMO O OSSO SACRO E O OSSO	
			COCCIGEO. FORNECIDO COM FRASCO PARA LIQUIDOS,	
			CONEXOES E MALETA DE TRANSPORTE.	
			MARCA: NASCO LF01036U.	
65386	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO ACESSO VENOSO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			TORSO AVANÇADO.ESTE MODELO POSSUI CATETERES	
			INTRODUZIDOS NA VEIA SUBCLAVIA DO LADO DIREITO E	
			ESQUERDO E UM SISTEMA PORT- A-CATH (SISTEMA	
			IMPLANTAVEL DE ACESSO VENOSO). AGUA PODE SER	
			PASSADA PELOS DOIS CATETERES. O MODELO ESTA	
			MONTADO SOBRE UM SUPORTE DESMONTAVEL.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W43007.	
65387	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE ACESSO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			VENOSO CENTRAL. DESENHADO PARA A PRATICA DE	
			PUNÃAO VENOSA CENTRAL GUIADA POR ULTRASSOM	
			BEM COMO PUNÃAO EM PONTOS DE REFERENCIA.	
			CARACTERISTICAS:PERMITE AOS ESTUDANTES	
			IDENTIFICAR OS PONTOS DE PUNÃAO ATRAVES DO	
			RECONHECIMENTO DAS ESTRUTURAS PRINCIPAIS.ATRAVES	
			DA INSERÃAO DE UM AGULHA NA VEIA O SANGUE	
			SIMULADO PODERA SER COLETADO COM PRESSAO	
			NEGATIVA SOBRE A SERINGA OS ESTUDANTES PODERAO	
			EXECUTAR A PUNÃAO CENTRAL VENOSA RETORNO DE AR	
			INDICA PUNÃAO INCORRETA NO PULMAO PELO MUITO	
			REALISTA NO TOQUE E EM SUA ESTRUTURA EXTERNA	
			PEÃAS DE REPOSIÃAO DISPONIVEIS PARA OS PONTOS DE	

			PUNÃAO. PUNÃAO VENOSA CENTRAL GUIADA POR	
			ULTRASSOM: COM O USO DE UM APARELHO DE	
			ULTRASSOM O SIMULADOR PERMITE: PUNÃAO VENOSA	
			INTERNA DA JUGULAR PUNÃAO VENOSA SUBCLAVIA.	
			MARCA: KOKEN LM090.	
65388	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE ASPIRAÇAO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			JOELHO. ESTE MODELO ESPECIALIZADO E UTILIZADO PARA	
			TREINAMENTO DA TECNICA DE ASPIRAÇAO DE LIQUIDO	
			SINOVIAL.APRESENTA DESIGN SIMPLIFICADO PARA	
			FACILIDADE DE USO PELE, MUSCULATURA E PATELA (COM	
			ALMOFADA DE GORDURA) DE RETIRADA RAPIDA PARA	
			PERMITIR A TROCA AGIL DO SACO SINOVIAL, SACO	
			SINOVIAL SE CONECTA FACILMENTE COM RESERVATORIO	
			DE LIQUIDO BOLSA DE 1 LITRO DE FLUIDO QUE PERMITE	
			SESSOES TREINAMENTO ININTERRUPTAS PARA GRUPOS	
			MAIORES DE ALUNOS POSTURA E MANIPULAÇAO DO	
			PACIENTE.TECNICAS DE PALPAÇAO IDENTIFICAÇAO DOS	
			PONTOS ANATOMICOS DE REFERENCIA E AREAS	
			DOLOROSAS ASPIRAÇÃO DO LIQUIDO SINOVIAL DA	
			ARTICULAÇAO DO JOELHO A PARTIR DE AMBOS ASPECTOS:	
			LATERAL E MEDIAL.CARACTERISTICAS.	
			MARCA: LIMBS & THINGS 70020	
65389	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE PUNÃAO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			LOMBAR PEDIATRICO. MODELO DE UM RECEM-NASCIDO NA	
			POSIÃAO ADEQUADA PARA O EXERCICIO DA PUNÃAO	
			LOMBAL.POSIÃAO LATERAL.COLUNA VERTEBRAL REALISTA	
			DESCARTAVEL COM MEDULA ESPINHAL,PODE SER	
			PALPADO PARA LOCALIZAR O PONTO DE PUNÃAO.PODE	

			SER PREENCHIDO COM LIQUIDO.	
			MARCA: NASCO LF01000U.	
65390	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			CATETERIZAÇAO VENOSA CENTRAL.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44017.	
65391	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			PUNÇAO VENOSA CENTRAL GUIADA COM PELE REALISTA.	
			MARCA: KOKEN LM090.	
			OBS: SIMULADOR SEM ADESIVO DO TOMBAMENTO	
65392	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO CATETERISMO VESICAL BISSEXUAL.	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			SIMULADOR PARA A CATETERIZAÇAO MASCULINA E	
			FEMININA E CUIDADOS COM OSTOMIAS.ESTE SIMULADOR	
			DOIS EM UM PODE SER UTILIZADO PARA PRATICAR AS	
			SEGUINTES MEDIDAS: CATETERIZAÇAO:OS ORGAOS	
			GENITAIS MASCULINOS E FEMININOS INTERCAMBIAVEIS	
			POSSUEM UMA VALVULA URETRAL MODULAR PARA EVITAR	
			O VAZAMENTO DE LIQUIDOS.CUIDADOS COM OSTOMIAS: 3	
			OSTOMIAS ARTIFICIAIS (COLOSTOMIA	
			TRANSVERSA,ILEOSTOMIA E OSTOMIA SUPRAPUBLICA)	
			PODEM SER DILATADAS PARA PRATICAR PROCEDIMENTOS	
			DE IRRIGAÇAO E APLICAÇAO DE BOLSAS DE OSTOMIA.CADA	
			OSTOMIA ESTA CONECTADA A UM TANQUE INTERNO.	
			FORNECIDO COM BOLSA DE TRANSPORTE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W45068.	

65393	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE MANOBRA DE SONDAGEM NASOGASTRICA E NASOENTERAL. MARCA: 3B SCIENTIFIC W43020. 	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
65394	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE MANOBRA DE SONDAGEM NASOGASTRICA E NASOENTERAL. MARCA: 3B SCIENTIFIC W43020. 	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
65395	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE MANOBRA DE SONDAGEM NASOGASTRICA E NASOENTERAL. MARCA: 3B SCIENTIFIC W43020. 	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
65396	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE MANOBRA DE SONDAGEM NASOGASTRICA E NASOENTERAL. MARCA: 3B SCIENTIFIC W43020. 	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
65397	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE EXAME DO FUNDO DE SACO E COLO UTERINO. ESTE MODELO DE UMA PELVIS FEMININA NATURAL FOI CONCEBIDO PARA APRENDER E PRATICAR AS MEDIDAS DIAGNOSTICAS GINECOLOGICAS ATRAVES DA DEMONSTRAÇAO DE CARACTERISTICAS ANATOMICAS, PALPAÇAO DA PAREDE ABDOMINAL, E DEMONSTRAÇAO DO EXAME COM O	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA

			ESPECULO. O MODELO E FEITO DE UM PLASTICO DE VINIL	
			MACIO E FACIL DE LIMPAR COM UMA TEXTURA	
			SEMELHANTE A DA PELE E POSSUI CARACTERISTICAS	
			ANATOMICAS MUITO REALISTA. FORNECIDO COM AS	
			SEGUINTES PEÇAS SUBSTITUIVEIS: COLO UTERINO E	
			UTERO NORMAIS PARA A DEMONSTRAÇAO DA INSERÇAO E	
			REMOÇAO DE UM DISPOSITIVO INTRA-UTERINO	
			PARACERVIX NORMAL , COLO UTERINO COM POLIPO NO	
			CANAL CERVICAL , - COLO UTERINO COM	
			CARACTERISTICAS DE PROLAPSO UTERINO , COLO	
			UTERINO COM NEOPLASIA (CARCINOMA) UTERO NA 10a	
			SEMANA GESTACIONAL , 2 ADNEXE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44535.	
65398	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE EXAME DA	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			PROSTATA.ESTE SIMULADOR E COMPOSTO POR UM	
			ABDOMEN MASCULINO E 4 GLANDULAS PROSTATICAS	
			DIFERENTES SUBSTITUIVEIS A SEREM UTILIZADAS PARA	
			PRATICAR O DIAGNOSTICO POR MEIO DO EXAME RETAL. AS	
			4 PROSTATAS APRESENTAM AS SEGUINTES	
			CARACTERISTICAS: TUMOR BENIGNO, LEVEMENTE	
			AMPLIADO, SEM CONDIÇAO PATOLOGICA ESTAGIO INICIAL	
			DE UM CARCINOMA, HA UM CAROÇO INDIVIDUAL FIXO E	
			PALPAVEL NO QUADRANTE SUPERIOR REPRESENTAÇAO DA	
			PROLIFERAÇAO DO CARCINOMA, O PEQUENO CAROÇO	
			CRESCEU E DESENVOLVEU-SE EM UMA MASSA EXTERNA	
			COMPACTA NA SUPERFICIE DA PROSTATA. A PROSTATA	
			INTEIRA ESTA AFETADA PELO CARCINOMA APRESENTA UMA	
			TEXTURA DURA E IRREGULAR FORNECIDO COM	

			LUBRIFICANTE, PRODUTO DE LIMPEZA E MALETA DE	
			TRANSPORTE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44014.	
65399	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE EXAME	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			TESTICULOS. O AUTO-EXAME DOS TESTICULOS E TAO	
			IMPORTANTE PARA A DETECÇAO DE TUMORES COMO O	
			AUTO-EXAME DAS MAMAS NA MULHER . ESTE SIMULADOR	
			EXTREMAMENTE REALISTA POSSUI UMA PELE ARTIFICIAL	
			MACIA E FINA COM ESTRUTURAS INTERNAS DELICADAS E	
			QUATRO TUMORES ARTIFICIAIS. TRATA-SE DE UM MODELO	
			IDEAL PARA ENSINAR E APRENDER OS METODOS DE	
			PALPAÇAO CORRETOS. PARA MANTER A TEXTURA MACIA E	
			REALISTA DA PELE ARTIFICIAL DEVE SER APLICADO	
			REGULARMENTE UM POUCO DE TALCO.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W44112	
65400	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO EM	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			SISTEMA GINECOLOGICO. 51 SISTEMA DE TREINAMENTO	
			GINECOLOGICO, PARA TREINO E PRATICA DE TECNICAS DE	
			DIAGNOSTICO: - FIBROIDE INTRAMUSCULAR, - MIOMAS: -	
			CISTO OVARIO, - HDROSSALPINGE EM SILICONE ESPECIAL.	
			SIMULA CONDIÇOES NORMAIS OU CONDIÇOES COM	
			PATOLOGIAS, TAIS COMO: UTERO NORMAL (TAMBEM	
			USADO PARA RETROFLEXAO), - UTERO COM GRAVIDEZ	
			INICIAL, - FIBROIDE I (TUNICA MUSCULAR), - FIBROIDE II	
			(ENDOMETRIO), - CISTO OVARIO I (TAMANHO DE UMA BOLA	
			DE PING-PONG), - CISTO OVARIO II (DO TAMANHO DE UMA	
			BOLA DE TENIS), - HIDROSSALPINGEAS DIMENSOES DOS	
			CISTOS E DO MIOMAS PODEM SER MODIFICADOS COM UMA	

			BOMBA DE AR. COM ESTE SISTEMA O UTILIZADOR PODE	
			APLICAR OS SEGUINTES TIPOS DE EXAMES: -	
			VAGINOSCOPIA (INCLUI ESPECULO VAGINAL), - EXAMES	
			INTERNOS COM OU SEM PATOLOGIAS, - EXAME RECTAL	
			COM OU SEM PATOLOGIAS, - ENDOSCOPIA, - RECOLHA DE	
			TECIDO (INCLUI EQUIPAMENTO NECESSARIO).	
			MARCA: KOKEN LM050.	
65401	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			PARTO COM PERINEO DE EPISIOTOMIA. ESTE SIMULADOR	
			DE PARTO VERSATIL REPRESENTA A CAVIDADE PELVICA	
			COM PONTOS DE ORIENTAÇAO ANATOMICOS RELEVANTES	
			E CONTORNOS DAS ESTRUTURAS OSSEAS DA PELVE	
			COLORIDOS. O MODELO PERMITE PRATICAR O MANEJO	
			INTRA-UTERINO E OFERECE AS SEGUINTES	
			POSSIBILIDADES PARA PRATICAR MEDIDAS PRE-NATAIS,	
			INTRAPARTO E POS-PARTO: PALPAÇAO DAS FONTANELAS,	
			DA COLUNA VERTEBRAL, DOS JOELHOS E DOS COTOVELOS	
			DO FETO. APRESENTAÇAO DE VERTICE PARTO VAGINAL	
			NORMAL, PARTO COM APRESENTAÇAO DE NADEGAS	
			COMPLETA, PODALICA, PARTO COM CIRURGIA CESARIANA.	
			APRESENTAÇAO DE VERTICE E DE NADEGAS EM PARTOS	
			MULTIPLOS. DEMONSTRAÇAO DE PLACENTA PREVIA TOTAL,	
			PARCIAL E MARGINAL PROLAPSO DO CORDAO UMBILICAL.	
			MANOBRA DE RITGEN.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W45025	
65402	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			PARTO COM MONITORIZAÇAO DE FORÇA.SIMULADOR DE	
			PARTO PROMPT FORCEPS COM MONITORIZAÇAO DE FORÇA	

			BASICA PERMITE SIMULAÇAO DE DISTOCIA DE OMBRO.	
			ESTA VERSAO DE SIMULADOR DE PARTO PROMPT INCLUI O	
			BEBÊ COM MONITORIZAÇAO DE FORÇA QUE DISPOES DE	
			UM DISPOSITIVO QUE PERMITE MEDIR A FORÇA APLICADA	
			AO BEBÊ DURANTE O PARTO. NORMAL COM PLACENTA E	
			CORDAO UMBILICAL SEPARADOS E PERMITE OS SEGUINTES	
			PROCEDIMENTOS: PARTO NORMAL , PARTO EM POSIÇAO	
			DE QUATRO PONTOS, PARTO A VACUO, GESTAO DE	
			DISTOCIA DE OMBRO, PARTOS FORCEPS: EXTRAÇAO COM	
			TRAÇAO E COM ROTAÇAO, EXTRAÇAO DA PLACENTA	
			CARACTERISTICAS: BEBÊ COM CORPO COMPLETAMENTE	
			ARTICULADO - SISTEMA DE MONITORIZAÇAO DE FORÇAS	
			QUE INCLUI UM PACOTE DE SOFTWARES PARA VISUALIZAR,	
			MEDIR E GRAVAR DADOS SIMULTANEAMENTE. PESO 2,3 kg,	
			FONTANELAS PALPAVEIS E LINHAS DE SUTURA CLAVICULAS	
			E ESCAPULAS PALPAVEIS, PLACENTA COM CORDAO	
			DESMONTAVEL. MAE COM PERNAS COMPLETAMENTE	
			MOVEIS.	
			MARCA: LIMBS & THINGS 80005.	
65403	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMETNO DE	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			DILATAÇAO CERVICAL.SIMULADOR DE EXAME CERVICAL E	
			PARTO. ESTE MODELO E COMPOSTO POR 6 BLOCOS	
			PELVICOS E E EXTREMAMENTE VALIOSO PARA	
			DEMONSTRAR E PRATICAR O EXAME CERVICAL ANTES DO	
			PARTO. REPRESENTAÇAO DETALHADA DA ESTRUTURA E	
			DENSIDADE DO TECIDO INTERNO E DIMENSAO	
			ANATOMICAMENTE ACURADA, PROPORCIONANDO	
			CONDIÇOES MUITO REALISTAS. O MODELO REPRESENTA	

			AS SEGUINTES FASES: 1a FASE (SEM DILATAÇAO,SEM	
			APAGAMENTO), 2a FASE (DILATAÇAO DE 2 cm, 50 DE	
			APAGAMENTO), 3a FASE (DILATAÇAO DE 2cm,	
			APAGAMENTO COMPLETO), 4a FASE (DILATAÇAO DE 5cm,	
			APAGAMENTO COMPLETO) 5a FASE (DILATAÇAO DE	
			7cm,APAGAMENTO COMPLETO) 6a FASE (DILATAÇAO DE	
			9cm, APAGAMENTO COMPLETO). FORNECIDO COM MALETA	
65404	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO EM	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			SIGMOIDOSCOPIA. TRATA-SE DE UM MOLDE ACURADO DE	
			UM INTESTINO GROSSO COM SIGMOIDE, FLEXURAS	
			ESQUERDA E DIREITA DO COLON E AS ESTRUTURAS	
			INTERNAS DO COLON ASCENDENTE E DO CECO. O	
			SIMULADOR REPRESENTA 12 ESTRUTURAS PATOLOGICAS	
			DIFERENTES, ENTRE OUTRAS: POLIPO SESSIL, POLIPO	
			PEDUNCULADO POLIPO HIPERPLASTICO LESOES	
			CANCEROAS. O MODELO PERMITE PRATICAR AS TECNICAS	
			DE EXAME E DE IMAGEM. FORNECIDO COM SUPORTE,	
			LUBRIFICANTE E MALETA DE TRANSPORTE. MEDIDAS: 47 X	
			17 X 66cm.	
			MARCA: NASCO LF01084U	
65405	BOM	MODELOS	ANTOMICO PARA FINS DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			FINALIDADE SIMULADOR DE EXAME MAMAS CANCER PARA	
			INSPEÇAO PRECISA. MOLDE ORIGINAL DE UM TORX	
			FEMININO COM MAMAS DE TAMANHO MEDIO, COM	
			ASPECTOS FISICOS MUITO REALISTAS PARA APRENDER E	
			PRATICAR O EXAME DAS MAMAS. FEITO DE SILICONE DE	
			ALTA QUALIDADE REPRESENTA DETALHADAMENTE AS	
			ESTRUTURAS MAIS DELICADAS DA PELE APRESENTA UMA	

			EXAME DAS MAMAS EM POSIÇAO ERETA E DEITADA	
			ALTERAÇOES PROVAVELMENTE BENIGNAS E MALIGNAS DE	
			DIFERENTES FORMAS E ESTAGIOS - 2 ALTERAÇOES	
			PROVAVELMENTE BENIGNAS, - 4 ALTERAÇOES	
			PROVAVELMENTE MALIGNAS, - 2 ALTERAÇOES TIPICAS	
			INCLUI O QUADRO INFORMATIVO AS MAMAS. O MODELO E	
			FORNECIDO COM TALCO, CINTOS DE FIXAÇAO, SUPORTE E	
			MALA DE TRANSPORTE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC L50.	
65406	BOM	MODELOS		ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,	
			FINALIDADE MANEJO INTRA-UTERINO, PRE-NATAIS,	
			INTRAPARTO, POS, TIPO CAVIDA PELVICA COM VERTICES E	
			NADEGAS, APLICAÇAO SIMULAÇAO PARTO NORMAL E	
			CESARIANA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLACENTA,	
			PROLAPSO, CORDAO UMBILICAL, MANOBRA RITGEN,	
			OUTROS COMPONENTES REVESTIMENTO ABDOMEN, FETO	
			MASCULINO E FEMININO, ACESSORIOS MALETA	
			TRANSPORTE.	
			MARCA: 3B SCIENTIFIC W45025.	
			OBS: SIMULADOR SEM A ETIQUETA DO TOMBAMENTO	
65407	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE PALPAÇAO DE	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			UTERO FUNDUS PUERPERAL.CARACTERISTICAS: - ESTE	
			SIMULADOR FOI DESENVOLVIDO PARA O TREINAMENTO	
			REALISTA DE PALPAÇAO DE UTERO, FABRICADO A PARTIR	
			DE MATERIAL ESPECIAL NA REGIAO ABDOMINAL PERMITE A	

			IDENTIFICAÇAO MUITO REALIESTA DO FUNDO DO UTERO, -	
			PERMITE EXAME DOS GRANDES LABIOS DA VULVA, BEM	
			COMO PROCTOPTOSIA. VULVA LAVAVEL - PERMITE PRATICA	
			DE TROCA DE ROUPAS INTIMAS, LENÇOIS, E	
			GAZES/CURATIVOS COM SENSAÇAO E AMBIENTAÇAO	
			REALISTA - PERMITE A TROCA DOS 4 UTEROS EM	
			DIFERENTES CONDIÇOES PARA PALPAÇAO REALISTA	
			METODO PARA TROCA DOS DIFERENTES UTEROS: -	
			APLIQUE TALCO A CAVIDADE ABDOMINAL DO UTERO -	
			POSICIONE O UTERO ESCOLHIDO CONFORME IMAGEM AO	
			LADO PERMITE AS SEGUINTES PRATICAS: - EXAME DO	
			UTERO PARA IDENTIFICAÇAO DE CONDIÇAO BOA OU MA (	
			BOA OU MA NO PRIMEIRO DIA) - MEDIDAS E PALPAÇAO DO	
			FUNDUS UTERI (TROCA ATRAVES DA SEMANA: PRIMEIRO	
			DIA, TERCEIRO DIA E QUINTO DIA) - L.	
			MARCA: KOKEN LM055.	
65408	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE ENEMA	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			AVANÇADO. SIMULADOR DE REMOÇAO DE FEZES E	
			INTRODUÇAO DE GLICERINA ENEMA DE GLICERINA. NO	
			CAMPO DA EDUCAÇAO DE ENFERMAGEM O TREINAMENTO	
			DE REMOÇAO DE FEZES E INJEÇAO DE GLICERINA (ENEMA	
			DE GLICERINA) PODE SER PRATICADO COM MUITO	
			REALISMO NESTE SIMULADOR QUE PERMITE TREINAMENTO	
			REALISTA DESSAS PRATICAS. PRATICAS: REMOÇAO DE	
			FEZES: ESTE MODELO SIMULA SITUAÇOES DE PESSOAS	
			ACAMADAS OU DE IDADE COM DIFICULDADES PARA	
			ELIMINAR AS FEZES POR SI SOS. A REMOÇAO DE	
			FEZES(SIMULADAS) DO RETO PODE SER PRATICADA	

			ATRAVES DE INSERÇAO DIGITAL. AS FEZES ARTIFICIAIS SAO	
			INSERIDAS NO INTESTINO E REMOVIDAS PELO ANUS	
			ATRAVES DAS TECNICAS APROPRIADAS. INTRODUÇAO DE	
			GLICERINA (ENEMA DE GLICERINA). ESTE PROCEDIMENTO	
			DE INTRODUÇAO DE GLICERINA PODE SER PRATICADO EM	
			SITUAÇOES DE PESSOAS ACAMADAS OU COM IDOSOS EM	
			DIFICULDADES PARA EVACUAR NATURALMENTE.UM FLUIDO	
			DE GLICERINA PODE SER INJETADO (FICA	
			POSICIONADO A PARTIR DE UM TUBO DE DRENAGEM AO	
			LADO.	
			MARCA: KOKEN LM068.	
65409	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO .SIMULADOR DE PARTO CORPO INTEIRO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			NOELLE AVANÇADO COM BEBÊ PARA RCP. ESTE	
			SIMULADOR TOTALMENTE ARTICULAVEL E A MELHOR E	
			MAIS COMPLETA OPÇAO DE TREINAMENTO DE PARTO.	
			REPRESENTA UM MULHER ADULTA EM TAMANHO NATURAL	
			E FOI CONCEBIDO PARA POSSIBILITAR A PRATICA DAS	
			MEDIDAS: PRE NATAL, INTRAPARTO E POS PARTO, BEM	
			COMO, TREINAMENTO DE ASSISTENCIA IMEDIATA A MAE E	
			AO RECEM NASCIDO APOS O PARTO. CARACTERISTICAS: -	
			ARTICULAÇOES MOVEIS - VIA AEREA ENTUBAVEL COM	
			EXPANSAO DO TORAX - BRAÇO PARA INJEÇAO VENOSA	
			(FLUIDOS/MEDICAMENTOS) - COBERTURA DO ESTOMAGO	
			REMOVIVEL - PERMITE PRATICA DE MANOBRAS DE	
			LEOPOLD - MULTIPLOS SONS DO CORAÇAO DO FETO -	
			SISTEMA DE NASCIMENTO AUTOMATICO - MEDIDA DA	
			CABEÇA DESCENDENTE E DILATAÇAO CERVICAL -	
			MULTIPLAS LOCALIZAÇOES DA PLACENTA - CERVICES	

			DILATADOS MULTIPLOS - INSERÇAO DE VULVA PARA	
			PRATICA DE SUTURAS POS PARTO - 1 - BEBÊ RECEM	
			NASCIDO ARITICULADO COM PLACENTA - 1 BEBÊ PARA	
			PRATICA DE RCP COM V	
			MARCA: GAUMARD S550.	
65432	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO DE	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			ORDENHA MANUAL EM MULHERES LACTANTES.MOLDE	
			ORIGINAL DE UM TORAX FEMININO COM MAMAS DE	
			TAMANHO MEDIO, COM ASPECTOS FISICOS MUITO	
			REALISTAS PARA APRENDER E PRATICAR O EXAME DAS	
			MAMAS. FEITO DE SILICONE OU SIMILAR DE IDADE	
			SUPERIOR REPRESENTA DETALHADAMENTE MESMO AS	
			ESTRUTURAS MAIS DELICADAS DA PELE APRESENTA UMA	
			MAMAS. FEITO DE SILICONE OU SIMILAR DE IDADE	
			SUPERIOR REPRESENTA DETALHADAMENTE MESMO AS	
			ESTRUTURAS MAIS DELICADAS DA PELE APRESENTA UMA	
			DIFERENTES FORMAS E ESTAGIOS. O MODELO E	
			FORNECIDO COM TALCO,CINTOS DE FIXAÇAO E SUPORTE.	
			MARCA: LIFEMODEL.	
65433	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO EM	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			TRAQUEOSTOMIA.TRATA-SE DE MODELO EXCELENTE PARA	
			PRATICAR MEDIDAS DE SUCÇAO ORAL,NASOFARINGEA,	
			NASOTRAQUEAL E TRAQUEAL, BEM COMO A INSUFLAÇAO	
			DO MANQUITO (CUFF), A LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DO	
			ESTOMA E A TROCA DE CURATIVOS OU BANDAGENS.	
			ATRAVES DE UMA PORÇAO TRANSPARENTE NO PESCOÇO	
			DO MODELO E POSSIVEL OBSERVAR O CATETER DE	
			SUCÇAO E O TUBO DE VENTILAÇAO ARTIFICIAL. ATRAVES	

			DO LADO INFERIOR DO SIMULADOR E POSSIVEL	
			CONTROLAR O POSICIONAMENTO DO CATETER DE SUCÇAO	
			NO BRONQUIO DIREITO (VISIVEL) OU ESQUERDO	
			(INVISIVEL).	
			MARCA: NASCO.	
65434	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO AVANÇADO PARA TREINAMENTO EM	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			PNEUMOTORAX.O MODELO OFERECE A POSSIBILIDADE DE	
			PUNÇAO E TORACOTOMIA NO SEGUNDO INTERCOSTAL NA	
			AREA DA LINHA MEDIOCLAVICULAR E NO QUINTO ESPAÇO	
			INTERCOSTAL NA AREA DA LINHA AXILAR MEDIA.TRATA-SE	
			DE UM OTIMO MODELO PARA DEMONSTRAÇAO DA	
			INTRODUÇAO CORRETA DE AGULHAS PARA ALIVIAR A	
			PRESSAO NO TORAX DO ACIDENTADO. O MODELO E	
			FORNECIDO COM UMA BOMBA DE PE,ESPAÇOS PLEURAIS E	
			UMA BOLSA DE TRANSPORTE, SEM A AGULHA DE PUNÇAO.	
			MARCA: SIMULAIDS.	
65435	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			GERENCIAMENTO DE VIAS AREAS DIFICIES. SIMULADOR	
			CABEÇA ADULTO AVANÇADA PARA TREINAMENTO DE	
			ENTUBAÇAO ADULTO COM ANATOMIA REALISTA. PERMITE	
			VISUALIZAR CLARAMENTE O SACO ALVEOLAR, ARVORE	
			BRONQUIAL E ESTRUTURAS FLEXIVEIS DE VASOS	
			SANGUINEOS DOS PULMOES SECCIONADOS CRUZADOS E	
			EXPOSTOS ATE O BRONQUIO PRINCIPAL INTERNO E OS	
			ESPAÇOS FARINGEOS ORAIS E NASAIS. POSSUI VIAS	
			AEREAS COMPLICADAS POR DENTES QUEBRADOS, ADEMAS	
			LINGUAIS E ESPAMOS LARINGEOS. O ESTOMAGO	
			ANATOMICO INCHA COM ENTUBAÇAO ESOFAGICA OU	

			EXCESSO DE PRESSAO DURANTE RESPIRAÇAO DE	
			EMERGENCIA, ALEM DO RECURSO DE VOMITOS DESTE	
			MANEQUIM FAZEM COM QUE ESTE SIMULADOR SEJA UMA	
			FERRAMENTA EXCEPCIONAL PARA O TREINAMENTO E	
			GERENCIAMENTO DAS VIAS AEREAS. ACOMPANHA: BOLSA	
			DE TRANSPORTE,LUBRIFICANTE,PULMAO E ESTOMAGO DE	
			REPOSIÇAO E INTRUÇAO DE USO.	
			MARCA: SIMULAIDS	
65436	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO DE GERECIAMENTO	Laboratório de Técnicas Cirúrgicas
			DE VIAS AEREAS E ENTUBAÇAO. COM ESTA UNIDADE,	
			PODERA EXERCITAR PROCEDIMENTOS E HABILIDADES DE	
			INTUBAÇAO,INCLUSIVE CONHECIMENTO E	
			RECONHECIMENTO DE ANATOMIA, INTUBAÇAO	
			ENDOTRAQUEAL, INTUBAÇAO NASOTRAQUEAL, USO DE	
			TUBOS DE APOIO PARA CASOS DE EMERGENCIA EM VIAS	
			AEREAS NO LOCAL, COMO OS LMAs E O COM BITUBE,	
			FIXAÇAO E SUCÇAO, E MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES.	
			SAO INCLUIDOS UMA MALETA MALEAVEL, LUBRIFICANTE E	
			INSTRUÇOES DE USO.	
			MARCA: NASCO.	
65437	BOM	SIMULADOR	DE USO DIDATICO PARA TREINAMENTO EM TRAUMATISMO	ALMOXARIFADO DO LAB. DE FISIOLOGIA
			CRANIO ENCEFALICO.	
			MARCA: LAERDAL.	

Apêndice 4 – Questionário do plano de acompanhamento de egressos

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Parte I – Dados de Identificação

Caracterização dos egressos

Data de nascimento: / / Sexo: [ ] F [ ]M

Estado Civil: Nº de filhos: ___

Faixa Etária do egresso: - Entre 21 e 25 anos [ ]
- Entre 26 e 30 anos [ ]
- 31 anos e acima [ ]

Você: - concluiu o curso de Graduação em Medicina [ ]
- desistiu / abandonou o curso [ ]
- foi transferido(a) [ ]

Ano de desligamento do Curso: ___

Tempo utilizado para a conclusão do Curso, em semestres:_____

Qual o seu conhecimento de línguas estrangeiras?

-Inglês: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Espanhol: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Francês: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Outras: Qual?_____[ ] lê [ ] escreve [ ]fala

Ao concluir o Curso de Medicina, cursou pós-graduação?

[ ] Residência 1. Qual_____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ] Especialização 2. Qual_____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ] Especialização 3.Qual _____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ] Especialização 4. Qual _____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ] Mestrado. Área_____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ]Doutorado.Área_____

Instituição_____Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

[ ] Não fez nenhum curso.

[ ] Outros. Especificar:Tipo_____Área_____,

Instituição__Em Curso [ ] Ano de Conclusão _____

Trabalha atualmente? [ ] Sim [ ] Não

Em caso afirmativo, responda

Emprego 1

Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar _____

[] UBS [ ] CAPS [ ]PSF

[] Hospital [ ] Assistência domiciliar []Laboratório

[ ]Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior

[ ] Outro_____

Há quanto tempo nesta instituição:_____data de ingresso__/___/_____

Cargo que ocupa_____

Salário/renda mensal:_____(em reais)

Emprego 2[ ] Sim [ ] Não

Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar _____

[] UBS [ ] CAPS [ ]PSF

[] Hospital [ ] Assistência domiciliar []Laboratório

[ ]Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior

[ ] Outro_____Há quanto tempo nesta instituição:__data de ingresso __/__/ _____

Cargo que ocupa_____

Salário/renda mensal:_____(em reais)

Emprego 3[ ] Sim [ ] Não

Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar

_____

[] UBS [ ] CAPS [ ]PSF

[] Hospital [ ] Assistência domiciliar []Laboratório

[ ]Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior

[ ] Outro_____Há quanto tempo nesta instituição: __data de ingresso __/__/_

Cargo que ocupa_____

Salário/renda mensal:_____(em reais)

Aponte três áreas de interesse na formação em pós-graduação – especialização:

1-_____

2-_____

3-_____

Parte II – Perguntas

1) A formação na Medicina/UNIR contribuiu para a sua inserção no mercado de trabalho? [ ]Sim [ ]Não

2) Se SIM, em que aspectos a formação como médico na UNIR contribuiu para a sua inserção no mundo/mercado de trabalho?

3) O que não foi abordado no curso durante a sua formação na UNIR que dificultou a sua inserção e/ou permanência no mundo/mercado de trabalho?

4) Para a sua inserção e permanência no mundo do trabalho, quais competências foram requeridas? Assinale sim ou não para cada alternativa abaixo.

Domínio de conhecimento técnico-científico [ ] Sim [ ] Não

Tomada de decisões [ ] Sim [ ] Não

Comunicação [ ] Sim [ ] Não

Liderança [ ] Sim [ ] Não

Administração [ ] Sim [ ] Não

Educação de equipes [ ] Sim [ ] Não

Relacionamento interpessoal [ ] Sim [ ] Não

Pensamento / visão crítico-reflexivo [ ] Sim [ ] Não

Conhecimentos interdisciplinares [ ] Sim [ ] Não

Ética [ ] Sim [ ] Não

Outras. Quais?_____

5) Estas competências foram desenvolvidas durante a graduação? Assinale as opções Sim ou Não ou Em parte para as alternativas abaixo e Justifique-as.
Domínio de conhecimento técnico-científico [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Tomada de decisões [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Comunicação [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Liderança [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Administração [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Educação de equipes [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Relacionamento interpessoal [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Pensamento / visão crítico-reflexivo [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Conhecimentos interdisciplinares [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Ética [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte

Justifique:_____

Outras. Quais?_____

Justifique: _____

6) Que sugestões você daria para:
- Formação de futuros médicos?
- Cursos de pós-graduação Latu Sensu?
- Cursos de pós-graduação Strictu Sensu?

Apêndice 5 – Requerimento de atividades complementares e de extensão

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Núcleo de Saúde Departamento de Medicina

Eu_____, matrícula_____, acadêmico(a) do curso de Medicina, solicito a validação de_____horas[1] das *Atividades Complementares e de Extensão (ACE)* por mim realizadas. Entrego em anexo a este documento cópias dos certificados comprobatórios.

Obs.: 1) Entregar os certificados paginados sequencialmente. 2) Mínimo de 200 horas de ACE como requisito para a integralização curricular.

Nº da página	Atividade	Participação	Local	Período	Carga Horária	Parecer do professor tutor	
						Deferido	Indeferido

Professor tutor responsável pela análise das ACE Data:

[1] Total de horas solicitadas pelo aluno

Apêndice 6 – Instrumento de avaliação – internato

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MEDICINA

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO

DISCIPLINA: _____ LOCAL DE ESTÁGIO:_____

ALUNO/A: _____

PROFESSOR(ES): _____ NOTA : _____

OBS: cada aspecto deve ser pontuado no valor de 0 (zero) a 10 (dez). A soma dos aspectos será de 0 (zero) a 100 (cem)

ASPECTOS A AVALIAR		PONTOS
	ÁREA COGNITIVA – CONHECIMENTOS	
	Argumentação com fundamentação científica	
	Correção, atualização e pertinência das respostas dadas	
	Facilidade de aprendizado	
	ÁREA AFETIVA – ATITUDES E COMPORTAMENTO	
	Comportamento ético profissional	
	Assiduidade, pontualidade e cumprimento de prazos	
	Relacionamento respeitoso e discreto com usuários, colegas, equipe e instituição de estágio	
	ÁREA PSICOMOTORA – HABILIDADES	
	Identificação de problemas de saúde ou estabelecimento de diagnósticos pertinentes	
	Execução de técnicas e manobras adequadas e com prontidão	
	Elaboração de evoluções e prescrições completas e pertinentes	
	Planejamento de tarefas com estabelecimento de prioridades	

Observações:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Apêndice 7 – Ementas, objetivos e bibliografia das disciplinas optativas

1) Língua Portuguesa (60 horas – 3 créditos)

EMENTA:

Leitura e produção de textos técnicos e literários. Tipologia textual. Unidade , coesão e coerência textual. Argumentação. Revisão gramatical, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência e colocação. A disciplina oportunizará o conhecimento da dinamicidade da língua, além da compreensão das diferentes variantes linguísticas, como também, a percepção do padrão culto dentro dos níveis da linguagem.

OBJETIVOS:

Desenvolver no aluno o sentido da língua como um processo interativo através da leitura e escrita de textos, conciliando as análises internas e externas dos mesmos, enfatizando correção, clareza e criticidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABREU, A. S. Curso de redação. São Paulo: Ática, 1997.
KOCH, I. V. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1987.
FAUSTTICH, E. L. Como ler, entender e redigir um texto. 9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1994.
GALVES, C. O Texto: leitura e escrita. Campinas: Pontes, 1998.
KOCH, I. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo. São Paulo: Cortez, 2002.
FRANCO, C. A. X.; TERRA, C. Prática de texto. Rio de Janeiro: Vozes, 1992.
TEZZA, C.; FARACO, C. A. Oficina de texto. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

2) LIBRAS (60 horas – 3 créditos)

EMENTA:

Aspectos clínicos, educacional e sócio antropológicos da surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Noções de variação. Pratica da Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.

OBJETIVOS:

Proporcionar uma inserção básica dos alunos nos aspectos culturais e linguísticos das pessoas surdas, enfatizando seu modo peculiar de comunicação. Pretende-se que esta discussão seja feita a partir do referencial teórico proposto, mas principalmente dos conhecimentos práticos adquiridos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Edusp, v.I e II, 2001.

FELIPE, Tania. Libras em Contexto. Rio de Janeiro: MEC, 2007.

QUADROS, Ronice & KARNOPP, Lodenir. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. ArtMed: Porto Alegre, 2004.

FERREIRA-BRITO, Lucinda. "Língua Brasileira de Sinais – Libras". In: Brasil, Secretaria de Educação Especial – FERREIRA-BRITO, Lucinda et al (orgs). Brasília: SEESP. 1997. V. III. (Série Atualidade pedagógicas nº 4)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SÁ, Nídia Limeira. Cultura, Poder e Educação de Surdos. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2002.

STROBEL, Karen. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 2008.

SKLIAR, Carlos. La educación de los sordos: una reconstrución histórica, cognitiva y pedagógica. Mendozza, República Argentina: EDIUNC, 1977.

LABORIT, Emmanuelle. O voo da gaivota. Tradução de Lelita Oliveira. São Paulo/SP: Ed. Best Seller Círculo do livro, 1994.

3) HOMEOSTASIA DOS FLUIDOS CORPÓREOS (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Estudo da homeostasia, do compartimento de fluídos orgânicos

OBJETIVOS:

Estudar os mecanismos homeostáticos gerais dos líquidos corpóreos, como suas interdependências e as interrelações da fisiologia com a terapêutica fornecendo informações sobre os mecanismos fisiopatológicos gerais de interesse na formação do médico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVERTHORN, D. U. *Fisiologia Humana - uma abordagem integrada*, 5a ed., Ed. Artmed, RS. ISBN 9788536322841, 2010) .

HALL, J. E. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica*, 12a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN: 978-85-352-3735-1, 2011.

FOX, S. I. - Human Physiology 12th ed., Mac Graw Hill (2011).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COSTANZO, L. S. *Fisiologia*, 4a ed., Ed., Elsevier, Rio de Janeiro. ISBN-10:85-352-3894-8, 2011.

BERNE, R. M., LEVY, M. N., KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. *Fisiologia*, 6a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN-10: 9788535230574. 2009.

Stevens, Alan & Romrell, L.J.; Histologia Humana – Editora Manole. 7ª edição São Paulo 2001

Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

4) INGLÊS INSTRUMENTAL (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:

Estratégias de leitura. Técnicas de leituras. Estratégias de vocabulário.

OBJETIVOS:

Trabalhar o ensino da Língua Inglesa buscando despertar o interesse por uma segunda Língua, através de leituras de textos direcionados ao respectivo curso. Além disso, proporcionar conhecimento na Língua Inglesa; valorizar o estudo de uma segunda Língua; incentivá-los a pesquisa para um estudo mais elevado na sua respectiva área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALLIANDRO, H. Dicionário Escolar Inglês Português. Ao livro Técnico, RJ 1995.

BERLITZ, CHARLES. Inglês passo a passo. Campina/SP: MARTINS FONTES, 2000.

GAIL, B. Inglês para leigos. São Paulo: ALTA BOOKS, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MCKAY, S. L. Teaching English as an International Language. Oxford. 2002.

TAYLOR, J. Gramática Delti da Língua Inglesa. Ao Livro Técnico, RJ. 1995.

SCHUMACHER, Cristina. Pílulas de Inglês. São Paulo: Editora campus.

SILVA, J. A. de C.; GARRIDO, M. L.; BARRETO, T. P. Inglês Instrumental: Leitura e Compreensão de Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA. 1994.

5) CIÊNCIAS HUMANAS (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:
Disciplinas cursadas com autorização do NDE em outros cursos da UNIR, classificadas na área das humanidades.

OBJETIVOS:
Propiciar a integração inter-cursos através do estímulo a frequenta diferentes disciplinas em diferentes cursos de graduação.

BIBLIOGRAFIA:
A depender das disciplinas escolhidas

6) CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)
EMENTA:
Disciplinas cursadas, com autorização do NDE, em outros cursos da UNIR, classificadas na área das ciências sociais aplicadas.

OBJETIVOS:
Propiciar a integração inter-cursos através do estímulo a frequenta diferentes disciplinas em diferentes cursos de graduação.

BIBLIOGRAFIA:
A depender das disciplinas escolhidas

7) CIÊNCIAS DA SAÚDE

EMENTA:

Disciplinas cursadas, com autorização do NDE, em outros cursos da UNIR, classificadas na área das ciências da saúde.

OBJETIVOS:

Propiciar a integração inter-cursos através do estímulo a frequenta diferentes disciplinas em diferentes cursos de graduação.

BIBLIOGRAFIA:

A depender das disciplinas escolhidas

8) CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

EMENTA:

Disciplinas cursadas, com autorização do NDE, em outros cursos da UNIR, classificadas na área das ciências exatas e da terra.

OBJETIVOS:

Propiciar a integração inter-cursos através do estímulo a frequenta diferentes disciplinas em diferentes cursos de graduação.

BIBLIOGRAFIA:

A depender das disciplinas escolhidas

9) FERRAMENTAS MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

EMENTA:
Aplicação das técnicas de biologia molecular no diagnóstico laboratorial; Aulas teórico-práticas das diversas técnicas de biologia molecular (Extração de ácidos Nucleicos, PCR e Eletrofrorese, Pirosequenciamento, Análise de sequências e Eletroforese de Proteínas).

OBJETIVOS:
Propiciar aos alunos oportunidades de aprofundamento nas técnicas moleculares aplicadas ao diagnóstico laboratorial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Burtis, C.A.; Ashwood, E.R.; Bruns, D.E. Tietz Fundamentos de Química Clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª ed. Barueri, SP: Manole, 2008.

Erichsen, E.S.; Viana, L.G.; Faria, R.M.D.; Santos, S.M.E. Medicina Laboratorial para o Clínico. 1ª ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Pratt, C.; Cornely, K. Bioquímica Essencial. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Nelson, D.L.; Cox, M.M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 4 ª ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

MURRAY, R. K. e outros: “Harper – Bioquímica”, 29a ed., 2013

NELSON, D. L.; COX, M. M.: Lehninger – Princípios de Bioquímica, 6a ed., 2014

VOET, D.; VOET, J. G. – Bioquímica, 4a ed., 2013

MORAN, L. A. et al. Bioquímica, 5a ed., 2013

10) TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA:

EMENTA:

Tópicos complementares referentes à bioquímica, de interesse para a formação médica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos na área da bioquímica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

4. CAMPBELL, M. K.; FARREL, S.O. – Bioquímica, 2007
5. LAGUNA et al.: Bioquímica de Laguna, 6a ed., 2012
6. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. – Bioquímica Básica, 3a ed., 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

6. MURRAY, R. K. e outros: “Harper – Bioquímica”, 29a ed., 2013
7. NELSON, D. L.; COX, M. M.: Lehninger – Princípios de Bioquímica, 6a ed., 2014
8. VOET, D.; VOET, J. G. – Bioquímica, 4a ed., 2013
9. MORAN, L. A. et al. Bioquímica, 5a ed.,2013
10. CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.. Bioquímica ilustrada. 2 ed. Artmed, 2002.

11) TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA CELULAR (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Tópicos complementares referentes à Biologia Celular, de interesse para a formaçãomédica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos na área da Biologia Celular.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; DE ROBERTIS, Eduardo M. F.. De Robertis bases da biologia celular e molecular: . 4 ed. Guanabara Koogan, 2010. 389 p. v. ALBERTS, Bruce. Biologia Molecular da Celula: . 5 ed. Artmed, 2010. 1369 p. v.

JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa; CARNEIRO, Sylvio Mário Puga. Biologia celular e molecular: . 8 ed. Guanabara Koogan, 2011. 332 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Site: Acervo Digital da Universidade de São Paulo (USP) - MOL – Microscopia Online http://www.icb.usp.br/mol/0funciomol.html

Site: Acervo Digital da universidade São Judas Tadeu – USJT
http://www.usjt.br/acervolaminas/index.php/citologia

12) TÓPICOS ESPECIAIS EM GENÉTICA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS):
EMENTA:

Genética mendeliana; Material genético; Mecânica celular; Ligação, recombinação e mapeamento cromossômico; Ultra estrutura do gene; Regulação gênica; Mutação, Reparo e Recombinação; Estrutura e modificações cromossômicas, variações numéricas e estruturais; Genomas e Genômica; A Genética das Bactérias e Seus Vírus e resistência a antibióticos; Genética de Populações: Teorema de Hardy e Weinberg; Fatores que alteram a frequência dos genes das Populações; Determinação das frequências gênicas e genotípica sem populações em equilíbrio.

OBJETIVOS:

O objetivo geral desta disciplina consiste em instruir o aluno sobre os aspectos fundamentais da estrutura, funcionamento e regulação dos genes a nível molecular e suas interações com proteínas na dinâmica celular. Através de aulas teóricas, estudo de revisões bibliográficas, capítulos de livros-texto e artigos científicos. Serão discutidas as

bases bioquímicas e moleculares da estrutura e função dos ácidos nucléicos e os seus papéis na manutenção e transmissão da informação genética, incluindo uma análise detalhada dos processos de replicação, transcrição e tradução, bem como seus mecanismos regulatórios. Entender a dinâmica dos genes nas populações e os mecanismos evolutivos.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

SNUSTAD, D. PETER. Fundamentos da Genética - 7ª Ed. 2017. Editora: Guanabara Koogan. 604p

STRACHAN, T.; READ, A. Genética molecular humana. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 808p.

GRIFFITHS, ANTOHONY J.F. WESSLER, SUSAN R. CARROLL, SEAN B. DOEBLEY, JOHN. Introdução à Genética. 11° Edição -. São Paulo: Guanabara Koogan, 2016.780.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MENCK, C. F. M.; SLUYS, MARIE-ANNE.V. Genética molecular básica. - 1ª Ed. 2017. Editora: Guanabara Koogan.

JAMES D. WATSON; TANIA A. BAKER; STEPHEN P. BELL; ALEXANDER GANN; MICHAEL LEVINE; RICHARD LOSICK. Biologia Molecular do Gene. 7ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2015. 912p

BEIGUELMAN, B. Genética de populações humanas. Ribeirão Preto: SBG, 2008. 235p.

13) HISTÓRIA DA MEDICINA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Visão histórica e crítica a respeito do exercício das noções de doença e práticas de cura desde os tempos mais remotos até aos tempos modernos.

OBJETIVOS:

O curso pretende desenvolver no acadêmico uma visão histórica e crítica a respeito do exercício das noções de doença e práticas de cura desde os tempos mais remotos até aos tempos modernos, abordando também esses aspectos no Brasil com ênfase na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BENCHIMOL, Jaime Larry e TEIXEIRA, Luiz Antonio. Cobras, lagartos e outros bichos: uma historia comparada dos Institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro. UFRJ, 1993.

BENCHIMOL, Jaime Larry. Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela no Rio de Janeiro (1880-1903). Rio de Janeiro. FIOCRUZ, UFRJ, 1999.

BENCHIMOL, Jaime Larry. Manguinhos do sonho à vida: a Ciência na Belle Époque. Rio de Janeiro. FIOCRUZ/COC, 1990

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BODSTEIN, Regina C. de Andrade (coord.). História e Saúde Pública: a política do controle do câncer no Brasil. Rio de Janeiro. PEC/ENSP, 1987. 212p.

BRAGA, José Carlos de Souza; PAULA, Sérgio Goes de. Saúde e previdência: estudos de política social. São Paulo. HUCITEC, 1986. 224p.

BRITTO, Nara, LIMA, Nísia Trindade. Salud y nación: Propuesta para el saneamiento rural. Un estudio de la revista Saúde (19181919). In: CUETO, Marcos (Ed.). Salud, cultura y sociedad en América Latina: Nuevas perspectivas históricas. Lima: IEP. Organización Panamericana de la Salud, 1996. 253p. p.135-158. (Estudos Históricos, 20).

BRITTO, Nara. Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira. Rio de Janeiro. FIOCRUZ, 1995. 111 p.

BRITTO, Nara. Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira. Rio de Janeiro. Editora Fiocruz, 1995.

14) TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOFÍSICA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS):

EMENTA:

Tópicos complementares referentes à Biofísica, de interesse para a formação médica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos na área da Biofísica.

Bibliografia Básica:

AIRES, M.M. Fisiologia. 3a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2008.

DURÁN, J. E. R. Biofisica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

GARCIA, E.A.C. Biofisica. São Paulo: Sarvier, 2002

COMPLEMENTAR

HENEINE, I.F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2003..

15) FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO (40 horas – 2 créditos)

EMENTA:

Ao final da disciplina o aluno deverá compreender os diferentes sistemas de transferência de energia e saber associá-los aos diferentes tipos de exercício físico, com base nas definições de potência e capacidade dos sistemas. O aluno também deverá entender os mecanismos de respostas agudas dos diferentes sistemas (sistema cardiovascular e respiratório) à execução de diferentes tipos de exercício físico (aeróbio, anaeróbio e de força). Ênfase especial será dada a conceitos clássicos em fisiologia do exercício, como o VO2máx e o Limiar Anaeróbio.

OBJETIVOS:

Analisar de forma crítica as respostas fisiológicas e metabólicas que ocorrem durante a prática de diferentes tipos de exercícios e/ou atividades físicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVERTHORN, D. U. *Fisiologia Humana - uma abordagem integrada*, 5a ed., Ed. Artmed, RS. ISBN 9788536322841, 2010) .

HALL, J. E. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica*, 12a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN: 978-85-352-3735-1, 2011.

FOX, S. I. - Human Physiology 12th ed., Mac Graw Hill (2011).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COSTANZO, L. S. *Fisiologia*, 4a ed., Ed., Elsevier, Rio de Janeiro. ISBN-10:85-352-3894-8, 2011.

BERNE, R. M., LEVY, M. N., KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. *Fisiologia*, 6a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN-10: 9788535230574. 2009.

Stevens, Alan & Romrell, L.J.; Histologia Humana – Editora Manole. 7ª edição São Paulo 2001

Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

16) TÓPICOS ESPECIAIS EM IMUNOLOGIA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Tópicos complementares referentes à Imunologia, de interesse para a formação médica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos na área da Imunologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ABBAS, Abul K. Imunologia básica – Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. Elsevier, Rio de Janeiro, 2015. 8ª edição.

KINDT, T.J.; GOLDSBY, R. A.; & OSBORNE, B.A. Imunologia de Kuby. Artmed, Porto Alegre, 2008. 6ª Edição

JANEWAY, CHARLES A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 7ª edição.

ROITT, IVAN M. Imunologia. Guanabara Koogan. São Paulo: Atheneu, 2013. 12ª edição.

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Revinter. Rio de Janeiro, 2009. 2ª edição.

GELLER, M; SCHEINBERG, M. Diagnóstico e tratamento das doenças imunológicas. Elsevier, Rio de Janeiro, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Um grande compêndio de imunologia para estudantes que pretendem aprofundar o tema: PAUL, WILLIAM E. Fundamental Immunology./ Philadelphia: Lippincott-Raven, 2008. 6. ed.

Periódicos da área

17) DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PARASITOLOGIA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Preparar o aluno para realizar o diagnóstico etiológico das principais protozooses e helmintoses humanas presentes no país. Aprofundar o estudo da interação parasito/hospedeiro no sentido de promover a compreensão dos resultados laboratoriais e sua correlação com os achados clínicos e epidemiológicos. Ao final desenvolver o raciocínio para o estabelecimento de ações profiláticas e fortalecer o sentido de integração do aluno à comunidade.

OBJETIVOS:

Conhecer helmintos, protozoários e seus vetores que atuam na integridade da saúde do homem. Formar atitudes favoráveis ao fortalecimento do sentido de responsabilidade com a saúde humana.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NEVES, David Pereira, MELO, Alan Lane, LINARDi, Pedro Marcos & VICTOR, Ricardo W. Almeida. Parasitologia Humana. S. Paulo: Ed. Atheneu, 12ª edição, 2011.

CIMERMAN, B & FRANCO, M A. Atlas de Parasitologia. S. Paulo: Ed. Atheneu, 1ª edição, 2006.

DE CARLI, Geraldo Atílio. Parasitologia Clínica. Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. S. Paulo: Ed. Atheneu, 2ª edição, 2008.

VERONESI, Ricardo e FOCACCIA, Roberto. Tratado de Infectologia. S. Paulo: Ed. Atheneu, 4ª edição, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COURA, JOSÉ RODRIGUES. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005. Procedimentos laboratoriais em parasitologia médica. OMS, Liv. Santos, 1ªed., São Paulo, Brasil, 1999.

FERREIRA, WALTER & ÁVILA, SANDRA L. M. Diagnóstico laboratorial. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Revista de Patologia Tropical Portal: http://www.parasitologia.org.br

18) IMUNOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Aplicação e interpretação dos métodos imunológicos visando o diagnóstico clínico.

OBJETIVOS:

Tem como objetivo conscientizar o aluno profissionalmente, salientando a importância da Imunologia Clínica no diagnóstico de doenças. Visa também mostrar a inter-relação da imunologia com outras áreas do conhecimento.

Bibliografia:

BIBLIOGRAFIA BASICA:

ABBAS, Abul K. Imunologia básica – Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. Elsevier, Rio de Janeiro, 2015. 8ª edição.

KINDT, T.J.; GOLDSBY, R. A.; & OSBORNE, B.A. Imunologia de Kuby. Artmed, Porto Alegre, 2008. 6ª Edição

JANEWAY, CHARLES A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 7ª edição.

ROITT, IVAN M. Imunologia. Guanabara Koogan. São Paulo: Atheneu, 2013. 12ª edição.

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Revinter. Rio de Janeiro, 2009. 2ª edição.

GELLER, M; SCHEINBERG, M. Diagnóstico e tratamento das doenças imunológicas. Elsevier, Rio de Janeiro, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Um grande compêndio de imunologia para estudantes que pretendem aprofundar o tema: PAUL, WILLIAM E. Fundamental Immunology./ Philadelphia: Lippincott-Raven, 2008. 6. ed.

Periódicos da área.

19) TÓPICOS EM FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR (40 HORAS – 2 CRÉDITOS)

EMENTA:

Função cardíaca, hemodinâmica e motricidade. Regulação e função da respiração. Volumes e capacidades pulmonares.

OBJETIVOS:

Discutir mecanismos de regulação e adaptação do sistema cardiovascular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVERTHORN, D. U. *Fisiologia Humana - uma abordagem integrada*, 5a ed., Ed. Artmed, RS. ISBN 9788536322841, 2010) .

HALL, J. E. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica*, 12a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN: 978-85-352-3735-1, 2011.

FOX, S. I. - Human Physiology 12th ed., Mac Graw Hill (2011).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COSTANZO, L. S. *Fisiologia*, 4a ed., Ed., Elsevier, Rio de Janeiro. ISBN-10:85-352-3894-8, 2011.

BERNE, R. M., LEVY, M. N., KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. *Fisiologia*, 6a ed., Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN-10: 9788535230574. 2009.

Stevens, Alan & Romrell, L.J.; Histologia Humana – Editora Manole. 7ª edição São Paulo 2001

Rhoades, R.A - Fisiologia Médica – 2a edição Rio de Janeiro - Editora Guanabara Koogan, 2005.

Angolani, H.E.& Houssay, A.B. Fisiologia Humana de Houssay – 7a edição atualizada e ampliada – Editora Artmed, Porto Alegre, 2004.

20) SEMIOTÉCNICA NEUROLÓGICA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS):

EMENTA:

Abordagem aprofundada da semiologia em neurologia.

OBJETIVOS:

Capacitar o aluno para a realização do exame neurológico (aprendizado da semiotécnica neurológica); promover o aprendizado dos termos técnicos relacionados às disfunções do sistema nervoso; estimular a compreensão e aplicação prática do diagnóstico topográfico em neurologia; colocar em prática os preceitos éticos na relação médico-paciente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Speciali, J G. Semiotécnica Neurológica. Medicina, Ribeirão Preto 29:19-31, 1996;

Sobreira, C F R; Brum, D G. Exame Neurológico. In: J A Baddini Martinez; M Dantas; J C Voltarelli. eds. Semiologia Geral e Especializada. 1ed. Rio de Janeiro - RJ: Guanabara Koogan, 2013;

Bicherstaff, E R. Exame neurológico na prática médica;

Sanvito, W. - Propedêutica neurológica;

Porto, C C. Exame clínico, bases para a prática médica. Guanabara Koogan.

21) MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EM PNEUMOLOGIA E CARDIOLOGIA: ELETROCARDIOGRAMA E PROVAS DE FUNÇÃO RESPIRATÓRIA (40 HORAS – 2 CRÉDITOS).

EMENTA:

Fornecer aos alunos condições básicas para leitura e interpretação do eletrocardiograma e da espirometria através de estudo teórico e prático, para que ao fim do curso, o mesmo possa utilizá-los como métodos auxiliares de diagnóstico.

OBJETIVOS:

Conhecer a espirografia e o eletrocardiograma como método auxiliar no diagnóstico de diversas doenças; identificar se a técnica do exame está correta e analisar os exames; identificar e correlacionar as alterações da espirometria e do eletrocardiograma encontradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARNEIRO, E. F. O eletrocardiograma. Rio de Janeiro: Revinter, 1985.

DECCACHE, W; CASTRO, M. C. V. O eletrocardiograma. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.

MAIA, I. G. ECG nas Arritmias. Rio de Janeiro: Editora Cultura Médica, 1989.

BATES. Respiratory function in disease. W.B. Saunders, 1995.

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT. Diretrizes para testes de função pulmonar. Teste de Exercício Cardiopulmonar. J. Pneumol. Brasília, 2002.

22) DIREITOS HUMANOS E MEDICINA (80 HORAS – 4 CRÉDITOS)

EMENTA:

Apresentação do campo do saber. A Medicina como prática do poder. Saúde enquanto Política. SUS direitos. Direitos e Judicialização da saúde. Saúde Mental e Luta Antimanicomial. Direitos Humanos e Sexuais e Reprodutivos. Trans e intersexualidade e a pratica médica. Violência obstétrica. Diversidade étnica.

OBJETIVOS:

Introduzir os conceitos de Direitos Humanos e seus desafios contemporâneos. Apresentar o Estado da Arte; expor as principais contribuições teóricas; refletir sobre as dimensões dos direitos humanos. Analisar o trabalho e a prática em saúde numa leitura humanista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GRECO, Dirceu and WELSH, James. Direitos humanos, ética e prática médica. Rev. Bioét. [online]. 2016, vol.24, n.3, pp.443-451.

MARTIN, Leonard. Os Direitos Humanos nos Codigos Brasileiros de Etica Medica. Editora Loyola, 2002.

Maxwell RS, Pounder DJ. The medicine andhumanrightsspecialstudy module: a physicians for humanrights (UK) initiative. MedTeach. 1999;21(3):294-8.

Pessini L, Barchifontaine CP, Hossne WS, Fabri AM. Ética e bioética clínica no pluralismo e diversidade. São Paulo: São Camilo/Ideias Letras; 2012.

23) ACUPUNTURA (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:

Apresentação, evolução histórica e contextualização da Acupuntura; Evidências e indicações clínicas da Acupuntura; Mecanismo neurofisiológico da dor; Mensuração da

dor; Dor crônica; Síndrome dolorosa miofascial; Pontos básicos da Acupuntura, correlações anátomo-funcionais; Uso clínico dos pontos básicos; Técnica e aplicação de agulha; Possíveis complicações de Agulhamento: prevenir, reconhecer e tratar; Aplicações clínicas práticas.

OBJETIVOS:
Proporcionar conhecimentos básicos sobre a Acupuntura e a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e a sua utilização como especialidade médica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MACIOCIA, G. Fundamentos da Medicina Chinesa. SP: Roca, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FOCKS, C. Atlas de Acupuntura. SP: Manole, 2005.

CARNEIRO, N.M. Fundamentos da Acupuntura Médica. SC: Sistema, 2001.

LING-SHU – Base da Acupuntura Tradicional Chinesa. SP: Andrei, 1995.

ROSS, J. Zang Fu – Sistemas de Órgãos e Vísceras da M T Chinesa. SP: Roca,1994.

INSTITUTO DE MTC DA BEIJING. Atlas de Semiologia da Língua. SP: Roca, 1994.

24) FARMACOLOGIA CLÍNICA (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:

Estudar a abordagem dos princípios gerais da terapêutica clínica dos medicamentos nas diversas patologias, norteando os princípios básicos de atendimento ao paciente mediante a avaliação crítica da eficácia e segurança dos fármacos.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno aprofundamento dos princípios básicos da farmacocinética relacionados à terapêutica clínica. Capacitar o aluno, através de práticas supervisionadas a desenvolver tomada de decisão na prescrição farmacológica de distintos grupos terapêuticos.

BIBLIOGAFIA BÁSICA:

GOODMAN, L.S.,GILMAN, G. A. et.al. Goodman e Gilman´s: As Bases Farmacológicas da Terapéutica. 12ª ed., ED. Mc Graw – Hill Interamericana do Brasil; 2012. 2079 p.

KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica e Clínica. 13ª ed. Porto Alegre:AMGH Editora/McGraw-Hill e ArtMed; 2015

FAUCI, A. S; BRAUNWALD, E.; ISSELBACHER, K. J. et al. *Harrison* – Princípios de Medicina Interna. 18 ed. McGraw Hill Interamericana do Brasil Ltda; 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DIPIRO, J. T.; TALBERT, R. L.; YEE, G. C; MATZKE, G. R.; WELLS, B. G.; POSEY, L. M. Pharmacotherapy – a pathophysiologic approach. 19ª ed. New York: Appleton & Lange, 2016

KAPLAN, H. I., et al. Tratado de Psiquiatria. 6 ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 1999

RANG, H. P., DALE, M. M., RITTER, J. M., GARDEN. P. Farmacologia. 7ed. Rio de Janeiro, Ed.Elsevier; 2011. 768p.

DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R. M.; PLANETA, C. S.; GALLACCI, M.; AVELLAR, M.C.W., (Eds). Farmacologia Integrada. *5*ª. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2014. 3781p.

DEF Dicionário de Especialidades Farmacêuticas EPUC Editora de Publicações Científicas Ltda, 38ª ed., 2015.

The Merk Manual of Diagnosis and Therapy. 19ª ed. New Jersey, USA:Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc Whitehouse Station; July 2011.

FUCHS, F.D; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica 4ª ed, Ed, Guanabara Koogan, 2010.

Micromedex, Inc. International Healthcare Information Series CEBRIM http://www.cff.org.br/

25) INTERCONSULTA PSICOLÓGICA (60 HORAS – 3 CRÉDITOS):

EMENTA:

Aspectos psicológicos acerca da saúde e do adoecimento. O ciclo da vida do ponto de vista psicológico. Fundamentos da Interconsulta. Registro, comunicação e trabalho interdisicplinar em instituições de saúde.

OBJETIVOS:

Reconhecer e compreender a importância do trabalho da equipe interdisciplinar em unidades de saúde, sobretudo na atenção primária e na média complexidade. Saber

executar estratégias para a atenção à saúde mental envolvendo aspectos coletivos, estimulando a atuação interdisciplinar e, porventura, transdisciplinar. Construção atitudes reflexivas e éticas na relação aos usuários e demais colaboradores da área da saúde. Obter habilidades para a assistência aos usuários/pacientes e seus familiares, respeitando as características idiossincrásicas dos envolvidos e contemplando questões de ordem psicológica implicadas.

BIBLIOGRAFIA:

AMARAL, Marília dos Santos; GONCALVES, Cristiane Holzschuh; SERPA, Monise Gomes. Psicologia Comunitária e a Saúde Pública: relato de experiência da prática Psi em uma Unidade de Saúde da Família. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 32, n. 2, p. 484-495, 2012.

BALINT. Michael. O médico: seu paciente e a doença. São Paulo: Atheneu, 1984

BOTEGA, Neury. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. Porto Alegre: ArtMed, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Clínica ampliada e compartilhada. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

CAMPOS, Rosana. Psicanálise e Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2014.

CZERESNIA, Dina (Org.) Os sentidos da saúde e da doença. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013.

COUTO, Marcia Thereza; GOMES, Romeu. Homens, saúde e políticas públicas: a equidade de gênero em questão. Ciênc. e Saúde Coletiva. Vol.17, n.10, pp. 2569-2578, 2012.

FERREIRA NETO, João Leite. Artes da existência. Foucault, práticas clínicas e práticas sociais. In:___Psicologia, políticas públicas e o SUS. São Paulo: Escuta, 2011.

FORTES, Letícia Maria Furlanetto; CHAZAN, Luiz Fernando. Modelo para a implantação de interconsulta e consulta conjunta com a equipe do programa de saúde da família (PSF). Boletim Científico. Associação Brasileira de Psiquiatria, 2016, mimeo.

26) INTRODUÇÃO À MEDICINA GENÔMICA (40 HORAS – 2 CÉDITOS)

EMENTA:

A genética está indiscutivelmente entre as áreas que apresentaram os avanços mais rápidos e significativos na medicina nos últimos anos. Cada vez mais se estabelece uma ligação clara entre a estrutura genômica e a patogênese das doenças. Esses mecanismos

têm implicação direta na resposta aos tratamentos e na manutenção da saúde humana. Por essa razão é essencial para o aluno adquirir conhecimentos atualizados sobre a genômica, desde as suas bases, até a sua aplicação na área de diagnóstico e pesquisa, representada pelos estudos citogenéticos clássicos e moleculares. Citogenética clássica - Citogenética molecular – Sequenciamento – Exoma, Transcriptoma, epigenôma (estudo dos métodos e discussão das aplicações); interpretação dos resultados (correlação genótipo-fenótipo); medicina genômica personalizada.

OBJETIVOS:

Debater os principais métodos citogenéticos clássicos e moleculares e sua utilização na pesquisa médica atual. Explorar alguns dos crescentes arranjos de testes genéticos que estão disponíveis atualmente.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

STRACHAN, T.; READ, A. Genética molecular humana. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 808p.

JAMES D. WATSON; TANIA A. BAKER; STEPHEN P. BELL; ALEXANDER GANN; MICHAEL LEVINE; RICHARD LOSICK. Biologia Molecular do Gene. 7ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2015. 912p

ROSENBERG, L.; ROSENBERG,D. Human Genes and Genomes - Science, Health, Society. 1ª edição. Elsevier, 2012. 446 p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOONE PM, BACINO CA, SHAW CA, ENG PA, HIXSON PM, PURSLEY AN, KANG SH, YANG Y, WISZNIEWSKA J, NOWAKOWSKA BA, DEL GAUDIO D, XIA Z, SIMPSON-PATEL G, IMMKEN LL, GIBSON JB, TSAI AC, BOWERS JA, REIMSCHISEL TE, SCHAAF CP, POTOCKI L, SCAGLIA F, GAMBIN T, SYKULSKI M, BARTNIK M, DERWINSKA K, WISNIOWIECKA-KOWALNIK B, LALANI SR, PROBST FJ, BI W, BEAUDET AL, PATEL A, LUPSKI JR, CHEUNG SW, STANKIEWICZ P. Detection of clinically relevant exonic copy-number changes by array cgh. HUM MUTAT. 2010 SEP 16.

SHCHELOCHKOV OA, CHEUNG SW, LUPSKI JR. Genomic and clinical characteristics of microduplications in chromosome 17. AM J MED GENET A. 2010 MAY;152 (5):1101-10. REVIEW.

STANKIEWICZ P, LUPSKI JR. Structural variation in the human genome and its role in disease. ANNU REV MED. 2010;61:437-55. REVIEW.

27) EMERGÊNCIAS ENDOCRINOLÓGICAS (20 HORAS – 1 CRÉDITO)

EMENTA:

Propiciar ao estudante condições para o desenvolvimento de habilidades para atuar junto a situações de emergência endocrinológica.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos emergenciais das principais complicações endocrinológicas bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes frente ao paciente crítico. Capacitar o aluno, através de práticas supervisionadas no laboratório de habilidades, a diagnosticar, avaliar e iniciar o tratamento dos principais distúrbios endocrinológicos encontrados na Clínica Médica.

BIBILIOGRAFIA BASICA:

Harrison, Medicina Interna - 18ª Ed, 2013

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7ª Ed, 2013

Larsen P.R. - Williams Textbook of Endocrinology - W.B.Saunders - 12ª edição, 2011

Irwin, Richards - Terapia Intensiva - Editora Guanabara Coogan – 6ª Ed, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

28) OSTEOMETABOLISMO (20 HORAS – 1 CRÉDITO)

EMENTA:

Promover o entendimento da fisiologia do metabolismo do cálcio e diagnóstico das principais osteopatias.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos em Fisiologia Óssea e as patologias decorrentes do desbalanço na formação e reabsorção óssea, no diagnóstico diferencial e suas principais complicações endocrinológicas. Bem como papel fundamental do médico generalista na prevenção e diagnóstico da osteoporose: uma doença com alta prevalência e com consequentes gastos a saúdas pública e impacto na qualidade de vida. Capacitar o aluno, através de aulas práticas de Densitometria a diagnosticar, avaliar e iniciar o tratamento das doenças osteometabólicas.

BIBILIOGRAFIA BASICA:

Harrison, Medicina Interna - 18ª ed, 2013
Larsen P.R. - Williams Textbook of Endocrinology - W.B.Saunders - 12ª ed, 2011
Manual de Doenças Osteometabólicas e Distúrbios do Metabolismo Mineral.: Clifford Rosen et al. 8ªed. 2014

Guia Prático em Osteometabolismo. Sergio Setsuo Maeda et al. 2014

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

The Journal of Bone and Mineral Research https://www.asbmr.org/Publications/JBMR/default.aspx

New England Journal of Medicine www.nejm.org,
British Medical Journal www.bmj.com
Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

29) CUIDADOS PALIATIVOS (20 HORAS – 1 CRÉDITO)

EMENTA:

Aborda os princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores determinantes do atendimento humanizado e, por conseguinte, a melhoria na qualidade da assistência multiprofissional direcionada aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura e sua família.

OBJETIVOS:

Compreender os princípios dos Cuidados Paliativos; Compreender o processo de adaptação à doença crônica; Demonstrar competências na implementação de um plano de cuidados de qualidade em conformidade com a filosofia dos Cuidados Paliativos ao paciente com doença potencialmente incurável e à sua família; Demonstrar capacidade de reflexão bioética e crítica na análise de assuntos complexos inerentes aos cuidados paliativos; Reconhecer atitudes pessoais, bem como sentimentos, valores e expectativas em relação à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe na sociedade; Compreender os princípios do trabalho em equipe multidisciplinar.

BIBILIOGRAFIA BÁSICA

Pessini L, Bertachini L. Humanização e cuidados paliativos. São Paulo: Edições Loyola; 2004. Pimenta CAM, Mota DDCF, Cruz DALM. Dor e cuidados paliativos: enfermagem, medicina e psicologia. Barueri: Manole; 2006.

Santos FS. Cuidados paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer. São Paulo: Atheneu; 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Araújo PVR, Vieira MJ. As atitudes do homem frente à morte e o morrer. Texto Contexto Enferm 2001; 10(3): 101-17.

Baliza MF, Bousso RS, Spineli VMCD, Silva L, Poles K. Cuidados paliativos no domicílio: percepção de enfermeiras da Estratégia Saúde da Família. Acta Paul Enferm 2012;25(n spe2):13-8.

Esslinger I. De quem é a vida, afinal? São Paulo: Casa do Psicólogo; 2004.

Incontri D, Santos FS. A arte de morrer: visões plurais. Bragança Paulista: Comenius; 2007.

Kovács MJ. Educação para a morte: temas e reflexões. Casa do Psicólogo; 2003.

30) FUNDAMENTOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:

Propiciar aos participantes um referencial teórico-metodológico e prático que possibilite o desenvolvimento de ações no campo da Saúde do Trabalhador, na perspectiva da participação em atividades e programas relacionados ao enfrentamento dos problemas de saúde decorrentes do trabalho.

OBJETIVOS:
Compreender o trabalho como determinante da doença e da saúde, contribuindo para a formação integral de profissionais de saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Rev. Saúde Pública [online]. 1991, vol.25, n.5, pp. 341-349.

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v25n5/03.pdf Acesso em: 27/03/2013.

NEHMY, Rosa Maria Quadros; DIAS, Elizabeth Costa. Os caminhos da Saúde do Trabalhador: para onde apontam os sinais? Rev. Med Minas Gerais, 2010; 20(2 Supl 2). Disponível em: http://rmmg.medicina.ufmg.br/index.php/rmmg/article/view/261/244 Acesso em: 17/03/2015.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm Acesso em: 21/02/2015

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 777/2004 MS, de 28/04/2004. Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde – SUS.

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-777_28042004%20%28ST%20no%20SINAN%29.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html Acesso em: 12/11/2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GUIMARÃES, B. M. et all.Análise da carga de trabalho de analistas de sistemas e dos distúrbios osteomusculares. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 24, n. 1, p. 115-124, jan./mar. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/fm/v24n1/v24n1a13.pdf acesso em 11/10/2014

SILVA, N. R. da. Fatores determinantes da carga de trabalho em uma unidade básica de saúde . Ciênc. Saúde Coletiva. 2011, vol.16, n.8, pp. 3393-3402. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n8/a06v16n8.pdf . Acesso em: 11/02/2013

VILELA, R. A. G; ALMEIDA, I. M.; MENDES, R. W. B. Da vigilância para prevenção de acidentes de trabalho: contribuição da ergonomia da atividade. Ciência & Saúde Coletiva, 17 (10): 2817-2830, 2012 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n10/29.pdf Acesso em 01/07/2014

ALVAREZ, D.; FIGUEIREDO, M.; ROTENBERG, L. Aspectos do regime de embarque, turnos e gestão do trabalho em plataformas offshore da Bacia de Campos (RJ) e sua relação com a saúde e a segurança dos trabalhadores. Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 201-216, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbso/v35n122/a04v35n122.pdf Acesso em: 30/06/2014

ALBUQUERQUE, F. P. de; BARROS, C. R. dos S.; SCHRAIBER, Lilia Blima. Violência e sofrimento mental em homens na atenção primária à saúde. Rev Saúde Pública 2013;47(3):531-9 Disponível em http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v47n3/0034-8910-rsp-47-03-0531.pdf Acesso em 18/07/2014

31) INTERPRETAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS EM MEDICINA INTERNA (20 HORAS – 1 CRÉDITO)

EMENTA:

Fornecer os conhecimentos básicos na abordagem diagnóstica clínica inicial , interpretação de exames complementares e estabelecimento prognóstico de casos clínicos dentro das várias especialidades médicas.

OBJETIVOS:

Ampliar os conhecimentos em ectoscopia das principais síndromes clínicas, bem como proporcionar aos alunos a aquisição de habilidades e atitudes frente ao paciente e suas queixas. Capacitar o aluno, através de práticas supervisionadas no laboratório de habilidades , a diagnosticar, avaliar e iniciar o tratamento das principais síndromes clínicas encontradas na Clínica Médica.

BIBILIOGRAFIA BASICA:

Harrison, Medicina Interna - 18ª Ed, 2013

Porto, Celmo Celeno - Semiologia Médica - 7ª Ed, 2013
Irwin, Richards - Terapia Intensiva - Editora Guanabara Coogan – 6ª Ed, 2015

Goldman L, Ausiello D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. 24ªEdição. Rio de Janeiro:ELSEVIER, 2014

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

New England Journal of Medicine www.nejm.org,

British Medical Journal www.bmj.com

Revistas eletrônicas www.revista.fmrp.usp.br

32) RESPONSABILIDADE JURÍDICA PELO ATO MÉDICO (60 HORAS – 3 CRÉDITOS)

EMENTA:

Possibilitar aos discentes uma visão crítica e construtiva acerca dos aspectos teórico e prático da atividade médica e seus efeitos penais, permitindo a estes dimensionarem o exercício profissional na sua interface com o direito, numa perspectiva de gerenciamento dos riscos inerentes à área da saúde e os limites da responsabilidade jurídica.

OBJETIVOS:
Compreender a dimensão jurídico-penal do exercício da medicina na sua interface com o direito.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAMMPANARI, Nicelly Alessandra Bohatch. *Responsabilidade penal do médico*. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 04 set. 2008. Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=1055.20857&seo=1>. Acesso em: 15 jan. 2018.

CUNHA, Carlos Leonardo Figueiredo e outros. A responsabilidade civil do médico e o ato médico: perspectivas interdisciplinares. Artigo publicado no Caderno de Pesquisa, São Luís, v. 18, n.1, jan./abr. 2011.

PRATES, Núria Derviche e MARQUARDT, Marcelo. A responsabilidade penal do médico e o processo penal. Simpósio Medicina e Direito. J Vasc Br 2003, Vol. 2, Nº3. Disponível em: http://jvascbras.com.br/pdf/03-02-03/simposio/03-02-03-241.pdf. Acesso em: 15 jan. 2018.

SCHREIBER, Simone. Reflexões acerca da responsabilidade penal do médico. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 801, 12 set. 2005. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/7271. Acesso em: 9 jan. 2018.